

Examen Immunologie 2^{ème} année / 2026**1) Concernant les organes lymphoïdes primaires (Cocher la proposition INEXACTE)**

- 1- Apparaissent tôt dans la vie embryonnaire
- 2- Situées en dehors des voies de pénétrations et de circulation des antigènes du soi.
- 3- Sont le siège de maturation (éducation) et de différenciation des lymphocytes mémoires
- 4- Sont le site d'élimination des lymphocytes auto-réactifs.
- 5- Leur développement est dépendant des infections virales

A: 1+3+5 B:1+4+5 C: 2+3+5 D: 1+2+4+5 E: 1+2+3+5

2) Le thymus est: (Cocher la proposition INEXACTE)

- 1- Le premier organe lymphoïde à apparaître, à partir de la 1^{ème} semaine de gestation
- 2- Issu d'une ébauche provenant des 3^{èmes} et 4^{èmes} poches pharyngées,
- 3- Caractérisé par une ébauche commune avec celle des glandes thyroïdes chez l'Homme
- 4- Vers la 16^{ème} semaine on constate l'apparition des premiers lymphocytes matures.
- 5- Vers la 36^{ème} semaine: le thymus termine son organogénèse.

A: 1+2+5 B: 2+3+4 C: 3+5 D:1+3+4 E: 1+2+5

3) Lors de la sélection intra-thymique: (Cocher la proposition INEXACTE)

- A- Les étapes de sélection intra thymique permettent la génération du répertoire T.
- B- Les lymphocytes T sont éduqués à reconnaître le soi et à le tolérer.
- C- Les lymphocytes T quittent le thymus pour aller se localiser au niveau des organes lymphoïdes secondaires (aires T dépendantes).
- D- Ils y pénètrent par voie sanguine, peuvent circuler d'un organe lymphoïde à une autre par voie lymphatique.
- E- Ces lymphocytes T en attente d'une éventuelle rencontre avec l'Ag sont des lymphocytes T double positif naïfs.

4) Les organes lymphoïdes périphériques sont: (Cocher la proposition INEXACTE)

- A- De structure de type réticulo-endothéliale.
- B- De développement est plus tardif que les OL 1^{aire}.
- C- Le lieu de rencontre et de contact entre antigène et cellules phagocytaires.
- D- Réparties dans toutes les zones par lesquelles peut pénétrer un antigène
- E- Le siège de la réponse immunitaire adaptative

5) La sélection positive des lymphocytes T: (Cocher la proposition EXACTE)

- A- A lieu au niveau de la médulla
- B- A lieu au niveau de la jonction cortico-médullaire
- C- A lieu au stade de thymocyte double négatif
- D- Favorise le développement des thymocytes capables d'interagir avec les molécules du CMH
- E- Permet la survie des thymocytes qui interagissent avec les peptides du soi.

6) Au cours de la sélection négative des Lymphocytes T: (Cocher la proposition EXACTE)

- A- Les peptides sont présentés par les lymphocytes B.
- B. Fait intervenir les thymocytes doubles négatifs (CD4-et CD8-) issus de la sélection positive
- C. L'affinité des interactions détermine le devenir des réarrangements des TCR.
- D- La génération des plasmocytes T régulateurs se fait au cours de cette étape.
- E- Ces étapes de sélection intra-thymique permettent l'élimination des T auto-réactifs

7) Les lymphocytes T (LT):: (Cocher la proposition EXACTE)

- A- Bénéficient du microenvironnement médullaire pour se différencier en LT matures
- B- Expriment le CD4 et le CD8 après activation,
- C- Sont dits thymocytes simple positif lorsqu'ils expriment le CD3.
- D- Passent par deux étapes de sélection pour acquérir la tolérance centrale.
- E- Libèrent les cytokines pour détruire les antigènes.

8) Les lymphocytes T helper de type 1 (LTh1): (Cocher la proposition EXACTE)

- A- Reconnaittent les peptides associés aux molécules du CMH de classe II.
- B- Induisent la production d'anticorps d'isotype IgE.
- C- Sont des LT cytotoxiques naturellement.
- D- Sont générés précocement au cours de l'ontogenèse.
- E- Sécrètent la cytokine IL-2 pour activer les autres lymphocytes.

9) L'interaction moléculaire suivante délivre signal qui induit la commutation isotypique proposition EXACTE)

- A- TCR (a. B)/CD8-(peptide-CMH II)
- B- LFA-3-CTLA-4
- C- CD2-CD19
- D- CD4-CD80/CD86
- E- CD40 Ligand-CD40.

10) Le premier signal d'activation des LT CD8" implique: (Cocher la proposition EXACTE)

- A- [TCR (a. B)/CD3]/CD8-(peptide-CMH I)
- B- CTLA-4-B7.1/B7.2.
- C- CD2-LFA3
- D- CD28-CD80/CD86.
- E- CD95 Ligand-CD95.

11) Le lymphocyte B migM": (Cocher la proposition EXACTE)

- A- Dérive de la cellule souche myéloïde.
- B- Se différencie en LB mature au contact des cellules spléniques.
- C- Se différencie en plasmocyte producteur d'IgM.
- D- Exprime le CD79a suite à sa différenciation en plasmocyte.
- E- Exprime la chaîne lourde 5 (IgD) cytoplasmique au stade de B mémoire.

12) Le lymphocyte B: (Cocher la proposition EXACTE)

- A- Subit une maturation finale au niveau de la moelle osseuse.
- B- Est localisé majoritairement au niveau du paracortex du ganglion.
- C- Peut reconnaître l'antigène à l'état natif.
- D- Est le support de l'immunité cellulaire.
- E- Exprime le CD19 au stade de plasmocyte.

13) Le BCR est un marqueur des lymphocytes: (Cocher la proposition EXACTE)

- A- Pré-pro B
- B- Pro-B
- C- Pré-B
- D- B mémoires
- E- Plasmocytes

14) Les centres germinatifs sont le siège: (Cocher la proposition EXACTE)

- A- De l'expansion clonale des lymphocytes B immatures
- B- Du réarrangement séquentiel des gènes codant les parties constantes du BCR
- C- De la maturation d'affinité du BCR
- D- De la commutation de classe des TCR
- E- De la formation des lymphocytes B mémoires immatures

15) Pour les IgA sécrétaires: (Cocher la proposition EXACTE)

- A- La chaîne lourde alpha est la même des IgA sériques
- B- La pièce sécrétoire est synthétisé par le plasmocyte
- C- La pièce J est synthétisé par les cellules épithéliales
- D- La pièce sécrétoire facilite le passage placentaire des igA
- E- Rôle important dans les défense au niveau des endothéliums

15) Les immunoglobulines G (IgG): (Cocher la proposition INEXACTE)

- A- La chaîne lourde est la chaîne gamma
- B- La plus abondante des immunoglobulines dans le sang
- C- Joue un rôle dans l'activation du facteur & du complément
- D- Assure le phénomène d'ADCC
- E- Passe au niveau placentaire

17) Le fragment Fc d'une immunoglobuline est responsable: (Cocher la proposition EXACTE)

- 1. De sa spécificité Anticorps
- 2. De son aptitude éventuelle à fixer le complément
- 3. Du passage placentaire s'il s'agit d'une IgG
- 4. De la fixation sur les mastocytes s'il s'agit d'une igM
- 5. De l'ADCC

A.1+2+3 B. 3+4+5 C. 2+3+4+5 D. 2+3+5 E. 2+4

18) Concernant les propriétés des IgM sériques: (Cocher la proposition EXACTE)

- 1. Contient la pièce sécrétoire
- 2. Contient la pièce J
- 3. Formée de 10 sous unités
- 4. Dépourvu de résidus sucrés
- 5. Chaîne lourde plus longue que celle des IgG

A.1+2+5 B. 3+5 C.2+3+5 D.2+5 E. 1+2+4

19) Les régions constantes des chaînes H portent des structures conservées qui assurent diverses fonctions (Cocher la proposition INEXACTE)

- 1- L'adhérence aux phagocytes.
- 2- La fixation des molécules HLA
- 3- Le transfert placentaire
- 4- L'ADCC
- 5- La reconnaissance et la fixation de l'épitope

A.1+2+5 B. 2+ 5 C.2+3+5 D.4+5 E.1+2

20) Les sélécines: (Cocher la proposition EXACTE).

- 1- Sont des molécules solubles.
 - 2- Ont pour ligands des résidus glucidiques.
 - 3- interviennent dans l'adhésion des leucocytes à l'endothélium vasculaire.
 - 4- Sont des glycoprotéines transmembranaires.
 - 5- Comportent les L-sélécines dont l'expression est induite sur les leucocytes
- A.3+4+5 B. 2+3+4 C.1+5 D.2+5 E. 1+2+5

21) Parmi les fonctions des molécules d'adhésion, on peut citer: (Cocher la proposition EXACTE).

- A. La migration des cellules en apoptose.
- B. La reconnaissance et la présentation des antigènes.
- C. L'adhésion cellulaire irréversible à l'endothélium vasculaire au repos.
- D. La formation de la synapse immunologique au cours de la présentation d'antigène.
- E. L'adhésion réversible des leucocytes aux cellules endothéliales par les intégrines après activation.

22). Les cellules tueuses naturelles ou cellules NK: (Cocher la réponse INEXACTE)

- A- Ont souvent une morphologie de grands lymphocytes granuleux.
- B- Sont doués d'une cytotoxicité restreinte par les le CMH.
- C- Possèdent des récepteurs pour les immunoglobulines G
- D- Peuvent exprimer des récepteurs pour le fragment Fc.
- E- Ont une activité augmentée par l'interféron gamma.

23). Les cellules dendritiques: (Cocher la proposition INEXACTE)

- A- Sont des cellules présentatrices d'antigènes professionnelles
- B- Capables de stimuler efficacement les lymphocytes T CDB+ et lymphocytes CD4+ naifs
- C- Expriment les molécules HLA de classe I et HLA de classe II.
- D- Expriment les molécules de surface CD40, 87
- E- Sécrètent de l'IL-2 et de l'interféron γ

24) Le phénomène de cytotoxicité cellulaire anticorps-dépendant (ADCC) peut faire intervenir des:**(Cocher la proposition EXACTE)**

- A- Lymphocytes B cytotoxiques.
- B- Polynucléaires basophiles.
- C- Polynucléaires éosinophiles avec des IgG spécifiques dans les helminthiases
- D- Cellules naturelle Killer.
- E- Mastocytes.

25). Les cellules tueuses naturelles ou cellules NK: (Cocher la proposition EXACTE)

- A- Expriment la molécule CD3.
- B- Représentent la sous-population majoritaire des lymphocytes.
- C- Nécessitent pour exercer leur activité lytique la reconnaissance du complexe CMH II-peptide.
- D- Sont impliquées dans la destruction des cellules tumorales
- E- Collaborent avec les lymphocytes B pour éliminer les antigènes thymo-indépendants.

26) Concernant la fonction effectrice du PNN: (Cocher la proposition EXACTE)

- 1- La reconnaissance des antigènes est exclusivement dépendante des TLR
 - 2- L'explosion oxydative et la synthèse de protéines de novo sont les deux mécanismes essentiels de la bactéricide
 - 3- La nétose forme de mort cellulaire, au cours de laquelle le PNN libère le NET composé de chromatine décondensé, garni des protéines anti-microbiennes
 - 4- Le PNN exerce une fonction pro inflammatoire et anti-inflammatoire selon le besoin
 - 5- Assurent la reconnaissance et la présentation des antigènes aux lymphocytes
- A:1+2+3 B:3+4 C:2+4 D:1+4 E:1+3

27) La voie commune du complément: (Cocher la proposition INEXACTE)

- A- Est initiée par le clivage du C5
- B- Peut-être régulée par le CD55 et le CD59
- C- Est commune aux trois voies d'activation du complément
- D- S'active exclusivement dans la voie classique
- E- Aboutit à la formation du complexe d'attaque membranaire

28) Les cytokines assurent la communication intercellulaire par: (Cocher la proposition INEXACTE)

- A- Le mode autocrine
- B- Le mode endocrinien.
- C- La mode paracrine
- D- Les neurotransmetteurs
- E- Des récepteurs dans la cellule cible

29) Les chimiokines: (Cochez la proposition INEXACTE)

- A- Sont un type particulier de cytokines
- B- Sont impliquées dans la mobilisation cellulaire
- C- Impliquent dans leur dénomination les deux résidus cystéine conservés en N-terminal
- D- Utilisent dans leur dénomination les initiales IL-
- E- Utilisent des récepteurs comme le CCR6 et CCR7

30) Les cytokines peuvent être (Cochez la proposition INEXACTE)

- A. Des molécules à activité antivirale
- B. Des facteurs de croissance hématopoïétiques
- C. Impliquées dans les pathologies inflammatoires
- D. Ciblées pharmacologiquement dans certaines maladies
- E. Secrétées au repos sans la présence de stimulus

31) Les molécules HLA de classe 1: (Cocher la proposition INEXACTE).

- 1- Sont exprimées par les cellules nucléées de l'organisme.
 - 2- Présentent le peptide immunogène exogène aux lymphocytes T CD8.
 - 3- La chaîne α est polymorphe.
 - 4- La chaîne β est extracellulaire.
 - 5- La chaîne γ est polymorphe.
- A: 2+3 B: 2+3+4+5 C:2+3+4 D:2+4 E: 1+2+3+4

32) Les molécules HLA présentent les caractéristiques suivantes: (Cocher la proposition INEXACTE).

1. Les molécules de classe II peuvent être induites sur certaines cellules par l'interféron gamma.
2. Les variations responsables du polymorphisme allélique sont induites par des recombinaisons géniques
3. Chaque molécule HLA est capable de présenter de nombreux peptides différents.
4. Les lymphocytes B expriment les molécules HLA de classe I et II.
5. Les molécules HLA présentent une spécificité étroite pour la liaison peptidique

A: 1+2+3 B: 2+3 C: 3+5 D: 1+4 E:2+3+4

33) Au cours d'une réaction inflammatoire aiguë, on observe: (Cocher la proposition EXACTE)

- 1- Une augmentation de la fraction gamma
- 2- Une hyper-albuminémie
- 3- Une augmentation de la CRP sérique
- 4- Une augmentation de la synthèse de l'interleukines IL-6
- 5- Une diminution de la calcémie

A: 1+3 B:1+5 C: 2+5 D:4+5 E: 3+4

34) Les PRR: (Cocher la proposition INEXACTE)

- A. Reconnaittent les PAMP et DAMP
- B. Incluent les TLR
- C. Sont présents sur les macrophages
- D. Sont identiques chez tous les individus
- E. Subissent un réarrangement génique

35) L'histamine: (Cocher la proposition INEXACTE)

- A- Est un médiateur préformé
- B- Augmente la perméabilité vasculaire
- C- Est produit de novo à partir des phospholipides membranaires
- D- Est libérée lors de la dégranulation des mastocytes et des polynucléaires basophiles
- E- Un des premiers médiateurs libérés au cours de la réaction inflammatoire

36) La réaction inflammatoire est médiée par (Cocher la proposition INEXACTE) 1

- A- L'histamine.
- B- Les leucotriènes
- C- La bradykinine
- D- Les interleukines de type IL2
- E- Le complément

37) Les cellules sanguines circulantes recrutées lors d'une réaction inflammatoire sont (Cocher la proposition INEXACTE)

- A- Les mastocytes
- B- Les monocytes
- C- Les polynucléaires neutrophiles
- D- Les polynucléaires éosinophiles
- E- Les polynucléaires basophiles

38) Les mécanismes effecteurs de la réponse inflammatoire sont : (Cocher la proposition INEXACTE)

- A- L'opsonisation
- B- Cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps (ADCC)
- C- La phagocytose
- D- La dégranulation
- E- L'explosion oxydative

39) La famille des intégrines compte parmi ses membres les molécules suivantes: (Cocher la proposition INEXACTE)

- A- VLA 4
- B- LFA 1.
- C- PSGL-1
- D- CR4
- E- CR3

40) Au cours du phénomène de migration transendothéliale des neutrophiles au site de la réaction inflammatoire on retrouve (Cocher la proposition INEXACTE)

- A. Une expression précoce des P-sélectines en quelques minutes sur les cellules endothéliales
- B- Une intervention des sélectines dans le phénomène de capture et de roulement des neutrophiles
- C- Une expression des E-sélectines sur les cellules endothéliales dans les 6 heures.
- D- Une expression de VCAM et ICAM1 sous l'action de cytokines pro inflammatoires IL1 et TNFa
- E- Une participation des intégrines lors de la phase précoce.

Examen Anapath 3^{ème} année / 2026

1 Parmi les caractères suivants, les quels sont utilisés dans la classification pTNM

(Combinaison juste):

- A. Taille de la tumeur
 - B. Présence ou non de métastases
 - C. Différenciation de la tumeur
 - D. Index mitotique
 - E. Anomalies cytonucléaires
- Combinaisons possibles: AB/AD/BC/BE

2 Le mélanome: RF

- A. Peut se développer à partir d'un nævus
- B. L'immunohistochimie aide à son diagnostic
- C. Souvent de mauvais pronostic
- D. Est en tumeur bénigne
- E. On l'appelle « Acral» quand il se développe dans la plante du pied

3 Toutes ces tumeurs embryonnaires sont de nature blastémateuse sauf une:

- A. Hépatoblastome
- B. Médulloblastome
- C. Neuroblastome
- D. Chondroblastome
- E. Pneumoblastome

Concernant le lymphome de Burkitt: (RJ)

- A. L'activité mitotique est faible
- B. Est une urgence thérapeutique
- C. Présente une architecture nodulaire
- D. Est un lymphome T
- E. Est un lymphome NK

5 Parmi les tumeurs mésenchymateuses de malignité intermédiaire, on peut citer: (RF)

- A. Le rhabdomyome
- B. La tumeur desmoïde
- C. Les tumeurs fibreuses solitaires
- D. Le sarcome de Kaposi
- E. Le dermato fibrosarcome de Darier et Ferrand

6 L'ostéosarcome: (RF)

- A. Touche surtout le sujet jeune
- B. Est une tumeur ostéoformatrice
- C. Est faite de rhabdomyoblastes
- D. Siège surtout au niveau de la métaphyse des os long
- E. Caractérisé par la présence d'une ostéoïde tumorale

7 On distingue plusieurs variétés histologiques de liposarcome: (RF)

- A. Liposarcome myxoïde.
- B. Le lipome à cellules pléomorphes
- C. Liposarcome bien différencié
- D. Liposarcome dédifférencié
- E. Liposarcome pléomorphe

8 Les adénomes colorectaux (RF)

- A. Peuvent être d'architecture tubuleuse, villositaire ou tubulo-villositaire
- B. Souvent dysplasiques
- C. Les atypies cytonucléaires sont discrètes en cas de dysplasie de bas grade
- D. Perte de la mucosécrétion et un pléomorphisme nucléaire marqué dans la dysplasie de haut grade
- E. Ils sont dépourvus de dysplasie lorsqu'ils sont de petite taille

9 Le carcinome in situ (CIS) est défini comme: (RJ)

- A. Un carcinome qui franchit la membrane basale
- B. Un carcinome qui ne franchit jamais la membrane basale
- C. Un carcinome invasif
- D. Une tumeur bénigne
- E. Un adénome

10 Parmi ces gènes, lesquels n'appartiennent pas à la famille des gènes suppresseurs de tumeur ?

- A. Gène du rétinoblastome Rb
- B. Her2
- C. BRCA1/BRCA2
- D. Gène APC
- E. Gène C-KIT

Combinaisons possibles: ABCD DE AE BE

11 Les tumeurs urothéliales se développent à partir de :(RJ)

- A. L'épithélium transitionnel
- B. L'épithélium squameux
- C. L'épithélium glandulaire
- D. L'épithélium cylindrique
- E. Tissu conjonctif

12 Les anticorps anti cytokératine s'expriment dans: (RJ)

- A. Les cellules épithéliales.
- B. Les cellules musculaires
- C. N'expriment jamais dans les mélanomes
- D. Les cellules nerveuses
- E. Les cellules ostéoclastiques

13 Les carcinomes se disséminent souvent par voie: (RJ)

- A. La voie lymphatique
- B. La voie hématogène
- C. La veine porte
- D. La dissémination nerveuse
- E. La voie des séreuses

14 Les métastases: (RJ)

- A. Sont des foyers tumoraux contigus à la tumeur primitive
- B. Ne comportent pas de stroma tumoral
- C. Apparaissent toujours tardivement
- D. Peuvent être révélatrices du cancer
- E. Leur siège de prédilection est le muscle cardiaque

15 Le stroma tumoral: (RF)

- A. Est indispensable à la croissance tumorale
- B. Provient de l'hôte
- C. Est plus développé dans les carcinomes que dans les sarcomes
- D. Est inutile à l'angiogenèse tumorale
- E. Peut contenir une substance spécifique sécrétée par les cellules tumorales

16 La dysplasie: (RF)

- A. Est une lésion précancéreuse acquise
- B. Associe des anomalies, architecturales et cytonucléaires
- C. Existe dans les tissus conjonctifs sous forme de sarcome in situ
- D. Peut-être de bas grade ou de haut grade
- E. Peut régresser, rester stable ou évoluer

17 Concernant la cellule cancéreuse: (RF)

- A. Elle échappe aux mécanismes de l'homéostasie tissulaire
- B. Elle possède un pouvoir de multiplication limité
- C. Elle présente des anomalies morphologiques et fonctionnelles
- D. Elle peut acquérir un pouvoir invasif et métastatique
- E. Elle comporte des mutations génétiques

18 Toutes ces tumeurs, sont malignes sauf une laquelle: (RJ)

- A. Le mélanome
- B. Le lymphome
- C. Le lipome
- D. Le mésothéliome
- E. Le néphroblastome

19 Devant une suspicion de réaction de rejet d'un greffon, il est urgent de: RJ

- A. Réaliser un bilan immunologique
- B. Réaliser des biopsies.
- C. Faire un scanner suivi d'IRM
- D. Rajouter des immunosuppresseurs
- E. Enlever le greffon

20 Le rejet suraigu: R.J

- A. Du aux lymphocytes du donneur
- B. Du aux anticorps préexistants
- C. Survient quelques semaines après la greffe
- D. Réversible après traitement
- E. Se produit par une réaction d'hypersensibilité de type I

21 L'hypersensibilité de type III: RF

- A. Du à un excès de complexes immuns circulants
- B. Se voit dans les glomérulonephrites post-streptococciques.
- C. Fait intervenir le système du complément
- D. Fait intervenir la phagocytose
- E. Encore appelée: réaction à médiation cellulaire

22 Toutes ces affections font intervenir des réactions d'hypersensibilité de type II sauf une:

- A. Maladie de Basedow
- B. Syndrome de Good Pasture
- C. Anémie hémolytique
- D. Tuberculose
- E. Myasthénie

23 Les moyens de diagnostic d'une infection parasitaire utilisés en Anatomie Pathologique sont: RF

- A. Etude morphologique avec coloration de routine
- B. Coloration histochimique du PAS et Giemsa
- C. Etude immunohistochimique utilisant des anticorps spécifiques
- D. Examen ultra structural en microscopie électronique
- E. Examen direct

24 Parmi les lésions suivantes laquelle est considérée comme directe, liée à l'effet cytopathogène des virus: RJ

- A. Congestion vasculaire
- B. œdème inflammatoire
- C. Corps d'inclusion nucléaires et/ou cytoplasmiques.
- D. Infiltrat mononucléé
- E. Fibrose

25 Les cellules épithélioïdes : RF

- A. Ressemblent aux cellules épithéliales
- B. Sont des cellules d'origine histiocytaire
- C. Sont des cellules très actives
- D. Ont une activité sécrétoire importante
- E. Sont d'origine tumorale

26 Dans le granulome à corps étranger les cellules géantes: RJ

- A. Sont de type Langhans
- B. Proviennent de la fusion des cellules épithélioïdes
- C. Sont de type Muller
- D. Les noyaux se disposent en périphérie sous forme de couronne ou en fer à cheval
- E. Se disposent de façon concentrique en granulome

27 Une suppuration qui se développe et se collecte dans une cavité préformée correspond à: (RJ)

- A. Un empyème
- B. Un phlegmon
- C. Un abcès
- D. Une pustule
- E. Un anthrax

28 Un abcès se distingue d'un phlegmon par: RJ

- A. Richesse en polynucléaires
- B. Présence de pyocytes
- C. Aspect collecté de la lésion
- D. Etendu des thromboses veineuses
- E. Intensité de l'exsudat fibrineux

29 La couche périphérique de la membrane pyogène d'un abcès est composée de: R.J

- A. Nécrose fibrinoïde
- B. Polynucléaires altérés
- C. Cellules épithélioïdes
- D. Tissu conjonctif jeune
- E. Vascularite

30 La régénération épithéliale qui est parallèle à la régénération conjonctive fait intervenir: (RJ)

- A. La prolifération des cellules épithéliales du centre vers la périphérie des berges
- B. La multiplication des myofibroblastes
- C. La prolifération des fibroblastes
- D. La synthèse des composants de la membrane basale
- E. Le remodelage de la matrice extracellulaire

31 La phase de détersion: (RJ)

- A. Succède à la phase cellulaire
- B. Elimine les tissus nécrosés
- C. Permet le rapprochement des berges
- D. Si elle est incomplète, elle peut parfois évoluer vers la guérison
- E. Elle peut être seulement interne

32 Tous ces facteurs influencent la qualité de la réparation tissulaire, sauf un lequel ?

- A. L'arrêt de l'agression initiale
- B. L'étendue de la destruction ou la nécrose
- C. Qualité de la détersion
- D. La bonne vascularisation et innervation tissulaire
- E. Le mécanisme de détersion

33 La contraction de la plaie au cours de la cicatrisation est attribuée aux: (RJ)

- A. Macrophages
- B. Polynucléaires
- C. Myofibroblastes
- D. Mastocytes
- E. Fibroblastes

34 L'une de ces étapes fait intervenir les macrophages: RF

- A. La coaptation
- B. La détersion
- C. La leucodiapédèse
- D. L'œdème
- E. La cicatrisation

35 Le granulome inflammatoire formé lors de la phase cellulaire: RF

- A. Comporte des cellules sanguines et celles de la matrice extra cellulaire
- B. Son rôle est important dans la détersion et la réaction immunitaire
- C. Les médiateurs chimiques interviennent rarement
- D. Il est encore appelé le bourgeon charnu inflammatoire
- E. La phagocytose constitue l'une de ces étapes

36 La réaction vasculo-exudative au cours du processus inflammatoire: (RF)

- A. Survient avant la phase cellulaire
- B. Fait intervenir les vaisseaux
- C. La congestion active est l'une de ces étapes
- D. La leuco diapédèse ne se voit jamais pendant cette réaction
- E. Sa constatation au cours d'une autopsie cardiaque permet de suspecter un IDM

37 Lésions compliquées retrouvées au cours de l'athérosclérose: RF

- A. Prolifération tumorale
- B. Ulcération de la plaque
- C. Hémorragie et l'hématome intra-plaque
- D. Thrombose sur la plaque
- E. Embolie

38 Toutes ces affirmations sur l'athérosclérose sont justes sauf une, laquelle: (RF)

- A. C'est des remaniements de l'intima
- B. Touche les artères de gros et moyen calibre
- C. C'est l'accumulation de lipides et glucides complexes
- D. Une modification du média est présente
- E. Le secteur veineux peut être touché

39 Une plaque athéromateuse devient instable sous l'influence de tous ces facteurs sauf un lequel ?

- A. La composition de la plaque en lipide
- B. La solidité de la chape fibreuse
- C. La réaction inflammatoire
- D. Les infections
- E. Le sexe

40 Les lésions réversibles de l'athérosclérose sont: (RJ)

- A. Le point lipidique
- B. La strie lipidique
- C. La plaque gélatineuse
- D. La plaque athéromateuse constituée
- E. La plaque ulcérée

Combinaisons possibles: ADE/DE/ABC/AB/AC

41 La métaplasie (RJ):

- A. Est une anomalie congénitale
- B. Elle ne s'observe pas dans les tissus conjonctifs
- C. C'est la transformation d'un tissu normal en un autre tissu normal, de structure et de fonctions différentes
- D. La conversion est d'origines embryonnaires différentes
- E. Elle est toujours pathologique

42 L'hyperplasie survient surtout dans (RF):

- A. L'épiderme
- B. L'épithélium intestinal
- C. L'épithélium respiratoire
- D. Le parenchyme hépatique
- E. Le myocarde

43 La matrice extracellulaire (MEC) est principalement composée de: RJ

- A. Cellules épithéliales
- B. Collagène, proteoglycanes et glycoprotéines
- C. Lipides et glucides
- D. ADN et ARN
- E. Lymphocytes et macrophages

44 L'atrophie tissulaire (RF):

- A. Elle signifie une réduction de la taille tissulaire
- B. Elle peut être due à l'atrophie cellulaire
- C. Elle peut être représentée par une diminution du nombre de cellules
- D. Elle s'accompagne d'une consommation maximale d'énergie
- E. Suite à l'atrophie tissulaire, il en résulte une réduction de la fonction

45 La coloration histochimique trichrome de Masson colore en vert ou en bleu: (RJ)

- A. Les mucines neutres.
- B. La mélanine
- C. L'hémosidérine
- D. Les fibres de collagène
- E. Les fibres de réticuline

46 À propos de l'examen extemporané, quelle affirmation est correcte ? (RJ)

- A. L'examen se fait après fixation du prélèvement tissulaire au formol tamponné neutre à 10%
- B. C'est un examen qui permet un diagnostic histologique définitif
- C. Le délai de rendre les résultats est de 6 à 8 heures
- D. C'est un examen rapide, réalisé au cours d'une intervention chirurgicale
- E. Il consiste à analyser uniquement des cellules isolées

CAS CLINIQUE (1)

Patiente âgée de 42 ans qui présente un goitre avec signes d'hyperthyroïdie. L'échographie met en évidence un goitre plongeant avec présence de nombreux nodules colloïdes. La patiente s'est faite opérée.

47. La pièce parvenue au service d'Anatomie et Cytologie Pathologiques doit être fixée dans (RJ):

- A. Le xylène
- B. Le formol à 10% tamponné à PH neutre
- C. L'alcool éthylique
- D. Le liquide de Bouin
- E. L'eau distillée

48. La durée de fixation de cette pièce opératoire est de (RJ)

- A. 4h
- B. 6h
- C. 10 h
- D. 18 h
- E. 24-72 h

49. A l'examen macroscopique, la glande thyroïde est augmentée de taille, il s'agit d'une (RJ):

- A. Dystrophie
- B. Aplasie
- C. Hypertrophie
- D. Métaplasie
- E. Hypoplasie

50. A l'examen microscopique, cette lésion tissulaire est liée à une: (RJ)

- A. Dystrophie
- B. Hyperplasie
- C. Hypertrophie
- D. Métaplasie
- E. Hypoplasie

CAS CLINIQUE (2)

Une patiente de 68 ans aux antécédents de polyarthrite rhumatoïde, consulte pour macroglossie de la langue et œdèmes des membres inférieurs, mous, prenant le godet. Le bilan biologique montre une insuffisance rénale sévère. Une ponction-biopsie rénale échoguidée est réalisée. L'examen histopathologique montre à la coloration HE des dépôts amorphes, éosinophiles, cellulaires dans les parois des capillaires glomérulaires et artériolaires.

51. L'aspect morphologique est fortement évocateur de (RJ)

- A. Une hyalinose
- B. Une fibrose
- C. Une élastose
- D. Une amylose
- E. Une nécrose

52. Quelle coloration histochimique permet le diagnostic ? R.J

- A. La coloration de Perls
- B. La coloration au rouge Congo
- C. La coloration à l'acide périodique de Schiff (PAS)
- D. La coloration de Ziehl-Neelsen
- E. La coloration au bleu de toluidine

53. En lumière polarisée, les dépôts amorphes éosinophiles présentent une biréfringence caractéristique de couleur: (RJ)

- A. Rouge-orange
- B. Bleu-violet
- C. Vert-Jaune
- D. Jaune-doré
- E. Aucune biréfringence

54. Parmi les sites de biopsie suivants, lequel est le plus sensible pour diagnostiquer une maladie systémique ? (RJ)

- A. Biopsie hépatique
- B. Biopsie rénale
- C. Biopsie cardiaque
- D. Biopsie des glandes salivaires accessoires (lèvre) ou biopsie rectale
- E. Biopsie pulmonaire transbronchique

55. Quelle est sa nature biochimique? (RJ)

- A. Lipidique
- B. Protéique
- C. Glucidique
- D. Fibrinoïde
- E. Glucoprotéique

56. La protéine précurseur secondaire à cette maladie inflammatoire chronique (polyarthrite rhumatoïde) est dans ce contexte: R.J

- A. Les chaînes légères d'immunoglobulines (kappa ou lambda)
- B. La transthyrétine (TTR)
- C. La protéine SAA (Serum Amyloid A)
- D. La 22-microglobuline
- E. L'apolipoprotéine AI

CAS CLINIQUE (3)

Après exposition prolongée aux rayons solaires chez un adulte jeune, il apparaît une rougeur et une chaleur cutanée avec sensation de brûlure au niveau des parties exposées de son corps.

57. Il s'agit de quel type d'inflammation? (RJ)

- A. Inflammation purulente
- B. Inflammation œdémateuse
- C. Inflammation congestive
- D. Inflammation fibrineuse
- E. Inflammation hémorragique

58. Dans ce type d'inflammation il y a prédominance de: RJ

- A. L'œdème inflammatoire
- B. L'exsudation cellulaire
- C. L'extravasation des hématies
- D. La congestion vasculaire par vasodilatation artériolo-capillaire
- E. Lésions vasculaires thrombosantes

59. L'évolution se fait le plus souvent vers: RJ

- A. Une résolution sans séquelles
- B. La formation d'un abcès
- C. Une réaction fibreuse
- D. Une nécrose tissulaire étendue
- E. La formation de fausses membranes

60. Ce type d'inflammation se rencontre aussi dans: RJ

- A. L'angine diphtérique
- B. Exanthème des maladies éruptives
- C. Purpura rhumatoïde
- D. Rejet aigu des greffes
- E. L'endocardite infectieuse

Examen Immunologie 3^{ème} année / 2026**1) L'immunofluorescence direct: Indiquer la ou les réponse(s) INEXACTE(S)**

- a) Consiste à déposer directement l'anticorps marqué sur la préparation antigénique étudiée.
- b) Possède une plus grande sensibilité que la méthode indirecte.
- c) Aide au diagnostic des déficits immunitaires congénitaux par le phénotypage des populations lymphocytaires.
- d) Détecte le dépôt des immunoglobulines et du complément dans une biopsie tissulaire.
- e) Représente la technique de choix dans le diagnostic immunologique de maladies auto-immunes.

2) L'immunofluorescence indirecte sur lignée cellulaire Hep2: Indiquer la ou les réponse(s) INEXACTE(S)

- a) Permet de dépister de nombreux auto-anticorps anti-nucléaire (ANA).
- b) C'est une technique quantitative qui permet le dosage des ANA.
- c) Représente la technique de choix dans le diagnostic immunologique de maladies auto-immunes non spécifiques d'organes.
- d) Se réalise en deux étapes pour la mise en évidence des auto-anticorps dans le sérum
- e) Permet le dépistage de plusieurs ANA utilisant plusieurs marqueurs fluorescents dans la même réaction.

3) La Technique ELISA (ENZYM-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY): Indiquer la ou les réponse(s) INEXACTE(S)

- a) Est sensible et adaptée à la réalisation des grandes séries de dosage.
- b) Est réalisée sur frottis cellulaire ou sur une coupe d'organe.
- c) Permet la détermination de la concentration par l'utilisation d'une courbe d'étalonnage.
- d) Utilise l'isothiocyanate de rhodamine comme substance de marquage.
- e) Révèle la réaction antigène-anticorps par la mesure de la densité optique.

4) Dans la technique de l'immunodiffusion double: Indiquer la ou les réponse(s) INEXACTE(S)

- a) L'antigène migre dans un gel d'agarose.
- b) L'anticorps suit le courant d'électroendosmose.
- c) La diffusion des réactants se fait de proche en proche et dans tous les sens.
- d) La ligne de précipitation se forme dans la zone d'équivalence entre les deux réservoirs.
- e) L'identité entre deux solutions antigéniques est analysée.

5) Dans l'immunodiffusion radiale (MANCINI): Indiquer la ou les réponse(s) INEXACTE(S)

- a) L'immunoprécipitation est proche des réservoirs de dépôt.
- b) Les résultats sont déduits à partir d'une courbe de calibration.
- c) La diffusion dans le gel est unidirectionnelle.
- d) La précipitation des complexes immuns est circulaire.
- e) On n'utilise pas de courant électrique.

6) Les techniques d'immunoprécipitation quantitatives sont: Indiquer la ou les réponse(s) EXACTE(S)

- a) La Néphélométrie et turbidimétrie laser.
- b) La technique du LAURELL.
- c) L'Immunodiffusion double en milieu gélifié (Ouchterlony).
- d) L'Electrosynérèse.
- e) L'Immunofixation.

7) L'immunoélectrophorèse: Indiquer la ou les réponse(s) INEXACTE(S)

- a) Est une technique d'immunoprécipitation en milieu gélifié.
- b) Est adaptée à l'analyse des al globulines qui suivent le courant d'électroendosmose.
- c) Est une technique comparative qui utilise un témoin qui est un sérum humain normal.
- d) Permet d'analyser les immunoglobulines sériques (IgG, IgA, IgM).
- e) Permet de doser la concentration d'une protéine dans un liquide biologique.

8) Le test au latex: Indiquer la ou les réponse(s) EXACTE(S)

- a) Consiste à mettre en présence le sérum à tester avec des GR de mouton.
- b) Est utilisé pour la détection des auto-anticorps de classe IgM dirigés contre le fragment Fc des IgG.
- c) Peut être utilisé dans le diagnostic des anémies hémolytiques auto-immunes.
- d) Permet la recherche des facteurs rhumatoïdes (FR)
- e) Est une technique basée sur l'utilisation du complément sérique.

9) Les tests suivants utilisent l'agglutination active: Indiquer la ou les réponse(s) EXACTE(S)

- a) La détermination du groupage sanguin
- b) Le test du Waaler & Rose.
- c) Le test de COOMBS indirect.
- d) La recherche de la C Reactive Protéine.
- e) La recherche d'anticorps anti IgG.

10) Dans les réactions d'agglutination: Indiquer la ou les réponse(s) EXACTE(S)

- a) L'antigène est particulaire.
- b) Les anticorps doivent être utilisés en excès de concentration pour former le réseau.
- c) La réaction positive se traduit par la présence d'une phase homogène.
- d) La réaction négative est visible à l'œil nu et se traduit par la formation d'agrégats.
- e) L'hémagglutination positive forme au fond d'une cupule, un tapis rouge.

11) Le profil protéique suivant est en faveur d'une réaction inflammatoire aigue: Indiquer la ou les réponse(s) EXACTE(S)

- a) Une augmentation de l'Orosomucoïde.
- b) Une augmentation des IgM seriques.
- c) Une augmentation de la fraction C3 du complément
- d) Une augmentation de l'Albumine.
- e) Un taux d'immunoglobulines normal.

12) Le profil protéique sérique suivant renseigne sur la présence, probable, d'une réaction inflammatoire associée à une hémolyse intra vasculaire: Indiquer la ou les réponse(s) EXACTE(S)

- a) L'Albumine et l'Haptoglobine sont de concentrations sériques augmentées.
- b) Une augmentation isolée de la concentration de la Transferrine.
- c) Une hyper gammaglobulinémie (IgG, IgA et IgM) polyclonales.
- d) Une augmentation de l'Orosomucoïde avec une Haptoglobine de concentration normale.
- e) Une diminution de la Transferrine avec une augmentation de l'Albumine.

13) Dans l'hypersensibilité de type 1: Indiquer la ou les réponse(s) EXACTE(S)

- a) La sensibilisation est souvent muette.
- b) L'inflammation induite est liée à la libération de l'histamine,
- c) Les tests cutanés explorent le terrain atopique.
- d) La dégranulation des mastocytes survient dans les 24h suivant le contact avec l'allergène.
- e) Les LT CD8+ cytotoxiques sont les principaux acteurs.

14) Les immunoglobulines E: Indiquer la ou les réponse(s) EXACTE(S)

- a) Sont produites suite à un 2^e contact avec l'allergène.
- b) Peuvent être détectées, au niveau sérique, par un test ELISA simple sandwich.
- c) Sont effondrée chez le sujet atopique,
- d) Sont la cible de la thérapeutique utilisée pour inhiber l'Histamine.
- e) Spécifiques d'allergènes systémiques exposent au risque de choc anaphylactique,

15) Le Prick test: Indiquer la ou les réponse(s) EXACTE(S)

- a) Permet de tester plusieurs allergènes.
- b) Consiste à piquer l'épiderme à travers une goutte de la solution allergénique
- c) Donne une réaction positive si le diamètre de l'érythème dépasse 15 mm à la 24 heure.
- d) Est pratiqué quel que soit la nature de l'allergène.
- e) Explore la mémoire immunologique cellulaire

16) L'identification de l'allergène en cause est basée sur: Indiquer la ou les réponse(s) INEXACTE(S)

- a) La numération et formule sanguine qui nous donne l'hyperéosinophilie.
- b) Le dosage des IgE sériques totales.
- c) La pratique des tests cutanés (Prick test).
- d) La recherche des IgE spécifiques.
- e) Le test de dégranulation des basophiles

17) Dans l'hypersensibilité de type II, le mécanisme est lié à la présence: Indiquer la ou les réponse(s) INEXACTE(S)

- a) Des anticorps de type IgG cytotoxiques
- b) Du complément
- c) Des cellules naturelles killers
- d) Des anticorps de type IgG non cytotoxiques
- e) Des macrophages

18) Dans l'hypersensibilité de type II, les pathologies les plus fréquentes: Indiquer la ou les réponse(s) INEXACTE(S)

- a) L'incompatibilité foeto-maternelle ABO
- b) La maladie hémolytique du nouveau-né
- c) L'incompatibilité foeto-maternelle Rhésus D
- d) L'incompatibilité transfusionnelle ABO
- e) Rejet de greffe hyper-aigu

19) Le test de COOMBS direct est: Indiquer la ou les réponse(s) INEXACTE(S)

- a) Basé sur l'utilisation d'un anticorps marqué par une enzyme.
- b) Effectué sur un échantillon de sang prélevé chez la mère.
- c) Utilisé pour rechercher les anticorps anti-Rhésus sur les hématies fœtales.
- d) Positif si l'anti-Ig (réactif de COOMBS) retrouve des anticorps sur les hématies testées.
- e) Couramment utilisé dans l'exploration des anémies hémolytiques.

20) L'hypersensibilité de type III est impliquée dans les pathologies suivantes: Indiquer la ou les réponse(s) EXACTE(S)

- a) L'alvéolite extrinsèque
- b) Le rejet aigu d'allogreffe.
- c) La maladie de GOOD PASTURE.
- d) L'anémie hémolytique auto-immune.
- e) La maladie des éleveurs d'oiseaux.

21) Un état d'hypersensibilité de type III généralisée est suspecté devant la présence: Indiquer la ou les réponse(s) EXACTE(S)

- a) De complexes immuns circulants.
- b) D'une augmentation du taux de l'activité hémolytique du complément (CH50).
- c) D'une diminution des concentrations sériques des immunoglobulines.
- d) D'une production importante d'IFN γ et d'IL4
- e) D'une infiltration des lésions par les lymphocytes TCD8

22) La réaction d'Arthus: Indiquer la ou les réponse(s) INEXACTE(S)

- a) Est caractérisée par une hyperproduction d'immunoglobulines spécifiques de l'allergène
- b) Se déclenche immédiatement après un deuxième contact avec l'allergène.
- c) Est due au dépôt des complexes immuns dans le site d'inoculation.
- d) Fait intervenir un faible taux d'anticorps de classe IgG.
- e) Est caractérisée par l'apparition de lésions nécrotiques et hémorragiques.

23) Les conditions suivantes favorisent le développement de la réaction d'HS de type III généralisée: Indiquer la ou les réponse(s) EXACTE(S)

- a) L'injection unique d'une forte dose d'un Ag hétérologue par la voie IV.
- b) La sensibilisation doit se faire inévitablement par la voie S/cutanée.
- c) L'injection de l'adjuvant complet de Freund (ACF) doit se faire par la voie intra musculaire.
- d) Les doses injectées sont répétées pendant plusieurs jours.
- e) L'injection d'une dose par semaine de l'Ag par la voie générale.

24) La réaction d'hypersensibilité de type IV se caractérise par:**Indiquer la ou les réponse(s) EXACTE(S)**

- a) Lin déclenchement rapide après un second contact avec l'allergène.
- b) Une production exagérée des IgG qui induisent la destruction de l'allergène par le MAC.
- c) Un infiltrat inflammatoire composé de LTHI et de macrophages.
- d) Une production d'IL-4, par les LT d'hypersensibilité retardée spécifiques de l'allergène.
- e) Une implication exclusive l'immunité à médiation cellulaire.

25) La dermatite de contact est déclenchée par des: Indiquer la ou les réponse(s) EXACTE(S)

- a) Haptènes lipophiles.
- b) Protéines de haut poids moléculaire.
- c) IgG.
- d) Dépôts de fractions de clivage du complément
- e) Des haptènes <1 kDa.

26) Les maladies auto-immunes qui impliquent un mécanisme du type IV comprennent:**Indiquer la ou les réponse(s) INEXACTE(S)**

- a) Le diabète de type 1.
- b) La thyroïdite de Hashimoto.
- c) La sclérose en plaques.
- d) Le lupus érythémateux systémique.
- e) La myasthénie.

27) La réaction tuberculinique: Indiquer la ou les réponse(s) EXACTE(S)

- a) Est déclenchée par l'introduction du bacille tuberculeux par voie sous cutanée
- b) Apparaît inévitablement chez les individus qui souffrent de déficit en lymphocytes T
- c) Consiste à inoculer la tuberculine additionnée de LTH spécifiques de la tuberculine.
- d) Est le signe d'une rencontre préalable avec le Bacille de KOCH.
- e) Est positive si le diamètre de l'induration est > 1.5 mm.

28) La réaction immunitaire innée anti virale: Indiquer la ou les réponse(s) EXACTE(S)

- a) Intervient si les cellules immunitaires ont développé une mémoire contre les virus.
- b) Implique les cellules lymphocytaires qui expriment des récepteurs spécifiques des virus.
- c) Se caractérise par la sécrétion de l'interféron alpha (IFN α).
- d) Permet l'élimination des virus par les Ac neutralisants.
- e) Génère des effecteurs cytotoxiques qui reconnaissent les peptides viraux associés aux CMH I

29) Lors d'une agression bactérienne: Indiquer la ou les réponse(s) INEXACTE(S)

- a) Le complément est activé par la voie alterne.
- b) Les PNN sont les premières cellules à migrer vers le site infecté.
- c) Les anticorps interviennent immédiatement après l'effraction des barrières anatomiques.
- d) Les macrophages interviennent tardivement recrutés par les cytokines TH1
- e) La réaction inflammatoire est impliquée dans le chimiotactisme et la migration transendothéliale des leucocytes.

30) Dans les maladies auto-immunes, le diagnostic nécessite: Indiquer la ou les réponse(s) INEXACTE(S)

- a) La recherche d'auto-Anticorps par une technique d'immunofluorescence.
- b) La recherche d'auto-Anticorps par une technique immuno-enzymatique.
- c) La recherche d'auto-Anticorps par une technique Dot.
- d) Le dosage du complément hémolytique (CH50).
- e) La recherche d'auto-Anticorps au niveau sérique et urinaire

31) Concernant le VIH: Indiquer la ou les réponse(s) EXACTE(S):

- a) La Reverse Transcriptase permet la pénétration du virus dans la cellule cible.
- b) La souche virale utilisant le corécepteur CXCR4 infecte les macrophages.
- c) Le provirus qui reste latent pour une durée variable peut être détecté par les CTL.
- d) L'effet cytopathogène du virus est responsable de la déplétion des LT CD4
- e) Le gène Env code pour la P24.

32) Les corécepteurs pour le VIH: Indiquer la ou les réponse(s) INEXACTE(S)

- a) Sont représentés par les récepteurs pour le TNF α -R et l'IL-1B-R (sur les macrophages).
- b) Sont représentés par le CXCR4 sur les LT CD4+ naïfs.
- c) Sont le CCR5 à la phase de primo infection et le CXCR4 dans les formes sévères.
- d) Jouent un rôle important dans la fixation du virus et la fusion des membranes virus-cellule cible.
- e) Permettent de distinguer le VIH 1 du VIH 2.

33) Le stade SIDA est caractérisé par: Indiquer la ou les réponse(s) INEXACTE(S)

- a) La présence de symptômes cliniques: sarcome de KAPOSI
- b) Une forte prolifération des LT CD8.
- c) Un nombre de LT CD4+ < 200 éléments/mm³
- d) Une augmentation de la charge virale.
- e) L'absence d'infections opportunistes.

34) Le diagnostic de l'infection par le VIH repose sur: Indiquer la ou les réponse(s) INEXACTE(S)

- a) La sérologie VIH (ELISA).
- b) La numération des LT CD-4
- c) La RT-PCR.
- d) Le Western Blot (HIV-1)
- e) Le dosage des IgG sériques.

35) Les signes suivants peuvent être révélateurs d'un myélome multiple:**Indiquer la ou les réponse(s) INEXACTE(S)**

- a) Atteinte rénale.
- b) Hypercortisolémie.
- c) Hypercalcémie
- d) Hypo-gammaglobulinémie.
- e) Syndrome de Raynaud.

36) La maladie de Waldenström: Indiquer la ou les réponse(s) INEXACTE(S)

- a) Est caractérisée par une prolifération plasmocytaire exprimant un BCR IgM.
- b) Peut être révélée par un syndrome hémorragique
- c) Est caractérisée par la présence d'une immunoglobuline de classe M monoclonale
- d) Le myélogramme montre une infiltration lympho-plasmocytaire. THO
- e) L'hyperviscosité sanguine est en rapport avec une forte concentration du composant monoclonal.

37) Concernant la transplantation: Indiquer la ou les réponse(s) INEXACTE(S)

- a) Le cross match consiste à faire agir le sérum du receveur sur des cellules du donneur en présence de complément.
- b) Le rejet hyper aigu est la conséquence de la présence d'allo Anticorps cytotoxiques et préformés chez le receveur, spécifiques des antigènes du donneur.
- c) Le dépôt du C4d spécifique au rejet aigu humoral est constamment retrouvé lors des biopsies exploratrices.
- d) La présence chez le receveur d'IgG préformés anti-HLA du donneur contre indique la transplantation.
- e) Allogreffe survient entre des individus génétiquement différents et issus d'une même espèce.

38) Le cross-match ou épreuve de compatibilité croisée par LCT: Indiquer la ou les réponse(s) INEXACTE(S)

- a) Consiste à mettre les sérums du receveur en présence des cellules du donneur
- b) Les cellules cibles sont les lymphocytes du sang périphérique du donneur vivant
- c) Les lymphocytes ganglionnaires ou spléniques dans le cas d'un donneur cadavérique.
- d) Est réalisé avec les lymphocytes totaux ou les lymphocytes T pour les anticorps anti-HLA de classe 1.
- e) Les cellules B et NK pour les anticorps anti HLA classe 11.

39) L'anti-CD25: Indiquer la ou les réponse(s) EXACTE(S)

- a) Est un allo anticorps qui prévient le rejet de greffe.
- b) Nécessite l'utilisation d'adjuvants.
- c) Est un hétéro anticorps: produit par l'immunisation d'une espèce différente de l'espèce humaine.
- d) Empêche la reconnaissance de l'allo antigène.
- e) Est un anticorps monoclonal qui exerce son action sur les LT et les LB activés.

40) Parmi les molécules immunosuppressives utilisées en pharmacologie:**Indiquer la ou les réponse(s) INEXACTE(S)**

- a) Ciclosporine
- b) Tacrolimus
- c) Paracétamol
- d) Mycophenolate Mofetil (MMF)
- e) Méthotrexate

Examen Cardiologie : Groupe 03 / 2026**Q1. La triade de Virchow décrit: (RJ)**

- A. Les mécanismes physiopathologiques de la thrombose.
- B. La nature du contenu impliqué dans la genèse de la thrombose.
- C. L'hypercoagulabilité comme facteur déclencheur de thrombose.
- D. La lésion pariétale comme un mécanisme associé de thrombose
- E. ACD sont justes.

Q2. Quel signe électrique est pathognomonique d'une péricardite: (RJ)

- A. La tachycardie sinusale.
- B. L'alternance électrique.
- C. Le sous décalage du segment PQ
- D. Le sus-décalage de ST diffus et concave vers le haut.
- E. Les critères de Holtzman.

Q3. L'HTA systolique isolée (RF)

- A. Est caractéristique de l'HTA du sujet âgé.
- B. En rapport avec une diminution de la compliance artérielle.
- C. Est souvent retrouvée chez le sujet jeune.
- D. Les inhibiteurs calciques sont une bonne alternative thérapeutique
- E. ABD sont justes

Q4. Quel est le principal paramètre de classification d'une insuffisance cardiaque à visée thérapeutique: (RJ)

- A. La classification de la NYHA.
- B. L'étiologie sous jacente.
- C. Le facteur précipitant.
- D. Par le degré de congestion.
- E. Par la fraction d'éjection.

Q5. La cause la plus fréquente d'ischémie myocardique organique est: (RJ)

- A- Athérome coronaire
- B- Anomalies congénitale des artères coronaires
- C- Artérite non athéromateuse
- D- Spasme coronaire.
- E- Etats de choc.

Q6. Un angor typique est défini comme: (RF)

- A- Gène constrictive de la poitrine.
- B- Irradie au cou, à l'épaule et au bras.
- C- Ne disparaît pas lors de la prise de dérivés nitrés.
- D- Favorisé par l'exercice.
- E- Disparaît lors du repos.

Q7. Un angor classe 3 CCS (Canadian Cardiovascular Society) survient: (RJ)

- A. Au repos
- B. Au moindre effort
- C. Suite à un effort important
- D. Pendant la nuit
- E. Lors d'émotions

Q8. Parmi ces molécules, laquelle ne fait pas partie du traitement des symptômes du syndrome coronaire chronique: (RJ)

- A. Bisoprolol
- B. Diltiazem
- C. Molsidomine
- D. Ramipril
- E. Vérapamil

Q9. Chez un patient de 35 ans sans contre-indication à l'anticoagulation, le choix de prothèse le plus approprié est:

- A. Prothèse biologique.
- B. Prothèse mécanique.
- C. Homogreffe.
- D. Valvuloplastie.
- E. Une implantation par cathétérisme.

Q10. Une ischémie myocardique fonctionnelle peut être due à : (RF)

- A. Inflammation des artères coronaires.
- B. Anémie.
- C. Hyperthyroïdie.
- D. Tachycardie ventriculaire.
- E. Bloc auriculo-ventriculaire.

Q11: L'œdème aigu du poumon d'origine hémodynamique (indiquer la ou les bonnes réponses):

- A. Traduit une insuffisance cardiaque droite sévère
- B. Peut compliquer un rétrécissement mitral serré
- C. Est dû à un bronchospasme
- D. Est toujours la conséquence d'une élévation de la pression capillaire pulmonaire
- E. Traduit une altération de la fonction cardiaque gauche

Q12. Quels sont les facteurs favorisant une poussée d'insuffisance cardiaque (indiquer la ou les bonnes réponses)

- A. Une infection broncho-pulmonaire
- B. Une intervention chirurgicale abdominale
- C. Une anémie
- D. Un écart de régime
- E. Un trouble du rythme

Q13. Quel est l'élément sémiologique qui permet d'affirmer l'origine cardiaque d'une hépatomégalie (RJ)

- A. Œdème des membres inférieurs
- B. Ascite
- C. Reflux hépato jugulaire
- D. Caractère douloureux
- E. Circulation collatérale

Q14: Une poussée d'insuffisance ventriculaire droite peut s'accompagner de: (indiquer la ou les bonnes réponses)

- A- Souffle d'insuffisance tricuspidienn
- B- Râles crépitants
- C- Œdèmes des membres inférieurs
- D- Râles sibilants
- E- Reflux hépato-jugulaire

Q 15: Un œdème aigu pulmonaire cardiogénique peut être traité par: (RJ)

- 1- Furosémide
- 2- Digoxine
- 3- Nitroglycérine
- 4 - Propanolol

Compléments corrects: A: 1,2,3 B. 1,3 C: 2,4 D: 1,4 E:1,2,3,4

Q 16: L'intervalle PR ou PQ: (indiquer la ou les bonnes réponses)

- A. Est théoriquement isoélectrique
- B. Correspond à la dépolarisation septale
- C. Débute à la fin de l'onde P
- D. Se termine à la fin de l'onde R
- E. N'est pas associé à la conduction auriculoventriculaire.

Q 17: Parmi les propositions concernant les troubles de conduction, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

- A. Un bloc auriculo-ventriculaire 1 (BAV 1) peut être responsable d'une syncope.
- B. Dans un BAV III, le rythme auriculaire et le rythme ventriculaire sont réguliers.
- C. Dans le BAV II type Mobitz II, l'espace PR s'allonge progressivement avant que l'onde P ne soit bloquée.
- D. La présence d'un bloc de branche gauche doit faire rechercher une cardiopathie sous-jacente
- E. Dans le BSA III, il y a plus d'ondes P bloquées que conduites

Q 18: un ECG montre des ondes P sinusales et régulières à 70/mn, un rythme ventriculaire régulier à 35/min, des complexes QRS à 0.14 sec et un aspect rSR' en V1, un espace PR constant à 0.18 sec. Il s'agit de (RJ)

- A. Un bloc sinoauriculaire II type II.
- B. Un bloc auriculo-ventriculaire II type 1.
- C. Un bloc auriculo-ventriculaire II type 2
- D. Un bloc auriculo-ventriculaire II type 2/1 et un BBD.
- E. Un bloc auriculo-ventriculaire III.

Q 19: Quelle (s) lésion (s) doit-on évoquer en 1er lieu devant l'apparition d'un BAV III au cours de l'évolution d'une endocardite infectieuse ? (RJ)

- A. Perforation d'une sigmoïde aortique.
- B. Perforation septale
- C. Abscess septal
- D. Embolie coronaire
- E. Rupture d'un cordage de la mitrale

Q 20: le diagnostic électrocardiographique de BAV III repose sur: (laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

- A. Dissociation auriculo-ventriculaire
- B. Rythme d'échappement inférieur à 30/min
- C. Rythme d'échappement régulier
- D. Nombre d'ondes P supérieur au nombre de QRS
- E. Nombre d'ondes P inférieur au nombre de QRS

Q21: Parmi ces bêtabloquants, lequel n'est pas prescrit en cas d'insuffisance cardiaque: (RJ)

- A. Bisoprolol
- B. Carvedilol
- C. Atenolol
- D. Metoprolol succinate.
- E. Nebivolol

Q22. Dans quelle classe se situe la flécaine dans la classification de Vaughan-Williams: (RJ)

- A. Classe I
 - B. Classe II
 - C. Classe III
 - D. Un test d'effort
 - E. Aucun examen si le patient est stable et asymptomatique
- E. Un taux de troponines.

Q 28: L'élévation du LDL-cholestérol au-dessus de 70 mg/dL (1,8 mmol/L) après angioplastie traduit: (RJ)

- A. Un objectif thérapeutique atteint
- B. Un risque faible de récurrence
- C. Une situation tolérable chez le sujet âgé
- D. Une indication à intensifier le traitement par statine
- E. Ne doit pas être prise en considération dans la prise en charge.

Q29: Chez un patient de 45 ans, opéré pour rétrécissement aortique serré, sans contre-indication à l'anticoagulation, quelle prothèse est la plus indiquée ? (RJ)

- A. Prothèse biologique, car moins thrombogène
- B. Prothèse mécanique, pour sa durabilité supérieure
- C. Homogreffe aortique, pour éviter l'anticoagulation
- D. Prothèse biologique, car mieux tolérée hémodynamiquement
- E. L'implantation d'un TAVI

Q 30: Les effets cardiaques des tonicardiaques sont: (RJ)

- A. Une vasodilatation systémique
- B. Une augmentation de la fréquence cardiaque
- C. Une augmentation de la contractilité myocardique
- D. Une accélération de la conduction auriculo-ventriculaire
- E. Une diminution de l'excitabilité.

Q31: La digoxine est contre-indiquée en cas de: (RJ)

- A. Bloc auriculo-ventriculaire complet non appareillé
- B. Fibrillation auriculaire chronique
- C. Insuffisance cardiaque systolique
- D. Flutter auriculaire
- E. Sujet âgé

Q 32: Quel paramètre biologique doit être surveillé régulièrement chez un patient traité par Digoxine? (RJ)

- A. Glycémie
- B Kaliémie
- C. Calcémie
- D. Urée seule
- E. Natrémie

Cas clinique 1: Mme A., 35 ans, sans antécédents notables, angines a répétitions a l'enfance, présente depuis plusieurs mois une dyspnée d'effort NYHA II à IIL À l'auscultation: un roulement diastolique à l'apex avec claquement d'ouverture mitral. L'échographie montre une surface mitrale à 1,2 cm², un gradient moyen à 10 mm Hg, et pas de thrombus intra-auriculaire gauche, le Diamètre Antéro-postérieur de l'OG est à 38mm, en rythme sinusal.

Q33: Sur le plan physiopathologique cette pathologie entraine principalement:

- A. Une augmentation de la pression dans l'oreillette gauche
- B. Une diminution du volume d'éjection systolique gauche
- C. Une hypertension pulmonaire passive
- D. Une surcharge volumique du ventricule gauche
- E. Les propositions A, B et C sont exactes

Q34: Quelle(s) proposition(s) thérapeutique(s) est/sont adaptée(s) à son cas ?

- A. Diurétiques et bêtabloquants pour contrôler les symptômes
- B. Anticoagulation orale systématique
- C. Dilatation mitrale percutanée par ballon en l'absence de contre indications
- D. Commissurotomie chirurgicale ouverte d'emblée
- E. Remplacement valvulaire mitral mécanique

Q35: Quel examen permet d'évaluer la possibilité de tenter une dilatation percutanée de la valve mitrale (RJ)

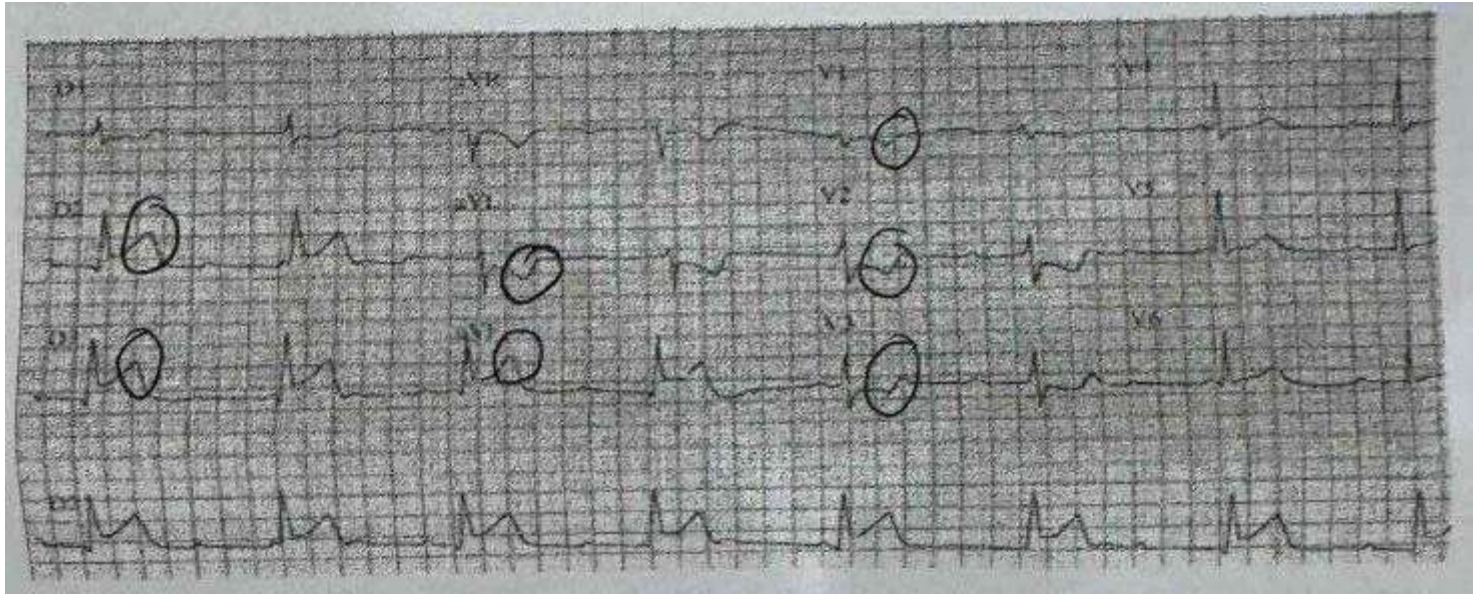
- A. Echocardiographie transthoracique
- B. ECG
- C. BNP
- D. Echocardiographie transoesophagienne
- E. La coronarographie

Q 36: Nous indiquons une Dilatation mitrale percutanée, quelle sera la principale contre indication à cette décision ?

- A. IM minime
- B. Surface mitrale 1,2 cm²
- C. Thrombus dans l'oreillette gauche
- D. Score de Wilkins à 6
- E. Symptômes NYHA III

Cas clinique 2:

Un patient de 52 ans qui consulte pour précordialgies évoluant depuis 3 heures.



Q37. Quelle est votre conclusion ECG devant ce tracé (Donnez la ou les réponses justes)

- A. SCA sans sus décalage du segment ST
- B. Images en miroir en Antéroseptal et latéral haut
- C. Onde de Pardee en inférieur
- D. SCA avec sus décalage du segment ST en inférieur
- E. BAV III ème degré.

Q38. Quelle est votre prise en charge (Donnez la ou les réponses justes)

- A. Revascularisation différée
- B. Revascularisation en urgence
- C. Stimulation temporaire
- D. Pace maker définitif
- E. Amiodarone en IVL

Q39: Quel est le traitement à la sortie de l'hôpital (Donnez la ou les réponses justes)

- A. Antiagrégants plaquettaires
- B. B-bloquants
- C. Dérivés nitrés
- D. Furosemide
- E. Statines

Q 40: Quelle est la complication à long terme de ce type de cardiopathie (RF)

- A. Insuffisance cardiaque
- B. Troubles du rythme ventriculaire graves
- C Endocardite infectieuse
- D. Récidive.
- E. La survenue d'autres évènements cardiovasculaires graves.

Examen Cardiologie : Groupe 04/ 2026**Q1. La triade de Durozier: (RJ)**

- A. Typique de la fuite mitrale.
- B. Claquement d'ouverture de la mitrale.
- C. Signe que la valve mitrale est très calcifié.
- D. Comporte un roulement diastolique.
- E. BD sont justes.

Q2. Quel signe électrique est évocateur d'une péricardite: (RF)

- A. La tachycardie sinusale.
- B. L'alternance électrique.
- C. Le sous décalage du segment PQ
- D. Le sus-décalage de ST diffus et concave vers le haut.
- E. Les images en miroir.

Q3. Les complications possibles d'une péricardite tuberculeuse (RF)

- A. La récidence.
- B. La tamponnade.
- C. La forme constrictive
- D. L'hypertension portale.
- E. La forme purulente.

Q4. Quel est le principal paramètre de classification d'une insuffisance cardiaque à visée thérapeutique: (RJ)

- A. La classification de la NYHA
- B. L'étiologie sous-jacente,
- C. Le facteur précipitant.
- D. Par le degré de congestion.
- E. Par la fraction d'éjection.

Q5. Un des éléments suivants doit faire suspecter un abcès septal dans l'endocardite: (RJ)

- A. Persistance de la fièvre.
- B. Persistance d'une hyper leucocytose A
- C. CRP élevée
- D. Une fuite aortique
- E. Un Bloc auriculo ventriculaire à l'ECG.

Q6. L'examen de première intention devant la suspicion de l'AOMI est: (RJ)

- A. Angio-IRM
- B. Echo doppler veineux des membres inférieurs
- C. IPS
- D. Artériographie
- E. Rigidité du pouls

Q7. La complication redoutée après revascularisation de l'ischémie aigüe des membres inférieurs est: (RJ)

- A. Hypoglycémies
- B. Hyperkaliémie
- C. Hypocalcémie
- D. Œdème pulmonaire isolé
- E. Hypokaliémie

Q8. Parmi ces molécules, laquelle ne fait pas partie du traitement des symptômes du syndrome coronaire chronique: (RJ)

- A. Diltiazem
- B. Molsidomine
- C. Ramipril
- D. Verapamil
- E. Les B-bloqueurs

Q9. Chez un patient de 85ans sans contre-indication à l'anticoagulation, le traitement est: (RJ)

- A. Prothèse biologique par voie chirurgicale.
- B. Prothèse mécanique par voie chirurgicale.
- C. Homogreffe
- D. Valvuloplastie.
- E. Une implantation par cathétérisme d'un TAVI

Q10. Une ischémie myocardique fonctionnelle peut être due à: (RF)

- A. Inflammation des artères coronaires.
- B. Anémie.
- C. Hyperthyroïdie
- D. Tachycardie ventriculaire.
- E. Bloc auriculo-ventriculaire.

Q11. Concernant les diurétiques de l'anse: (RJ)

- A. Ils diminuent la filtration glomérulaire au niveau du tube proximal.
- B. Induisent une alcalose métabolique en augmentant l'excrétion de bicarbonates
- C. Ils réduisent la calciurie.
- D. Inhibent le co transporteur $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$ au niveau de la branche ascendante de Henlé,
- E. Ils entraînent une hyperkaliémie.

Q12. Quels sont les facteurs favorisant une poussée d'insuffisance cardiaque (indiquer la ou les RJ)

- A. Une infection broncho-pulmonaire
- B. Une intervention chirurgicale abdominale
- C. Une anémie
- D. Un écart de régime
- E. Un trouble du rythme

Q13: Quel est l'élément sémiologique qui permet d'affirmer l'origine cardiaque d'une hépatomégalie (RJ)

- A. Œdème des membres inférieurs
- B. Ascite
- C. Reflux hépato jugulaire
- D. Caractère douloureux
- E. Circulation collatérale

Q14: Des diurétiques: (RJ)

- A. Les thiazidiques restent efficaces en cas d'insuffisance rénale sévère.
- B. Les thiazidiques provoquent une hyperkaliémie et une acidose métabolique.
- C. Les antialdostérones entraînent une alcalose métabolique et une hypokaliémie
- D. Les antialdostérones sont théoriquement contre indiqués en cas d'insuffisance rénale sévère.
- E. Les thiazidiques font partie du traitement de fond de l'insuffisance cardiaque.

Q15. Un œdème aigu pulmonaire cardiogénique peut être traité par : (RJ)

- 1- Furosemide
 - 2- Digoxine
 - 3- Nitroglycérine
 - 4- Oxygène en position semi assise
- Compléments corrects: A: 1,2,3 B:13 C: 2,4 D: 1,3,4 E: 1,2,3,4

Q 16. L'intervalle PR ou PQ: (RJ)

- A. Est théoriquement isoélectrique
- B. Correspond à la dépolarisation septale
- C. Débute à la fin de l'onde P
- D. Se termine à la fin de l'onde R
- E. N'est pas associé à une conduction auriculoventriculaire

Q17. Parmi les propositions concernant les troubles de conduction, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

- A. Un bloc auriculo-ventriculaire (BAV I) peut être responsable d'une syncope.
- B. Dans un BAV III le rythme auriculaire et le rythme ventriculaire sont réguliers
- C. Dans le BAV I type Mobitz II, l'espace PR s'allonge progressivement avant que l'onde P ne soit bloquée.
- D. La présence d'un bloc de branche gauche doit faire rechercher une cardiopathie sous-jacente
- E. Dans le BSA III y a plus d'ondes bloquées que conduites.

Q18. Quelles précaution à prendre en vue de dilater une sténose mitrale serrée (RJ)

- A. Echocardiographie Trans œsophagienne.
- B. Un ECG d'effort.
- C. Une IRM cardiaque.
- D. Un Doppler des membres inférieurs.
- E. Une coronarographie

Q19. Quelle est la conduite à tenir devant une tamponnade? (La ou les RJ)

- A. Rehydratation
- B. Chirurgie cardiaque en urgence
- C. Oxygénation nasale
- D. Ponction péricardique
- E. Remplissage par macromolécules

Q 20: le diagnostic électrocardiographique de BAV III repose sur: (laquelle (lesquelles) est (sont) vraie (s))

- A. Dissociation auriculo-ventriculaire
- B. Rythme d'échappement à QRS larges
- C. Rythme d'échappement irrégulier
- D. Nombre d'ondes P supérieur au nombre de QR) si rythme de base sinusal.
- E. Nombre d'ondes P inférieur au nombre de ORS

Q21: Parmi ces bêtabloquants, lequel n'est pas prescrit en cas d'insuffisance cardiaque) (RJ)

- A. Bisoprolol
- B. Carvedilol
- C. Sotalol.
- D. Nebivolol
- E. Métoprolol

Q22. Dans quelle classe se situe les ISGLT2: (RJ)

- A. Antidiabétiques
- B. Diurétiques agissant sur les canaux glucosodiques du tube contourné proximal
- C. Epargneurs de potassium
- D. Traitement de fond de l'insuffisance cardiaque à FE réduite seule.
- E. AB justes

Q23. En cas de fibrillation atriale associée à une cardiopathie ischémique, tous ces traitements anti-arythmiques peuvent être envisagés sauf un:

- A. Amiodarone
- B. Bisoprolol
- C. Diltiazem
- D. Sotalol
- E. Flécaine

Q24. Quels sont les signes d'une ischémie aigue ? (RF)

- A. Douleur
- B. pâleur
- C. abolition des pouls en extrémité du membre
- D. Dyspnée
- E. Troubles sensitifs

Q25. La cardiomyopathie hypertrophique: (RF)

- A. Peut entraîner une obstruction à l'éjection VG
- B. Nécessite sa mise sous B bloquants si obstructive
- C. Est parfois secondaire à une HTA
- D. Peut entraîner une Insuffisance cardiaque
- E. A un caractère familial

Q26. La gravité d'une embolie pulmonaire est reflétée par (cochez la ou les bonne réponse):

- A. Le terrain fragile sous-jacent
- B. La saturation en oxygène
- C. Le dosage des troponines et des peptides natriurétique
- D. L'atteinte du ventricule gauche.
- E. La dysfonction du ventricule droit à l'échocardiographie.

Q27. Quelles sont les complications de la thrombolyse: (RJ)

- A. l'échec
- B. Complications thromboembolique
- C. L'hypertension artérielle
- D. Des complications métaboliques
- E. Saignements graves.

Q 28: L'élévation du LDL-cholestérol au-dessus de 55mg/dL (1,8 mmol/L) après angioplastie pour infarctus du myocarde traduit: (RJ)

- A. Un objectif thérapeutique atteint
- B. Un risque faible de récurrence
- C. Une situation tolérable chez le sujet âgé
- D. Une indication intensifiée le traitement par statine
- E. Ne doit pas être prise en considération dans la prise en charge.

Q29: Chez un patient de 45 ans opéré pour rétrécissement (aortique serré, sans contre-indication à l'anticoagulation, quelle prothèse est la plus indiquée ? (RJ)

- A. Prothèse biologique, car moins thrombogène
- B. Prothèse mécanique, pour sa durabilité supérieure
- C. Homogreffe aortique, pour éviter l'anticoagulation
- D. Prothèse biologique, car mieux tolérée hémodynamiquement
- E. L'implantation d'un TAVI

Q 30. Les signes électriques d'une embolie pulmonaire: (RF)

- A. Troubles du rythme supra ventriculaire
- B. Sous décalage du PQ
- C. Bloc de branche droit
- D. Aspect S1Q3
- E. Des ondes T négatives en v1v2v3

Q 31: La dissection de l'aorte: (RF)

- A. L'échocardiographie transoesopahgienne est une des meilleures méthodes diagnostiques
- B. Le scanner cardiaque peut faire le diagnostic
- C. Le voile intimal divise la lumière en vrai et faux chenal
- D. Est toujours de sanction chirurgicale même après passage à la chronicité
- E. La gestion de la Pression artérielle est primordiale

Cas clinique 1:

Mme A, 35 ans, sans antécédents notables, angines à répétitions à l'enfance, présente depuis (plusieurs mois une dyspnée d'effort NYHA II à III. A l'auscultation: un souffle systolique à l'apex avec éclat du B2 pulmonaire et un rythme irrégulier. L'échographie montre une valve mitrale très remaniée, un ventricule gauche dilaté avec une FE préservée.

Q32: Sur le plan physiopathologique cette pathologie entraîne principalement (RJ)

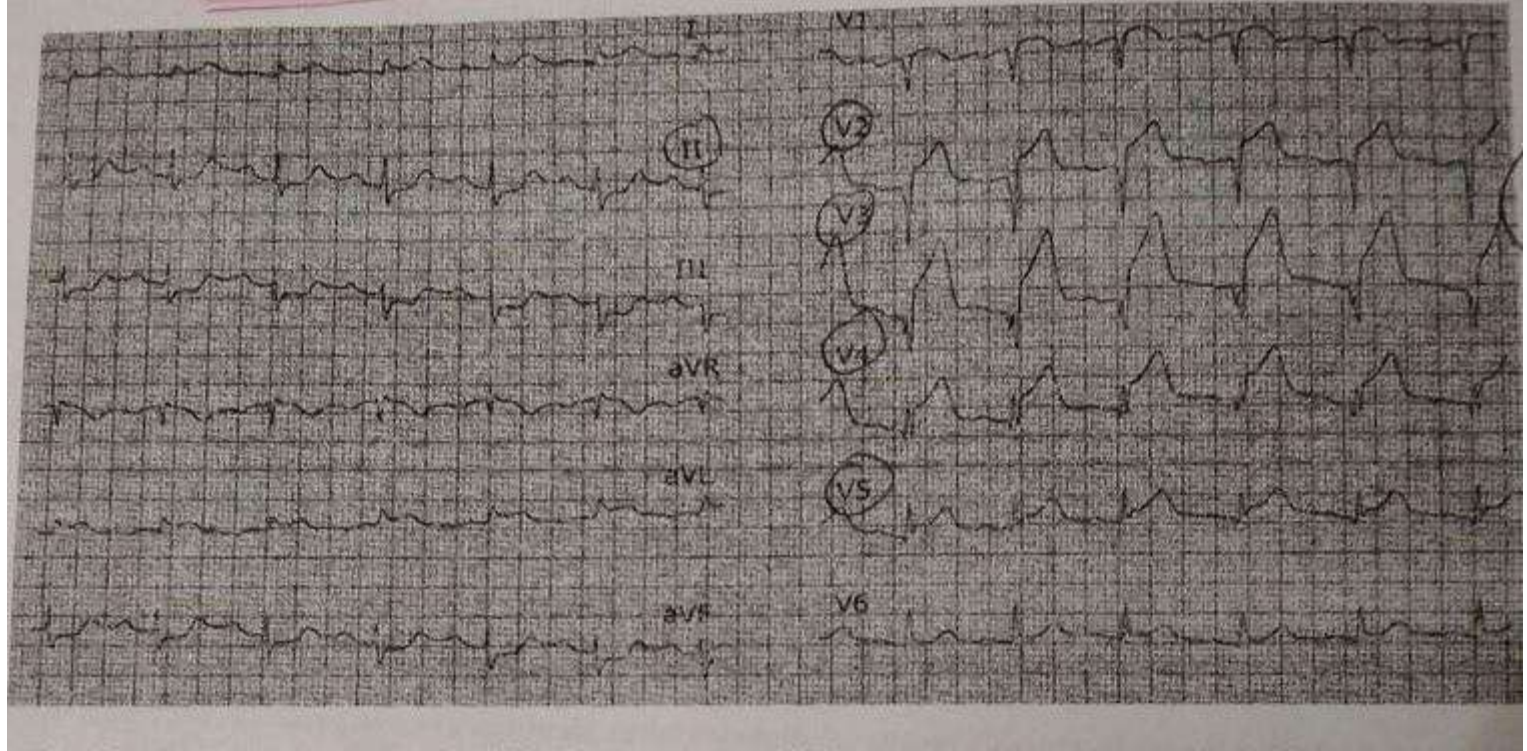
- A. Une adaptation du VG à l'augmentation du volume régurgitant
- B. Une augmentation du volume d'éjection systolique gauche
- C. Une hypertension pulmonaire passive
- D. Une surcharge volumique du ventricule gauche
- E. Les propositions A, C, D sont exactes

Q33: Quelle(s) proposition(s) thérapeutique(s) est/sont adaptée(s) à son cas? (RJ)

- A. Pas de traitement médical
- B. Un mitra clip.
- C. Dilatation mitrale percutanée par ballon en l'absence de contre indications
- D. Commissurotomie chirurgicale ouverte d'emblée
- E. Prise en charge chirurgicale.

Cas clinique 2:

Femme âgée de 68 ans consulte aux urgences médicales pour douleur thoracique constrictive du repos remontant à 14 H. Connue pour diabète et asthme sévère. L'examen clinique retrouve une patiente orthopnéique, SpO2: 89% à l'air libre, TA : 130/80 mm Hg, Auscultation cardiaque normale, Auscultation pulmonaire râles crépitants à mi champs pulmonaire



Q34. Quelle est votre conclusion ECG devant ce tracé (Donnez la ou les réponses justes)

- A. SCA sans sus décalage du segment ST
- B. Images en miroir en inférieur
- C. Onde de T déviation en antérieur
- D. Q de nécrose en Antéro-septal
- E. Fibrillation atriale

Q35. Quelle est votre prise en charge (Donnez la ou les réponses justes)

- A. Pas de revascularisation immédiate car délais dépassés.
- B. Revascularisation en urgence par angioplastie car douleurs persistantes.
- C. Stimulation temporaire.
- D. Défibrillation.
- E. Prise en charge de l'OAP.

Q36. Comment prendre en charge le patient: (Donnez la ou les réponses justes)

- A. B bloquants d'emblée.
- B. Diurétiques par voie veineuse
- C. Position demi assise et oxygénothérapie
- D. Dérivés nitrés
- E. Traitements antiagrégants.

Q37: Quel est le traitement à la sortie de l'hôpital (Donnez la ou les réponses justes)

- A. Antiagrégants plaquettaires
- B. Diurétiques
- C. IEC
- D. ISGLT2
- E. Statines

Q38. Pourquoi les Béta Bloquants sont contre indiqués chez la patiente (RJ)

- A. Asthme sévère.
- B. Insuffisance cardiaque
- C. Risque de bradycardie
- D. Risque d'hypotension
- E. Risqué d'ischémie aigue du membre

Q39. Quelle est la complication à long terme de ce type de cardiopathie (RF)

- A. Insuffisance cardiaque
- B. Troubles du rythme ventriculaire graves
- C. Endocardite infectieuse
- D. Récidive.
- E. La survenue d'autres évènements cardiovasculaires graves.

Q40. Quels sont les facteurs de risque cardiovasculaires identifiés chez la patiente: (la ou les RJ)

- A. Le tabagisme
- B. Le sexe
- C. Le diabète
- D. L'âge
- E. L'asthme

Examen Cardiologie : Groupe 05 / 2026**Question 1. Concernant l'hypertension artérielle (HTA) secondaire (RF)**

- A. Représente plus de 50% des HTA chez l'adulte
- B. Concerne environ 5 à 10% des HTA chez l'adulte
- C. Fréquente chez le sujet jeune
- D. Suspectée devant une hypertension résistante
- E. Nécessite une prise en charge spécialisée

Question 2. Toutes les causes suivantes peuvent être responsables d'HTA secondaire, sauf une: (RJ)

- A Néphropathies parenchymateuses
- B. Hyperaldostérionisme primaire
- C. Intoxication à la réglisse
- D. Insuffisance veineuse chronique
- E. Sténose de l'artère rénale

Question 3. Mr H.R, âgé de 52 ans, non diabétique, non-fumeur. Pression artérielle en consultation 135/85 mmHg. bilan biologique normal, SCORE cardiovasculaire faible.**Concernant ce patient, (RF)**

- A. Il s'agit d'une hypertension artérielle
- B. Il s'agit d'une PA élevée
- C. Une MAPA ou une automesure est indiquée pour confirmer le diagnostic
- D. Un traitement médicamenteux n'est pas indiqué d'emblée
- E. La prise en charge repose en première intention sur des mesures hygiéno-diététiques

Question 4. La triade «céphalées-sueurs-palpitations associée à une HTA est en faveur de (RJ):

- A. Coarctation de l'aorte
- B. Adénome de Conn
- C. Phéochromocytome
- D. Sténose des artères rénales
- E. Aucune de ces propositions

Question 5. Dans l'hypertension artérielle secondaire, le traitement étiologique est médical dans (RJ):

- A. Coarctation de l'aorte
- B. Adénome de Conn
- C. Phéochromocytome
- D. Sténose des artères rénales
- E. Hyperplasie des surrénales

Question 6. Hypotension artérielle orthostatique est définie (RF)

1. Est définie par une chute d'au moins 20 mmHg de la pression systolique lors du passage couché debout
 2. Est définie par une chute d'au moins 20 mmHg de la pression diastolique lors du passage couché debout
 3. Doit systématiquement être recherchée chez le sujet diabétique
 4. Doit systématiquement être recherchée chez le sujets Âgés sous traitement antihypertenseur
- A. 1.3.4 B. 2.3,4 C. 1.2.4 D. 1.2.3 E. 1.3

Question 7. Dans l'hypertension artérielle, l'ECG peut montrer (RF)

- A. Fibrillation auriculaire
B. Hypertrophie ventriculaire gauche de type systolique
C. Signes de cardiopathie ischémique D. Hypertrophie auriculaire gauche
E. Hypertrophie ventriculaire gauche de type diastolique

Question 8. Hypertension artérielle blouse blanche (RJ)

- A. PA élevée en consultation et normale à domicile
B. PA normale en consultation et élevée à domicile
C. PA élevée en consultation et à domicile
D. Fréquence 50%
E. Aucune de ces propositions

Question 9. Dans l'hypertension artérielle, toutes ces classes thérapeutiques entraînent une réduction de la morbi-mortalité cardiovasculaire sauf une. Laquelle?

- A. Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC)
B. Inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine II (ARA II)
C. Bêtabloquants
D. Diurétiques thiazidiques
E. Antihypertenseurs centraux

Question 10. Dans l'hypertension artérielle, toutes ces associations sont synergiques sauf une. Laquelle ?

- A IEC-inhibiteurs calciques
B. ARA II inhibiteurs calciques
C. IEC ARA II
D. Bêtabloquants + diurétiques
E ARA II-diurétiques thiazidique

Q11. La triade de Durozier: (RJ)

- A. Typique de la fuite mitrale.
B. Claquement d'ouverture de la mitrale.
C. Signe que la valve mitrale est très calcifié
D. Comporte un roulement diastolique.
E. BD sont justes.

Q12. Toutes ces propositions concernant le syndrome coronarien sans sus décalage de ST sont justes sauf une, laquelle:

- A. Survient sur des plaques d'athéromes pas forcément serrées
- B. Peut se manifester par une ischémie sous épocardique
- C. L'insuffisance rénale évoque le haut risque
- D. La thrombolyse n'est pas indiquée
- E. Les statines à fortes doses sont indiquées si dyslipidémie

Q13. Toutes ces propositions concernant le syndrome coronarien avec sus décalage de ST sont justes sauf une, laquelle

- A. La thrombolyse est préférée si l'angioplastie primaire n'est pas réalisable dans les deux heures
- B. L'angioplastie primaire est préférée si réalisée moins d'une heure
- C. L'angioplastie de sauvetage est préférée si la thrombolyse a échoué
- D. L'angioplastie de routine est préférable avant 24 heures
- E. L'angioplastie facilitée est préférable à la thrombolyse si contre indiquée

Q14. Les accidents cardiovasculaires (RF)

- A. Sont la première cause de mortalité après les cancers
- B. Sont la conséquence de l'athérothrombose
- C. Ont provoqué une transition épidémiologique en Algérie depuis les années 1990
- D. L'augmentation de l'espérance de vie pourrait expliquer l'augmentation de leur incidence
- E. La prévention secondaire demeure la pierre angulaire pour diminuer leur incidence

Q15. Quel signe électrique est évocateur d'une péricardite: (RF)

- A. La tachycardie sinusale.
- B. L'alternance électrique.
- C. Le sous décalage du segment PQ
- D. Le sus-décalage de ST diffus et concave vers le haut.
- E. Les images en miroir.

Q16. La complication redoutée après revascularisation de l'ischémie aigüe des membres inférieurs est: (RJ)

- A. Hypoglycémie
- B. Hyperkaliémie
- C. Hypocalcémie
- D. Œdème pulmonaire isolé
- E. Hyperkaliémie

Q17. Chez un patient de 60 ans avec contre-indication à l'anticoagulation avec sténose aortique serrée, le traitement est: (RJ)

- A. Prothèse biologique par voie chirurgicale.
- B. Prothèse mécanique par voie chirurgicale
- C. Homogreffe
- D. Valvuloplastie
- E. Une implantation par cathétérisme d'un TAVI

Q18. Le BAV Mobitz I (cochez la réponse juste):

- A. Est défini par un PR constant avec blocage inopiné de l'onde P
- B. Est fréquent au cours du STEMI antérieur
- C. Est souvent Bénin.
- D. Nécessite toujours l'implantation d'un pacemaker.
- E. Évolue toujours vers le BAV complet

Q 19. Concernant le bloc de branche (cochez la réponse juste),

- A. Il est dit complet si la durée du QRS dépasse 120 ms.
- B. Le bloc de branche droit est plus bénin que le bloc de branche gauche
- C. Un bloc incomplet s'inscrit avec un QRS d'une durée 80 à 110 ms.
- D. Le bloc de branche droit peut être associé à une pathologie pulmonaire.
- E. Toutes les réponses sont justes

20. Concernant le BBG complet (Coches la réponse juste)

- A. S'inscrit avec un aspect Q5 sur les dérivations précordiales antérieures (V1-V3).
- B. S'inscrit avec un aspect RS sur les dérivations précordiales latérale V5-V6
- C. Nécessite toujours une implantation de pacemaker.
- D. Nécessite l'administration de l'Isuprel en urgence.
- E. Le QRS est 120 ms.

21. Concernant le bloc auriculo ventriculaire (cocher la réponse juste);

- A. Il est toujours symptomatique
- B. touche exclusivement les sujets âgés
- C. Peut-être causé par certains médicaments comme les bêtabloquants
- D. Nécessitent toujours une implantation de FM.
- E. Toutes les réponses sont fausses.

Q 22. Quelle est la molécule de choix dans la PEC aigue d'un BAV complet secondaire à un SCA STEMI inférieur (cocher la réponse juste):

- A. ISUPREL
- B. ADRENALINE
- C. NORADRENALINE
- D. ATROPINE
- E. SALBUTAMOL

Q 23. Quelles sont parmi ces réponses des causes de BAV complet:

- 1. Iatrogène (médicamenteuse)
- 2. Ischémique
- 3. Métabolique (hyperK Acidose)
- 4. Dégénératif
- 5. Endocardite infectieuse

A: 1,2,3. B: 4,5, C: 1,2,3,5, D: 1,2,3,4,5, E: 2,4,5

Q 24. De quels degrés sont les BAV, qui ne nécessitent pas une implantation de Pacemaker?

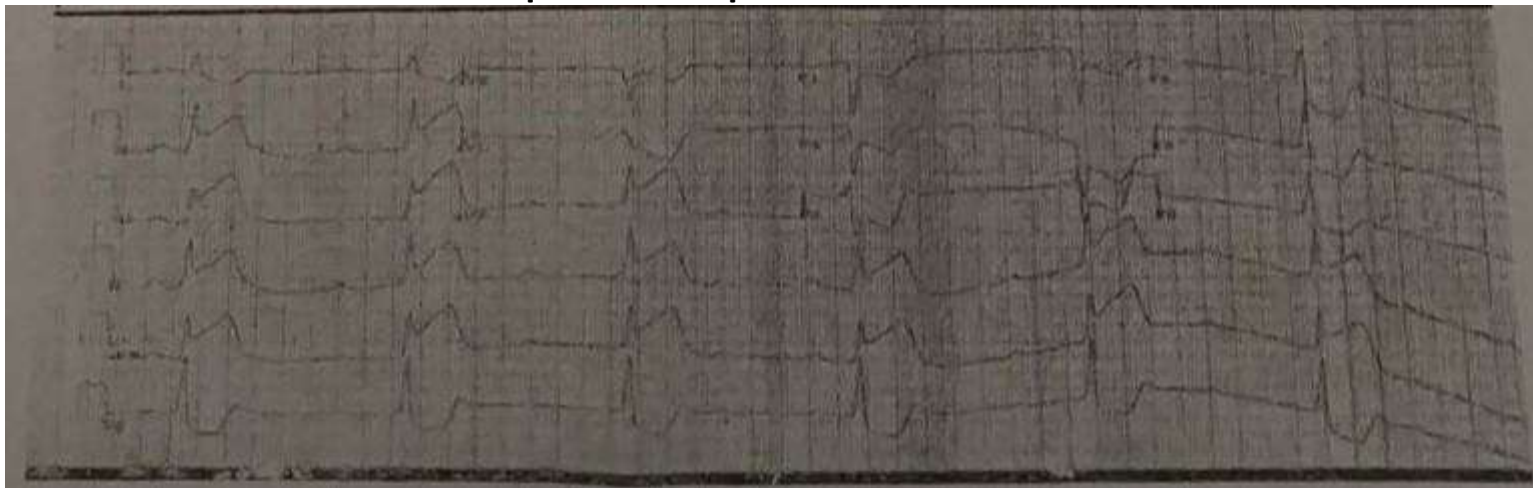
1. BAV 1er degré
 2. BAV 2eme degré MOBITZ I
 3. BAV 2 me degré Mobitz II
 4. BAV complet
 5. BAV transitoire dans l'IDM inférieur
- A. 1,3 B 1,5 C. 1,2,3,5 D. 2,3 E. 1,3,5

Q 28. Quelle est le molécule de choix pour la PEC initiale d'un BAV complet fréquence cardiaque 30 bpm, d'origine dégénérative

- A. Atropine
- B. ISUPREL
- C. B2mimétiques
- D. Salbutamol
- E. Tonicardiaques

Vous recevez aux urgences une femme âgée de 65 ans, diabétique depuis 20 ans sous insuline, qui s'est présentée suite à une syncope à l'emporte pièce, il y a 1h.

Actuellement elle se plaint de douleur thoracique constrictive. L'examen clinique retrouve une patiente consciente coopérante, TA 110/70 mmHg. Fréquence cardiaque 35 bpm, SPO2: 95%. Le reste de l'examen clinique est sans particularisés



Q26: Quelles sont les mesures initiales à administrer chez cette patiente: (choisissez une seule association)

- A. Monitoring non invasif
 - B. Oxygénothérapie
 - C. Isuprel afin d'accélérer le rythme cardiaque
 - D. Atropine afin d'accélérer le rythme cardiaque
 - E. Doses de charge par Aspirine et inhibiteur du P2Y12
- A (A-C) B (B-D-E) C (B-C-E) D (A-D-E) E (C-E)

Q27. Quels sont les armes thérapeutiques possibles chez cette patiente (cochez la réponse fausse);

- A- Pacemaker en urgence.
- B- Revascularisation par thrombolyse.
- C- Revascularisation par angioplastie primaire
- D- Atropine
- E- Sonde de stimulation externe

Homme de 72 ans, dyspnée NYHA III, orthopnée, œdème. TA 115/70, FC 88 bpm, créatininémie normale, K+ normal. Echo: FEVG 30%, pas de rétrécissement antique serré. Après décongestion (amélioration clinique),

Q28. Quelle stratégie thérapeutique est la plus adaptée pour améliorer le pronostic (mortalité / hospitalisation), une réponse juste ?

- A. Diurétique de l'anse Digoxine en première intention
- B. IEC bêtabloquant diurétique uniquement (les autres classes au cas par cas)
- C. Mise en route précoce des "4 piliers" (IEC/ARNI-bêtabloquant + ARMISGLT2), avec diurétique ajusté aux symptômes
- D. Ivabradine d'emblée (car FC > 80 BPM) avant tout le reste
- E. Nitrés au long cours pour soulager la dyspnée

Q29: Quels B bloquants sont contre-indiqués dans ce syndrome:

- A. Propranolol
- B. Métoprolol
- C. Bisoprolol
- D. Acébutolol
- E. Carvedilol

Q30. Concernant le diagnostic et la prise en charge initiale d'une suspicion d'insuffisance cardiaque, quelles propositions sont vraies?

- 1- Un BNP/NT-proBNP normal rend l'insuffisance cardiaque peu probable
- 2- L'échocardiographie est l'examen clé pour confirmer l'IC et préciser le mécanisme (FEVG, valves...).
- 3- Les diurétiques de l'anse, utilisés seuls, réduisent la mortalité,
- 4- L'oxygène doit être donné systématiquement même si la saturation est normale
- 5- Une cause déclenchante doit être recherchée (ischémie, infection, FA rapide, iatrogénie...).

A (1,2,5) B (1,2,3) C (2,3,5) D. (1,4,5) E. (1. 2, 4)

Q31. Concernant la cardiomyopathie hypertrophique (CMH), quelle proposition est la plus exacte?

- A. La CMH est toujours secondaire à une HTA chronique
- B. Le souffle systolique augmente typiquement lors de la manœuvre de Valsalva (ou à l'effort)
- C. Le traitement de première intention du gradient obstructif est le furosémide
- D. L'ECG est habituellement normal.
- E. Les dérivés nitrés sont indiqués dans la CMH obstructive pour traiter les douleurs thoraciques

Q32. Chez un patient avec cardiomyopathie hypertrophique (CMH), quel élément fait craindre un risque élevé de mort subite? (une réponse juste)

- A- Antécédent d'arrêt cardiaque récupéré ou tachycardie ventriculaire soutenue
- B- Syncope inexpliquée
- C- Tachycardies ventriculaires non soutenues (TVNS) au Holter ECG
- D- Antécédent familial de mort subite (surtout jeune)
- E- Toutes les réponses sont justes

Q33. Concernant la dysplasie/cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit (CAVD), quelles propositions sont

- 1- Peut donner des palpitations et des syncopes par tachycardie ventriculaire
- 2- A l'ECG, se caractérise par la présence d'une onde Epsilon
- 3- La tachycardie ventriculaire est l'arythmie redoutée
- 4- Le sport intensif est conseillé car il protège le cœur
- 5- Il faut souvent limiter les sports intenses/compétitifs

A. (1,2,3,5) B. (1,3,4) C. (2,4,5) D. (1,4,5) E. (3,4,5)

Q 34: Concernant les diurétiques de l'anse: (RJ)

- A. Ils diminuent la filtration glomérulaire au niveau du tube proximal.
- B. Induisent une alcalose métabolique en augmentant l'excrétion de bicarbonates.
- C. Ils réduisent la calciurie
- D. Inhibent le cotransporteur $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$ au niveau de la branche ascendante de Henlé.
- E. Ils entraînent une hyperkaliémie.

Q35: Quels sont les facteurs favorisant une poussée d'insuffisance cardiaque (indiquer la ou les RJ)

- A. Une infection broncho-pulmonaire
- B. Une intervention chirurgicale abdominale
- C. Une anémie
- D. Un écart de régime
- E. Un trouble du rythme

Q36: Quelle est la conduite à tenir devant une tamponnade? (la ou les RJ)

- A. Réhydratation
- B. Chirurgie cardiaque en urgence
- C. Oxygénation nasale
- D. Ponction péricardique
- E. Remplissage par macromolécules

Q37. Dans quelle classe se situe les ISGLT2: (RJ)

- A. Antidiabétiques
- B. Diurétiques agissant sur les canaux glucosodiques du tube contourné proximal
- C. Epargneurs de potassium
- D. Traitement de fond de l'insuffisance cardiaque à FE réduite seule.
- E. AB justes

Q 38. La cardiomyopathie hypertrophique: (RF)

- A. Peut entraîner une obstruction à l'éjection VG.
- B. Nécessite sa mise sous B bloquants si obstructive
- C. N'a aucune relation avec l'HTA
- D. Peut entraîner une Insuffisance cardiaque
- E. A toujours un caractère familial

Q 39. la gravité d'une embolie pulmonaire est reflétée par (cochez la ou les bonne réponse):

- A. Les D dimères
- B. La saturation en oxygène
- C. Le dosage des troponines et des peptides natriurétique
- D. Le Score PESI.
- E. La dysfonction du ventricule droit à l'échocardiographie.

Q40: Les signes électriques d'une embolie pulmonaire: (RF)

- A. Troubles du rythme supra ventriculaire
- B. Sous décalage du PQ
- C. Bloc de branche droit
- D. Aspect S1Q3
- E. Des ondes T négatives en v1v2v3

Examen Hématologie : Rotation 01/ 2026**1. Les groupes sanguins érythrocytaires:**

- A. Sont définis par des anticorps présents sur la membrane érythrocytaire
- B. des molécules transmises génétiquement selon la loi de Mendel
- C. Sont des molécules acquises lors d'une immunisation fœto-maternelle
- D. Ont un intérêt uniquement lors des transfusions sanguines
- E. Sont définis par des antigènes acquis après une infection bactérienne

2. Quelle est l'affirmation concernant le concentré érythrocytaire :

- A. Contient des hématies de plusieurs donneurs de même phénotype
- B. Se conserve pendant environ 40 jours en chambre froide 4°C.
- c. Doit toujours être transfusé en association avec le plasma frais congelé
- D. A+B
- E B+C

3. Le site principal de l'hémolyse extravasculaire est:

- A. Le foie
- B. Le rein
- C. La rate
- D. La moelle osseuse
- E. Le cœur

4. Les manifestations hémorragiques suivantes sont d'observation courante dans l'hémophilie, sauf une laquelle

- A- Hémarthrose du genou
- B- Ecchymoses spontanées
- C- Purpura pétéchial spontané généralisé
- D- Hématome du psoas
- E- Hémorragie prolongé après morsure de la langue

5. Parmi les propositions suivantes concernant la Leucémie Lymphoïde Chronique, quelles sont les réponses exactes ?

- 1) Elle peut s'accompagner d'une anémie hémolytique autoimmune
- 2) L'immunophénotypage permet d'établir le score de Matutes
- 3) L'immunophénotypage permet d'établir le score de Sokal
- 4) Le frottis montre des ombres de Gumprecht
- 5) Son diagnostic repose sur la ponction de moelle
- A- 1+3+4 B-1+2+4 C-1+3+5 D-2+4+5 E-1+4+5

6. Une thrombopénie est observée au cours de:

- 1- La leucémie aigue
- 2- La leucémie lymphoïde chronique stade A
- 3- L'aplasie médullaire
- 4- La leucémie myéloïde chronique en phase chronique
- 5- L'hypersplénisme
- A- 3+4+5 B-1+4+5 C-2+3+4 D-2+4+5 E-1+3+5

7. Parmi les propositions suivantes, précisez laquelle (ou lesquelles) s'accompagnent d'un allongement à la fois du temps de Céphaline Activé (TCA) et du temps de Quick (TQ):

- 1- Déficit en vitamine K
 - 2- Déficit en facteur V
 - 3- Un auto anticorps anti facteur VIII
 - 4- Une insuffisance hépato cellulaire
 - 5- Déficit en facteur XIII
- A-1+3+4 B-2+4+5 C-1+3+5 D-2+3+5 E-1+2+4

8. Quel est le principal rôle du facteur Von Willebrand ?

- A. Activer la voie extrinsèque
- B. Stabiliser le facteur VIII et favoriser l'adhésion plaquettaire
- C. Activer la fibrinolyse
- D. Inhiber la thrombine
- E. Activer la voie intrinsèque

9. Quelle est la fonction principale de la thrombine ?

- A. Transformer la fibrine en fibrinogène
- B. Activer le facteur X
- C. Activer la plasmine
- D. Activer les plaquettes
- E. Transformer le fibrinogène en fibrine

10. Quelle (s) est (sont) parmi ces maladies celle (s) qui est (s) en rapport avec un trouble de l'hémostase primaire:

- 1- L'hémophilie
 - 2- Maladie de Von Willebrand
 - 3- Insuffisance hépatocellulaire
 - 4- Purpura thrombopénique immunologique
 - 5- Fibrinolyse aiguë primitive
- A-1+2 B-1+3 C - 2 + 3 D - 2 + 4 E - 3 + 4

11. Les éléments en faveur d'une thrombopénie immunologique primaire sont:

- 1- Thrombopénie isolée $< 100000/\text{mm}^3$
 - 2- Présence d'une inconstante
 - 3- Absence d'anomalie de l'hémostase (TP, TCA normaux)
 - 4- Présence de schizocytes au frottis sanguin
 - 5- Présence d'anticorps antinucléaires à un titre élevé au bilan immunologique
- A-1+2 B-1+3 C-1+4 D-2+3 E-3+5

12. Le bilan préthérapeutique en oncologie est fait de (RJ)

- 1. Evaluation de la fonction cardiaque
 - 2. Explorations fonctionnelles respiratoires (EFR)
 - 3. Exploration de la fonction hématopoïétique
 - 4. Evaluation de l'état nutritionnel Evaluation de l'état psychologique
- A- 1+2+3 B-1+3+4 C- 1+2+3+4 D-1+3+4+5 E-2+3+4+5

13. Quelle est la réponse juste dans l'évaluation de l'état général pour autoriser un traitement étiologique du cancer:

- 1- PS 0
- 2- PS 1
- 3- PS 2
- 4- PS 3
- 5- PS 4
- A- 1 + 2 + 5 B- 1 + 3 + 4 C - 2 + 3 + 4 D- 1 + 2 + 3 E-1+4+5

14. Les facteurs de risque des cancers

- A. Agissent sur des cellules transformées ou métaplastiques
- B. Agissent sur des cellules normales
- C. Sont très souvent liés à la génétique
- D. Peuvent avoir un effet antagoniste
- E. N'ont pas d'effets cumulatifs

15. Les cancers liés aux expositions professionnelles (RJ)

- A. Les leucémies industrie de l'amiante
- B. Le cancer du poumon le cuir et la gomme
- C. Le cancer de la peau le chlore et le vinyle
- D. Le cancer de la vessie les teintureries, la gomme, les hydrocarbures
- E. Le cancer du foie matériaux d'isolement et le bois

16. Les effets secondaires de l'immunothérapie (RF)

- A. Sont toujours précoces
- B. Leur détection précoce est primordiale
- C. Secondaire à une réaction inflammatoire ou auto immune de certains organes
- D. Nécessite une prise en charge multidisciplinaire
- E. Toutes les réponses sont justes

17. Dans la classification TNM, le "N" correspond à (RJ)

- A- La taille de la tumeur primitive
- B- La présence de nécrose tumorale
- C- L'atteinte ganglionnaire régionale
- D- Le nombre de métastases
- E- L'atteinte ganglionnaire à distance

18. Le grade histologique renseigne sur : (RJ)

- A- L'étendue anatomique de la tumeur
- B- Le degré de différenciation cellulaire
- C- Le nombre de métastases
- D- Le volume tumoral
- E- L'activité mitotique uniquement

19. Parmi les mécanismes suivants, lequel n'est pas un mécanisme d'activation des oncogènes ?

- A. Réarrangement génique, comme le chromosome de Philadelphie (BCR-ABL)
- B. Amplification génique, comme l'HER2/neu dans le cancer du sein
- C. Mutation somatique activatrice, comme dans les gènes RAS
- D. Intégration virale près d'un proto-oncogène
- E. Allongement des télomères par activation de la télomérase

20. Les protéines produites par les proto-oncogènes incluent toutes les suivantes Sauf

- A. Facteurs de croissance
- B. Récepteurs des facteurs de croissance
- C. Transducteurs de signal
- D. Protéines de réparation de l'ADN
- E. Facteurs de transcription

21. Tous les gènes suivants sont des suppresseurs de tumeurs sauf:

- A. Le gène du rétinoblastome (Rb)
- B. Le gène HER2
- C. Les gènes BRCA-1 et BRCA-2
- D. Le gène p53
- E. Le gène APC

22. Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas une étiologie possible d'aplasie médullaire acquise?

- A. Médicaments (chloramphenicol, carbamazépine...)
- B. Virus des hépatites
- C. Exposition au benzène
- D. Clone HPN
- E. Irradiation ionisante

23. Quel est l'aspect typique de la biopsie ostéo-médullaire dans l'aplasie médullaire ?

- A. Moelle pauvre infiltrée par des cellules blastiques
- B. Moelle normale avec fibrose réticulinique
- C. Moelle adipeuse, avec une cellularité à moins de 30%
- D. Moelle pauvre avec présence de mégacaryocytes dysplasiques
- E. Moelle infiltrée par des amas de cellules extra hématologiques

24. Quel est le traitement spécifique d'aplasie médullaire idiopathique sévère chez un sujet âgé de plus de 40 ans ou en absence de donneur compatible ?

- A. SAL, ciclosporine ± Eltrombopag
- B. Greffe autologue de moelle
- C. Hydroxyurée
- D. Azacitidine
- E. Interféron alpha

25. Les signes neurologiques sont:

- A. Spécifiques à la carence en folates
- B. Spécifiques à la carence en vitamine B12
- C. Toujours présent dans la carence en vitamine B12
- D. Toujours irréversibles
- E. Inexistants en cas de maladie de Biermer

26. La leucémie myéloïde chronique est caractérisée par tous ces signes sauf uns?

- A. La présence souvent d'une splénomégalie
- B. La translocation réciproque t (9, 22)
- C. La translocation réciproque t (19:22)
- D. Le chromosome Philadelphie
- E. L'évolution biphasique

Le bilan fait objective: un taux de: GB : 230000/mm³, Hb: 9 gr/dl, plaquettes : 800000 /mm³, un équilibre leucocytaire: GB (36, 03, 13, 05, 00) et une Myélémie à 43% faite de 13% de Métamyélocytes, 08% de Myélocytes, 08% de Promyélocyte, 14% de Blastes et le caryotype retrouve la présence du chromosome Philadelphie et la PCR le transcrit BCR-ABL

27. Quel diagnostic vous retenez ? (1RJ)

- A- Le diagnostic est une leucémie myéloïde chronique en phase chronique
- B- Le diagnostic est une leucémie myéloïde chronique en phase accélérée
- C- Le diagnostic est une leucémie myéloïde chronique en phase acutisée
- D- Le diagnostic est une Leucémie Aigue Myéloblastique
- E- Le diagnostic est une thrombocythemie

28. Le traitement de Leucémie Myéloïde Chronique consiste selon l'ELN 2013 à: (RJ)

- 1) L'Hydroxurée pour réduire l'hyperleucocytose
- 2) Imatinib à 600 mg/j, ou Dasatinib à 70 mg x 2
- 3) Imatinib à 400 mg/
- 4) Nilotinib à 800 mg/j
- 5) Dasatinib 100 mg/j

A-1+4 B-1+3 C-4+5 D-1+5 E-1+2

29. Quels sont les gestes à faire avant toute transfusion sanguine?

- A. Faire un test de compatibilité au lit du malade
- B. Vérification des sérologies du receveur
- C. Rechercher les agglutines irrégulières chez le donneur avant et après transfusion
- D. La température du sang doit être à 25°C
- E. Toutes ces réponses sont justes

30. Dans le stade IIIA de La class de Salmon on retrouve (RJ)

- A. Un bilan radiologique normal
- B. Un taux de calcémie < 120 mg/l
- C. Une protéinurie des 24h 8g/24h
- D. Un taux d'HB < 8.5g/dl
- E. Une créatinémie >20mg/l

31. Les complications de la maladie de Cooley incluent:

1. Une hémochromatose secondaire
 2. Une insuffisance cardiaque
 3. Une déformation osseuse du crâne et du visage
 4. Un retard staturo-pondéral
 5. Une polyglobulie secondaire
- A- 1 + 2 + 3 + 4 B - 1 + 2 + 3 C - 1 + 2 + 4 D - 2 + 3 + 4 + 5 E- 1 + 3 + 5

32. Le dépistage prénuptial et prénatal de la thalassémie:

1. Permet d'éviter la naissance d'enfants homozygotes
 2. Est basé sur l'étude électrophorétique de l'hémoglobine
 3. Nécessite une biopsie hépatique
 4. Est indiqué dans les populations à risque
 5. Est sans intérêt en santé publique
- A- 1 + 2 + 4 B - 2 + 3 + 4 C - 1 + 3 + 5 D - 1 + 2 + 5 E-1+4+5

33. Critères cliniques pour l'arrêt de l'Imatinib

- 1- Age de 18 ans et plus
 - 2- Phase de la LMC Phase chronique uniquement
 3. Réponse moléculaire RM4.5 confirmée pendant 2 ans
 4. Réponse cytogénétique complète confirmée pendant 2ans
 5. Réponse hématologique complète uniquement
- A- 1 + 2 + 5 B - 1 + 2 + 4 C- 1 + 4 + 5 D- 1 + 2 + 3 E - 2 + 3 + 5

34. L'index pronostique international dans le myélome multiple (ISS) se base sur (RJ)

- A. Les bilans: rénal et phosphocalcique
- B. Les taux sériques de LDH et de la CRP
- C. Les taux d'albumine et de la b2 microglobuline sérique
- D. La masse tumorale
- E. La cytogénétique

35. Le myélome multiple se caractérise par (RF)

- A. Douleurs osseuses
- B. Splénomégalie
- C. Infiltration plasmocytaire médullaire
- D. Présence d'un pic monoclonal
- E. Les lésions osseuses radiologiques

36. Quel traitement spécifique est indiqué dans l'aplasie médullaire sévère chez un patient de 40 ans?

- A. Corticoïdes seuls
- B. Allogreffe de CSH
- C. Immunosuppresseur
- D. Facteurs de croissance G-CSF
- E. Programme transfusionnel

37. Une complication redoutable dans la carence en vitamine B12 non traitée: RJ

- A. Insuffisance rénale
- B. Trouble digestif
- C. Paraplégie spasmodique
- D. Pancytopénie irréversible
- E. Thrombose veineuse profonde

38. Concernant les télomères et la télomérase, quelle proposition est vraie ?

- A. Les télomères contiennent des informations génétiques essentielles
- B. Les télomères sont situés au centre des chromosomes
- C. Les télomères s'allongent à chaque division cellulaire.
- D. Le raccourcissement des télomères conduit à la sénescence cellulaire
- E. La télomérase est responsable du raccourcissement des télomères J

39. Concernant le lymphome de Hodgkin classique scléro-nodulaire, quelle proposition est fausse ?

- A. Il représente 70-90% des lymphomes de Hodgkin classiques
- B. Il présente une fibrose en bandes
- C. On observe des cellules lacunaires
- D. L'association avec l'EBV est supérieure à 90%
- E. C'est le sous-type le plus fréquent

40. L'immunophénotype typique du lymphome de Hodgkin classique comprend:

- A. CD30+, CD15+, CD45+
- B. CD30+, CD15+, PAX5 faible
- C. CD30-, CD15-, CD20+
- D. CD30+, CD15+, ALK+
- E. CD30-, CD15+, EMA+

41. Les tests explorant l'hémostase primaire comprennent:

- 1- Le temps de saignement
 - 2- Le TCA
 - 3- Le TP
 - 4- Etude de la fonction plaquettaire
 - 5- La numération plaquettaire
- A-3+4+5 B-2+3+4 C-1+4+5 D-1+2+3 E-1+3+4

42. Le suivi d'un patient atteint de cancer est un processus multidisciplinaire visant à: (RJ)

- 1- Assurer la continuité des soins
 - 2- Évaluer la tolérance
 - 3- Ajuster le traitement
 - 4- Maintenir la qualité de vie.
- A-1+2+4 B-1+2+3 C-1+3 D-1+3+4 E-1-2-3-4

43. La toxicité cardiaque de la chimiothérapie (RJ)

- A. Peut-être aiguë (trouble du rythme) ou chronique (cardiomyopathie, parfois insuffisance cardiaque)
- B. Les anthracyclines et 5 fluoro-uracile, exigeant un bilan cardiaque pré chimio, avec contrôle si anomalie, et respect des doses cumulées
- C. Caractérisée par une diminution de la fraction d'éjection ventriculaire gauche
- D. Les manifestations cliniques d'insuffisance cardiaque doivent orienter vers leur diagnostic
- E. Toutes les propositions sont justes

44. Le suivi au cours du traitement en oncologie (RJ)

- 1. Surveillance clinique état général, poids, signes vitaux.
- 2. Surveillance biologique: hémogramme, fonction rénale et hépatique.
- 3. Surveillance psychologique anxiété, dépression.
- 4. Surveillance radiologique

A - 1 + 2 B - 1 + 2 + 4 C - 2 + 3 + 4 D - 1 + 2 + 3 E- 1 + 2 + 3 + 4

45. Le rôle du médecin généraliste dans le suivi d'un patient atteint d'un cancer: (RJ)

- 1- Détection précoce des complications
- 2- Coordination avec les équipes spécialisées
- 3- Indiquer une chimiothérapie
- 4- Faire une radiothérapie.

A-1+4 B- 1 + 2 c - 2 + 4 D-1+3 E-2+3

46. Suivi post-traitement consiste à: (RJ)

- 1- Des consultations régulières
- 2- Une Imagerie selon le type de cancer
- 3- Surveillance des effets tardifs des traitements
- 4- Un scanner chaque mois

A - 1 + 3 + 4 B-1+2+3 C - 2 + 3 + 4 D 1 + 2 + 4 E- 1 + 2 + 3 + 4

47. Les échelles d'évaluation en cancérologie servent principalement à: (RJ)

- A- Déterminer le sexe et l'âge du patient
- B- Évaluer la réponse tumorale à un traitement seulement
- C. Apprécier l'état général, le pronostic et l'éligibilité aux traitements
- D- Identifier la mutation génétique du cancer
- E- Calculer la dose de chimiothérapie selon la surface corporelle

48. Selon les critères RECIST (RF):

- A- Il est possible de quantifier la réponse tumorale à l'évaluation
- B- Une réponse complète est la disparition de toutes les lésions
- C- Une réponse partielle correspond à diminution $\geq 30\%$ de la somme des diamètres des lésions cibles
- D- Diminution $< 20\%$ correspond à un échec thérapeutique
- E- Augmentation $\geq 20\%$ correspond à une progression de la maladie

49. L'utilisation d'une classification comme TNM permet avant tout de: (RJ)

- A- Adapter la chimiothérapie à la surface corporelle
- B- Evaluer la qualité de vie du patient
- C- Décrire précisément l'extension de la maladie et guider la stratégie thérapeutique
- D- Déterminer la cause du cancer
- E- Identifier les effets secondaires des traitements

50. Les échelles telles que ECOG, Karnofsky ou SBR sont utilisées principalement pou

- A- Uniformiser la recherche et comparer les résultats entre études cliniques
- B- Déterminer la nature génétique exacte de la tumeur
- C- Evaluer uniquement la douleur du patient cancéreux
- D- Décider de l'hospitalisation d'urgence
- E- Mesurer la toxicité hématologique d'un traitement

51. Parmi les critères nécessaires pour le dépistage: RF

- A- Récusable par la population
- B- Cancer souvent fréquent
- C- Test indolore
- D- Détection préclinique
- E- Rééritable

52. La prévention primaire: RJ

- A- On peut éviter jusqu'à la moitié des cancers avec la prévention primaire
- B- Vise à détecter les lésions précancéreuses
- C- C'est la même définition du dépistage
- D- Sert à réduire l'exposition aux facteurs de risque
- E- Améliore le pronostic de la maladie

Patiente AM âgée de 52 ans aux antécédents médicaux. Hypertension bien contrôlée.

Ménopause à 48 ans, antécédents familiaux: Mère décédée d'un cancer du sein à 50 ans. La patiente est suivie pour un carcinome canalaire infiltrant du sein gauche, stade IIb, RH+, HER2 Elle a bénéficié d'une chirurgie conservatrice suivie d'une chimiothérapie adjuvante (schéma FEC 5-Fluorouracile, Epirubicine, Cyclophosphamide). A J10 du 3e cycle de chimiothérapie, elle consulte aux urgences pour fièvre à 39.2°C, frissons, asthénie intense.

53. Quel est le premier bilan à demander

- A- Echographie abdominale
- B- Hémogramme
- C- Radiographie du thorax
- D- Un scanner hépatique
- E- Bilan hépatique

Examens complémentaires**NFS: Leucocytes à 1400/mm³, neutrophiles à 850/mm³ neutropénie sévère****CRP: 120 mg/L****Hémocultures: En cours****Radiographie thoracique Normale****ECBU: Négatif****54. Quel est le diagnostic retenu ?**

- A- Appendicite
- B- Leucopénie fébrile post-chimiothérapie, probablement d'origine bactérienne
- C- Épanchement pleural
- D- Hépatite
- E- Péricardite

55. La réponse optimale à 3 mois selon l'ELN est définie par:

- A. Une RHC, un BCR-ABL $\leq 10\%$, et/ou Ph+ $\leq 65\%$
- B. BCR-ABL $> 10\%$, et/ou Ph+ 65 à 95%
- C. Pas de RHC et/ou Ph+ $> 95\%$
- D. BCR-ABL $> 10\%$ et/ou Ph+ $> 35\%$
- E. Aucune réponse n'est juste

56. Les besoins physiologiques en far sont:

- A. 10 mg/j chez l'homme
- B. 20 mg/j chez la femme
- C. Les besoins au cours de l'allaitement sont multipliés x2
- D. Les besoins au cours de la grossesse sont multipliés x 3.
- E. Toutes les réponses sont justes

67. La transfusion de plaquettes

- 1. Peut être réalisée à partir d'un seul donneur après cytophérèse
- 2. Est dépourvu de risque de transmettre les infections virales: HIV, hépatites B et C
- 3. Peut provoquer l'apparition d'anticorps anti HLA pouvant se manifester par une réaction frisson hyperthermie.
- 4. Est indiquée lors du traitement des CIVD
- 5. Est indiquée systématiquement lors du traitement du purpura thrombopénique immunologique nouvellement diagnostiqué.

A-1+2+4 B-1+3+4 C-2+3+4 D-3+4+5 E-1+4+5

58. Quel est l'examen qui permet de type une Leucémie Aigüe Lymphoblastique?

- A. Biologie moléculaire
- B. Medullogramme.
- C. Immunohistologie.
- D. Immunophénotypage par cytométrie en flux
- E. Cytoponction ganglionnaire

56. Le Lymphome d'Hodgkin est caractérisée par:

- 1- Un granulome inflammatoire et présence des cellules de Reed Steinberg
 - 2- Une architecture ganglionnaire conservée.
 - 3- La cytoponction ganglionnaire oriente le diagnostic
 - 4- L immunohistochimie est obligatoire pour poser le diagnostic
 - 5- La localisation neuro-méningée est fréquente
- A:1+2+3 B:1+3+4 C:1+4+5 D:1+3+4+5 E:2+3+4

60. Quels sont les examens d'orientations à faire devant un syndrome anémique ?

1. Un médullogramme
 2. Un taux d'hémoglobine
 3. Un taux de réticulocytes.
 4. Calcule des indices érythrocytaires
 5. Un frottis sanguin
- A:1+2+3+5 B:1+3+4+5 C:1+4+5 D:1+3+4+5 E:2+3+4+5

Mme K. 25 ans, sans antécédents médicaux particuliers, consulte aux urgences pour l'apparition brutale et spontanée depuis hier de petites taches rouges, qui ne s'effacent pas lorsqu'on exerce une pression dessus, au niveau des membres inférieurs, associées à des plaques bleues, des gingivorragies et des cloques de sang au niveau de la face interne des joues. Elle ne rapporte aucun épisode fébrile ni prise médicamenteuse récente. Elle ne présente pas de syndrome infectieux ni de syndrome tumoral. Son bilan montre les résultats suivants Hb 13 g/dl: GR: 4,5 x 10⁶ /μL, VGM 87 CCMH 33%, GB 7200 /μL (PNN: 58%, Lymphocytes: 38%, Monocytes 45%) Plaquettes 8000/μL VS: 4 mm à la 1ère heure, CRP <5mg/l

61- Quel est le mécanisme principal du syndrome hémorragique chez cette patiente?

1. Anomalie acquise de l'hémostase primaire
 - 2- Déficit congénital en facteur VIII
 - 3- Atteinte de la paroi vasculaire
 - 4- Thrombopénie périphérique.
 - 5- Coagulopathie de consommation
- A-1+2 B-1+3 C-1+4 D-1+5 E-2+5

62. Quel est le signe clinique de gravité le plus préoccupant ?

- A- Pétéchies diffuses
- B-Age de la patiente
- C- Bulles hémorragiques endobuccales
- D- Absence de splénomégalie
- E- Début brutal, sans notion de traumatisme

63. Quelle(s) complication(s) doit (doivent) être systématiquement redoutée(s) ?

- A- Hémorragie rétinienne
- B- Hémorragie intracrânienne
- C- Hémorragie digestive
- D- Hématome rétro-péritonéal
- E- A+B

70- la patiente a présenté des céphalées atroces, avec trouble de la conscience, quelle est la complication la plus redoutable dans ce cas ?

- A. Un pic hypertensif
- B. Leucostase pulmonaire
- C. Hémorragie cérébro-meningée
- D. Une encéphalite
- E. AVC ischémique

Une Patiente de 35 ans, consulte pour une gêne de l'hypochondre gauche avec amaigrissement et une asthénie évoluant depuis 6 mois L'examen clinique retrouve une splénomégalie type V. Débord splénique 22 cm, une anémie, des ecchymoses au point d'injections.

71- Quel est le diagnostic qui vous semble le plus évident? (1RJ)

- A. Une Beta thalassémie homozygote majeure
- B. Une splénomégalie Infectieuse
- C. Une leucémie myéloïde chronique
- D. Une leucémie aigue
- E. Une Lymphome Non Hodgkinien

72- Quels sont les examens complémentaires qui vous permettent d'évoquer et de confirmer votre diagnostic ? (RJ)

- 1. Un hémogramme et un frottis sanguin
- 2. Un caryotype et une biologie moléculaire par PCR
- 3. Un médullogramme
- 4. Une biopsie
- 5. Un Bilan d'hémostase

A-1+2+5 B-1+2+4 C-1+4+5 D-1+2+3 E-2+3+5

73. Interpréter ces données: GB 3000 /mm³, GR 2000000 /mm³, Hb: 6 g/dl, Hte: 22%, plaq: 75000/mm³ et un taux de réticulocyte à 8%.

- A. Anémie modérée microcytaire hypochrome arégénérative, une hyperleucocytose franche avec une thrombopénie sévère.
- B. Anémie sévère microcytaire hypochrome arégénérative, une hyperleucocytose modérée avec une thrombopénie sévère.
- C. Anémie sévère macrocytaire arégénérative, une hyperleucocytose modérée avec une thrombopénie modérée.
- D. Anémie sévère microcytaire normochrome régénérative, une leucopénie modérée avec une thrombopénie sévère.
- E. Anémie sévère macrocytaire régénérative, une leucopénie modérée avec une thrombopénie modérée

74. Un homme âgé de 55 ans consulte pour des adénopathies cervicales évoluant depuis 02 mois, Clinique: adénopathie cervicale gauche de 6 cm et axillaire droite de 2 cm. Quel est le diagnostic le plus probable?

- A. Leucémie Myéloïde Chronique
- B. Leucémie Aigue Lymphoblastiques
- C. Lymphome Non Hodgkinien de haut grade de malignité
- D. Leucémie Lymphoïde Chronique
- E. Leucémie algue Myéloblastique.

Examen Maladies Infectieuses Groupe : 02 / 2026**1. La bactériémie à *S. aureus*: (Les RJ)**

- A. Elle est souvent transitoire et sans conséquence
- B. L'association à une endocardite
- C. Elle s'associe fréquemment à des localisations secondaires métastatiques
- D. La porte d'entrée reste inconnue dans 30% des cas
- E. Elle est le plus souvent liée à *Staphylococcus epidermidis*

2. La porte d'entrée la plus fréquente d'une bactériémie à *S. aureus* est: (Les RJ)

- A. Les lésions cutanées
- B. L'appareil urinaire
- C. Un cathéter veineux central ou périphérique
- D. Une carie dentaire
- E. Une infection ORL

3. Une infection streptococcique du groupe A (SGA) est dite invasive lorsqu'on isole le germe : (Les RJ)

- A. Du pharynx
- B. Du liquide céphalorachidien
- C. Du sang
- D. Des sécrétions nasales
- E. De la peau

4. Quelles sont les caractéristiques ou entités cliniques qui définissent une infection invasive à SGA ?

- A. Angine purulente
- B. Impétigo bulleux
- C. Choc toxique streptococcique
- D. Fasciite nécrosante
- E. Scarlatine

5. Diagnostic d'une Dermo-Hypodermite Bactérienne Nécrosante (DHBN): (Les RJ)

- A. Rougeur intense, œdème et bulles superficielles évoquent le diagnostic.
- B. L'extension rapide du placard est un signe d'alarme.
- C. Bulles hémorragiques, aspect violacé ou crépitation font suspecter une DHBN.
- D. Le diagnostic est confirmé uniquement par la présence de SGA sur hémoculture.
- E. La ponction-biopsie est utile pour différencier DHBN et érysipèle

6. Face à une suspicion de Dermo-Hypodermite Bactérienne Nécrosante, quelles sont les mesures urgentes à prendre ?

- A Débuter une corticothérapie à forte dose pour contrôler l'inflammation locale.
- B. Démarrer une antibiothérapie IV probabiliste à large spectre.
- C. Attendre les résultats de l'imagerie (IRM ou TDM) avant toute intervention chirurgicale.
- D. Réaliser un débridement chirurgical large et précoce de tous les tissus nécrosés.
- E. Le patient peut être pris en charge initialement en ambulatoire si l'état général est conservé.

7. Un homme de 35 ans, sans antécédent particulier, présente une méningite purulente.**Quelles propositions sont justes concernant la prise en charge initiale?**

- A. Le ceftriaxone est un traitement de première intention adapté
- B. L'antibiothérapie peut être différée après le résultat du LCR
- C. L'association amoxicilline + gentamicine est nécessaire d'emblée
- D. L'administration de la dexaméthasone doit précéder le C3G
- E. L'antibiothérapie doit être poursuivie au moins 6 semaines

8. Quelles sont les particularités cliniques et évolutives de la méningite à Pneumocoque?

- A. La mortalité est comparable à celle de la méningite à Méningocoque
- B. C'est l'étiologie de méningite la plus sévère et la plus létale
- C. La méningite à Pneumocoque est fréquemment associée à une porte d'entrée ORL
- D. Il existe une prophylaxie des cas contacts pour la méningite à Pneumocoque (vaccination).
- E. Le LCR est typiquement lymphocytaire.

9. Un patient jeune présente fièvre, céphalées, pupura diffus et signes de choc. Quelles propositions sont justes ?

- A. Réaliser une TDM cérébrale en urgence pour éliminer les contre-indications à la PL.
- B. Le diagnostic repose sur la PL qui doit précéder tout traitement
- C. L'administration immédiate d'une C3G IV est prioritaire
- D. L'absence de syndrome méningé élimine une infection méningococcique
- E. La PL peut être normale au début d'une méningococcémie fulminante

10. Quelles sont les caractéristiques de la méningite à Listeria monocytogènes ?

- A. Le LCR est toujours franchement purulent.
- B. Le traitement repose sur l'association Amoxicilline + Gentamicine
- C. Elle touche préférentiellement les patients âgés (> 65 ans), les immunodéprimés et les femmes enceintes
- D. C'est une méningite avec un taux de mortalité est faible.
- E. La durée de traitement est plus courte que pour les autres méningites (7 jours).

11. Un patient présente un LCR trouble mais l'examen direct est négatif. Quelles propositions sont justes?

- A. On débute une C3G en urgence
- B. Il faut attendre la culture du LCS avant de traiter
- C. L'association Amoxicilline doit être envisagée selon l'âge et le terrain
- D. La dexaméthasone n'a pas d'intérêt dans ce contexte
- E. Attendre les résultats des hémocultures avant de traiter

12. Quels éléments cliniques ou biologiques sont évocateurs d'une Méningite Tuberculeuse?

- A. Un début brutal et une régression spontanée rapide des symptômes
- B. Un mode d'installation progressif et insidieux
- C. Un LCS avec hypoglycorachie franche
- D. Un LCS avec une hyperleucocytose à prédominance de polynucléaires neutrophiles.
- E. La recherche de Bacilles de Koch (BK) à l'examen direct est positive dans 90% des cas.

13. Quelle est la stratégie thérapeutique immédiate (H0 - H48) devant une encéphalite à liquide clair sans orientation étiologique ? (1RJ)

- A. Aciclovir IV + Amoxicilline
- B. Ceftriaxone + Vancomycine.
- C. Amoxicilline + Gentamicine
- D. Attente du résultat PCR-HSV avant traitement
- E. Aciclovir IV seul

14. Risque d'exposition rabique Classification OMS (Les R.J)

- A. Griffure superficielle sans saignement sur un doigt, par un animal domestique sous surveillance catégorie II.
- B. Morsure de l'avant-bras avec effraction du derme et saignement catégorie III.
- C. Léchage sur peau intacte catégorie II.
- D. Griffure superficielle du visage catégorie II.
- E. Simple manipulation d'une chauve-souris, même sans morsure catégorie III

15. Sérothérapie antirabique post-exposition (Les RJ)

- A. En cas de morsures multiples, elle doit être administrée en urgence en perfusion.
- B. Indiquée seulement si l'animal est confirmé enragé.
- C. A instaurer immédiatement, quel que soit le délai d'exposition.
- D. A administrer uniquement par voie intramusculaire.
- E. Infiltrer autour de la plaie, le reste en IM à distance

16. Prise en charge antibiotique de la leptospirose: (Les RJ)

- A. Traitement uniquement symptomatique pour les formes anictériques.
- B. Doxycycline per os traitement de première intention des formes non sévères.
- C. Fluoroquinolones: traitement de référence.
- D. Pénicilline G IV ou ceftriaxone IV: traitements des formes sévères.
- E. Antibiothérapie à débiter seulement après confirmation sérologique

17. Diagnostic de la Fièvre Boutonneuse Méditerranéenne: (Les RJ)

- A. Le diagnostic de la FBM est essentiellement clinique, surtout en zone endémique
- B. La PCR sur sang est indispensable pour la confirmation du diagnostic.
- C. La sérologie est positive dès les premiers jours de la maladie,
- D. L'absence d'escarre d'inoculation n'élimine pas le diagnostic.
- E. Le Rickettsia conorii peut être isolé sur les hémocultures

18- Primo-infection VIH: (Les RJ)

- A. Se manifeste toujours par une fièvre élevée et une éruption maculopapuleuse.
- B. Peut s'accompagner de troubles neurologiques comme une méningite lymphocytaire.
- C. Se traduit par une charge virale indétectable dès les premiers jours,
- D. La sérologie est toujours positive à ce stade.
- E. Peut mimer une mononucléose infectieuse.

19. Phase asymptomatique du VIH: (Les RJ)

- A. C'est une période cliniquement silencieuse mais biologiquement active.
- B. Le risque de transmission est faible, voire nul, en l'absence de symptômes.
- C. Le taux de CD4 reste normal et stable durant toute cette phase,
- D. La charge virale devient indétectable sans traitement.
- E. L'absence de symptômes traduit l'élimination progressive du virus

20. Toxoplasmose cérébrale et SIDA: (Les RJ)

- A. C'est la cause la plus fréquente d'atteints focale du SNC chez le patient SIDA
- B. Le diagnostic de certitude repose sur les images en cocarde à l'IRM
- C. La sérologie toxoplasmose positive confirme le diagnostic.
- D. Le diagnostic de certitude repose sur la mise en évidence du parasite dans le LCR ou le tissu cérébral.
- E. En pratique, le diagnostic repose sur la bonne réponse clinique et radiologique au traitement d'épreuve.

21- Le tétanos (1 Réponse fausse)

- A) Est une toxi-infection due à Clostridium tétani
- B) Est une pathologie non contagieuse mais immunisante
- C) Le réservoir essentiel est le sol
- D) Le diagnostic est strictement clinique
- E) La prévention est la principale arme thérapeutique de la maladie

22- Facteurs de mauvais pronostic du tétanos (1 Réponse fausse)**A) Incubation <7 jours**

- B) Invasion < 2 jours
- C) Nouveau-né ou sujet âgé > 70 ans
- D) Existence d'un trismus
- E) Paroxysme

23- Mécanisme d'action physiopathologique de la toxine tétanique (tetanospasmine) (1RJ)

- A) Destruction directe et irréversible des motoneurones alpha
- B) Bloque la recapture de dopamine et sérotonine
- C) Migre par transport rétrograde et bloque la libération de GABA et glycine
- D) Se lie aux récepteurs post-synaptiques d'acétylcholine causant paralysie flasque
- E) Provoque une démyélinisation des fibres périphériques

24- Pathologies responsables d'éruptions maculo-papuleuses, sauf: (1 Réponse fausse)

- A) Rubéole
- B) EBV
- C) Scarlatine
- D) Fièvre typhoïde
- E) Syndrome main-pied-bouche

25- Diagnostic microbiologique de la diphtérie (Les RJ)

- A. Prélèvement pharyngé avec culture sur milieu tellurite
- B. La sérologie diphtérique est le standard pour le diagnostic en urgence
- C. Le test de toxine (Elek ou PCR) confirme le pouvoir toxigène
- D. L'hémoculture isole systématiquement la bactérie
- E. La coloration Gram positive seule suffit pour confirmer le diagnostic

26- Quelles sont les deux complications viscérales graves dues à la diffusion de la toxine diphtérique ?

- A. Arthrite septique, la complication la plus fréquente
- B. Atteinte des nerfs périphériques entraînant des paralysies ou polynévrites
- C. Atteinte rénale aiguë systématique
- D. Myocardite (inflammation du muscle cardiaque) pouvant entraîner une insuffisance cardiaque
- E. Endocardite précoce

27- Étiologie et transmission de la varicelle (Les RJ)

- A. La varicelle est causée par le virus varicelle-zona (VZV)
- B. La transmission se fait uniquement par contact avec les lésions
- C. La transmission aérienne et par gouttelettes respiratoires est possible
- D. Les adultes font des formes atténuées
- E. Ne touche jamais les nouveau-nés

28- Indications principales du traitement antiviral du zona: (Les R

- A. Traitement systématique de tous les patients, quelle que soit leur condition
- B. Les sujets immunodéprimés
- C. Le zona chez le sujet de plus de 50 ans
- D. La zone du tronc chez l'enfant
- E. L'antiviral doit être débuté après 7 jours d'évolution

28- Chez un patient fébrile avec ictère et douleur abdominale, le diagnostic infectieux le plus urgent à éliminer est:

- A. Angiocholite
- B. Hépatite B
- C. Leptospirose
- D. Paludisme
- E. Fièvre typhoïde

30- Eleveur de bétail présente une fièvre > 20 jours avec spondylodiscite L4-L5. Diagnostic suspecter en premier:

- A. Mal de Pott
- B. Endocardite
- C. Brucellose
- D. Fièvre typhoïde
- E. Leptospirose

31- Lequel des éléments suivants est le plus évocateur de la mononucléose?

- A. Lymphocytose > 50% avec cellules atypiques
- B. Hyperleucocytose neutrophilique
- C. Thrombopénie isolée
- D. Anémie microcytaire
- E. Hyperéosinophilie

32- Phase d'état (2 septénaire) de la fièvre typhoïde: quels signes sont fréquents ? (Les RJ)

- A. Fièvre en plateau
- B. Tâche noire
- C. Une dissociation pouls-température
- D. Diarrhées liquidiennes en eau de riz
- E. Constipation

33- Quelles sont les complications graves les plus fréquentes à redouter lors d'une fièvre typhoïde ?

- A. Pneumonie bactérienne
- B. Insuffisance rénale aiguë
- C. Péritonite
- D. Hépatite
- E. Hémorragie gastro-intestinale

34- Que faire immédiatement après une piqûre profonde avec aiguille contaminée ? (Les RJ)

- A. Laver abondamment la plaie à l'eau et au savon
- B. Faire saigner doucement la plaie
- C. Attendre la sérologie du patient
- D. Consulter en infectiologie après résultat sérologie
- E. Déclaration de l'accident

35- 1flacon est positif à S. epidermidis à 60 h d'incubation, chez un patient sans matériel implanté. Que concluez-vous?

- A. Bactériémie vraie
- B. Fausse positivité due à l'automate
- C. Contamination probable
- D. Infection sur cathéter
- E. Endocardite subaiguë probable

36- Parmi les affirmations suivantes concernant les bactériémies à BGN, laquelle est FAUSSE?

- A. Elles représentent la première cause de choc septique.
- B. Elles proviennent fréquemment du tube digestif.
- C. Leur résistance naturelle aux β -lactamines est rare.
- D. Le risque est accru chez les patients porteurs de dispositifs invasifs.
- E. Pseudomonas aeruginosa peut coloniser les surfaces hospitalières humides.

37- Le score qSOFA est principalement utile: (1RJ)

- A. Pour évaluer la gravité chez les patients en réanimation
- B. Pour diagnostiquer une défaillance multiviscérale confirmée
- C. Comme outil de dépistage rapide hors réanimation
- D. Pour guider l'antibiothérapie probabiliste
- E. Pour déterminer le pronostic à long terme

38- Patient avec sepsis a une PAM à 60 mmHg après remplissage et une lactatémie à 3 mmol/L. Quelle conclusion tirer ?

- A. Sepsis simple
- B. Sepsis sévère
- C. Choc septique
- D. Syndrome de réponse inflammatoire simple (SIRS)
- E. Choc cardiogénique

39. Un patient hospitalisé présente une infection urinaire à *Klebsiella pneumoniae*. Quel antibiotique est le plus approprié en première intention? (une réponse fausse)

- A. Piperacilline-tazobactam
- B. Amoxicilline
- C. Ceftriaxone
- D. Imipénème
- E. Ceftazidime

Examen Maladies Infectieuses : Groupe 04 / 2026

1. Quelles sont les deux molécules de choix pour traiter une infection sévère à *S. aureus* sensible à la méticilline (SASM)?

- A. La Vancomycine
- B. L'amoxicilline
- C. L'oxacilline
- D. La Cefazoline (Cephalosporins de 1ere génération)
- E. La Ceftriaxone (Cephalosporine de 3ème génération)

2- Concernant les infections sur le matériel (prothèses, cathéters), quelles sont les deux affirmations vraies ?

- A. La formation d'un biofilm protège les bactéries de l'action des antibiotiques et du système immunitaire.
- B. Les souches de *S. aureus* ne sont pas capables de former un biofilm.
- C. Le *Staphylococcus epidermidis* est la principale cause d'infections des cathéters veineux centraux
- D. est toujours considéré comme un contaminant lorsqu'il est isolé en hémoculture.
- E. L'antibiothérapie suffit exclusivement à guérir une infection sur prothèse de hanche

3- Quels sont les caractères de Toxi-infection Alimentaire (TIAC) staphylococcique ?

- A. Incubation courte (2 et 6 heures)
- B. Fièvre élevée obligatoire.
- C. Vomissements violents et répétés.
- D. Transmission par l'eau souillée.
- E. Nécessite une antibiothérapie curative?

4- Pourquoi la clindamycine est-elle indiquée dans les infections graves nécrosantes à staphylocoque ?

- A. Parce qu'elle possède une activité bactericide supérieure à celle des bêta-lactamines
- B. Parce qu'elle est la seule molécule active sur les souches de SARM
- C. Pour sa capacité à détruire directement la capsule d'acide hyaluronique
- D. Pour son effet anti-toxinique par inhibition de la synthèse des toxines (ex. PVL)
- E. Pour sa bonne pénétration tissulaire et son activité au sein du biofilm

5- Quels signes cliniques font partie des critères de définition du Choc Toxique Staphylococcique (SCT)?

- A. Une éruption érythémateuse diffuse (type coup de soleil).
- B. Une hypertension
- C. Une hypothermie
- D. Une évolution vers desquamation tardive
- E. Une polyurie importante.

6- Quels examens confirment le caractère invasif d'une infection streptococcique ?

- A. Un prélèvement de gorge positif.
- B. Des hémocultures positives à *S. pyogènes*
- C. La présence du germe dans le liquide céphalo-rachidien (LCR).
- D. Un test de diagnostic rapide (TDR) positif.
- E. Un prélèvement cutané de lésions d'impétigo.

7- Quelles sont les caractéristiques de l'infection à streptocoque du groupe B?

- A. C'est la cause majeure des infections néonatales (méningites, septicémies).
- B. Le réservoir principal est l'appareil respiratoire.
- C. Le dépistage vaginal est recommandé chez la femme enceinte entre 35 et 37 SA.
- D. Il est responsable d'angines sévères.
- E. Il est classé comme un streptocoque alpha-hémolytique

8- Concernant l'érysipèle, forme la plus fréquente des DHBNN chez l'adulte, quelles affirmations sont justes ?

- A. L'agent causal principal est *Staphylococcus aureus*
- B. Le diagnostic est essentiellement clinique et ne nécessite pas d'examens microbiologiques systématiques
- C. Le placard inflammatoire est érythémateux, œdémateux, chaud, douloureux, parfois accompagné de crépitation
- D. La recherche d'une porte d'entrée cutanée doit être systématique à l'examen
- E. Les AINS sont recommandés pour leur effet anti-inflammatoire et antalgique

9. Face à un patient présentant un syndrome méningé aigu, quelles sont les priorités absolues de prise en charge ?

- A. Débuter systématiquement une corticothérapie à haute dose, puis réaliser la PL
- B. Un fond d'œil est obligatoire avant toute ponction lombaire
- C. La ponction lombaire doit être réalisée rapidement, sauf contre-indication neurologique
- D. Une antibiothérapie probabiliste doit être instaurée immédiatement en cas de contre-indication à la PL
- E. L'antibiothérapie ne doit être administrée qu'après obtention des résultats du LCS, quel que soit son aspect

10. Concernant la pathogénie de la méningite à *Neisseria meningitidis*, quelles propositions sont exactes ?

- A. Le portage pharyngé asymptomatique est rare (<1%)
- B. L'infection invasive débute souvent par une bactériémie transitoire
- C. Elle évolue rapidement vers une méningo-encéphalite
- D. Une localisation extra méningée est possible
- E. L'atteinte méningée est souvent précédée d'une infection ORL, (sinusite, otite)

11. Chez un adulte avec méningite purulente et diplocoques Gram positifs au LCS, quelles propositions sont exactes ?

- A. Le traitement repose sur une céphalosporine de 3^e génération IV
- B. L'association systématique d'emblée de la vancomycine est obligatoire dans tous les cas
- C. Une ponction lombaire de contrôle doit être réalisée systématiquement à 48 heures
- D. La dexaméthasone doit être administrée avant ou avec la première dose d'antibiotique
- E. La durée du traitement est de 7 jours

12. Quels éléments orientent vers une méningite tuberculeuse ?

- A. Début progressif des symptômes sur plusieurs jours à semaines
- B. LCR clair lymphocytaire, avec hypoglycorachie et hyperprotéinorachie
- C. Evolution brutale avec altération rapide de la conscience en moins de 48 h
- D. IRM cérébrale montrant un œdème cérébral diffus sans atteinte basilaire
- E. Protéinorachie normale ou basse

13. Quelles sont les particularités de la méningite à Listeria chez l'adulte ? A. Le LCR est toujours clair et lymphocytaire

- B. Elle touche préférentiellement le sujet âgé, les femmes enceintes et les immunodéprimés
- C. Le syndrome méningé est toujours franc et typique
- D. Le traitement de référence est le cefotaxime
- E. La présentation clinique est variable et peut prendre plusieurs formes, de bénigne à sévère

14- Un homme de 65 ans fièvre confusion hallucinations: La PCR HSV sur LCS à 48h est négative Votre conduite ?

- A. Poursuivre l'aciclovir IV 10 mg/kg/j et répéter la PL après j4
- B. Arrêter l'aciclovir car la PCR est négative
- C. Maintenir l'amoxicilline IV pour couvrir Listeria
- D. Réaliser un scanner cérébral de contrôle
- E. Donner une corticothérapie systématique

15. Après des pluies diluviennes cet hiver dans la région de Blida, plusieurs patients présentent fièvre, céphalées et syndrome pseudo-grippal. Quelle étiologie est la plus probable?

- A. Grippe saisonnière
- B. COVID-19
- C. Leptospirose.
- D. Infection à méningocoque
- E. Infection à entérovirus

16- Chez un adulte présentant fièvre aiguë avec myalgies et conjonctivite bilatérale au mois d'août, pourquoi la doxycycline est-elle considérée comme un traitement probabiliste préféré?

- A. Elle prévient l'apparition des surinfections pulmonaires liées à la grippe
- B. Elle agit sur les rickettsioses
- C. Elle est bactéricide sur la majorité des bactéries
- D. Elle couvre la leptospirose
- E. Elle est très efficace contre les conjonctivites

17- FBM: Concernant ce tableau clinique, quelles propositions sont exactes?

- A. L'atteinte palmo-plantaire est évocatrice
- B. L'absence d'escarre n'élimine pas le diagnostic
- C. La sérologie permet de confirmer le diagnostic
- D. L'amoxicilline doit être initiée sans attendre la confirmation biologique
- E. Une hyperleucocytose neutrophile importante est typique

18- Patient VIH non traité, CD4 = 90/mm³, présente candidose buccale et CD4 = 90/mm³, Quelles sont les implications ?

- A. Phase chronique asymptomatique
- B. Phase chronique symptomatique mineure
- C. Risque faible de Pneumocystose
- D. Risque élevé de toxoplasmose cérébrale prophylaxie si IgG positive
- E. Début immédiat de traitement antiretroviral (ARV) après bilan des infections opportunistes

13. Quels marqueurs biologiques sont utilisés pour le suivi d'un patient sous ARV?

- A. La charge virale plasmatique (ARN VIH) pour évaluer L'efficacité du traitement
- B. Le dosage hebdomadaire de l'antigène p24
- C. Les lymphocytes T CD4 pour évaluer le degré de restauration immunitaire.
- D. Le test Western Blot tous les 6 mois vérifier la séroconversion
- E. La vitesse de sédimentation (VS) comme seul marqueur de suivi

20- Une femme présente 2 tests de dépistage VIH positifs après une transfusion il y a 1 mois, alors qu'elle était initialement négative. Le Western Blot est négatif. faut-il faire

- A. Il s'agit d'un faux positif aucun traitement ni suivi nécessaire
- B. Il s'agit probablement d'une primo-infection réaliser PCR ARN VIH pour confirmation
- C. Le WB négatif permet de considérer le patient non infecté
- D. Les 2 sérologies positives confirment le diagnostic début immédiat de trithérapie
- E. La discordance ELISA/WB est toujours due à une erreur technique

21- Le sepsis est défini comme:

- A. Une infection prouvée avec fièvre > 38,5 °C
- B. Une réponse inappropriée de l'hôte entraînant une dysfonction d'organe
- C. Un syndrome infectieux avec hypotension artérielle persistante
- D. Un score SOFA ≥ 2 ou une augmentation de 2 points
- E. Une infection limitée à un seul organe

22- En cas de bactériémie:

- A. La recherche de porte d'entrée est systématique
- B. L'échocardiographie est indiquée si S.aureus ou entérocoque
- C. Le scanner thoraco-abdomino-pelvien est inutile
- D. La source infectieuse n'a pas d'impact sur la conduite
- E. L'ablation d'un matériel suspect n'est pas prioritaire

23- Les entérobactéries à céphalosporinase déréprimée (AmpC):

- A. Résistent aux céphalosporines de 3 génération (C3G)
- B. Restent sensibles à l'amoxicilline
- C. Possèdent un gène ampC hyperexprimé
- D. Résistent à l'acide clavulanique
- E. Sont sensibles à l'imipénème

24- Au cours de la rubéole acquise: Les RF

- A. La contagiosité disparaît avec la disparition de l'éruption
- B. Une éruption scarlatiniforme est possible
- C. Une inflammation des articulations peut compliquer une forme commune
- D. La splénomégalie est constamment présente.
- E. Les adénopathies sont de siège cervical

25- La rubéole chez la femme enceinte: Les RF

- A. Elle peut se transmettre au fœtus par voie placentaire
- B. Le test d'avidité des IgG peut dater l'infection de moins de 03 mois.
- C. Son diagnostic repose sur l'échographie obstétricale
- D. Elle peut se compliquer de malformations fœtales neurologiques
- E. Elle est à déclaration obligatoire

26- Interprétez ce profil sérologique de la mononucléose: IgM (+) anti VCA, IgG (-) anti VCA, IgG (-) anti EBNA: RJ

- A. Infection aiguë à EBV
- B. Infection ancienne
- C. Réactivation d'une infection à EBV
- D. Infection à EBV en phase de convalescence
- E. Absence d'infection à EBV

27- Concernant le tétanos néonatal; Les RJS

- A. Forme clinique gravissime
- B. Se transmet de la mère à son nouveau-né.
- C. Evitable par la vaccination de la mère surtout en fin de grossesse
- D. S'exprime initialement par un refus de tété dans un contexte d'apyrexie et hypotonie globale.
- E. L'hygiène ombilicale insuffisante et les pratiques traditionnelles sont souvent en cause.

28- Parmi les propositions suivantes concernant l'immunothérapie du tétanos, laquelle est exacte:

- A. Les immunoglobulines humaines spécifiques sont administrées pour neutraliser la toxine circulante
- B. Les immunoglobulines doivent être injectées par voie intraveineuse directe pour une efficacité maximale
- C. Le traitement par immunoglobuline dispense de la vaccination ultérieure
- D. L'injection d'immunoglobulines humaines permet de neutraliser la toxine fixée au niveau du système nerveux central
- E. L'administration de sérum antitétanique d'origine équine est privilégiée aujourd'hui en raison de sa longue demi vie

29- La fièvre au cours de la brucellose: (1 RJ)

- A. fièvre continue en plateau
- B. fièvre rémittente quotidienne
- C. fièvre intermittente
- D. fièvre ondulante
- E. fièvre anarchique

30- Une femme enceinte présente fièvre, frissons, et la goutte épaisse retrouve un Plasmodium falciparum avec une parasitémie à 7%. Quelle est la conduite à tenir?

- A. Quinine orale si pas de vomissements
- B. Artésunate injectable
- C. Les dérivés d'artémisinine sont contre-indiqués chez la femme enceinte
- D. Quinine injectable uniquement si vomissements
- E. Les réponses A, C et D sont justes

31- La fièvre au cours de la brucellose: (1 RJ)

- A. fièvre continue on plateau
- B. fièvre rémittente quotidienne
- C. fièvre intermittente
- D. fièvre ondulante
- E. fièvre anarchique

32- La réaction sérologique de référence de la Brucellose est :(1RJ)

- A. Sérologie de Wright
- B. Sérologie de Widal et Felix
- C. Sérologie de Weil et Felix
- D. Sérologie de de Martin et Pettit
- E. Teste au Rose bengale

33- Situations d'urgence devant un ictère fébrile: (1RF)

- A angiocholite
- B. kyste hépatique
- C. sepsis
- D. hépatite fulminante
- E. neuropaludisme

34- Concernant le zona: (La ou les RJ)

- A. L'éruption est habituellement précédée de douleurs dans le même territoire
- B. C'est une primo-infection à VZV
- C. Les séquelles douloureuses sont à craindre surtout chez le sujet âgé
- D. Diagnostic essentiellement biologique
- E. L'éruption est bilatérale dans les métamères symétriques

35- Quelle est la méthode qui permet de poser le diagnostic de varicelle ? (1 RJ)

- A. Sérologie ELISA
- B. PCR à partir des cellules vésiculaires
- C. L'isolement du virus par culture cellulaire
- D. Immunofluorescence directe
- E. Arguments cliniques

36- Quelles sont les complications tardives de la diphtérie ? (Les RJ)

- A. Paralysies
- B. Pneumonie
- C. Méningite
- D. Myocardite
- E. Pancréatite

37- La fièvre typhoïde: (1RF)

- A. Est une maladie endémo- épidémique en Algérie
- B. Son point de départ est digestif
- C. Le réservoir est strictement humain
- D. La lithiase vésiculaire constitue un facteur de risque de portage chronique
- E. Il n'existe aucun vaccin pour cette pathologie

38- La fièvre typhoïde, au 2^m septénaire, elle se manifeste par: (Les RJ)

- A- Une fièvre en plateau
- B. Une dissociation pouls-température
- C- Présence de la tache noire
- D. Une fosse iliaque droit gargouillante
- E- Une éruption palmo-plantaire

39- A propos du choléra: cochez la ou les réponses fausses

- A. Maladie parasitaire épidémique de gravité redoutable
- B. L'incubation > 1 semaine
- C. Le vibrion cholérique se transmet par les mains contaminées
- D. Est une maladie contagieuse à caractère épidémique
- E. La déshydratation aigue conditionne le tableau clinique grave

Examen Endocrino : Groupe 02 / 2026**1. Concernant le diagnostic du diabète sucré, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?**

- A. Le diagnostic de diabète peut être posé devant deux glycémies à jeun $\geq 1,26$ g/L réalisées à quelques jours d'intervalle
- B. Une glycémie capillaire ≥ 2 g/L mesurée au cabinet permet à elle seule de poser le diagnostic
- C. Une HbA1c $\geq 6,5\%$ peut être utilisée pour diagnostiquer un diabète en dehors de certaines situations cliniques
- D. Une glycémie à jeun comprise entre 1,10 et 1,25 g/L correspond à un diabète débutant
- E. Chez un patient symptomatique, une glycémie > 2 g/L permet de poser immédiatement le diagnostic

A) A B) A+B+E C) A+B+C D) A+C+E E) B+C+E

2. Concernant la physiopathologie du diabète sucré, quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) ? (RF)

- A. Le diabète de type 1 est lié à une destruction auto-immune des cellules β des îlots de Langerhans
- B. Le diabète de type 2 est exclusivement dû à une insulino-résistance périphérique
- C. L'hyperglycémie du diabète de type 2 résulte à la fois d'une insulino-résistance et d'un défaut progressif de sécrétion d'insuline
- D. Le foie joue un rôle central dans l'hyperglycémie à jeun par augmentation de la production hépatique de glucose
- E. L'insuline inhibe la néoglucogenèse hépatique et favorise la captation du glucose par les tissus périphériques

3. Concernant la classification du diabète sucré, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s)?

- A. Le diabète de type 1 correspond à un déficit absolu en insuline, le plus souvent d'origine auto-immune
- B. Le diabète de type 2 est lié uniquement à une insulino-résistance périphérique
- C. Le diabète gestationnel est un diabète découvert pour la première fois pendant la grossesse
- D. Les diabètes secondaires incluent les diabètes liés aux maladies du pancréas exocrine
- E. Le MODY fait partie des diabètes de type 2

A) B+C B) A+C+D C) B+C+D D) C+D+E E) A+D

4. Concernant la prise en charge initiale d'une complication aiguë du diabète

- A. L'insuline IV est toujours la première mesure
- B. La réhydratation prime sur l'insulinothérapie
- C. Le bicarbonate est systématique en cas d'ACD
- D. Le facteur déclenchant doit être recherché et traité
- E. L'oxygénothérapie est inutile

A) B+D B) A+B C) B+C D) C+D E) D+E

5. L'hypoglycémie chez le patient diabétique:

- A. Elle est définie par une glycémie $< 0,70$ g/L.
 - B. Elle peut entraîner des troubles de la conscience.
 - C. Elle est toujours liée à un excès d'insuline
 - D. Les bêtabloquants peuvent masquer les signes d'alerte
 - E. Elle n'a jamais de conséquences neurologiques
- A) A+B+C B) A+B+D C) B+C+D D) C+D+E E) B+D+E

6. L'acidocétose diabétique, quelles affirmations sont vraies? (RF)

- A. Elle survient principalement chez le diabétique de type 1
- B. Elle est caractérisée par une acidose métabolique à trou anionique élevé
- C. La glycémie est toujours supérieure à 5 g/L
- D. Les corps cétoniques sanguins sont augmentés
- E. Elle peut être déclenchée par une infection

7. Les inhibiteurs des SGLT-2 (Gliflozines)

- A. Inhibent la réabsorption du glucose dans le tube proximal du néphron, ce qui entraîne une glycosurie forcée.
 - B. Inhibent la réabsorption du glucose dans le tube distal du néphron, ce qui entraîne une glycosurie forcée.
 - C. Inhibent la réabsorption du glucose dans le tube proximal du néphron, ce qui entraîne une glycosurie faible.
 - D. Sont contre indiqués en cas d'insuffisance rénale sévère.
 - E. Sont recommandés en cas d'insuffisance rénale sévère.
- A) A+D B) B+D C) C+D D) A+E E) B+E

8. Concernant les effets indésirables des traitements du diabète, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

- A. La metformine peut provoquer des troubles digestifs, surtout en début de traitement
 - B. Les sulfamides hypoglycémisants exposent à un risque d'hypoglycémie prolongée
 - C. Les inhibiteurs de SGLT2 peuvent favoriser les infections génito-urinaires
 - D. Les analogues du GLP-1 sont responsables d'hypoglycémies sévères lorsqu'ils sont utilisés seuls
 - E. L'insulinothérapie est associée à un risque de prise de poids
- A) A+B+C+E B) B+C+E C) C+D+E D) A+C+E E) B+D+E

9. Concernant l'insulinothérapie, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s)?

- A. L'insuline est toujours indiquée d'emblée dans le diabète de type 1
 - B. Les analogues d'insuline à action rapide doivent être injectés juste avant ou au début du repas
 - C. Les insulines basales ont pour objectif principal de corriger l'hyperglycémie post-prandiale
 - D. L'hypoglycémie est l'effet indésirable le plus fréquent de l'insuline
 - E. L'insuline est contre-indiquée chez le sujet âgé
- A) A+D B) B+C C) C+D D) D+E E) A+B+D

10. La neuropathie diabétique périphérique se caractérise par (RF)

- A. Une atteinte distale symétrique
- B. Une prédominance sensitive
- C. Des douleurs nocturnes fréquentes
- D. Des pouls pédieux diminués
- E. Un risque accru de développer un pied diabétique.

11. Parmi les propositions suivantes relatives Juste ves à la rétinopathie diabétique, indiquez celle qui est

- A. Elle est liée à l'ancienneté du diabète.
 - B. Elle peut être asymptomatique aux premiers stades.
 - C. La rétinopathie diabétique non proliférante se caractérise par la présence de néovaisseaux.
 - D. La forme proliférante expose au risque d'hémorragies du vitre.
 - E. Le fond d'œil n'est indiqué qu'en cas de baisse de l'acuité visuelle
- A) A+B+C+D+E B) A+B C) A+B+D D) A+B+C+D E) A+B+D+E

12. À propos du goitre carentiel

- A. Il est initialement diffus
 - B. Il peut devenir multinodulaire avec le temps
 - C. Il est toujours associé à une hypothyroïdie clinique
 - D. Il résulte d'une stimulation prolongée par la TSH
 - E. Il disparaît toujours spontanément à l'âge adulte
- A) C+D B) A+D C) A+D+E D) A+B+D E) B+C+D

13. À long terme, un goitre carentiel peut évoluer vers: (RF)

- A. Un goitre multinodulaire
- B. Une autonomie fonctionnelle
- C. Une hyperthyroïdie à l'âge adulte
- D. Une hypothyroïdie centrale
- E. Des complications compressives

14. Quels sont les principaux mécanismes physiopathologiques de l'hyperthyroïdie? (cochez la réponse fausse)

- A. Auto-immune
- B. Destruction glandulaire inflammatoire 2
- C. Production autonome par les nodules toxiques
- D. Médicamenteux
- E. Aucune proposition

15. Quel est le résultat de la scintigraphie au cours de la maladie de BASEDOW? (cochez la réponse juste)

- A. Hyperfixation diffuse et homogène
- B. Hypofixation
- C. Hyperfixation localisée
- D. Absence de fixation
- E. Hyperfixation hétérogène

16. Quelles sont les situations où le taux de TSH est bas indépendamment de toute maladie thyroïdienne? (cochez la réponse fausse) ?

- A. Lors du 1er T de la grossesse.
- B. Lors du 2eme T de la grossesse
- C. Lors du 3eme T de la grossesse
- D. Patients en mauvais état général
- E. Patients traités par corticoïdes

17. Décrire hypertyroïdie induite par l'amiodarone type

- A. Survient sur une pathologie thyroïdienne sous-jacente Nodules ou maladie de Basedow
- B. Survient sur une thyroïde saine, indication de l'Amiodarone
- C. La surcharge iodée entraîne une production d'HT par les nodules autonomes
- D. L'antigenicité est réveillée avec flambée de la maladie de Basedow.
- E. Traitement: Antithyroïdiens de synthèse /perchlorate de K+

18. Concernant l'hypothyroïdie, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s)?

- A. L'hypothyroïdie primitive se caractérise par une TSH élevée
 - B. Une TSH normale élimine toujours une hypothyroïdie
 - C. La cause la plus fréquente d'hypothyroïdie chez l'adulte est la thyroïdite d'Hashimoto
 - D. Le traitement de référence de l'hypothyroïdie est la lévothyroxine
 - E. L'hypothyroïdie peut être responsable d'une hypercholestérolémie
- A)A+B+C B)A+C+D+E C)B+C+D D)C+D+E E)A+D+E

19. Quel type auto-ac est élevé au cours de la thyroïdite d'Hashimoto (cochez la réponse juste)

- A. Ac anti-TPO
- B. Ac anti-TSH
- C. Ac anti-TRACK
- D. Ac anti-AAN
- E. Ac anti-DNA

20. Quelle est votre escalade thérapeutique en hypolipémiants en prévention secondaire?

- A. règles hygiéno diététiques puis statine puis ezetimibe
- B. Statine puis associations de statines puis ezetimibe
- C. Statine puis ezetimibe puis anti PCSK9
- D. Règles hygiénodietétiques+ statine puis ezetimibe puis anti PCSK9,
- E. RHD seules

21. Concernant le syndrome métabolique, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s)

- A. Il se définit par la présence d'au moins trois critères parmi: obésité abdominale, hypertension artérielle, hyperglycémie, hypertriglycéridémie, HDL-cholestérol bas
 - B. L'IMC est le critère central pour le diagnostic
 - C. L'insulinorésistance est un mécanisme physiopathologique clé
 - D. Il augmente le risque de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires
 - E. Le traitement repose uniquement sur les hypolipémiants
- A) A+B+D B)B+C+D C) A+C+D D) C+D+E E) A+B+C

22. La valeur seuil du tour de taille pour définir l'obésité abdominale chez l'homme selon l'IDF (population européenne) est:

- A > 80cm
- B > 88cm
- C > 94cm
- D > 102cm
- E > 110cm

23. Concernant l'obésité, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

- A. L'obésité est définie par un IMC ≥ 30 kg/m²
 - B. Le tour de taille n'a pas d'intérêt pour évaluer le risque cardiovasculaire
 - C. L'obésité abdominale (viscérale) est associée à une insulino-résistance
 - D. L'obésité augmente le risque d'hypertension, diabète de type 2 et maladies cardiovasculaires
 - E. La seule stratégie efficace de traitement est la chirurgie bariatrique
- A)A+C B)B+C+D C)A+C+D D) A+D+E E) C+D+E

24. Concernant les complications mécaniques de l'obésité

- A. Apnée du sommeil
 - B. Arthrose des genoux et hanches
 - C. Reflux gastro-cesophagien
 - D. Insuffisance cardiaque restrictive
 - E. Hyperventilation alvéolaire
- A)A+B+C B) A+B C)B+E D) A+B+C+D+E E) A+B+D

25. Concernant la prise en charge de l'obésité:

- A. Régime hypocalorique + activité physique = traitement de première intention
 - B. Les médicaments anti-obésité sont indiqués systématiquement dès IMC ≥ 30 *
 - C. La chirurgie bariatrique est indiquée si IMC ≥ 40 ou ≥ 35 avec comorbidités
 - D. La chirurgie bariatrique réduit exclusivement le poids, pas les comorbidités
 - E. Le suivi psychologique est recommandé
- A) A+B+C B) A+B C) B+E D) A+C+E E) A+B+D

26. Tous ces signes sont retrouvés dans l'hypercalcémie sauf:

- A. Vomissements
- B. Confusion
- C. Hypotension artérielle
- D. Déshydratation extracellulaire
- E. Coma

27. Tous ces signes peuvent se voir au cours de l'hypocalcémie sauf:

- A. Signe de Chvostek
- B. Signe de Trousseau
- C. Paresthésies distales
- D. Tétanie
- E. Diminution de l'espace QT à l'ECG

28. Chez le sujet non diabétique, quelle est la cause la plus fréquente de l'hypoglycémie organique :

- A. L'insuffisance surrénalienne centrale
- B. L'insuffisance surrénalienne périphérique
- C. L'Hypothyroïdie
- D. L'insulinome
- E. Les tumeurs non beta pancréatiques

29. Concernant l'insuffisance surrénalienne, quelle est la réponse fausse ?

- A. L'insuffisance surrénalienne primaire (Maladie d'Addison se caractérise par un déficit en cortisol et en aldostérone
- B. L'insuffisance surrénalienne secondaire est toujours associée à une hyperkaliémie
- C. Les signes cliniques fréquents incluent fatigue, hypotension, perte de poids et hyperpigmentation
- D. Le diagnostic repose sur la mesure de la cortisolémie à 8 h et le test de stimulation à l'ACTH (Synacthène)
- E. Le traitement repose sur l'hormonothérapie substitutive: hydrocortisone fludrocortisone selon le type

30. Parmi les signes cliniques de l'insuffisance surrénalienne primaire, lesquels sont fréquents?

- A. Asthénie/fatigue
- B. Hyperpigmentation des zones exposées et plis cutanés
- C. Hypertension artérielle sévère
- D. Amaigrissement
- E. Hypotension orthostatique

31. Parmi les éléments suivants, lesquels orientent vers une HTA secondaire

- A. Début avant 40 ans
- B. HTA résistante aux traitements classiques
- C. Hypokaliémie associée
- D. Survenue brutale d'une HTA modérée chez une personne âgée
- E. ATCD familiaux d'HTA

A)A+C B)A+C+D C)A+D+E D)A+B+D E)A+B+C

32. L'hyperaldostéronisme primaire: (RF)

- A, Il est souvent associé à une hypokaliémie
- B. L'aldostérone est basse et la rénine élevée
- C. Le dépistage repose sur le rapport aldostérone/rénine
- D. L'HTA est souvent résistante
- E. Le traitement peut être chirurgical ou médical selon la cause

33. le phéochromocytome: (RF)

- A. Il sécrète de façon autonome des catécholamines
- B. L'HTA est toujours permanente et constante
- C. Les symptômes typiques Incluent céphalées, palpitations et sueurs
- D. Le diagnostic repose sur les dosages des métanéphrines plasmatiques ou urinaires
- E. L'ablation chirurgicale est le traitement de choix

34. l'HTA du syndrome de Cushing:

- A. Elle est souvent associée à une obésité centrale et à un visage lunaire
 - B. Le dosage du cortisol libre urinaire sur 24 h permet le dépistage
 - C. L'HTA est toujours sévère et résistante
 - D. L'HTA disparaît immédiatement après traitement, quelle que soit la cause
 - E. Les tests de freinage à la dexaméthasone aident au diagnostic
- A)A+B+C B)A+B+D D)A+B+E E)B+C+D

35. pour le dosage du RAR, il est recommandé de respecter des conditions: (RF)

- A. Position assise de minimum 15mn
- B. Prélèvement matinal
- C. Régime désodé
- D. Normokaliémie
- E. Arrêt des antialdostérone

36. La polyurie du diabète insipide est définie chez l'adulte par:

- A. Une diurèse > 1,5 L/24 h
- B. Une diurèse > 2 L/24 h
- C. Une diurèse > 3 L/24 h
- D. Une diurèse > 5 L/24 h
- E. Une diurèse > 10 L/24

37. Dans le diabète insipide néphrogénique:

- A. L'ADH est toujours effondrée
- B. L'ADH est élevée ou normale
- C. L'osmolarité urinaire augmente fortement après administration de desmopressine
- D. La cause principale est auto-immune
- E. Le patient a une soif abolie

38. La cause la plus fréquente d'insuffisance hypophysaire chez l'adulte est:

- A. Le traumatisme crânien
- B. L'adénome hypophysaire
- C. L'hypophysectomie congénitale
- D. L'apoplexie hypophysaire
- E. L'hypophysite lymphocytaire

39. L'association brutale de céphalées, troubles visuels, d'hypotension artérielle et d'hypoglycémie évoque:

- A. Syndrome de Schwartz-Bartter
- B. Apoplexie hypophysaire
- C. Maladie d'Addison primitive
- D. Thyroïdite d'Hashimoto
- E. Hémorragie intra-thalamique

40. À propos du prolactinome: (choisissez la réponse fausse)

- A. Il est le plus fréquent des adénomes hypophysaires.
- B. La prolactine est stimulée par la dopamine hypothalamique.
- C. Le taux de prolactine est proportionnel à la taille de la tumeur.
- D. Le traitement de première intention repose sur la cabergoline.
- E. peut être responsable d'un retard pubertaire chez l'adolescent.

41. Les tumeurs de l'hypophyse: RF

- A. Les carcinomes représentent la majorité de ces tumeurs
- B. Les tumeurs de l'hypophyse sont des néoplasies de la selle turcique
- C. Elles sont dominées par les adénomes hypophysaires développés à partir de l'antéhypophyse
- D. Les adénomes hypophysaires peuvent être non sécrétants
- E. L'immunohistochimie met en évidence le type d'hormone sécrétée

42. Les neuroblastomes RF

- A. Sont des tumeurs de la médullosurrénale
- B. Prédominant chez l'enfant
- C. Se développent à partir de la lignée sympathique
- D. Sont des tumeurs bénignes
- E. Composée de neuroblastes immatures

43. Concernant les tumeurs corticosurrénales: RJ

- A. Les carcinomes corticosurrénaux sont très fréquents
- B. Se présentent comme une masse de grande taille > 5 cm d'aspect lobulé
- C. Le score de Weiss est valable dans les tumeurs oncocytaires
- D. Pour poser le diagnostic de malignité un seul critère histologique suffit.
- E. Les mitoses sont fréquentes

44. Le carcinome médullaire de la thyroïde: RF

- A. Il existe des formes sporadiques et des formes familiales.
- B. Les formes familiales peuvent entrer dans le cadre des néoplasies endocriniennes multiples de type II (NEM II)
- C. L'histologie montre un polymorphisme cellulaire: cellules rondes, polygonales, fusiformes
- D. Les cellules fixent l'anticorps anti calcitonine
- E. Se développe à partir des Cellules de l'épithélium vésiculaire

45. Le Carcinome papillaire de la thyroïde:

- A. Souvent de siège sous capsulaire V.
- B. Sa taille varie de 1 mm à 10 cm
- C. Le diagnostic repose sur la mise en évidence de modifications nucléaires particulières
- D. Le diagnostic repose sur la mise en évidence d'effraction capsulaire et d'embolies vasculaires
- E. L'histologie montre une architecture papillaire avec des micro-calcifications

46. Concernant les lipides, Il est recommandé de:

- A. Augmenter les acides gras saturés
- B. Préférer les huiles riches en oméga 6
- C. Privilégier les acides gras mono-insaturés
- D. Consommer les graisses trans
- E. Éviter les huiles à point de fumée élevé

47. Comment influence le mode de cuisson l'indice glycémique:

- A. La cuisson prolongée diminue l'IG
- B. La cuisson al dente des pâtes entraîne un IG plus bas
- C. La transformation d'un aliment en purée diminue l'IG
- D. De refroidissement des féculents après cuisson augmente l'IG
- E. La cuisson type wok, permet une destruction complète des glucides?

48. Chez un patient atteint d'insuffisance rénale chronique (IRC) stade 4 non dialysé, l'apport protidique recommandé est:

- A. > 1,2 g/kg/j
- B. 1 g/kg/j
- C. 0,6-0,8 g/kg/j
- D. 0,3 g/kg/j
- E. hypopurinique

49. Un indice glycémique élevé signifie:

- A. Un faible impact glycémique
- B. Une absorption lente du glucose
- C. Une élévation rapide de la glycémie
- D. Un aliment pauvre en glucides
- E. Un effet hypoglycémiant

50. L'activité physique recommandée chez l'adulte est:

- A. 30 min/mois
- B. 60 min/semaine
- C. 150-300 min/semaine modérée
- D. Uniquement intense
- E. Facultative si régime équilibré

CAS CLINIQUE 1:

Mme B., 32 ans, G2P1, consulte à 9 SA pour asthénie, palpitations modérées, intolérance à la chaleur et perte de poids de 2 kg en un mois.

Elle ne présente pas de vomissements gravidiques.

➤ Pas d'antécédents thyroïdiens connus.

➤ Examen clinique:

- FC: 98 bpm
- TA: **115**/70 mmHg
- IMC: 22 kg/m²
- Goitre discret. non douloureux
- Pas d'exophtalmie
- Examen obstétrical normal
- Bilan biologique initial
- TSH ultrasensible: 0,05 mUI/L
- FT4:21 pmol/L
- FT3: normale
- β-hCG: conforme au terme

51. Devant ce tableau, quels diagnostics doivent être évoqués en priorité ?

- A. Maladie de Basedow
- B. Hyperthyroïdie gestationnelle transitoire
- C. Thyroïdite d'Hashimoto en phase initiale
- D. Thyroïdite subaiguë de De Quervain
- E. Surdosage en lévothyroxine

A)A+E B) B+C C)C+D D)D+E E) A+E

➤ Investigations complémentaires demandées:

- Anticorps anti-TPO: très positifs
- Anticorps anti-TG: positifs
- Anticorps anti-récepteur de la TSH (TRAb) négatifs
- Echographie thyroïdienne: Thyroïde hypoéchogène, hétérogène, Vascularisation normale

52. Quel est le diagnostic final le plus probable ?

- A. Hyperthyroïdie gestationnelle transitoire
- B. Maladie de Basedow fruste
- C. Thyroïdite d'Hashimoto en phase d'hyperthyroïdie (hashitoxicose)
- D. Thyroïdite infectieuse
- E. Hyperthyroïdie iatrogène

Évolution (6 semaines plus tard -15 SA)

La patiente consulte pour fatigue intense, frilosité et prise de poids. Nouveau bilan: TSH: 8,5 mU/L FT4: basse

53. Cette évolution est caractéristique de:

- A. Une hyperthyroïdie gestationnelle prolongée
- B. Une maladie de Basedow biphasique
- C. Une thyroïdite d'Hashimoto évoluant vers l'hypothyroïdie
- D. Une erreur de laboratoire
- E. Une insuffisance hypophysaire

54. Quelle est la prise en charge thérapeutique à ce stade?

- A. Antithyroïdiens de synthèse
- B. B-bloquants prolongés
- C. Abstention thérapeutique
- D. Introduction de lévothyroxine
- E. Iode radioactif

55. Concernant la thyroïdite d'Hashimoto pendant la grossesse, quelles affirmations sont vraies

- A. Elle peut débuter par une phase d'hyperthyroïdie
 - B. Les TRAb sont habituellement positifs
 - c. Elle expose à un risque obstétrical si non traitée
 - D. Le traitement substitutif est souvent nécessaire
 - E. Elle contre-indique la grossesse
- A) A+C+D B) A+B+C C) B+C+D D) C+D+E E) A+E

CAS CLINIQUE 2:

Madame F. 30 ans nulligeste, nullipare, consulte pour aménorrhée à l'arrêt de sa contraception orale oestroprogestative depuis 4 mois, sans désir de grossesse. Ménarche à l'âge de 13 ans, développement pubertaire normal. La patiente n'a pas de cycle menstruel depuis 4 mois Le dosage qualitatif des bHCG est négatif.

56. Quelle est votre démarche diagnostique

- A. Prises médicamenteuses Radiothérapie ou chimiothérapie
- B. Maladie endocrinienne ou chronique (maladie cœliaque...)
- C. Chercher des douleurs pelviennes cycliques, on s'orientera vers une cause utérine
- D. l'existence de bouffées de chaleur+++inconstante, à insuffisance ovarienne
- E. Il s'agit d'une aménorrhée primaire

57. La patiente signale un hirsutisme important, séborrhée, acnée, quelles sont les causes des cet état d'hyperandrogénie

- A. SOPK
- B. Hyperplasie congénitale des surrénales
- C. Cause tumorale ovarienne
- D. Syndrome de sheehan
- E. iatrogénie

➤ **Le bilan biologique de la patiente retrouve:**

- Estradiol - 25 pg/ml (N en début phase folliculaire = 30-80).
- FSH = 3 UIA (N = 2-8)
- LH = 2 UIA (N = 2-5)
- Prolactine: 247 ng/mL (<20)
- Testostérone: 0,42 ng/mL
- TSH: 2,3 mUI/mL
- FT4: 15,1 pmol/L

58. Quel examen paraclinique demandez vous à visée étiologique ? RJ

- A. test au synactene
- B. hysterosalpingographie
- C. IRM pelvienne
- D. Caryotype
- E. IRM cérébrale

59. Il s'agissait d'un adénome à prolactine, quel est votre cat RJ

- A. Prescrire Un agoniste dopaminergique, de la bromocriptine
- B. De la cortisone
- C. Une chimiothérapie
- D. Surveillance
- E. Traitement chirurgicale d'emblée

60. quelles sont les causes d'aménorrhée :

- A. La grossesse
- B. L'hyperprolactinémie
- C. Le syndrome des ovaires polykystiques
- D. L'hypothyroïdie peut provoquer une aménorrhée ou des cycles irréguliers
- E. Toutes les réponses sont justes

Examen Gynécologie : Groupe 01 / 2026**Examen théorique:**

1- Quel(s) est/sont le(s) critère(s) d'un traitement médical de la grossesse extra-utérine ? (RJ)

1. Hémodynamique stable.
2. Patiente paucisymptomatique.
3. Hématosalpinx ≤ 3 cm à l'échographie.
4. GEU non visible à l'échographie.
5. HCG $\leq 5\ 000$ UI/L

A-(1-2-3-4-5) B-(1-2-3-4) C-(1-3-4-5) D1-(-2-5) E-(2-3-4)

2-L'évolution d'une grossesse ectopique (GEU): RJ

- A- La rupture brutale avec Hémopéritoine engageant le pronostic vital maternel
- B- La fissuration à bas bruit avec Hématocèle enkystée
- C- L'arrêt de la GEU avec involution spontanée
- D- La constitution d'un hématosalpinx
- E- Toutes ces propositions sont justes

3- La Présentation du siège: (RJ)

- 1- Son repère est représenté par le sacrum fœtal
- 2- La prématurité figure parmi ses étiologies
- 3- Est une présentation longitudinale hautement dystocique
- 4- La modalité la plus fréquente est celle du fœtus assis en tailleur
- 5- La manœuvre de Mauriceau est indiquée en cas de relèvement des bras

A (1-2-3-4) B (1-2-3-4-5) C(1-2-3) D(1-2) E (1-2-5)

4- Dans une présentation de siège, les critères d'une tentative d'accouchement par voie basse sont: RF

- 1-Deflexion de la tête fœtale
- 2-Uterus cicatriciel
- 3-Un promonto retro pubien < 9 cm
- 4-Age gestationnel inférieur à 30 SA
- 5-Poids fœtal estimé à 4000 gr

A (1,2) B (2,4) C (1,2,3) D (1,2,3,4) E(1,2,3,4,5)

5- Facteurs de risques du tumeurs malignes de l'ovaire: réponse fausse

- A Mutation des gènes BRCA 1 ou 2
- B- Le syndrome de Lynch
- C- Nulliparité, menarchie précoce; ménopause tardive
- D- Les patientes prisent en charge en fécondation in vitro
- E- La contraception orale, la grossesse et l'allaitement

6- Examen de 1ere intention en cas de tumeurs de l'ovaire: réponse juste

- A- IRM pelvienne
- B- Les marqueurs tumoraux
- C- Tomodensitométrie thoraco-abdominale
- D- Echographie pelvienne
- E- TEP scanner

7-Complications des tumeurs ovariennes : réponse fausse

- A- Torsion annexielle
- B- Hémorragie intra-kystique
- C- Rupture de kyste
- D- Compression
- E- Grossesse extra-utérine

8-Les kystes fonctionnels: réponse fausse

- A- Ne nécessite aucun traitement
- B- Disparaît lors des contrôles échographiques
- C- Sont folliculaires lorsqu'ils sont formés lors de la première partie du cycle
- D- Kyste du corps jaune lorsqu'il est formé au cours de la deuxième partie du cycle
- E- Nécessite un traitement chirurgical

9-Quelle est l'examen de référence dans le bilan d'extension locorégionale du cancer de l'endomètre ? réponse juste

- A- L'hysteroscopie
- B- La cystoscopie
- C- L'examen clinique pelvien sous anesthésie
- D- La rectoscopie
- E- L'IRM pelvienne

10-Quels sont les modes d'action des pilules œstroprogestative: réponse juste

- A-blocage de l'ovulation
 - B-blocage de la folliculogénèse
 - C-l'absence de formation du corps jaune
 - D-modification de la glaire cervicale
 - E-muqueuse endométriale impropre à la nidation
- A(a-b-c) B-(c-d-e) C-(a-d-e) D-(b-c-d) E(a-c-e)

11- complications possibles d'une contraception par stérilet:

- a-douleur pelvienne.
 - b-perforation utérine.
 - c-hémorragie génitale
 - d-chute d'organe.
 - e-grossesse.
- A-(a-b-c) B-(b-d-e) C-(c-d-e) D-(b-d-a) E(a-c-e)

12-les GHR présente un problème de santé publique d ou la nécessité de :(RF)

- A-dépistage précoce.
- B-prise en charge adaptée.
- C-surveillance essentiellement par l'obstétricien
- D-Surveiller le taux de mortalité maternelle et périnatale afin de mieux axer la prise en charge de ces GHR
- E-maitriser l'accouchement des GHR

13-parmi les facteurs de risque de développer une grossesse à haut risque :(RF)

A-Age Inférieur 17 ans ou sup a 35 ans

B-Bas niveau socio-économique.

C-Alcool-tabac

D-Obésité.

E-ATCD de mort de travail

14-Les complications des fibromes utérins: réponse fausse

A- Nécrose

B- Torsion

C- Hydronéphrose

D- Hémorragies

E- Dégénérescence épithéliomateuse

15-L-'Infertilité du couple: réponse fausse

A- Une infécondité

B-Incapacité de concevoir après une année de rapports sexuelles réguliers

C- Infertilité plus de 2ans chez les patiente âgées mois de 35ans

D- Elle peut être primaire ou secondaire

E- Certaines causes d'infertilité restent sans cause (infertilité inexplicée)

16-La rupture utérine: réponse fausse

A- Le plus souvent su un utérus cicatriciel

B- Peut-être spontanée ou provoquée

C- Peut être responsable de morbi-mortalité materno-fœtal

D- Très fréquente au 1er trimestre lorsque la cicatrice est d'origine gynécologique

E- Survient pendant la grossesse ou pendant le travail

17-Parmis les causes de la ruptures utérines sont réponse fausse

A- Les accouchements dystociques

B- Les expressions utérines

C- L'accouchement du siège

D- La disproportion foeto-pelvienne

E- L'utilisation irrationnelle de l'ocytocine

18-Les étiologies des avortements spontanées : réponse fausse

A- Les anomalies chromosomiques sont la cause la plus fréquente

B- Diabète chronique

C- Le syndrome de SAPL

D- insuffisance du corps jaune (insuffisance lutéale)

E- La béance cervico isthmique et la cloison utérine

19-Dans les présentations défléchies: réponse juste

A- La présentation front est la plus fréquente des présentations défléchies

B. Le repère de la présentation de la face est le nez

La présentation de la face est une déflexion 3/3

D- La présentation de la face est souvent confondue avec la présentation transverse

E- La présentation de la face est eutocique dans la variété postérieure

20-L'hémorragie de la délivrance: réponse fausse

- A- Est une vraie urgence
- B- Peut-être causé par les troubles de l'hémostase
- C- Nécessite une prise en charge immédiate
- D- Le recours à l'hystérectomie est toujours le seul traitement
- E- Un examen de la filière génitale est impératif

21-L'allo-immunisation réponse fausse

- A- Secondaire aux passages des hématies fœtales dans la circulation maternelle.
- B- Les anticorps maternels sont de type IGG
- C- Le risque est l'ictère néo natal
- D- Survient lorsque le rhésus maternel est positif et le rhésus fœtal est négatif
- E- Le risque fœtal est l'anémie et le mort fœtale in utero

22-L'incompatibilité fœto-maternelle: réponse juste

- A- Survient toujours lors de la première grossesse
- B- Survient chez une mère RH positif avec un fœtus RH négatif
- C- Peut-être prévenue par l'injection d'anti D lorsque le taux de RAI est positif
- D- Lié au passage transplacentaire d'IgG
- E- Peut-être diagnostiqué par le test de Coombs indirect chez le nouveau-né

Mme A., 28 ans, G1P1, a accouché par voie basse Il y a 48 heures d'un nouveau-né vivant, à terme, de 3300 g.

Le travail a été long, avec rupture prématurée des membranes depuis 18 heures.

Les suites immédiates de couches ont été simples.

Depuis ce matin, la patiente présente :

- une fièvre à 39 °C
- des douleurs pelviennes
- des lochies fétides
- une sensibilité utérine à la palpation

23-Quel(s) diagnostic(s) évoquez-vous en priorité?

- A. Endométrite du post-partum
- B. Thrombophlébite pelvienne septique
- C. Infection urinaire
- D. Hématome du périnée
- E. État subfébrile physiologique du post-partum

**24-Parmi les éléments suivants, lesquels constituent des facteurs de risque d'endométrite?
RF**

- A. Rupture prolongée des membranes
- B. Travail long
- C. Accouchement par voie basse
- D. Touchers vaginaux répétés
- E. Césarienne

25-Quels examens sont indiqués en première intention? RF

- A. NFS, CRP
- B. Hémocultures
- C. ECBU
- D. Echographie pelvienne
- E. IRM pelvienne

26-Quelles propositions thérapeutiques sont adaptées ? réponse fausse

- A. Antibiothérapie probabiliste IV large spectre
- B. Antipyrétiques et antalgiques
- C. Surveillance des éléments cliniques et biologiques
- D. Révision utérine si rétention suspectée
- E. Arrêt immédiat de l'allaitement

27-En l'absence de prise en charge adaptée, quelles complications peuvent survenir?

- A. Sepsis
- B. Thrombophlébite pelvienne
- C. Infertilité secondaire
- D. Choc septique
- E. Abscess pelvien

28-Concernant la prise en charge de l'accouchement des présentations défléchies: réponse fausse

- A. La présentation de front impose une césarienne à terme
- B. Une présentation de face menton postérieur contre-Indique la voie basse
- C. Une rotation spontanée du menton est possible pendant le travail
- D. La surveillance du travail doit être renforcée
- E. L'extraction instrumentale est toujours possible en présentation de face

29-Concernant les complications de l'accouchement des présentations défléchies: réponse fausse

- A. Le risque de dystocie est augmenté
- B. Le risque de souffrance fœtale est plus élevé
- C. Les lésions faciales néonatales sont possibles
- D. Le pronostic maternel n'est pas vraiment engagé c'est surtout fœtal
- E. Le risque de rupture utérine n'est pas nul

30-Concernant la présentation de front: réponse fausse

- A. Le diamètre engagé est le diamètre mento-vertical
- B. Le point de repère est le front
- C. L'accouchement par voie basse est impossible à terme
- D. Elle est souvent transitoire
- E. Elle n'est pas compatible même avec un bassin normal

31-À propos de la présentation de face: réponse fausse

- A. Le point de repère est le menton
- B. Le diamètre engagé est le sous-mento-bregmatique
- C. L'accouchement par voie basse est possible si le menton est antérieur
- D. Le diamètre engagé est le mento-vertical
- E. Le travail est généralement plus long que dans la présentation du sommet

32-En l'absence de prise en charge, la présentation transversale peut entraîner : réponse fausse

- A. Procidence du cordon
- B. Rupture utérine
- C. Accouchement eutocique
- D. Souffrance foétale aiguë
- E. Mort foétale

33- Prolapsus génitale, l'élytrocele est un prolapsus: réponse juste

- A- Du col utérin
- B- De la vessie
- C- Du rectum
- D- Du corps utérin
- E- Du cul de sac de Douglas

34-Quels sont les facteurs qui favorisent le prolapsus génital:

- 1- La nullipare
 - 2- L'accouchement par forceps
 - 3- La toux chronique
 - 4- Port de charge lourde.
 - 5- L'accouchement d'un macrosome
 - 6- Episiotomie lors de chaque accouchement
- A(5-6) B (2-5-6) C (2-3-4-5-6) D (2-3-4-5) E (2-5)

35-Parmis ces propositions sur le fibrome est grossesse laquelle est fausse:

- A- Un fibrome peut générer le diagnostic d'une grossesse très jeune
- B- Lorsque on fait le diagnostic d'un volumineux fibrome aux troisièmes trimestres Il faut faire la myomectomie
- C- Le fibrome peut être un obstacle à l'accouchement
- D- La nécrobiose aseptique est la complication la plus fréquente pendant la grossesse
- E- On observe plus souvent des présentations anormales

36-Au cours d'une suspicion de grossesse extra-utérine, lorsque l'examen clinique vous semble normal quel sera votre prochaine étape: réponse juste

- A- Reconvoquer la patiente 10jous après
- B- Pratiquer une coelioscopie, meilleur élément de diagnostic et de traitement
- C- Demander un taux de BHCG et une échographie
- D- L'opérer immédiatement
- E- Aucune de cette réponse n'est juste

37-Une biopsie du col montre un épithélium malpighien avec trouble de maturation, désorganisation de la stratification, hyperchromatisme, atypies cytonucléaires et mitoses ascensionnées, sans franchissement de la membrane basale. Le diagnostic est:

- A. Métaplasie malpighienne.
- B. Dysplasie (lésion intra épithéliale malpighienne).
- C. Carcinome épidermoïde invasif.
- D. Hyperplasie réactionnelle.
- E. Papillome bénin

38-L'évolution potentielle de ces lésions est:

- A. Transformation en carcinome épidermoïde invasif.
- B. Transformation en adénocarcinome endométrial.
- C. Transformation en sarcome.
- D. Transformation en lymphome.
- E. Guérison spontanée constante.

39-Concernant le cancer du col utérin et ses aspects cliniques et histopathologiques, toutes les propositions suivantes sont exactes sauf une:

- A. Le carcinome épidermoïde représente environ 80-90% des cancers du col.
- B. L'adénocarcinome se développe à partir de l'épithélium cylindrique endocervical et représente 10-20 % des cas
- C. Les formes rares comprennent le sarcome, le mélanome et le lymphome.
- D. Les formes bourgeonnantes sont souvent friables et saignent facilement au contact.
- E. Le carcinome épidermoïde est constitué de petites cellules rondes sans kératinisation ni ponts d'union.

40-Les tumeurs séreuses borderlines de l'ovaire se caractérisent par: (RF)

- A. Un bourgeonnement épithélial
- B. Une pluri stratification du revêtement épithélial
- C. Des atypies cytonucléaires modérées
- D. Une infiltration du chorion sous-jacent
- E. Des calcosphérites des 50% des cas.

41-Les carcinomes à cellules claires de l'ovaire: (RF)

- A- Présente un polymorphisme architectural et cellulaire.
- B- L'architecture peut être papillaire, tubulo-kystique et solide,
- C-Sont de nature épithéliale,
- D-Sont considérées comme des tumeurs de bas grade,
- E-Présentent un aspect en clou de tapissier.

42-La biopsie de l'endomètre est nécessaire dans les cas suivants, sauf un lequel ?

- A. Une infection spécifique
- B. Une lésion précancéreuse
- C. Cancer de l'endomètre
- D. L'endométriose
- E. Evaluation de la fonction hormonale

43-Tous ces aspects sont retrouvés dans l'hyperplasie atypique sauf un lequel ?

- A. Perte de la polarité cellulaire et nucléaire.
- B. Pluri stratification de l'épithélium de revêtement.
- C. Noyaux allongés, ovoïdes sans nucléoles, chromatine fine
- D. Augmentation du nombre des glandes par rapport au chorion
- E. Des images de mitoses fréquentes

44-La biopsie de l'endomètre d'une femme ménopausée objective: (RF)

- A. Une muqueuse peu épaisse
- B. Des glandes rectilignes, petites de taille à lumière étroite.
- C. Un chorion cytogène très peu cellulaire
- D. Absence de mitoses
- E. Un épithélium cubique pseudo stratifié.

45-La fibrose et l'oblitération de la lumière tubaire sont caractéristiques de (RJ):**A- Salpingite aiguë**

- B-Salpingite chronique
- C-Tumeur bénigne
- D-Grossesse ectopique
- E-Hyperplasie épithéliale

45-La stéatonécrose mammaire évolue classiquement vers (RJ):

- A. Une résorption complète sans séquelle.
- B. Une transformation maligne de type carcinome canalaire.
- C. Une fibrose, des calcifications et la présence de cellules géantes à corps étranger.
- D. La formation de microabcès à polynucléaires neutrophiles.
- E. Une atrophie complète du lobule concerné.

47-Le critère histologique principal permettant de distinguer une tumeur phyllode de bas grade d'un fibroadénome est (RJ)

- A. La présence d'une double assise cellulaire.
- B. La nature kystique des cavités glandulaires.
- C. L'augmentation de la cellularité du stroma conjonctif
- D. L'infiltration du tissu adipeux
- E. L'atypie marquée des cellules épithéliales

48-La lésion typiquement retrouvée chez la femme enceinte ou allaitante est (RJ):

- A. La cicatrice radiaire.
- B. L'adénome lactant.
- C. La mastite plasmocytaire.
- D. Le papillome central.
- E. L'adénose sclérosante.

49- La souffrance fœtale algue (SFA) est principalement définie par:

- A- Une hyperoxie fœtale.
- B- Une acidose métabolique liée à une hypoxie.
- C- Une alcalose respiratoire fœtale.
- D- Une augmentation du liquide amniotique.
- E- Une hypertension artérielle fœtale isolée.

50- Les décélérations tardives (DIP II) sont caractérisées par :

- A- Un début synchrone avec la contraction utérine.
- B-Un nadir (point le plus bas) qui survient après le sommet de la contraction.
- C-Une forme en "V" très brusque.
- D-Un lien exclusif avec une compression du cordon.
- E-Une récupération immédiate dès la fin de la contraction

51-En cas d'anomalie du RCF (catégorie II), quel examen permet de confirmer une acidose fœtale avec la meilleure spécificité

- A Le score de Manning
- B) Le Doppler de l'artère ombilicale.
- C) La mesure des lactates au scalp fœtal
- D) L'échographie cardiaque fœtale.
- E) L'amnioscopie

52- Devant des anomalies sévères du RCF liées à une hypercinésie utérine (contractions trop fréquentes), quelle est la conduite immédiate ?

- A-Augmenter le débit d'ocytocine.
- B-Mettre la patiente en position assise.
- C- Mettre la patiente en position DLG+ 02 ET administrer un traitement tocolytique et arrêter l'ocytocine
- D-Pratiquer une épisiotomie immédiate.
- E-Poser une sonde urinaire

Mme K., 32 ans, primigeste, à 31 semaines d'aménorrhée (SA), est hospitalisée pour une suspicion de RCIU.

Examen clinique: Tension artérielle à 155/98 mmHg, hauteur utérine à 24 cm (normale attendue: 27-28 cm)

Echographie: Biometries fœtales au 3ème percentile, oligoamnios (index amniotique réduit).

Doppler: Artères utérines perturber avec "notching", Doppler ombilical avec flux diastolique nul (reverse flow absent).

53-Quel est l'élément clinique initial ayant fait suspecter la SFC chez cette patiente? réponse juste

- A. La présence d'une hypertension artérielle.
- B. La diminution des mouvements actifs fœtaux.
- C. L'insuffisance de la hauteur utérine.
- D. L'âge gestationnel de 31 SA.
- E La prise de poids excessive de la patiente.

54- L'étiologie la plus probable de cette souffrance fœtale chronique est: réponse juste

- A. Une infection fœtale à CMV.
- B. Une anomalie chromosomique (Trisomie 18).
- C. Une insuffisance placentaire d'origine vasculaire.
- D. Une consommation de substances toxiques (tabac).
- E. Un diabète gestationnel mal équilibré.

55-L'étiologie la plus probable de cette souffrance fœtale chronique est réponse juste

- A. Une infection fœtale à CMV.
- B. Une anomalie chromosomique (Trisomie 18).
- C. Une insuffisance placentaire d'origine vasculaire.
- D. Une consommation de substances toxiques (tabac).
- E. Un diabète gestationnel mal équilibré

56- Quel paramètre échographique définit le mieux le RCIU "harmonieux" par rapport au RCIU "dysharmonieux" ? réponse juste

- A. Le périmètre abdominal uniquement.
- B. Le rapport périmètre céphalique / périmètre abdominal (PC/PA)
- C. La quantité de liquide amniotique.
- D. La mesure de la clarté nucale.
- E. Le poids placentaire

57-Quelle est la conduite à tenir Immédiate concernant la prématurité induite dans ce cas (31SA)? réponse juste

- A. Extraction immédiate par césarienne sans préparation.
- B. Transfert dans une maternité de type 1.
- C. Corticothérapie anténatale (Bétaméthasone) pour la maturation pulmonaire.
- D. Sulfate de magnésium pour le traitement de l'HTA.
- E. Repos strict au lit sans autre traitement.

58- Quel est le but de la neuroprotection par Sulfate de Magnésium dans ce contexte ?

- A. Faire baisser la tension de la mère.
- B. Prévenir les convulsions d'éclampsie chez la mère.
- C. Réduire le risque de paralysie cérébrale chez le prématuré de moins de 32 SA.
- D. Augmenter le flux sanguin vers le placenta.
- E. Accélérer la maturation rénale fœtale.

59- Concernant le traitement antibiotique d'une IGH non compliquée, quelle est la stratégie de référence ?

- A- Monothérapie par Amoxicilline pendant 7 jours.
- B-Antibiothérapie probabiliste, double ou triple, associant généralement Ceftriaxone (IM dose unique), Doxycycline (14 jours) et Métronidazole (14 jours).
- C-Traitement par ovules antifongiques pendant 3 jours.
- D-Hospitalisation systématique pour antibiothérapie intraveineuse de 21 jours.
- E-Abstention thérapeutique en attendant les résultats définitifs de la culture.

60- Parmi les facteurs favorisant la présentation transversale, on retrouve: réponse fausse

- A-Multiparité
- B-Placenta prævia
- C-Hydramnios
- D-Oligoamnios
- E-Grossesse gémellaire

PARTIE PRATIQUE:

1-l'examen du bassin: Réponse juste

- A- Évalue les dimensions et la forme du bassin féminin pour prédire la faisabilité d'un accouchement par voie basse
- B- impliquant uniquement un toucher vaginal
- C- N'est pas important à réaliser après un accouchement par césarienne
- D- Un examen clinique du bassin normal permet à coup sûr que l'accouchement se fera par voie basse
- E- Se fait uniquement par l'obstétricien

2-concernant le bassin obstétrical: réponse fausse

- A- Contient deux orifices et une excavation
- B- L'engagement de la présentation se fait au niveau du détroit supérieur
- C- L'exploration se fait par une pelvimétrie interne
- D- Le détroit moyen est un rétrécissement du niveau du tiers supérieure de l'excavation
- E- Le détroit inférieur est fait du détroit osseux et du bassin mou

3-La tête fœtale s'accommode au détroit supérieur grâce: Réponse juste

- A- Mouvement de flexion
- B- L'orientation en oblique
- C- Un mouvement d'asynclitisme
- D- Des déformations plastiques
- E- Toutes ces réponses sont justes

4-Concernant l'hystérosalpingographie laquelle est juste réponse juste

- A- Est le meilleur moyen pour explorer l'appareil génital féminin
- B- Actuellement n'est intéressante que pour explorer les trompes
- C- Permet d'explorer les ovaires
- D- Peut se faire à n'importe quel moment du cycle
- E- Toutes ces réponses sont fausses

5-A propos de la délivrance: (RF)

- A- Est la quatrième étape de l'accouchement
- B- Correspond à l'expulsion des annexes fœtales hors des voies génitales
- C- Survient dans la demi-heure suivant l'accouchement
- D- L'examen du délivre est systématique
- E- Il faut administrer des ocytociques dès la sortie des épaules

6-La délivrance normale: réponse juste

- A- La délivrance survient juste après l'expulsion du fœtus
- B- Le décollement placentaire est favorisé par la constitution d'un hématome rétro placentaire qui peut être responsable d'une souffrance fœtale lorsqu'il est précoce
- C- Une délivrance mode Duncan est moins hémorragique
- D- L'hémostase est assurée grâce à la ligature vivante de Pinard
- E- Aucune réponse n'est juste

7-L'échographie du 1 trimestre permet: réponse fausse

- A- L'évolutivité de la grossesse
- B- La chronicité en cas de grossesse multiple
- C- Permet la datation exacte de la grossesse
- D- Permet de calculer la clarté nucale et la longueur crânio-caudale
- E- Permet d'apprécier la croissance fœtale

8-L'échographie du deuxième trimestre permet d'apprécier réponse fausse

- A- La mesure des biométries fœtales
- B- La localisation placentaire
- C- La quantité du liquide amniotique
- D- La mesure de la clarté nucale
- E- Etude de la morphologie fœtale

9- Parmi les propositions suivantes laquelle ne fait pas partie des facteurs de risque de la macrosomie fatale

- A- Diabète gestationnel
- B- Multiparité
- C- L'obésité
- D- Le syndrome des ovaires polykystique
- E- L'âge maternel supérieur à 35ans

10-Le mécanisme générale de l'accouchement: réponse fausse

- A-La présentation du sommet est une présentation fléchie
- B-L'IODA est la présentation la plus fréquente
- C-Le repère de la présentation sommet est la petite fontanelle
- D-La présentation du sommet est une présentation eutocique
- E-En début du travail, la tête est perçue à travers l'orifice cervical

11-La protection civile vous sollicite pour un accouchement sur siège imposé; il s'agit d'une G5P4 sans antécédents médico-chirurgicaux particuliers. Femme en phase d'expulsion à dilatation complète, siège dégagé et le dos amorce sa rotation en arrière qu'elle sera votre CAT: (RJ)

- A- Réaliser une grande extraction du siège.
- B-Faire une césarienne d'urgence.
- C-Terminer l'accouchement avec rotation du 'dos en avant et manœuvres de LOVSET puis Mauriceau
- D-Terminer l'accouchement avec rotation du dos en avant et une manœuvre de Bracht
- E-Terminer l'accouchement avec rotation du dos en avant manœuvre de VERMELIN.

12-vous êtes de garde, et vous recevez en salle de naissance une patiente âgée de 34 ans aux antécédents de deux accouchement eutocique max de poids 2200GR, qui mène une grossesse à terme

À l'examen: on note une macrosomie manifeste

BCF bon et régulier

Le toucher vaginal retrouve un col très court souple à deux doigts larges poche des eaux bombante présentation très haute

Quelle sera votre prise en charge en salle de naissance: réponse juste

A-pratiquer un ERCEF et ouvrir un partogramme

- B-L'examen obstétrical n'est pas nécessaire car la patiente a déjà accouché
- C-mettre en route une perfusion d'ocytocine pour accélérer l'accouchement car c'est un macrosome
- D-mettre une voie d'abord, un ERCF, et un examen clinique du bassin
- E-aucune de ces réponses n'est compatible avec la prise en charge de cette parturiente

13-Le travail se déroule sans problème, mais au moment de l'expulsion la sage-femme vous appelle pour une dystocie des épaules quels attitudes vous allez pratiquer: réponse fausse

- A- Manœuvre de Mac Robert
- B-Manœuvre de Wood
- C- Manœuvre de Wood inverse
- D-Manœuvre de Jauquemier
- E-Manœuvre de Leopld

14-L'accouchement se termine bien mais au bout de 30 mn le placenta n'est pas délivré que faut-il faire: réponse juste

- A- Une perfusion d'ocytocine pour faire une délivrance dirigée
- B- faut faire une délivrance artificielle sous respect strict de l'asepsie
- C- Il ne faut pas se précipiter et ajouter encore 15 mn
- D- Faire un curage
- E- faire un curetage

15-Quel risque encours cette parturiente:

- A- Risque infectieux majeur
- B- Risque de déchirure périnéale
- C- Risque d'embolie pulmonaire
- D- Risque d'hémorragie de la délivrance
- E- Aucun des risques suscités

16-Concernat le curetage utérin: réponse juste

- A- Est systématique devant un avortement
- B- Indique quand la grossesse est de 16SA
- C- Est uniquement d'indication obstétrical
- D- Peut être pratiqué chez une patiente pour explorer des métrorragies post ménopausique
- E- Fait encourir un risque majeur infectieux

17-Concernant le dépistage organisé du cancer du sein, quelle proposition est vraie ?

- A- Il concerne les femmes a partir 50 ans
- B- Il repose sur une mammographie bilatérale pour plus de 40 ans et échographie mammaire pour moins de 40ans
- C- Il est réalisé tous les 3ans
- D- Il réduit la mortalité liée au cancer du sein
- E- Il nécessite une biopsie systématique

18-Concernant le cancer du col de l'utérus: réponse fausse

- A- Il est lié dans la majorité des cas à une infection par HPV tous type confond
- B- Le dépistage permet de détecter des lésions précancéreuses
- C- Il survient à tout moment de la vie de la femme
- D- Il est évitable par la vaccination
- E- C'est un cancer viro induit

19-L'hystérosalpingographie est: réponse juste

- A- Un examen endoscopique
- B- Un examen radiologique avec produit de contraste
- C- Un examen explorant essentiellement la cavité utérine
- D- Un examen thérapeutique
- E- Réalisée sous anesthésie générale

20-Devant une HPP persistante malgré ocytocine et massage : réponse fausse

- A-Vérifier la vacuité utérine
- B-Rechercher une déchirure cervicale
- C- Attendre l'arrêt spontané
- D- Explorer la coagulation
- E-Réaliser une révision utérine

Examen Gynécologie Groupe : 04 / 2026**Partie théorie:****1- La Présentation du siège: (RJ):**

- 1- Son repère est représenté par le sacrum fœtal
 - 2- La prématurité figure parmi ses étiologies
 - 3- Est une présentation longitudinale hautement dystocique
 - 4- La modalité la plus fréquente est celle du fœtus assis en tailleur
 - 5- La manœuvre de Mauriceau est indiquée en cas de relèvement des bras
- A. 1-2 B. 2-3-4-5 C. 1-2-3 D. 1-2 E. 1-2-5

2- Concernant les présentations du siège ? (RF):

- A- Le repère est le sacrum
- B- Le diamètre d'engagement est le bi trochantérien pour les deux modes.
- C- La prématurité est la cause fœtale la plus fréquente
- D- Le foyer des BCF est souvent sous ombilical dans le mode des pieds
- E- Le pied peut être touché au niveau de l'aire de dilatation dans le siège complet

3- Dans la présentation de siège, laquelle de ses propositions est juste:

- 1- Le siège décomplété est le mode des fesses
 - 2- Le diamètre biacromial s'oriente selon le diamètre du DS par le diamètre bitrochantérien
 - 3- Le siège fait donc une rotation de 45° en arrière dans les variétés sacro-iliaques postérieures
 - 4- Le dégagement se fait en sacro-transverse (droit ou gauche)
 - 3- La présentation du Bregma peut constituer un diagnostic différentiel
- A-1-3-4 B-4-5 C-1-2-4 D-1-3-5 E-1-2-5

4- Les critères d'acceptation de la voie basse dans la présentation du siège RJ:

- 1- Lésions rétinienne maternelles prédisposant au décollement de la rétine
 - 2- Une tête fœtale non défléchie à l'échographie du à la radio du contenu utérin
 - 3- Le promonto-retro-pubien à 85mm
 - 4- Les biométries fœtales au 50 ème percentile
 - 5- Un tracé du rythme cardiaque fœtal réactif
- A (1+2+3) B (2+3+5) C (1+2+5) D (2+4+5) E (1+3+5)

5- l'outil le plus sensible pour le diagnostic de la menace d'accouchement prématuré:

- A- La longueur du col
- B- le toucher vaginal
- C- la recherche de la fibronectine fœtale vaginale
- D- la perception de contraction
- E- toutes ces réponses sont justes

6- Parmi ces anomalies possibles lors de l'accouchement en présentation du siège, quelle est la dystocie la plus grave: La RJ

- A. La rupture précoce de la poche des eaux
- B. La dilatation traînante
- C. Le relèvement d'un bras
- D. L'arrêt de progression
- E. la rotation du dos en arrière

7- La présentation de la face: RF

- A- Le repère de la présentation est le menton
- B- C'est une présentation exclusivement dystocique
- C- L'accouchement par les voies naturelles n'est possible que si le menton tourne en avant
- D- Le dégagement de la tête se fait le plus souvent par forceps
- E- La césarienne est indiquée dans les présentations de la face en MIDP

8- La présentation de la face: RF

- A- C'est une présentation rare
- B- Le diamètre d'engagement est le sous mento bregmatique
- C- Le diamètre d'engagement est sincipito pré sternale
- D- La variété de présentation en MIGA est la plus fréquente
- E- Le dégagement se fait après déflexion de la tête

9- dans la présentation du front: RJ

- A- C'est une présentation fréquente
- B- L'accouchement par les voies naturelles n'est possible que par l'application d'un forceps
- C- L'accouchement par voie basse est impossible.
- D- Le repère de la présentation est la grande fontanelle
- E- Le diamètre de la présentation est le diamètre occipito frontal

10- dans la présentation du bregma: RF:

- A- La tête se présente en position partiellement fléchie
- B- Le repère de la présentation est le front
- C- L'engagement se fait après flexion de la tête
- D- L'engagement se fait par tassement de tous les diamètres de la tête fœtale
- E- Le dégagement se fait par flexion puis déflexion de la tête

11- Dans la présentation transversale: RF

- A. Elle est souvent due à la prématurité
- B. L'échographie est un outil diagnostique indispensable.
- C. La césarienne est le choix thérapeutique privilégié.
- D. L'indication principale de la VMI est réservée à l'extraction du deuxième jumeau
- E. Le pronostic materno-fœtal est réservé

12- Quel(s) est/sont le(s) critère(s) d'un traitement médical de la grossesse extra-utérine: (RJ)

1. Hémodynamique stable..
 2. Patiente paucisymptomatique.
 3. Hématosalpinx 53 cm à l'échographie.
 4. GEU non visible à l'échographie.
 5. HCG $\leq$ 5 000 UI/L
- A. 1-2-3-4-5 B. 1-2-3-4 C. 1-3-4-5 D. 1-2-5 E. 2-3-4

13- Le premier diagnostic à soulever chez une patiente âgée de 35 ans, G0P0 avec antécédent de tuberculose extra-pulmonaire traitée il y a 10 ans et insémination Intra-utérine avec sperme du conjoint il y a 02 mois et demi (HSG non faite) se présentant aux urgences dans un tableau d'hémorragie interne avec état de choc: la RJ

- A. Une pelvipéritonite post-insémination
- B. Une grossesse ectopique rompue
- C. Une torsion d'annexe certaine
- D. Une rupture d'un kyste ovarien méconnu
- E. Une reprise évolutive de la tuberculose

14- Lorsque l'examen clinique semble normal lors d'une suspicion de grossesse extra-utérine, que faut-il faire: RJ

- A. Reconvoquer la patiente 21 jours plus tard pour nouvel examen
- B. Faire une coélioscopie
- C. demander un dosage de B-HCG et une échographie
- D. L'opérer immédiatement
- E. Aucune de ces propositions n'est correcte

15- l'évolution d'une grossesse ectopique (GEU): RJ

- A. La rupture brutale avec Hémopéritoine engageant le pronostic vital maternel
- B. La fissuration à bas bruit avec Hématocèle enkystée
- C. L'arrêt de la GEU avec involution spontanée
- D. La constitution d'un hématosalpinx
- E. Toutes ces propositions sont justes

16- Dans la définition du couple Infertile:

- A- c'est l'absence de conception au-delà de 6 mois chez la patiente de plus de 35 ans
- B- absence de conception au-delà de 18 mois chez la femme moins de 35 ans
- C- juste après le mariage puisque l'infertilité est multifactorielle
- D- aucune de ces définitions
- E- toutes les définitions sont justes selon les dernières recommandations

17- Parmi les propositions concernant la toxoplasmose congénitale, une seule est fausse, laquelle ?

- A- L'infection foétale résulte classiquement du passage de toxoplasmose par voie transplacentaire
- B- Elle peut entraîner des atteintes cérébrales chez l'enfant
- C- Il faut que la primo-infestation de la mère ait lieu au cours de la grossesse
- D- La fréquence de transmission est d'autant plus grande que la grossesse est avancée
- E- L'atteinte foétale est d'autant plus sévère qu'elle est tardive

18- Les conséquences de l'infection rubéolique: RF

- A- Malformation cardiaque
- B- Malformation oculaire
- C- Malformation cochléaire
- D- Retard de croissance intra-utérin
- E- Malformation rénale

19- Une grossesse est dite « à haut risque » lorsqu'elle:

- A- Présente un risque accru de complications maternelles et ou fœtales
- B- Présente un risque accru de complications maternelles uniquement
- C- Nécessite une surveillance et un suivi à partir de 28 SA
- D- l'accouchement à 37 S est souhaitable quel que soit l'étiologie
- E- Toutes les réponses sont correctes

20- Parmi les facteurs de risque maternels de grossesse à haut risque, on peut citer:

- A- L'âge maternel < 18 ans ou > 35 ans
- B- Le tabagisme actif
- C- L'obésité ou le diabète
- D- Grandes multiparité
- E- Toutes les réponses sont justes

21- Dans une môle hydatiforme complète, quelle anomalie biologique est la plus caractéristique et la plus discriminante par rapport à une mole partielle ?

- A. Augmentation du CA-125 clinique modérée
- B. Hyperthyroïdie
- C. Un Taux de B-hCG très élevé, souvent > 100 000 UI/L
- D. Hypokaliémie associée à des vomissements
- E. toutes ces réponses sont justes

22- L'hémorragie de la délivrance est définie par :RJ

- A- une quantité de sang sup ou égale à 500 ml après accouchement voie basse
- B- une quantité sup ou égale à 1000 ml après accouchement par voie haute uniquement
- C- une quantité inférieure à 500 ml avec retentissement hémodynamique dans le post partum immédiat
- D- une quantité sup ou égale à 500 ml quel que soit le mode d'accouchement
- E- Toutes ces réponses sont fausses suites aux dernières recommandations

23- Une gestante rhésus négatif fœtus rhésus positif doit faire l'anti D sauf (une question fausse)

- A- Après accouchement test de Coombs positif chez la maman
- B- GEU
- C- avortement
- D- Manœuvre obstétricale
- E- un cerclage utérin

24- La pilule œstroprogestative normo dosée RF

- A- sont une contraception efficace
- B- sont pourvoyeuse d'accident thrombo embolique
- C- sont contre indiquée en cas d'ATCD d'AVC
- D- Ne peut absolument être prescrit chez la femme plus de 40 ans
- E- doit bénéficier d'un bilan préalable avant sa prescription

25- Quelle anomalie n'est pas un facteur de risque obstétrical?

- A- Antécédent de pré-éclampsie
- B- Antécédent de fausse couche précoce Isolée
- C- Antécédent de césarienne
- D- Grossesse multiple
- E- La grande multiparité

26- Quel est le rôle du suivi dans une grossesse à haut risque ?

- A- Vérifier que tout est normal
- B- Confirmer qu'il n'y a aucun problème
- C- Permettre une prise en charge proactive pour prévenir les complications
- D- Réduire la fréquence des rendez-vous médicaux
- E- Se contenter d'attendre que les complications apparaissent

27- Lors de l'exploration d'une aménorrhée primaire: RF

- A- par définition c'est l'absence de règles au-delà de l'âge de 18ans
- B- le premier examen à demander est la radiographie du poignet gauche
- C- le bilan hormonal est normal dans pratiquement tous les cas
- D- la recherche du développement des caractères sexuels secondaires est important
- E- La recherche de signes associés est primordial: anosmie, une malformation cardiaque

28- le syndrome de Turner :RF

- A- il s'agit d'une monosomie 45(X0)
- B- Un bilan hormonal perturbé
- C- Il s'associe à certaine malformation tel que cardiaque: coarctation de l'aorte
- D- un bilan hormonal normal
- E- Le syndrome de Turner peut être mosaïque avec 45(X0) et 46(XX)

29- Le prolapsus: RF

- A- Est une pathologie fréquente qui touche entre 30 et 50% des femmes
- B- Le traumatisme obstétrical est l'une des causes principales
- C- Son diagnostic est clinique avec sensation de boule dans le vagin responsable de pesanteur pelvienne
- D- Tous les organes pelviens peuvent être concernés (vessie, utérus et rectum)
- E- L'échographie pelvienne est indispensable au diagnostic

30- concernant l'aménorrhée secondaire :RF

- A- Elle est moins fréquente que l'aménorrhée primaire en consultation
- B- une grossesse doit être toujours éliminer en premier
- C- le taux de progestatif permet d'avoir une idée sur la sécrétion progestéronique
- D- le syndrome de Sheehan doit être rechercher si notion d'accouchement hémorragique
- E- certains médicaments peuvent être responsable

31- quelles sont les étiologies retrouvés dans l'aménorrhées primaires avec développements des caractères sexuelles secondaires :RF

- A- imperforation hyménale
- B- syndrome de Rokitansky kuster
- C- aplasie vaginale
- D- diaphragme vaginale
- E- craniopharyngiome

32- La souffrance fœtale aiguë est définie par la réponse la plus juste

- A- Une hypoxie d'installation progressive
- B- Une hypoxie brutale mettant en jeu le pronostic du fœtus
- C- Un retard de croissance intra-utérin (RCIU)
- D- un rythme de l'ERCF restreint pendant le travail
- E- Une tachycardie maternelle

33- Le signe cardiotocographique le plus évocateur d'une souffrance fœtale aiguë est:

- A- Tachycardie fœtale isolée
- B- Variabilité normale
- C- Décélérations tardives répétées et bradycardie prolongée
- D- Accélération persistantes
- E- rythme restreint

34- Le traitement d'une souffrance fœtale aiguë pendant le travail peut comprendre :RF

- A- Arrêt de l'ocytocine
- B- Maturation pulmonaire par corticoïdes
- C- Mise en décubitus latéral
- D- Oxygénothérapie maternelle
- E- Extraction fœtale en urgence si non amélioration

35- Les signes échographiques évocateurs de souffrance fœtale chronique sont :RF

- A- Oligoamnios
- B- un score de Manning inférieur à 4
- C- Aspects de cerveau en tonneau
- D- Diminution des mouvements actifs fœtaux
- E- Absence de vélocité diastolique au doppler ombilical

36- Devant un doppler ombilical montrant un flux diastolique nul ou inversé, la conduite recommandée est:

- A- Surveillance simple
- B- Extraction fœtale rapide selon l'âge gestationnel
- C- Augmenter les apports hydriques de la mère
- D- Administrer des tocolytiques
- E- Répéter le doppler dans une semaine

37- L'allo-immunisation: réponse fausse

- A- Elle est secondaire au passage d'hématies fœtales dans la circulation maternelle
- B- Les anticorps maternels sont de type IgM
- C- Le risque est celui de l'ictère néo natal
- D- Elle survient lorsque la mère est de rhésus négatif et le fœtus est de rhésus positif
- E- Les complications sont l'anémie fœtale et la mort fœtale

38- L'incompatibilité fœto-maternelle: RF

- 1- Survient toujours lors de la première grossesse
- 2- Survient chez une mère rhésus positif porteuse d'un fœtus rhésus négatif
- 3- Elle est liée au passage transplacentaire d'immunoglobulines IgG
- 4- Elle peut être détectée par un test de Coombs direct chez le nouveau-né
- 5 - Peut-être prévenue par une injection d'immunoglobuline anti-D

A (1-2) B (2-3-5) C (1-3-5) D (1-2-3)

39- le cycle menstruel dépend de: RF

- A- l'hypothalamus
- B- l'hypophyse postérieure
- C- l'ovaire
- D- l'endomètre
- E- organes génitaux réceptifs

40- la définition de la pré éclampsie se fait par:

- A- toutes souffrances organiques avec une hypertension
- B- association de l'œdème et signes neuro sensorielle
- C- une hypertension supérieure à 180 de systolique
- D- par la présence de complications paroxystique type éclampsie

41- Parmi les causes suivantes quelle est celle qui est la plus fréquentes des avortements du 1er trimestre:

- A- les aberrations chromosomiques
- B- les infections
- C- mauvaises conditions socioéconomique
- D- la consanguinité
- E- les iso immunisations rhésus

42- L'infection génitale haute: RJ

- A- est une infection utero annexielle
- B- nécessite toujours un traitement chirurgical
- C- le germe le plus souvent est le staph doré
- D- aucun impact sur la fertilité si le traitement est bien conduit
- E- toutes ses réponses sont justes

43- Vous recevez une patiente âgée de 53ans ménopausée à l'âge de 35ans, pour une augmentation du volume abdominale orienter par son gastro-entérologue suite à la découverte d'une masse ovarienne quel diagnostic vous allez poser:

- A- Une métastase d'un cancer digestif
- B- Une tumeur ovarienne
- C- Une carcinose péritonéale
- D- On ne peut pas se prononcer car on pas beaucoup d'éléments
- E- Aucun de ces diagnostics

Lors de votre interrogatoire vous notez que la patiente est une nulligeste nullipare, ayant bénéficiée d'un parcours de procréation médicalement assisté, prise de traitement hormonal substitutif et on note que dans sa famille plusieurs type de cancer tel que: cancer de l'angle colique gauche chez son frère et cancer de l'endomètre chez sa sœur

44- quels sont les facteurs de risques qu'on note dans notre interrogatoire: RF

- A. La nulliparité
- B. Parcours de procréation médicalement assisté
- C. Prise de traitement hormonal substitutif
- D. Notion de cancer dans la famille

45- quels examens complémentaires vous allez demander:

- 1- Une IRM pelvienne
 - 2- Un scanner thoraco abdomino pelvien
 - 3- Un dosage de CA.125
 - 4- Un scanner cérébral
 - 5- Une scintigraphie osseuse
- A(1-2-3) B (2-3-4) C (1-3-5) D (1-2-3-4-5) E(1-5)

46- la stratégie de prise charge que vous allez entreprendre est:

- A- Un traitement chirurgical
- B- Une radio-chimiothérapie en fonction de type histologique et la classification FIGO
- C- Une enquête familiale à la recherche d'un syndrome de LYNCH
- D- Faire une réunion de concertation pluridisciplinaire pour décider la meilleure option pour la patiente
- E- Toutes ses propositions sont juste

47- son pronostic dépend de: RF

- A- Réduction tumorale
- B- Type histologique
- C- Grade de différenciation histologique
- D- L'âge de la patiente
- E- Cinétique du CA.125

48- Mme S., 29 ans, G2P1, consulte à 24 SA pour sa visite prénatale. Antécédents:

IMC pré-grossesse: 29 kg/m³

Mère diabétique de type 2

Antécédents obstétricaux: 1 ère grossesse avec macrosomie fœtale (4,3 kg), sans complications néonatales.

Pas de diabète connu.

À ce stade de la grossesse:

La patiente se sent bien.

La glycémie à jeun du début de grossesse (à 8 SA): 0,88 g/L (4,9 mmol/L)

Pas d'hyperglycémie symptomatique.

La sage-femme propose le dépistage du diabète gestationnel.

49- Parmi les facteurs de risque suivants, lesquels indiquent un dépistage du diabète gestationnel dès 1er trimestre ?

- A- IMC $\geq$ 25 kg/m²
- B- Antécédent de macrosomie
- C- Antécédent de diabète gestationnel
- D- Antécédent familial de diabète au 1er degré
- E- toutes ces réponses sont justes

50- Quel test doit être réalisé pour dépister un diabète gestationnel entre 24 et 28 SA? RJ

- A- Glycémie à jeun seule
- B- HGPO 75 g en une étape)
- C- Test de O'Sullivan (50 g) suivi d'une HGPO 100 g si positif
- D- Mesure de l'HbA1c
- E- Hyperglycémie provoquée 200 g

51- Quel résultat de glycémie à jeun au 1er trimestre permet de diagnostiquer directement un diabète gestationnel?

- A- $\geq 0,85$ g/L (4,7 mmol/L)
- B- $\geq 0,92$ g/L (5,1 mmol/L)
- C- $\geq 1,26$ g/L (7,0 mmol/L)
- D- $\geq 0,95$ g/L (5,3 mmol/L)
- E- Aucune valeur ne suffit

52- Quels risques obstétricaux sont associés au diabète gestationnel ? RF

- A- Macrosomie
- B- Prééclampsie
- C- Césarienne
- D- Hypoglycémie néonatale
- E- Menace d'accouchement prématuré systématique

53- Quel prise en charge initiale pour cette patiente:

- A- Mesure hygiène diététique avec un régime hypocalorique
- B- Metformine d'emblée
- C- Insuline
- D- Régime restrictif
- E- sera considérée comme une grossesse normale si le diabète est sous régime et bien équilibré

54- Les lésions épidermoïdes intra épithéliales (RJ):

- A. Sont des lésions décelables à l'œil nu.
- B. Sont des lésions qui peuvent donner des métastases.
- C. Sont classées CIN3 si les atypies cyto nucléaires occupent toute l'épaisseur de l'épithélium avec des activités nucléaires visibles sur toute sa hauteur.
- D. Sont des lésions qui ne régressent jamais quel que soit leur grade.
- E. Celle classée CIN2 ne conservent pas de modification Koilocytaires à la surface.

55- Au niveau du col utérin le carcinome épidermoïde (RJ):

- A- Se développent chez toutes les femmes infectées par l'HPV.
- B- Apparaît rapidement après une infection HPV.
- C- Est une lésion non visible à l'œil nue.
- D- Se caractérise par l'infiltration du chorion par des amas de grandes cellules polygonales malpighiennes à différents degrés de différenciation et maturation.
- E- Est le type histologique le moins fréquent

56- Le polype endocervical RRF):

- A. Est une lésion bénigne.
- B. Touche les femmes âgées de 30-50 ans.
- C. Peut être provoqué par une inflammation chronique.
- D. Est fait de structures glandulaires kystisées ramifiées se disposant sur un axe fibreux inflammatoire richement vascularisé.
- E. Le risque de dégénérescence maligne est possible.

57- Une biopsie de l'endomètre réalisée chez une femme en activité génitale montre des glandes tortueuses, pseudos stratifiés avec figures mitotiques. Il s'agit de: (RF)

- A. La phase sécrétoire débutante
- B. La phase proliférative tardive
- C. La phase sécrétoire avancée
- D. L'ovulation
- E. La phase proliférative moyenne

58- Les signes histologiques du liéomyosarcome sont : (RF)

- A. Présence de cellules fusiformes régulières
- B. Faible densité cellulaire
- C. Présence de faisceaux courts de fibres musculaires lisses
- D. Présence de nécrose tumorale et d'atypies marquées
- E. Une activité mitotique faible

59- Les tumeurs séreuses borderlines de l'ovaire se caractérisent par (RF):

- A- Une pluri stratification du revêtement épithélial,
- B- Des mitoses en nombre augmenté mais modéré,
- C- Des atypies cytonucléaires modérées,
- D- Des calcosphérites dans 50% des cas,
- E- Une Invasion stromale.

60- Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux le placenta Increta ?

- A. Présence de villosités choriales dans la séreuse utérine.
- B. Invasion complète du myomètre par les villosités choriales.
- C. Présence de villosités choriales dans les vaisseaux du myomètre..
- D. Implantation du placenta dans le segment inférieur avec envahissement du myomètre superficiel.
- E. Implantation du placenta dans le segment inférieur sans envahissement du myomètre

61- Les facteurs pronostiques histologiques des carcinomes mammaires (RF):

- A. Envahissement ganglionnaire
- B. Taille tumorale
- C. Le type histologique
- D. Le grade histologique de Scarff, Bloom et Richardson (SBR)
- E. La stéatonécrose

Partie pratique:**1- la délivrance normale est: RJ**

- A- L'expulsion du placenta et ses membranes hors des voies génitales maternelles
- B- Elle représente le troisième et dernier temps de l'accouchement qui suit l'expulsion du fœtus
- C- C'est la période la plus dangereuse pour la mère
- D- Il est préconisé une surveillance rapprochée pendant les 02 premières heures
- E- Toutes les réponses sont justes

2- La délivrance placentaire est l'apanage de plusieurs facteurs qui sont : RJ

- A- La rétraction utérine qui est un phénomène passif et permanent
- B- La contraction utérine qui provoque le clivage de la caduque qui ouvre les sinus veineux et forme un HRP physiologique
- C- L'expulsion du placenta se fait sous l'influence des contractions utérine et de son propre poids
- D- Parfois aidé par l'opérateur en réalisant une expression utérine et une légère tension sur le cordon
- E- Toutes ces réponses sont justes

3- l'hémorragie de la délivrance (HDD): RF

- A. C'est la première cause de décès maternel dans le monde
- B. Son Diagnostic évident: hémorragie extériorisée, utérus mou dépassant l'ombilic et état de choc
- C. Sa PEC est pluridisciplinaire (réanimateur-anesthésiste, obstétriciens, sage-femme, infirmier, radiologue interventionnel)
- D. L'échographie pelvienne est indispensable au diagnostic de l'HDD
- E. Une révision de la filière génitale doit être réalisé en urgence avec une réanimation intensive

4- concernant l'indice de magnin: RF

- A- C'est la somme des mesures radiopelvimétriques du diamètre transverse médian (DTM) et du diamètre antéro-postérieur utile, diamètre promonto-rétropubien
- B- Cette somme DTM+DPRP est normalement supérieur à 23cm.
- C- Lorsque la somme est inférieure à 20 cm le pronostic est réservé
- D- lorsqu'il est entre 20 et 22cm la confrontation entre le fœtus et le bassin maternel (épreuve du travail) est formellement contre indiqué
- E- Un bon marqueur pour la décision à l'épreuve du travail

5- Dans la pelvimétrie externe 1 seul examen ne fait pas parti lequel?

- A. Le losange de Michaelis
- B. Le diamètre prépubien de Trillat
- C. Le diamètre bi-ischatique selon Grennhill
- D. Le diamètre bl-ischatique selon tarnier
- E. La manœuvre de Budin

6. Le dépistage de ...

- A. Par l'échographie du 1er trimestre seule
- B. Par le dosage des marqueurs sériques maternels
- C. Par le test combiné (clarté nucale + marqueurs sériques + âge maternel)
- D. Par l'amniocentèse d'emblée
- E. l'interruption de la grossesse est discutée si diagnostic de T21 est retenue

7- La complication la plus fréquente après une HSG est:

- A. Embolie gazeuse
- B. Infection pelvienne
- C. Syncope vagale
- D. Perforation utérine
- E. Hémorragie utérine massive

8- La principale indication de l'hystérosalpingographie est:

- A. Étudier l'endomètre et la perméabilité tubaire
- B. Evaluer la perméabilité tubaire
- C. Rechercher une tumeur ovarienne
- D. Visualiser la cavité abdominale
- E. Diagnostiquer une grossesse extra-utérine

9- Le curetage peut être à visée:

- A. Thérapeutique
- B. Diagnostique
- C. Préventive
- D. A-B-C

10- La complication la plus redoutée du curetage utérin est:

- A. L'hémorragie abondante.
- B. La perforation utérine
- C. L'infection
- D. La synéchie utérine
- E. Toutes ces réponses sont justes

Examen Uro-Néphrologie : Groupe 03 / 2026**1. Le dépistage de la maladie rénale chronique concerne (RF)**

- A. Tout enfant à la naissance
- B. Enfant ayant un petit poids de naissance
- C. Antécédent familiale de MRC
- D. Hypertension artérielle
- E. Infections urinaires à répétition

2. La résection trans-urétrale de vessie est (RTUV): (RF)

- A. Un moyen diagnostic et thérapeutique pour la tumeur de vessie
- B. Une seconde RTUV peut-être nécessaire en cas de tumeur volumineuse ou multifocale
- C. Elle a une place dans le traitement palliatif des tumeurs de vessie métastatiques
- D. Une seconde RTUV doit être envisagée dans un délai de 4 à 6 jours en cas d'absence de muscle identifié à la 1ère RTUV
- E. Elle renseigne sur l'extension au muscle (detrusor) de la tumeur de vessie.

3. Les traumatismes rénaux: RF

- A. Ils représentent 10% des traumatismes abdominaux
- B. Ils sont associés à d'autres lésions abdominales dans 60% des cas
- C. L'échographie abdominale est l'examen de choix pour déceler et classer les lésions
- D. Le traitement conservateur est le plus souvent entrepris
- E. Les traumatismes graves peuvent engendrer un état de choc hémodynamique

4. La cause la plus fréquente d'une fausse hyperkaliémie est:

- A. Prélèvements sanguins répétés
- B. Prélèvement sans garrot
- C. Leucopénie
- D. Prélèvement avec garrot
- E. Acheminement rapide du prélèvement vers le laboratoire

5. Parmi les traitements d'une hyperkaliémie, les traitements cités ci-dessous sont justes sauf un, lequel:

- A. Insuline avec glucose
- B. Salbutamol
- C. Résine échangeuse d'ions
- D. Epuration extra rénale
- E. Sérum salé

6. Un patient hypertendu sous traitement, présente lors de sa consultation une kaliémie à 3 mmol/l, ce chiffre vous évoque (RJ)

- A. Un traitement par les anti-aldostérones
- B. Un traitement par les thiazidiques
- C. Un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine
- D. La prise concomitante de laxatifs
- E. La prise de bêtabloquants

- 7. Quelle est la principale caractéristique de l'urine en cas d'IRA fonctionnelle? RJ**
- A. Abondante et riche en sodium
 - B. Peu abondante et pauvre en sodium.
 - C. Présence de nombreux cylindres hématiques
 - D. PH alcalin
 - E. Toutes ces propositions sont fausses
- 8. Quel est le traitement de l'IRA pré-rénale (RJ)**
- A. Antibiotiques
 - B. Levée de l'obstacle
 - C. Restauration d'une volémie efficace.
 - D. Immunosuppresseurs
 - E. Corticothérapie
- 9. Quel est le traitement de première intention de l'IRA obstructive? RJ**
- A. Diurétiques
 - B. Antibiotiques
 - C. Levée de l'obstacle
 - D. Immunosuppresseurs
 - E. Réhydratation
- 10. Quels sont les signes orientant vers une hématurie d'origine rénale?(RJ)**
- 1) Urines rouges foncée avec caillots
 - 2) Présence de cylindres hématiques
 - 3) Hématurie terminale
 - 4) Protéinurie associée
 - 5) Douleurs lombaires aiguës
- A 1+2 B 2+4 C2+5 D 3+5 E 3+2
- 11. Quels sont les signes orientant vers une cause urologique d'hématurie**
- 1) Présence de caillots
 - 2) Douleurs lombaires ou mictionnelles
 - 3) Présence de protéinurie
 - 4) Hématies déformées
 - 5) Présence d'HTA et œdèmes des membres inférieurs
- A 1+2 B 3+4 C4+5 D 1+3 E 2+4
- 12. Concernant la transplantation rénale (RF)**
- A. L'intervention est réalisée sous AG.
 - B. La néphrectomie des reins natifs est systématique
 - C. Le greffon est généralement implanté dans la fosse iliaque droite.
 - D. L'artère du greffon est anastomosée à l'artère iliaque primitive ou externe du patient
 - E. La veine du greffon est anastomosée à la veine iliaque primitive ou externe du patient

- 13. Le bilan de 1^{ère} intention de la MRC chez l'enfant, repose sur un ou plusieurs éléments, le ou lesquels ?**
- A. Bandelette urinaire
 - B. Echographie rénale
 - C. Uro-TDM
 - D. Echocoeur
 - E. L'estimation du DFG par MDRD
- 14. Parmi les propositions suivantes concernant les mécanismes d'action des diurétiques, lesquelles sont exactes?**
- A. Le furosemide agit au niveau de la membrane luminale de la branche ascendante large de l'anse de Henlé en inhibant le co-transporteur $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - 2\text{Cl}^-$ (NKCC2), bloquant ainsi la réabsorption de 20-25% du sodium filtré.
 - B. Les diurétiques de l'anse sont indiqués en première intention dans l'hypertension artérielle essentielle non compliquée, en raison de leur puissance supérieure aux thiazidiques
 - C. Les diurétiques épargneurs de potassium (spironolactone, amiloride) exposent au risque d'hyperkaliémie, particulièrement chez les patients insuffisants rénaux, sous IEC/ARA2, ou présentant un hyporéninisme-hypoaldostéronisme
 - D. L'hypertrophie du tube contourné distal en réponse à l'exposition chronique aux diurétiques de l'anse augmente la capacité de réabsorption sodée distale, contribuant à la diminution de l'efficacité diurétique
 - E. Les diurétiques thiazidiques sont particulièrement efficaces dans la prévention des récurrences de lithiases uriques car ils diminuent la calciurie
- 15. Quelle(s) est (sont) la (les) complication(s) habituelle(s) d'une insuffisance rénale chronique sévère?**
- A. Une anémie régénérative;
 - B. Une dénutrition protéino-énergétique;
 - C. Une alcalose métabolique
 - D. Une hyperuricémie souvent asymptomatique;
 - E. Une hypocalcémie favorisée par la diminution de production rénale de $1,25 (\text{OH})_2$ vitamine D
- 16. Dans la maladie des embolies de cholestérol, on constate: la ou les RF**
- A. La biopsie rénale montre une inflammation
 - B. Le traitement repose sur les anticoagulants
 - C. Les corticoïdes n'ont aucun rôle thérapeutique
 - D. Le pronostic est sévère
 - E. La mortalité est de 40%

- 17. Quel(s) élément(s) permet (tent) d'orienter vers le caractère chronique d'une insuffisance rénale?**
- A. Une augmentation du débit de filtration glomérulaire évoluant depuis plus de 3 mois;
 - B. L'existence depuis plus de 3 mois d'une protéinurie et d'une anomalie du sédiment urinaire;
 - C. La présence d'une hyperkaliémie associée à une acidose métabolique;
 - D. La présence d'une anémie normochrome normocytaire et régénérative au moment du diagnostic.
 - E. La présence de reins dont la taille est significativement réduite;
- 18. Concernant l'insuffisance rénale chronique, quel(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s)?**
- A. Elle peut être responsable d'une HTA;
 - B. Secondaire à des lésions anatomiques irréversibles du parenchyme rénal;
 - C. Elle est définie par une augmentation du DFG;
 - D. Elle s'accompagne toujours d'une baisse du débit urinaire;
 - E. Elle peut être responsable d'une hypervolémie.
- 19. Dans le syndrome de Microangiopathie thrombotique, on peut retrouver la ou les RJ**
- A. Anémie inflammatoire
 - B. Anémie mécanique
 - C. Au frottis, des hématies fragmentées
 - D. Une thrombopathie inflammatoire
 - E. Haptoglobine augmentée
- 20. Lors d'une néphropathie tubulo-interstitielle, on peut retrouver la ou les RF**
- A. Leucocyturie aseptique
 - B. Protéinurie massive
 - C. Protéinurie <2 g
 - D. Protéinurie <1g
 - E. Pression artérielle normale
- 21. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes**
- A. La triade classique associant fièvre, éruption cutanée et éosinophilie est toujours présente dans la néphrite interstitielle aiguë immunoallergique
 - B. La présence d'éosinophiles urinaires, a une bonne valeur prédictive positive pour le diagnostic de néphrite interstitielle aiguë immunoallergique
 - C. La biopsie rénale montrerait typiquement un infiltrat interstitiel lymphocytaire et éosinophilique avec œdème interstitiel, tandis que les glomérules et les vaisseaux sont généralement respectés
 - D. L'arrêt de l'antibiotique suffit généralement à obtenir une récupération complète de la fonction rénale dans les 48-72 heures
 - E. Les bêta-lactamines, les inhibiteurs de la pompe à protons et les AINS sont parmi les principales classes médicamenteuses responsables de néphrite interstitielle aiguë immunoallergique

- 22. Le saignement qui accompagne une rupture traumatique totale de l'urètre postérieur chez l'homme est:**
- A. Hématurie terminale
 - B. Hématurie initiale
 - C. Hématurie totale
 - D. Urétrorragie
 - E. Inexistant
- 23. En cas de suspicion de rupture de l'urètre postérieur chez un patient présentant une fracture du bassin, il faut éviter de:**
- A. Faire un toucher rectal
 - B. Installer une traction sur l'un des membres inférieurs
 - C. Faire un cathétérisme urétral diagnostic
 - D. Réaliser une laparotomie en cas de lésion intra-abdominale associée
 - E. S'assurer de la stabilité du patient avant toute approche urologique
- 24. L'examen qui permet de poser le diagnostic de la lésion de l'urètre en cas de fracture du bassin:**
- A. Echographie pelvienne
 - B. Bilan urodynamique
 - C. Urétrocystographie rétrograde
 - D. Scanner abdominal avec injection du produit de contraste
 - E. Cystoscopie
- 25. En matière de diagnostic de tumeur de vessie, la réponse juste:**
- A. La cystoscopie est systématique devant toute hématurie,
 - B. L'échographie sus-pubienne normale élimine le diagnostic de tumeur de vessie,
 - C. L'échographie sus-puhienne détecte les tumeurs < 5mm,
 - D. La cystoscopie est optionnelle en cas d'échographie évoquant le diagnostic de tumeur de vessie
 - E. La TVNIM nécessite une TDM thoraco-abdomino-pelvienne dans le cadre du bilan d'extension
- 26. Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas un facteur de risque de tumeur de vessie**
- A. Hydrocarbures aromatiques
 - B. Une infection vésicale récidivante
 - C. Alimentation végétale,
 - D. Antécédent d'irradiation pelvienne
 - E. Tabagisme
- 27. Parmi les signes suivants, lequel est considéré comme un signe de gravité de colique néphrétique imposant un avis urologique en urgence ?**
- A. Une agitation et anxiété du patient
 - B. Une colique néphrétique fébrile
 - C. Une irradiation de la douleur vers les organes génitaux
 - D. Des nausées et vomissements
 - E. Une anurie

- 28. Quel est le traitement médicamenteux de première intention recommandé pour une colique néphrétique simple ?**
- A. Un antalgique de niveau II per os
 - B. La morphine titrée en intraveineuse
 - C. Le kétoprofène en intraveineuse
 - D. Un inhibiteur calcique
 - E. Alpha bloquant
- 29. Quel examen d'imagerie est préconisé en première intention chez une femme enceinte présentant une colique néphrétique?**
- A. L'échographie rénale et vésicale
 - B. L'uro-scanner avec injection
 - C. Le scanner abdomino-pelvien sans injection
 - D. L'abdomen sans préparation (ASP)
 - E. L'IRM
- 30. Quel examen d'imagerie offre la meilleure sensibilité et spécificité pour visualiser directement la lithiase et les signes d'obstruction?**
- A. Le couple ASP-échographie
 - B. L'échographie seule
 - C. Le scanner hélicoïdal sans injection
 - D. L'abdomen sans préparation (ASP) seul
 - E. L'IRM
- 31. Quelles sont les situations qui imposent une exploration chirurgicale d'urgence en cas de traumatisme rénal: RJ**
- 1) Instabilité hémodynamique malgré la réanimation
 - 2) Stade 2 et 3 de l'AAST
 - 3) Avulsion ou lacération du pédicule rénal
 - 4) Perforation d'organe creux associé
 - 5) Stade la selon la classification de Chatelain
- A 1+2+5 B 1+4 C 1+3+4 D 2+3+5 E 3+4
- 32. L'orchidectomie pour cancer du testicule RF**
- A. Elle est réalisée par voie inguinale
 - B. Elle est réalisée même en la présence de métastases
 - C. Elle se fait impérativement après lo bilan d'extension
 - D. Elle peut s'accompagner de la mise en place d'une prothèse testiculaire
 - E. Elle a un intérêt diagnostique et thérapeutique
- 33. Quels sont les marqueurs tumoraux en rapport avec le cancer du testicule?**
- 1) CA19.9
 - 2) Alphaphœtoprotéine
 - 3) LDH
 - 4) CA 125
 - 5) HCG
- A 1+4 B 2+5 C 1+3+4 D 1+2+5 E 2+3+5

- 34. L'orchidectomie pour cancer du testicule RF**
- A. Elle est réalisée par voie inguinale
 - B. Elle est réalisée même en la présence de métastases
 - C. Elle se fait impérativement après lo bilan d'extension
 - D. Elle peut s'accompagner de la mise en place d'une prothèse testiculaire
 - E. Elle a un intérêt diagnostique et thérapeutique
- 35. Une biopsie rénale est indiquée devant: citez la réponse fausse (RF)**
- A. un syndrome de néphropathie glomérulaire.
 - B. syndrome néphrotique pur chez un enfant âgé de 1 à 10 ans.
 - C. insuffisance rénale aiguë (IRA) en absence de cause reconnue.
 - D. maladie de système associée à une protéinurie.
 - E. syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive (GNRP)
- 36. Un patient se présente aux urgences et il vous est adressé pour une séance de dialyse en urgence. Que faites-vous? la ou les RF**
- A. Vérifier la présence d'un OAP
 - B. Vérifier la présence d'une hyperkaliémie menaçante
 - C. Placer un cathéter fémoral temporaire
 - D. Placer un cathéter tunnellisé
 - E. Prescrire un diurétique de l'anse
- 37. Dans laquelle (lesquelles) des conditions particulières suivantes, un bilan d'infertilité peut-il être réalisé avant qu'une infécondité n'ait été établie (avant le délai d'un an sans grossesse)?**
- A. Existence d'un antécédent de cryptorchidie.
 - B. Palpation d'une varicocèle à l'examen clinique.
 - C. Existence d'un antécédent de traitement par chimiothérapie
 - D. AGE de la femme de 37 ans
 - E. Une interrogation de l'homme sur sa propre fertilité en l'absence actuelle de partenaire
- 38. Une biopsie prostatique:**
- A. S'impose devant une anomalie du toucher rectal
 - B. Se fait sous anesthésie locale ou générale
 - C. Se fait après la réalisation de l'IRM prostatique
 - D. S'impose devant une élévation du PSA
 - E. Toutes les réponses sont justes
- 39. La dialyse péritonéale: la ou les RJ**
- A. Est une technique d'épuration extra-rénale
 - B. Est une technique d'épuration d'épuration
 - C. Est une technique d'épuration intra-corporelle
 - D. A besoin d'un accès vasculaire
 - E. Il existe un risque de contamination par le virus de l'hépatite B

- 40. Lors de la mise en route de la dialyse péritonéale la ou les RF**
- A. Il faut tester la membrane péritonéale
 - B. Mettre en place un cathéter péritonéal dans une salle septique
 - C. Solliciter un chirurgien pour mettre en place le cathéter
 - D. Evaluer l'acuité visuelle du patient
 - E. Former le patient à la technique
- 41. Une infection péritonéale se caractérise par: (RF)**
- A. Liquide de drainage trouble
 - B. Perte d'UF
 - C. Liquide de drainage en faible quantité
 - D. Douleurs lombaires
 - E. Brulures mictionnelles
- 42. Les principes physico-chimiques d'échanges en hémodialyse sont la RF**
- A. Convection
 - B. Ultrafiltration
 - C. Osmose
 - D. Diffusion
 - E. Réabsorption
- 43. Un cancer de la prostate classé C T2a N0 M0 est un :**
- A. cancer atteignant plus de la moitié d'un lobe
 - B. cancer avec atteinte des vésicules séminales
 - C. cancer atteignant la moitié d'un lobe ou moins
 - D. cancer avec atteinte des deux lobes
 - E. cancer prostatique métastatique
- 44. le traitement d'un cancer de prostatique métastatique se base sur:**
- A. la réalisation d'une prostatectomie radicale
 - B. La suppression androgénique (hormonothérapie)
 - C. La curiethérapie interstitielle
 - D. La radiothérapie
 - E. HIFU
- 45. l'adénome prostatique est peu symptomatique si le score de l'IPSS est:**
- A. Entre 0 et 7
 - B. Entre 8 et 19
 - C. Entre 10 et 35
 - D. Entre 35 et 40
 - E. Supérieur à 40
- 46. quelles sont les informations fournies par l'échographie vésicale au cours d'une HBP:**
- A. Une hypertrophie détrusorienne
 - B. Un diverticule vésicale
 - C. Une lithiase de stase
 - D. Un résidu post mictionnel
 - E. Toutes les réponses sont justes

47. le traitement de l'HBP se base sur: (la réponse fausse)

- A. Un traitement médical en cas d'HBP modérément symptomatique
- B. La surveillance est possible si l'HBP est peu symptomatique
- C. Un traitement médical pour une HBP compliquée d'une lithiase vésicale
- D. Un traitement chirurgicale en cas d'HBP avec retentissement sur le haut appareil
- E. Le traitement chirurgical est possible par voie endoscopique ou par chirurgie a ciel ouvert

Mr K.L âgé de 69 ans, diabétique sous ADO, tabagique, cancer rectale opéré puis ayant subi de la radiothérapie adjuvante présente en consultation pour hématurie macroscopique terminale, brûlure mictionnelle, un ECBU confirme l'hématurie, avec absence d'infection urinaire.

1. Le diagnostic de tumeur de vessie est suspecté, quels sont les éléments évocateurs de diagnostic RF

- A. hématurie macroscopique
- B. Tabac
- C. Cancer rectal
- D. Antécédent de radiothérapie
- E. Age

2. Quel est l'examen complémentaire à réaliser en premier? RJ

- A. Echographie sus-pubienne
- B. Cystoscopie
- C. Coloscopie
- D. TDM Thoraco-abdomino-pelvienne
- E. URO-Scanner

3. Cet examen est revenu sans anomalie, mais le patient consulte pour la persistance de l'hématurie, quel est l'examen de seconde intention devant la persistance du doute concernant l'existence d'une tumeur de vessie? RJ

- A. Echographie sus-pubienne
- B. Coloscopie
- C. Cystoscopie
- D. TDM Thoraco-abdomino-pelvienne
- E. URO-Scanner

4. Ce second examen affirme l'existence d'une tumeur de vessie, quel est le geste à réaliser chez votre patient? RJ

- A. Cystoprostatectomie avec dérivation urinaire
- B. TDM Thoraco-abdomino-pelvienne à la recherche de localisation secondaire
- C. Résection trans-urétrale de la vessie (emportant le chorion)
- D. Résection trans-urétale de vessie complète
- E. Un bilan d'extension avant toute attitude thérapeutique

- 5. L'étude anatomo-pathologique révèle la présence d'un carcinome urothelial de haut grade, infiltrant le détrusor, le bilan d'extension ne révèle pas d'atteinte ganglionnaire locorégionale, ni d'atteinte métastatique à distance, quel est le stade de la tumeur? RJ**
- A. T1N1M0
 - B. T1N0M0
 - C. T2N1M0
 - D. T2N0M0
 - E. T2N0M1

- 6. Quelle est votre attitude thérapeutique**
- A. Instillation endo vésicale à base de BCG-thérapie
 - B. Cystectomie avec dérivation urinaire
 - C. Cystoprostatectomie avec dérivation urinaire
 - D. Néphro-urétérectomie totale
 - E. RTUV de second look

Un homme de 15 ans présente à la clinique avec une hypertension artérielle légère. Il ne présente aucun signe fonctionnel urinaire ou signe systémique. Ses analyses du sang montrent une créatininémie normale, mais une légère élévation de la pression artérielle, une analyse d'urine révèle protéinurie 1 g/24 h au dosage pondéral et une hématurie microscopique en Labstix. L'échographie rénale ne montre pas d'anomalies structurales significatives. A l'interrogatoire le patient se rappelle avoir présenté deux épisodes d'hématuries macroscopiques (durant l'année précédente)

- 1) Comment décrivez-vous ce syndrome (donnez la réponse juste)**
- A. Syndrome glomérulaire
 - B. Syndrome néphrétique aigu
 - C. Syndrome de glomérulonéphrite chronique
 - D. Syndrome d'hématurie macroscopique récidivante
 - E. Syndrome néphrotique
- 2) Parmi les propositions suivantes quel est le diagnostic le plus approprié? (Donnez la réponse juste)**
- A. Purpura rhumatoïde
 - B. Maladie inflammatoire de l'intestin
 - C. Maladie de Berger
 - D. Néphropathie hypertensive
 - E. Toutes les propositions sont fausses

Examen Dermatologie Groupe : 04 / 2026

1. Le diagnostic de l'acné repose sur les arguments suivants:

- A. Aspect clinique: la présence de papules, pustules et de comédons
- B. Sièges: parties couvertes.
- C. La mise en évidence du *Propionibacterium acné* dans le pus
- D. La présence d'ADP et de lymphangite
- E. L'âge: l'acné touche uniquement le jeune adolescent

2. Les épithéliomes basocellulaires: (RF)

- A. Sièges avec prédilection sur le visage
- B. Peuvent s'accompagner de métastases
- C. Peuvent être de couleur noire.
- D. Ont un aspect clinique polymorphe
- E. Ont habituellement un bon pronostic.

3. Le carcinome spinocellulaire (épidermoïde): (RF)

- A. Peut survenir sur une kératose actinique.
- B. Peut survenir sur une cicatrice de brûlure
- C. Peuvent s'accompagner de métastases.
- D. Épargne les muqueuses.
- E. Peut être végétant.

4. Les formes cliniques du psoriasis: (RJ)

- A. La forme universelle couvre moins de 50% du tégument
- B. La forme érythrodermique se traite à titre externe pour éviter les infections nosocomiales
- C. Les formes spinulosiques et guttata, se voient plus chez l'enfant
- D. Dans les formes topographiques, le psoriasis du visage est une forme fréquente.
- E. Le psoriasis arthropathique est une forme de sujet âgé

5. L'eczéma aigu se caractérise par: (RJ)

- A. Un prurit intense intermittent
- B. Un prurit surtout à la phase desquamative
- C. La phase de suintement précède la phase vésiculeuse
- D. Les différentes phases sont intriquées.
- E. Son diagnostic positif est porté par une étude anatomopathologique

6. Quel est votre CAT devant un érysipèle ? (RF)

- A. Repos au lit jusqu'à régression des signes inflammatoires
- B. Surélévation du membre inférieur
- C. Traitement antibiotique Penicilline G: 10-20M UI/j en perfusion jusqu'à apyrexie puis relais Penicilline V per os
- D. Soulager la douleur par des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
- E. Traitement de toute porte d'entrée

7. Les macules (ou taches) sont des lésions primitives seulement visibles, avec modification de la couleur de la peau sans relief, Infiltration. On distingue (RF)
- A. l'érythème
 - B. La cyanose
 - C. Le purpura
 - D. L'ulcération
 - E. L'hyperpigmentation
8. LÉSIONS PALPABLES A CONTENU LIQUIDIEN: (RF)
- A. Les bulles
 - B. Les vésicules
 - C. Les papules
 - D. Les pustules
 - E. Les phlyctènes
9. LÉSIONS PALPABLES A CONTENU SOLIDE: (RF)
- A. Les papules
 - B. Les nodules
 - C. L'érythème
 - D. La croûte
 - E. Les suures
10. Quel est l'examen de première intention à faire en cas de suspicion d'une leishmaniose cutanée (RJ)
- A- intradermoréaction à la leishmaniose
 - B- Recherche des leishmanies sur sang veineux
 - C- Biologie cutanée
 - D- Examen parasitologique direct au microscope optique
 - E- Echographie des parties molles
11. Les parasites de la leishmaniose cutanée: (RJ)
- A- Sont des protozoaires du genre leishmania
 - B- les formes amastigotes de leishmanies sont intracellulaires
 - C- les formes promastigotes de leishmanies sont extracellulaires
 - D- Ne sont pas visibles au microscope optique
 - E- Inoculé à l'homme par le piqûre d'un insecte vecteur: phlébotome femelle
12. Le poux de corps: RF
- A. sont retrouvés sur le corps et les vêtements surtout
 - B. peuvent être des vecteurs des maladies sexuelles graves
 - C. sont retrouvés les personnes en situation de précarité
 - D. c'est la forme la plus fréquente de pédiculoses
 - E. est due à *Pediculus Humanus Corporis*

13. La phthyriose: RF

- A. est due à un insecte accroché aux poils pubiens
- B. Se transmet habituellement par contact direct
- C. la transmission de la pédiculose pubienne est surtout sexuelle
- D. Peut se localiser au niveau des zones pileuses
- E. la phthyriose pubienne justifie le dépistage d'autres IST associées

14. Un de ces AINS anti H1 est de première génération : RJ

- A. Céterizine
- B. Mequitazine
- C. Fexofénadine
- D. Loratadine
- E. Desloratadine

15. l'urticaire commun présente les caractéristiques sémiologiques suivantes : RF

- A. prurit
- B. fugacité des lésions
- C. le caractère rigoureux
- D. le suintement
- E. l'aspect vésiculeux

Cas clinique 01 :

Une femme âgée de 28 ans, se présente en consultation pour des quelques lésions papulo pustuleuses associées à des comédons, siégeant au niveau de la partie basse du visage et évoluant depuis 6 mois.

1. Quel est votre diagnostic ? (RJ)

- A. Une folliculite bactérienne
- B. Une acné juvénile polymorphe
- C. Une acné de la femme adulte
- D. Un eczéma de contact
- E. Une mycose du visage

2. Quels signes recherchez vous à l'examen clinique chez cette femme ? (RF)

- A. Un hirsutisme
- B. Des troubles du cycle menstruel
- C. Une alopecie
- D. Une stérilité
- E. Aucun signe n'est à rechercher dans ce type d'acné

En examinant votre patiente, vous trouvez qu'elle présente effectivement un hirsutisme, une alopecie androgénique et une aménorrhée.

3. Vous décidez de faire des examens complémentaires

- A. Une échographie ovarienne uniquement
- B. Bilan hormonal seulement
- C. Un bilan hormonal + une échographie ovarienne
- D. Un hémogramme
- E. aucun de ces examens n'est nécessaire

La patiente est gênée par ses lésions, elle vous demande de lui prescrire un traitement en attendant les résultats des bilans,

4. Quel est le traitement de première Intention que vous prescrivez chez cette malade? (RJ)

- A. Une association rétinoïde topique + peroxyde de benzoyle
- B. Une association cycline par voie générale + isotrétinoïne par voie générale
- C. Acide fusidique en topique
- D. Un dermocorticoïde local
- E. Aucun traitement

5. La malade est inquiète et elle vous demande plus d'explications sur sa maladie, quelle est la proposition correcte (RJ)

- A. Il s'agit d'une pathologie inflammatoire qui peut survenir à tout âge
- B. Il s'agit d'une pathologie infectieuse
- C. Cette pathologie survient uniquement chez le jeune de moins de 25 ans
- D. C'est une pathologie grave
- E. Les problèmes hormonaux ne peuvent pas être la cause de ce type d'acné

Cas clinique 02 :

Un enfant de ans consulte avec ses parents pour un prurit de la racine de cuisses, des fesses et des mains. L'enfant dort très mal la nuit du fait d'une recrudescence nocturne du prurit. La famille est de retour à Alger depuis 10 jours d'un séjour de 4 semaines durant lequel ont dormi à plusieurs reprises dans différentes Auberges

1. l'agent pathogène de cette pathologie (RJ)

A. est due à un Insecte

B. est due à un arthropode sarcoptes scabiei de variété Hominis

C. peut être à l'origine d'épidémies dans des foyers, des institutions, des hôpitaux...

D. se transmet principalement par contact Indirect

E. résistante à toute thérapie

2. Parmi les propositions suivantes sur la gale, quelles sont celles qui sont exactes? (RJ)

A. Le sillon visible sur la peau correspond au tunnel creusé par la femelle

B. La transmission Interhumaine est le plus souvent directe

C. Les acariens adultes peuvent survivre plus de 10 jours dans le milieu extérieur.

D. Le prurit a des localisations particulières en fonction de l'âge et du sexe

E. Chez le sujet Âgé, les lésions sont souvent peu spécifiques

Examen epidemiologie : Groupe 01 / 2026

1) La fonction première des grilles de lecture critique dans le processus d'évaluation d'un article médical?

- A) Remplacer l'analyse statistique détaillée par une évaluation binaire (valide/non valide)
- B) Permettre un rejet rapide d'articles de faible qualité avant lecture approfondie
- C) Standardiser la rédaction des articles selon les exigences des revues scientifiques
- D) Calculer automatiquement le niveau de preuve selon l'échelle EBM
- E) Évaluer la pertinence clinique des résultats indépendamment de la méthodologie

2- Lors de l'application d'une grille de lecture critique adaptée à la structure d'étude, quel élément doit impérativement être évalué avant l'analyse des résultats?

- A) La significativité statistique des principaux résultats
- B) La cohérence entre le sens des résultats et les objectifs énoncés
- C) La conduite de l'étude et la gestion des biais potentiels
- D) L'impact factor de la revue de publication
- E) La déclaration de conflits d'intérêts des auteurs

3- Selon la définition OMS, une infection du site opératoire est considérée comme IAS si elle survient:

- A) Dans les 48 heures suivant l'intervention chirurgicale
- B) Dans les 7 jours suivant l'intervention, quel que soit le type de chirurgie
- C) Dans les 30 jours suivant l'intervention, ou jusqu'à 1 an si un implant a été posé
- D) Uniquement si elle nécessite une réintervention dans les 15 jours
- E) A partir du 5ème jour post-opératoire pour exclure les contaminations per-opératoires

4- Parmi les maillons de la chaîne de transmission infectieuse, lequel constitue le point d'action prioritaire pour prévenir la transmission croisée dans un service de soins?

- A) L'agent infectieux (bactéries, virus, champignons)
- B) Le réservoir (patient, personnel, environnement)
- C) La porte de sortie (sang, urines, pus)
- D) Le mode de transmission (contact, gouttelettes, air)
- E) L'hôte réceptif (patient fragile, immunodéprimé).

5- La définition d'une infection associée aux soins (IAS) repose sur un critère temporel fondamental à l'admission. Lequel?

- A) L'infection doit survenir après 72 heures d'hospitalisation pour être classée IAS
- B) L'infection doit être absente et non en période d'incubation au moment de l'admission
- C) L'infection est considérée IAS uniquement si le germe responsable n'était pas connu à l'admission
- D) L'infection doit être documentée par un prélèvement bactériologique positif dans les 48h suivant l'admission
- E) L'infection est IAS si elle survient après un geste invasif, quel que soit le délai

6- Concernant les précautions complémentaires selon le mode de transmission, quelle association est correcte?

- A) Précautions gouttelettes masque FFP2 obligation pour le personnel
- B) Précautions air masque chirurgical simple suffisant pour le personnel
- C) Précautions contact: gants et surblouse requis, isolement dans une chambre individuelle
- D) Précautions air distance de 1 mètre suffisante entre patients
- E) Précautions gouttelettes ventilation négative de la chambre obligatoire

7- La surveillance épidémiologique se distingue fondamentalement d'une simple collecte de données par :

- A) L'obligation légale de déclaration des cas aux autorités sanitaires
- B) Son caractère systématique, continu et organisé, couplé à l'analyse, l'interprétation et la rétro information
- C) L'utilisation de registres de morbidité et de mortalité
- D) La participation obligatoire de tous les établissements de santé du territoire
- E) La publication annuelle systématique des résultats dans un rapport national

8- Dans la prévention tertiaire des MNT décrite, quel objectif est poursuivi?

- A) Eviter l'apparition initiale de la maladie en agissant sur les facteurs du risque
- B) Détecter précocement la maladie asymptomatique pour améliorer le pronostic
- C) Eviter les complications et les rechutes chez les patients déjà atteints
- D) Réduire la prévalence de la maladie dans la population générale
- E) Limiter la transmission interhumaine des facteurs de risque comportementaux

Exercice 1: Énoncé

Une étude analytique est réalisée afin d'évaluer l'association entre le tabagisme et la survenue de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) chez des adultes âgés de plus de 40 ans

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant

	BPCO	Pas de BPCO	Total
Fumeurs	90	210	300
Non-fumeurs	30	270	300
Total	120	480	600

On souhaite étudier l'existence d'une association statistique entre le tabagisme et la BPCO au seuil de signification de 5%.

9. Le test statistique le plus approprié pour analyser ces données est:

- A) Test t du Student
- B) ANOVA
- C) Test exact de Fisher
- D) Test du Khi-deux d'indépendance
- E) Test de corrélation de Spearman

10- La valeur du χ^2 calculé est $\chi^2 = 37,5$. La p-value associée est $p < 0,001$.

Quelle est la conclusion correcte?

- A) L'association est non significative
- B) Les résultats sont dus au hasard
- C) On accepte l'hypothèse nulle
- D) existe une association statistiquement significative
- E) Le test n'est pas applicable

11- L'incidence de BPCO chez les fumeurs est:

- A) 10%
- B) 15%
- C) 20%
- D) 25%
- E) 30%

12- Dans ce type d'étude, la mesure d'association la plus appropriée est:

- A) Prévalence
- B) Odds ratio uniquement
- C) Risque relatif
- D) Différence de moyennes
- E) Valeur prédictive positive

13- Le risque de BPCO associé au tabagisme chez les fumeurs est multiplié par:

- A) 1
- B) 1,5
- C) 2
- D) 3
- E) 4

14- L'intervalle de confiance à 95% du RR est [2,0-4,5].

Quelle est l'interprétation correcte?

- A) L'association n'est pas significative
- B) Le tabac est un facteur protecteur
- C) Le RR n'est pas interprétable
- D) Le tabagisme est un facteur de risque statistiquement significatif
- E) Le risque est identique dans les deux groupes

15- L'excès de risque attribuable au tabagisme est:

- A) 5%
- B) 10%
- C) 15%
- D) 20%
- E) 30%

16- La fraction étiologique chez les exposés (FER) est:

- A) 20%
- B) 33%
- C) 50%
- D) 67%
- E) 75%

17- Après 5 ans de suivi, on a enregistré 140 décès parmi les 600 personnes suivies, et 100 décès parmi les sujets présentant une BPCO. Le taux de mortalité global et le taux de létalité par BPCO seraient:

- A) 23.3% et 83.3%
- B) 15% et 45%
- C) 23.3% et 50%
- D) 75% et 83.3%
- E) Aucune réponse juste

Exercice 2: Énoncé

Un nouveau test rapide est proposé pour le dépistage du diabète de type 2.

Une étude de validation est réalisée chez 5 000 patients, en comparaison avec la glycémie à jeun (gold standard).

Les résultats sont les suivants

Diabétiques confirmés: 500

Test positif: 450

Test négatif: 50

Non diabétiques: 4500

Test positif 900

Test négatif 3600

18- Quel est le triplet sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive du test:

- A) 80%, 90%, 33%
- B) 85%, 75%, 40%
- C) 90%, 80%, 33%
- D) 90%, 85%, 40%
- E) 98%, 75%, 25%

19- Ce test est particulièrement adapté pour:

- A) Confirmer le diabète
- B) Le dépistage (exclusion si négatif)
- C) Remplacer le gold standard
- E) Diagnostiquer sans confirmation
- D) Réduire la prévalence

20- Si la prévalence du diabète augmente dans la population testée:

- A) La sensibilité augmente
- B) La spécificité diminue
- C) La VPP augmente
- D) La VPN diminue toujours
- E) Les rapports de vraisemblance changent

Examen Epidémiologie : Groupe 03 / 2026

Q1. Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à la définition correcte de la valeur prédictive négative (VPN) d'un test diagnostique:

- A) Proportion de sujets testés négatifs parmi les individus malades
- B) Probabilité d'être sain lorsque le test est négatif
- C) Proportion de sujets testés négatifs parmi les sujets sains
- D) Probabilité d'être malade lorsque le test est négatif
- E) Probabilité d'être sain indépendamment du résultat du test

Q2. Dans une population de 146 patients, le test de référence identifie 58 cas positifs. Le test ELISA donne: 54 vrais positifs (VP), 1 faux positif (FP), 4 faux négatifs (FN), 87 vrais négatifs (VN). Quel est le triplet sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive du test ELISA:

- A) 92%, 98%, 99.8%
- B) 93.1%, 98.9%, 98.2%
- C) 85.9%, 97.8%, 92.0%
- D) 93.1%, 75.6%, 89.3%
- E) 90.8%, 99.9%, 100%

Q3. Pour qu'une étude cas-témoins produise une estimation utile du risque relatif, quelle condition doit être remplie:

- A) Exposition très fréquente
- B) Maladie très fréquente
- C) Maladie rare
- D) Biais de sélection maximal
- E) Suivi prospectif obligatoire

Q4. Dans une étude cas-témoins, le tableau suivant est obtenu:

	Exposés	Non Exposés
Témoins (sains)	24	53
Cas (malades)	42	27

Quel est l'odds-ratio associé à l'exposition:

- A) 0.29
- B) 1.88
- C) 3.44
- D) 7.91
- E) 0.55

Q5. Le MeSH (Medical Subject Headings) est:

- A) Un logiciel de gestion bibliographique
- B) Un thesaurus de descripteurs médicaux pour indexer les articles
- C) Un facteur d'impact des revues médicales
- D) Une norme de rédaction scientifique
- E) Un système de classification des maladies

Q6. Lors d'une investigation épidémiologique, quelle démarche méthodologique doit être réalisée avant toute intervention:

- A) Confirmer la réalité d'un excès de cas par rapport au seuil épidémique attendu
- B) Élaborer le protocole analytique
- C) Mettre en place les mesures de lutte
- D) Informer les autorités sanitaires
- E) Identifier la source de contamination

Q7. Une courbe épidémique d'intoxication alimentaire révèle une montée rapide des cas suivie d'une décroissance. Quel diagnostic épidémiologique donne l'allure de la courbe:

- A) Transmission interhumaine seulement
- B) Source commune ponctuelle
- C) Source commune persistante
- D) Exposition continue
- E) Transmission vectorielle

Q8. Dans le cadre d'une analyse épidémiologique descriptive, quelle méthode permet d'estimer la durée médiane d'incubation d'une maladie à partir de la courbe épidémique:

- A) L'intervalle temporel séparant le premier du dernier cas observé (étendue de la distribution des cas)
- B) La différence entre la date du pic épidémique et la date présumée d'exposition au facteur infectieux
- C) Le rapport entre le nombre total de cas et la population initialement exposée
- D) L'intervalle entre deux sommets consécutifs dans une épidémie à transmission interhumaine
- E) La valeur maximale du taux d'attaque observé au cours de l'épidémie

Q9. Dans la chaîne de transmission des maladies transmissibles, le réservoir de germes peut être:

- A) Uniquement l'homme malade
- B) L'homme, l'animal et le milieu extérieur
- C) Exclusivement le milieu extérieur
- D) Seulement l'animal
- E) Le vecteur actif

Q10. Le taux de létalité se calcule par:

- A) Nombre de décès/Population totale 100
- B) Nombre de cas mortels pour une maladie/Total des cas de cette maladie 100
- C) Nombre de décès/Nombre de sujets exposés x 100
- D) Nombre de cas nouveaux/Population à risque 100
- E) Nombre de décès/Nombre de naissances x 1000

Q11. Pour comparer deux proportions issues de deux échantillons indépendants, le test statistique approprié est:

- A. Test t de Student
- B. Test du χ^2 (Chi-deux)
- C. Test de Fisher exact
- D. Test de Wilcoxon
- E. Test de McNemar

Q12. L'hypothèse nulle (H_0) dans une comparaison de deux proportions stipule que:

- A. Les proportions sont différentes
- B. Les moyennes sont égales
- C. Les proportions sont égales
- D. Les variances sont égales
- E. Les échantillons sont appariés

Q13. Si le p-value obtenu est de 0,03 au seuil de 5%, on conclut que :

- A. H_0 est acceptée
- B. La différence observée est due au hasard
- C. On rejette H_0 car la différence est significative
- D. Le test est non valide
- E. Le risque β est supérieur à 5%

Q14. La première étape dans l'élaboration d'un protocole est:

- A. Le choix du test statistique
- B. La formulation de la problématique et des objectifs
- C. La description des résultats attendus
- D. Le recrutement des sujets
- E. L'analyse multivariée

Q15. Un objectif principal bien formulé doit être :

- A. Flou et général
- B. Pertinent, mesurable et en lien avec la problématique
- C. Basé sur les résultats préliminaires
- D. Déterminé à la fin de l'étude
- E. Unique et non modifiable

Q16. L'objectif principal de l'hygiène hospitalière est:

- A. Éliminer toutes les bactéries
- B. Réduire la transmission des infections associées aux soins
- C. Nettoyer les locaux
- D. Réduire le coût des produits désinfectants
- E. Maintenir le confort des patients

Q17. La transmission croisée est favorisée par:

- A. Le respect des précautions standard
- B. Le lavage des mains
- C. Le non-respect de l'hygiène des mains
- D. L'usage de solution hydroalcoolique
- E. La stérilisation du matériel

Q18. Les MNT comprennent principalement:

- A. Le paludisme et la rage
- B. Le diabète, les cancers et les maladies cardiovasculaires
- C. Les infections nosocomiales
- D. Les zoonoses
- E. Les maladies à déclaration obligatoire

Q19. Un outil clé pour la surveillance des MNT est:

- A. Le registre de morbidité
- B. Le carnet de vaccination
- C. L'enquête entomologique
- D. La base de données des maladies infectieuses
- E. Le rapport de mortalité hospitalière

Q20. La prévention primaire des MNT vise à:

- A. Dépister précocement les malades
- B. Réduire les facteurs de risque pour éviter la survenue de la maladie..
- C. Traiter les complications
- D. Évaluer les soins curatifs
- E. Réduire la mortalité post-maladie

Examen Gériatrie : Groupe 02/ 2026

1. Les effets de l'activité physique adaptée APA en gériatrie sont (RF)
 - A. Ralentir les changements physiologiques
 - B. Renforcer l'état cardiovasculaire
 - C. Favoriser le maintien de l'autonomie et prévenir la dépendance
 - D. Améliorer la cognition des personnes âgées
 - E. Prévenir et traiter les risques de chutes
2. Le Bilan clinique avant Activité Physique Adaptée (APA) doit contenir tous ces tests de performance physique sauf un lequel: (RF)
 - A. Vitesse de marche d'une durée 0.8m/sec
 - B. Test de lever de chaise avec un seuil de 14 secondes
 - C. Test d'appui unipodal d'une durée 5s associé à la montée et descente d'escalier.
 - D. Epreuve de la double tâche physique et cognitive
 - E. Timed up and go test avec un seuil de 12 à 20 secondes
3. L'objectif principal du maintien à domicile est: (RJ)
 - A. D'éviter tout recours à l'hospitalisation
 - B. D'assurer un confort psychologique uniquement
 - C. De préserver l'autonomie et la qualité de vie du patient
 - D. De réduire le coût pour la sécurité sociale
 - E. De maintenir les proches à distance
4. En Algérie, l'aide sociale aux personnes âgées est régie principalement par (RJ)
 - A. Le Code du travail
 - B. Le Code de la santé publique
 - C. Le Code de l'action sociale et de la solidarité nationale
 - D. Le Code civil
 - E. La Constitution
5. Au cours de la déshydratation de la personne âgée: (RF)
 - A. Les entrées sont égales aux sorties
 - B. Les maladies chroniques, certaines classes thérapeutiques et les conditions de l'environnement sont des facteurs aggravants.
 - C. On incrimine sur le plan physiopathologique: une diminution de la sensation de soif et une altération fonction rénale.
 - D. On décrit une diminution des apports alimentaires
 - E. La gravité est fonction de la cause et du délai de prise en charge.
6. La particularité de la déshydratation du sujet âgé : (RF)
 - A. Les symptômes sont souvent frustes et atypiques
 - B. Elle expose au risque d'erreur diagnostique
 - C. Elle se manifeste par une altération de la vigilance ou de troubles du comportement
 - D. La sévérité est appréciée par la perte de poids en % et l'état hémodynamique
 - E. Aucune de ses réponses n'est juste

7. Quel principe rôle par la maltraitance des personnes âgées m (RJ)

- A. Bienfaisance
- B. Justice
- C. Autonomie
- D. Confidentialité
- E. Tous les précédents

8. Selon T'OMS, la maltraitance des personnes Âgées implique

- A. Un acte unique ou répété dans une relation de confiance
- B. Un accident isolé sans lien de confiance
- C. Une négligence uniquement médicale
- D. Un problème social uniquement
- E. Un simple désaccord familial

9. Les deux premières phases de l'évolution démographique sont caractérisées par : (RJ)

- A. Raccourcissement de la durée de vie
- B. Augmentation de la fertilité infantile
- C. Augmentation des décès.
- D. Une fertilité des femmes stable
- E. Ces changements ont commencé en Europe de l'ouest

10. Toutes ces informations sont juste sauf: (RF)

- A. La majorité des personnes âgées sont des hommes
- B. Les différences d'espérance de vie suivant les sexes sont plus marquées dans les régions les plus développées.
- C. Le vieillissement est défini par l'ensemble des processus physiologiques
- D. C'est un processus lent et progressif.
- E. La gériatrie est exclusivement la médecine du sujet âgé avec incapacité.

11. Les troubles du sommeil: (RF)

- A. Concerneraient jusqu'à 42% des patients de plus de 65 ans.
- B. 83% des personnes âgées avec troubles du sommeil sont concernées par une insomnie dans un contexte isolé
- C. L'insomnie isolée sans comorbidités reste un diagnostic d'exclusion en gériatrie.
- D. Représentent un motif de consultation très fréquent.
- E. Ont un impact sur la qualité de vie.

12. Les particularités du sommeil chez les personnes âgées sont une: (RF)

- A. Diminution du temps total du sommeil et de son efficacité
- B. Augmentation des réveils nocturnes (fragmentation du sommeil)
- C. Diminution du sommeil profond.
- D. Augmentation progressive et continue de la sécrétion de mélatonine
- E. Avance de phase du sommeil responsable de réveils précoces.

13. Quel est le principal texte législatif en Algérie qui régit la protection des personnes âgées ? (RJ)

- A. La constitution algérienne de 2016×
- B. La loi n° 10-12 du 29 Décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées
- C. Le code civil algérien, livre II sur les majeurs protégés
- D. La loi algérienne sur la solidarité sociale de 2005
- E. Le code pénal algérien

14. A partir de quel âge une personne est légalement considérée comme personne Agée selon la loi 10-12 de 2010 (RJ)

- A. 55 ans
- B. 65 a
- C. 70 ans
- D. 75 ans
- E. 85 ans

15. Quel est le principal facteur de risque d'iatrogénie médicamenteuse chez le sujet âgé (RJ)

- A. L'automédication occasionnelle
- B. L'âge supérieur à 65 ans
- C. La polymédication
- D. La consommation de médicaments génériques
- E. La présence d'une seule pathologie chronique

16. Quelle est l'une des conséquences directes d'une mauvaise observance thérapeutique chez le sujet âgé (RJ)

- A. Amélioration de la qualité de vie
- B. Privation du bénéfice thérapeutique attendu
- C. Réduction du risque de chutes
- D. Diminution du coût des traitements
- E. Simplification du schéma posologique

17. Quelle mesure de vigilance est particulièrement recommandée lors de la prescription chez le sujet âgé ? (RJ)

- A. Privilégier systématiquement les médicaments les plus récents
- B. Eviter tout médicament cardiovasculaire
- C. Etre attentif à l'association de médicaments ayant une même propriété pharmacologique
- D. Ne jamais prescrire de médicaments sous forme de gouttes
- E. Arrêter tous les traitements en cas de maladie aiguë intercurrente

18. La fragilité chez la personne âgée se définit comme: (RJ)

- A. Un synonyme de la dépendance fonctionnelle
- B. Un état de vulnérabilité accrue face aux stress
- C. Une pathologie dégénérative du vieillissement
- D. Une incapacité permanente liée à la perte d'autonomie
- E. Une conséquence directe de la démence

19. Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas un critère du phénotype de fragilité selon Fried? (RF)
- A. Perte de poids involontaire
 - B. Fatigue auto-déclarée
 - C. Hyperactivité physique
 - D. Faible vitesse de marche
 - E. Faible force de préhension
20. Qu'est-ce que le vieillissement? (RJ)
- A. Diminution naturelle des facultés physiques et psychiques
 - B. Augmentation de la masse musculaire sans altération mentale
 - C. Amélioration des capacités physiques et mentales
 - D. Processus surtout psychologique sans impact physique
 - E. Augmentation de la force musculaire et de la mémoire
21. Quel mécanisme contribue au vieillissement cellulaire:
- A. Diminution des radicaux libres
 - B. Augmentation de la capacité de division cellulaire
 - C. Raccourcissement de télomères
 - D. Accumulation de la graisse
 - E. Perturbation biochimique cellulaire
22. Parmi les facteurs extrinsèques de la chute, on retient tous ces signes sauf un, lequel (RF)
- A. Mauvais éclairage
 - B. Extérieur mal adapté
 - C. Dépression
 - D. Habillement mal adapté
 - E. Obstacles
23. Le traitement préventif de la chute comporte tous ces volets thérapeutiques sauf un, lequel (RF)
- A. Traitement orthopédique de la fracture
 - B. Correction des causes médicales
 - C. Optimisation de l'équilibre
 - D. Approche éducative
 - E. Adaptation de l'environnement
24. La démarche diagnostic en cas de chute, comporte toutes ces étapes (RJ)
- A. Examen neurologique
 - B. Evaluation de la marche et de l'équilibre
 - C. Bilan complémentaire
 - D. Evaluation clinique globale
 - E. Toutes ces réponses sont justes

25. Quel signe clinique est typique du syndrome de désadaptation psychomotrice ? (RJ)

- A. Rétropulsion avec hypertonie réactionnelle
- B. Hypotonie flasque généralisée
- C. Tremblements d'attitude
- D. Dyskinésie faciale
- E. Ataxie cérébelleuse

26. Après 10 jours d'alitement chez le sujet âgé, on observe: (RJ)

- A. Une augmentation de la masse maigre
- B. Une augmentation du VO₂ max
- C. Une diminution de 30% de la synthèse protéique musculaire
- D. Une augmentation du tonus musculaire global
- E. toutes les réponses sont justes

27. Les besoins protéiques du sujet âgé (RJ):

- A. Sont de 0.7g/kg/j
- B. Diminuent pour éviter la surcharge rénale
- C. Sont augmentés à environ 1 à 1,2 g/kg/j
- D. Ne doivent pas dépasser 0,6 g/kg/j
- E. Sont couverts uniquement par les produits laitiers

28. Pour un sujet âgé en bonne santé, la répartition énergétiques recommandée est (RJ)

- A. Glucides 20% lipides 50%, protéines 30%
- B. Glucides 50-55%, lipides 30-15% protéines 10-15%
- C. Glucides 60%, lipides 20%, protéines 20%
- D. Glucides 40%, lipides 40%, protéines 20%
- E. Aucune répartition n'est recommandée chez la personne âgée

29. La polymédication est définie par (RJ)

- A. La prise d'au moins 2 médicaments
- B. La prise d'au moins 3 médicaments
- C. La prise d'au moins 5 médicaments de façon chronique
- D. La prise d'un seul médicament à risque
- E. La prescription d'antibiotiques

30. Les complications digestives du syndrome d'immobilisation comprennent (RF)

- A. Constipation
- B. Fécalome
- C. Gastrite ou ulcère indolore
- D. Diarrhée infectieuse
- E. Pseudo-obstruction colique aiguë (syndrome d'Ogilvie)

31. La polypathologie chez la personne âgée se définit par (RJ):

- A. La coexistence d'au moins deux maladies aiguës
- B. La coexistence d'au moins deux maladies chroniques
- C. La coexistence d'une maladie chronique et d'un handicap.
- D. L'association d'une maladie et d'un trouble cognitif
- E. L'association durable de plusieurs affections ayant un retentissement fonctionnel

32. La polymédication expose la personne âgée à (RJ):

- A. Moins d'effets secondaires grâce à l'adaptation des doses
- B. Un risque accru d'interactions médicamenteuses
- C. Une meilleure observance thérapeutique
- D. Une amélioration de la cognition
- E. Une augmentation du risque de chutes et de confusion

33. Quelle échelle est la plus adaptée pour évaluer la douleur chez une personne âgée non communicante (troubles cognitifs sévères)? (RJ)

- A. EVA (Echelle Visuelle Analogique)
- B. DN4
- C. Echelle Algoplus
- D. Score de Rankin
- E. Score de Barthel

34. En cas de douleur chronique modérée chez une personne âgée fragile, quel traitement est recommandé en première intention? (RJ)

- A. Codéine
- B. Morphine orale à libération immédiate
- C. Paracétamol
- D. Aspirine
- E. Diclofenac

35. Parmi les symptômes suivants, lequel est le plus fréquent en phase palliative? (RJ)

- A. Polyurie
- B. Nausées
- C. Fièvre
- D. Douleur
- E. Diarrhée

36. Un patient âgé de 85 ans, vivant seul, est admis aux urgences après une chute. Quelle est la démarche prioritaire recommandée en gériatrie pour ce patient (RJ)

- A. Hospitalisation brève et traitement symptomatique pluridisciplinaire
- B. Evaluation gériatrique globale et prise en charge
- C. Prescription systématique d'antalgiques puissants
- D. Orientation vers une structure psychiatrique
- E. Arrêt de tous les traitements antihypertenseurs

37. Quelle définition correspond le mieux à la gériatrie (RJ)

- A. Spécialité médicale centrée sur les maladies neurologiques graves personnes âgées
- B) Spécialité médicale qui assure la prise en charge globale des
- C. Discipline exclusivement consacrée au diagnostic de la démence
- D. Prise en charge purement psychiatrique des troubles du comportement
- E. Approche exclusivement nutritionnelle

38. Le vieillissement e l'appareil urinaire correspond à tous ces critères sauf un lequel, (RF)

- A. Phénomène physiologique
- B) Entraîne une augmentation de la capacité vésicale
- C. Entraîne une diminution de la contractilité du détrusor
- D. Entraîne une diminution du tonus du sphincter
- E. Peut affecter le contrôle neurologique

39. Parmi les causes précipitantes des troubles vésico sphinctériens chez le sujet âgé, on retrouve (RJ)

- A Délire
- B. Atrophie vaginale ou urétrale
- C. Restriction de mobilité
- D. Constipation
- E. Toutes ces réponses sont justes

40. Parmi les acteurs suivants, lequel intervient directement dans le maintien à domicile? (RJ)

- A. Médecin de travail
- B. Médecin traitant
- C. Médecin légiste
- D. Médecin du sport
- E. Médecin biologiste

Examen Médecine Légale : Groupe 03 / 2026

22- Une blessure occasionnée par un instrument tranchant est caractérisée par: (RJ)

- a. La plaie a l'aspect extérieur d'un orifice minime.
- b. Une plaie en boutonnière.
- c. Une plaie a bords Irréguliers
- d. La profondeur de la plaie dépend du tranchant de la lame.
- e. Une plaie plus profonde que large.

23- Dans l'avortement thérapeutique : (RJ)

- a. L'interruption de la grossesse fera peut-être cessée le danger.
- b. Le danger est sous la dépendance certaine de la grossesse.
- c. Indiqué en cas d'inceste
- d. Aucun autre moyen que l'avortement pour sauver la mère du danger.
- e. La future mère encourt un danger extrême, réel qui menace sa vie ou seulement son équilibre physiologique.

24- L'ecchymose (RJ):

- a. Peut apparaître à distance du traumatisme.
- b. Est une lésion vitale.
- c. Disparaît à la pression.
- d. Disparaît au lavage.
- e. peut apparaître après la mort.

25- Le tribunal: (RF)

- a. Est une juridiction de premier degré de l'ordre administratif.
- b. Comprend un président du tribunal, un juge d'instruction, et des magistrats
- c. Est constitué de chambre pénale, civile et d'accusation cour.
- d. Son objectif est de garantir l'unification de la jurisprudence de l'ordre administratif sur l'ensemble du territoire national.
- e. Juge les affaires déjà jugées au niveau des cours.

CAS CLINIQUE:

M.Samir âgé de 50 ans consulte pour toux productive persistante accompagnée de crachats sanguinolents et une chute pondérale. Les examens médicaux effectués mettent en évidence une formation tumorale maligne de haut grade du poumon gauche. Une indication chirurgicale est posée et le patient est hospitalisé.

26- L'information du patient doit porter sûr: (RJ)

- A- Le diagnostic et le traitement indiqué.
- B- Le diagnostic, le traitement indiqué et les risques encourus par le patient.
- C- Aucune information ne doit être communiquée au patient dans ce cas.
- D- Il appartient au médecin traitant de décider des informations à communiquer en fonction de la situation et au cas par cas.
- E- Réponses B et D sont justes.

Quelques mois après l'intervention chirurgicale et le traitement institué, le patient est reconduit à l'hôpital suite à l'apparition de complications métastatiques en rapport avec sa pathologie. Il se trouve en mauvais état général mais conscient et coopérant. L'échec thérapeutique est constaté après prise en charge médicale. Sa maladie se trouve alors au-dessus de toute possibilité thérapeutique curative

27- Quelle doit être alors la conduite à tenir de l'équipe soignante au regard de la loi et de la déontologie? (RJ)

A- L'abstention thérapeutique dans ce cas, car la poursuite des soins correspondrait à un acharnement thérapeutique.

B- La mise en place d'un protocole de soins palliatifs.

C- La décision dans ce cas doit être prise conjointement avec la famille

D- Prévoir la sortie du patient après la signature d'une décharge par le patient

E- La décision de l'arrêt des soins est conditionnée par la volonté du patient.

L'état général du patient se dégrade brusquement par la survenue d'une péritonite post-occlusive. Il présente des signes de choc avec troubles hémodynamiques. Il est évacué vers l'hôpital public le plus proche. Une intervention chirurgicale en urgence s'impose alors.

28- Quelles sont les conditions légales préalables à l'intervention chirurgicale dans ce cas? (RJ)

A- L'information et l'obtention du consentement éclairé du patient

B- L'obtention du consentement de la famille du patient.

C- L'intervention doit être réalisée dans ce cas sans aucune condition

D- Les réponses A et B sont justes

E- Aucune réponse juste.

Par la suite et dans le post-opératoire immédiat, le patient est victime d'une chute du lit de réanimation. Un hématome sous-dural aigue et une fracture temporale gauche sont constatés au scanner.

Le patient décède alors le lendemain des suites de ce traumatisme.

29- La responsabilité médicale engagée dans ce cas est: (RJ)

A- Responsabilité médicale pénale.

B- Responsabilité médicale administrative

C- Responsabilité médicale civile.

D- Responsabilité médicale disciplinaire

E- Les réponses B et C sont justes.

Un mois après le décès du patient, son frère se présente pour demander au médecin traitant un compte rendu médical d'hospitalisation détaillé qui servira selon ses dires à l'obtention de certains droits.

30- Quelle doit être la conduite à tenir du médecin traitant face à cette demande ? (RJ)

A- Répondre favorablement à cette demande; le secret médical étant aboli après le décès du patient.

B- S'abstenir dans ce cas de remettre tout document aux membres de la famille du patient en vertu de la loi pénale.

C- Ce document ne peut être remis qu'au seul conjoint du patient décédé en vertu de la loi.

D- Un compte rendu médical peut être établi et remis à la demande du juge.

E- Les réponses B et D sont justes.

Examen Médecine Légale : Groupe 04 / 2026

1. Dans la submersion-asphyxique on peut retrouver: (RJ)

- a. Une autopsie blanche.
- b. Une macération de la peau.
- c. La lésion d'amussat
- d. Des diatomées myocardiques.
- e. Des taches brunâtres pulmonaires.

2- Parmi les certificats obligatoires: (RJ)

- a. Certificat de non contagion.
- b. Certificat de constat de décès.
- c. Certificat d'arrêt de travail.
- d. Certificat d'examen de garde à vue.
- e. Certificat de déclaration de maladies obligatoires.

3- L'intoxication massive au monoxyde de carbone est responsable: (RF)

- a. Une coloration rouge carminé de la peau.
- b. Des lividités cadavériques postérieures.
- c. Une fracture de l'os hyoïde.
- d. Saturation de 2/3 de l'HB par le CO.
- e. Des taches de Tardieu.

4- Dans la suffocation faciale on peut retrouver: (RJ)

- a. Des lésions péri-buccales et nasales.
- b. Déchirures des vêtements.
- c. Une pâleur cutanéomuqueuse.
- d. Des fibres de laines dans les voies respiratoires.
- e. Un manchon ecchymotique péri-vasculaire.

5- Dans l'examen clinique d'agression sexuelle on peut retrouver: (RF)

- a. Des ecchymoses au niveau de la face interne des cuisses.
- b. Une lésion de brûlure cervicale.
- c. Des encoches congénitales à 02 et 10h de la membrane hyménale.
- d. Une ecchymose des grandes lèvres.
- e. Une fissure anale récente à 06h de la région anale.

6- la pendaison est caractérisée par: (RF)

- a. Un sillon cervical haut situé.
- b. Un sillon cervical bas situé.
- c. Un sillon cervical oblique.
- d. Des lividités cadavériques distales.
- e. Un sillon complet.

7- La strangulation à la main: (RF)

- a. Est essentiellement suicidaire.
- b. Le mécanisme de la mort peut survenir par Inhibition.
- c. Les lividités cadavériques sont sombres et distales.
- d. Le sillon cervical est haut situé, au dessus du larynx, Incomplet, oblique vers le haut, absent sous le nœud.
- e. Est une asphyxie d'origine pathologique.

8- L'hématome: (RJ)

- a. Est une collection sanguine dans une cavité néoformée par compression d'une artère contre le plan mou.
- b. Est une lésion vitale.
- c. Disparaît à la pression.
- d. Contusion du 3eme degré.
- e. Peut apparaître après la mort.

9- La plaie d'entrée d'une blessure par projectile d'arme à feu présente constamment: (RJ)

- a. Une zone de tatouage.
- b. Une collerette érosive.
- c. Une ecchymose périphérique.
- d. Un orifice de sorti proprement dit.
- e. Une zone d'estompement.

10- Une blessure occasionnée par un Instrument tranchant et piquant est caractérisée par: (RJ)

- a. La plaie a l'aspect extérieur d'un orifice minime.
- b. Une plaie en boutonnière.
- c. Une plaie à bords irréguliers.
- d. La plaie peut être ante ou post mortem
- e. La plaie peut être plus grande si la lame a été enfoncée ou retirée obliquement.

11- La cour: (RF)

- a. Est une juridiction de premier degré de l'ordre administratif.
- b. Comprend un président du tribunal, un juge d'instruction, et des magistrats
- c. Est constituée de chambre pénale, civile et d'accusation.
- d. Son objectif est de garantir l'unification de la jurisprudence de l'ordre administratif sur l'ensemble du territoire national.
- e. Juge les affaires déjà jugées au niveau des tribunaux.

12- L'avortement illégal: (RF)

- a. Une dérogation relative au secret médical à travers l'article 301 du code Pénal Algérien.
- b. Est considéré comme un crime contre la famille et les bonnes mœurs.
- c. Des hémorragies uniques avec expulsion d'un œuf en entier, sans signes infectieux sont en faveur d'un avortement criminel.
- d. Des signes toxiques peuvent orienter vers la nature criminelle de l'avortement.
- e. Le délit nécessite la réunion d'éléments matériels et intentionnels.

13- Concernant le contrat médical: (RJ)

- a. Il doit obligatoirement être établi par écrit pour être valide.
- b. Le patient est engagé indéfiniment avec le même médecin traitant.
- c. Il peut être soit à titre onéreux, soit à titre gratuit.
- d. La possibilité pour le médecin de se faire remplacer systématiquement sans Informer le patient.
- e. Il implique un accord de volonté entre les parties.

14- La maltraitance envers les enfants: (RJ)

- a. L'enfant maltraité peut présenter un retard de croissance staturo-pondéral.
- b. La prise en charge est multidisciplinaire
- . c. Le signalement est une dérogation au secret médical.
- d. Le signalement se fait après obtention du consentement du tuteur légal.
- e. L'enfant maltraité peut concerner le mineur de 18 ans.

15- Le consentement du patient: (RJ)

- a. Doit être systématiquement recueilli par écrit pour tous les actes médicaux.
- b. Peut-être tacite pour les actes médicaux courants.
- c. Est présumé acquis dès lors que le patient s'est présenté à la consultation.
- d. Il représente l'une des conditions du contrat médical.
- e. N'est pas requis si le traitement est conforme aux données acquises de la science.

16- Dans le coma dépassé: (RJ)

- a. L'EEG montre une activité cérébrale élémentaire précaire.
- b. La respiration et l'activité cardiaque sont maintenues de manière autonome.
- c. Il y a abolition totale des fonctions de la vie de relation et des fonctions végétatives.
- d. Le pronostic est Incertain, avec possibilité d'amélioration exceptionnelle.
- e. Le score de Glasgow est généralement compris entre 4 et 6.

17- Le dossier médical: (RF)

- a. Est mis à jour par les techniciens de la santé.
- b. Comporte les antécédents médicaux du patient.
- c. Comporte les résultats des examens para cliniques.
- d. Comporte les correspondances avec d'autres praticiens.
- e. Est remis aux mains propres de l'intéressé.

18- Le certificat d'arrêt de travail: (RJ)

- a. Est un certificat obligatoire.
- b. Comporte l'identité des autorités requérantes.
- c. Comporte l'identité de la victime.
- d. Comporte l'examen clinique et paraclinique.
- e. Comporte une incapacité totale de travail.

19- Les lividités cadavériques: (RJ)

- a. Renseignent sur d'éventuels déplacements du corps.
- b. Sont absentes en cas de mort subite.
- c. Débutent en moyenne 2-3H après le décès.
- d. Apparaissent au niveau des zones d'appuis.
- e. Leur couleur détermine la cause de la mort.

20- Constitue un droit des malades: (RJ)

- a. Le refus de soins.
- b. Des soins médicaux de qualité.
- c. Le droit à la guérison.
- d. La grève de la faim.
- e. Le choix du médecin.

Cas clinique N° 01:

Mme R., 45 ans, est hospitalisée pour une décompensation diabétique. Au cours de l'hospitalisation, elle vous confie être atteinte du VIH et vous demande expressément de ne pas en informer son mari, qui l'accompagne régulièrement et interroge l'équipe médicale sur l'état de santé de son épouse.

21- Le secret médical est défini par: (RJ)

- a. Le Code civil.
- b. Le Code de la santé publique.
- c. Le Code de déontologie médicale.
- d. Le Code pénal.
- e. La jurisprudence uniquement

22- Concernant la demande du mari, l'attitude la plus conforme au droit est : (RJ)

- a. L'informer du VIH pour prévenir un risque
- b. Lui donner des Informations vagues.
- c. Respecter le secret médical et refuser toute Information.
- d. Lui révéler le diagnostic si l'intention est bienveillante.
- e. Lui demander d'Insister auprès de son épouse.

23- Le secret médical peut être levé sans l'accord du patient dans le cas suivant: (RJ)

- a. Demande de la famille proche.
- b. Curiosité d'un autre médecin.
- c. Maladie à déclaration obligatoire.
- d. Volonté de rassurer l'entourage.
- e. Insistance du conjoint.

24- Si Mme R. accepte finalement que son mari soit informé, le médecin: (RJ)

- a. Peut tout révéler sans limite.
- b. Doit obligatoirement obtenir un accord écrit.
- c. Transmet uniquement les informations nécessaires.
- d. Perd toute obligation de secret.
- e. Peut déléguer l'annonce à un tiers non soignant.

25-La violation du secret médical expose le médecin principalement à: (RJ)

- a. Une sanction administrative uniquement.
- b. Une sanction disciplinaire uniquement.
- c. Une sanction pénale uniquement.
- d. Aucune sanction si l'intention est bonne.
- e. Des sanctions pénales, civiles et disciplinaires

CAS CLINIQUE N° 2:

Monsieur A. Salim, 68 ans est hospitalisé dans un service d'oncologie pour une néoplasie bronchique métastatique avec atteinte osseuse et hépatique, diagnostiquée il y a 9 mois. Il a bénéficié auparavant de plusieurs lignes de chimiothérapie toutes interrompues pour Inefficacité et intolérance.

L'état général du patient s'est nettement dégradé et les derniers bilans montrent une progression rapide de sa maladie.

L'équipe médicale estime que toute poursuite de traitement curatif serait déraisonnable.

Une orientation vers une prise en charge palliative est proposée. La famille s'oppose à tout arrêt des soins curatifs. Le malade très fatigué déclare: « Je ne veux plus souffrir, je veux juste être soulagé.

26- Quelle est la problématique éthique principale soulevée par cette situation ? (RJ)

- a. Le refus de soins du patient.
- b. Le conflit entre autonomie du patient et volonté de la famille.
- c. Le manque de moyens thérapeutiques.
- d. L'obligation légale de poursuivre les soins curatifs.
- e. L'euthanasie passive.

27- La poursuite de traitements curatifs dans ce contexte relèverait de: (RJ)

- a. L'obstination thérapeutique déraisonnable.
- b. Une obligation morale du médecin.
- c. Une bonne pratique clinique.
- d. Une sédation palliative.
- e. Un soin de confort.

28- Quel principe éthique justifie prioritairement l'orientation vers des soins palliatifs ? (RJ)

- a. Le principe de justice.
- b. Le principe de non-discrimination.
- c. Le principe de bienfaisance et non-malfaisance.
- d. Le principe de précaution.
- e. Le principe du secret médical.

29- Quelle attitude est la plus conforme à l'éthique médicale ? (RJ)

- a. Suivre la volonté de la famille contre celle du patient.
- b. Imposer l'arrêt des traitements.
- c. Mettre en place une décision collégiale avec le patient en respectant sa volonté.
- d. Poursuivre les traitements curatifs.
- e. Prévoir la sortie du patient vers son domicile.

30- Quel principe éthique doit être prioritairement respecté dans ce cas ? (RJ)

- a. Justice
- b. Précaution
- c. Autonomie du patient
- d. Respect de l'autorité médicale
- e. Intérêt de la famille

Examen Ophtalmologie Groupe : 01 / 2026

1. Quels éléments de l'œil participent directement à la focalisation de la lumière (cochez la réponse FAUSSE)

- A. Cornée
- B. Cristallin
- C. Corps ciliaire
- D. Rétine

2. Concernant la vascularisation de l'œil, quelles affirmations sont correctes ? (cochez la réponse juste)

- 1. Artère centrale de la rétine issue de l'artère ophtalmique
 - 2. Veines vortex drainent le corps ciliaire
 - 3. Choroïde vascularisée par les artères ciliaires postérieures courtes
 - 4. Macula irriguée uniquement par les artères ciliaires antérieures
 - 5. Iris irrigué par les artères rétinienne
- A(2+3) B-(1+2+3) C-(2+3+5) D-(1+2+3+4)

3. Quelles affirmations sur le strabisme sont correctes ? (cochez la réponse juste)

- 1. Strabisme accommodatif associé à hypermétropie
- 2. Strabisme peut entraîner amblyopie
- 3. Orthophorie «strabisme convergent»
- 4. Angle de déviation constant ou intermittent
- 5 Traitement uniquement chirurgical

A- (1+2+4) B- (1+2+3) C- (2+3+5) D- (1+2+3+4)

4. Manifestations d'une luxation postérieure du cristallin: (cochez la réponse FAUSSE)

- A. Douleur oculaire importante
- B. Baisse de l'acuité visuelle
- C. Cristallin dans cavité vitrénne
- D. Iridodonesis

5. Concernant les vices de réfraction, quelles affirmations sont correctes (cochez la réponse FAUSSE)

- A. Hypermétropie peut être associée à astigmatisme
- B. Myopie corrigée par lentilles divergentes
- C. Astigmatisme peut être cornéen ou cristallinien
- D. Presbytie baisse d'accommodation lié à l'âge

6. L'échographie oculaire en mode «A» est utilisée pour (cocher la réponse FAUSSE)

- A. visualiser le fond d'œil en cas de troubles des milieux transparents
- B. Mesurer la longueur axiale
- C. Calculer implant intraoculaire avant chirurgie de la cataracte
- D. Diagnostic de mélanome choroïdien couplée au mode B

7. Signes suspects du glaucome à angle ouvert et son évolution (cochez la réponse FAUSSE)

- A. Asymétrie excavation papillaire
- B. Rapport C/D <0.4
- C. Ressaut nasal au champ visuel
- D. Hémorragie du disque optique

8. Caractéristiques de Chlamydia trachomatis: (cochez la réponse juste)

- 1. Petit bacille gram positif
- 2. intracellulaire obligatoire
- 3. incapable de se multiplier en milieu artificiel
- 4. Réservoir mouche Musca sorbens
- 5. Non immunisante

A- (2+3+4) B-(1+2+3) C-(2+3+5) D- (1+2+4)

9. Les complications du diabète sur l'œil (cochez la réponse FAUSSE)

- A. Rétinopathie diabétique
- B. Cataracte précoce
- C. Œdème maculaire
- D. Conjonctivite

10. Concernant le dépistage de la rétinopathie diabétique: (cochez la réponse juste)

- 1. il est recommandé dès le diagnostic chez les diabétiques de type 2
- 2. il est inutile chez les enfants diabétiques
- 3. Il doit être fait tous les 5 ans
- 4. L'examen du fond d'œil est fondamental
- 5. La rétinographie peut être utilisée comme outil de dépistage

A- (1+4) B-(1+5) C-(1+4+5) D-(1+2+4)

11. Signes de neuropathie optique glaucomateuse (cochez la réponse FAUSSE)

- A. Réduction des fibres nerveuses rétiniennes à l'OCT
- B. Déficit du champ visuel
- C. Neurorétinite
- D. Excavation papillaire

12. Signes de rétinoblastome: (cochez la réponse juste)

- 1. Leucocorie
- 2. Strabisme
- 3. Hyphéma
- 4. Calcifications rétiniennes
- 5. Myopie brutale

A(1+2+4) B-(1+3+5) C- (2+4+5) D- (3+4+5)

13. Quels sont les facteurs de risque du glaucome chronique à angle ouvert: (cochez la réponse FAUSSE)

- A. La myopie forte
- B. L'hypermétropie
- C. Un cas similaire dans la famille
- D. Le diabète

14. Quelles sont les causes possibles de la cataracte ? (cochez la réponse juste)

- 1. Vieillesse naturelle du cristallin
- 2. Traumatisme oculaire
- 3. Exposition prolongée aux rayons UV
- 4. Diabète mal contrôlé
- 5. Utilisation prolongée de corticoïdes

A- (1+2+3) B- (2+4+5) C- (1+2+4+5) D- (1+2+3+4+5)

15. Complications possibles du mélanome choroïdien : (cochez la réponse FAUSSE)

- A. Décollement séreux de rétine
- B Glaucome secondaire
- C. Hémorragie intraoculaire
- D. Rétinite pigmentaire

16. Les analogues de prostaglandine en collyre doivent être évités en cas de: (cochez la réponse juste)

- 1. Glaucome chronique à angle ouvert TRT
- 2. Crise de glaucome angle à angle fermé
- 3. Herpes oculaire
- 4. Chirurgie oculaire
- 5. Glaucome pseudo-exfoliatif

A (2+3) B (1+5) C (2+3+4) D(3+4+5)

17. Signes cliniques d'un décollement de rétine hémotogène (cochez la réponse FAUSSE)

- A. Associé à une déchirure rétinienne
- B. Perte de vision
- C. Douleur oculaire
- D. Flash lumineux

18. Les différents traitements au laser pour les glaucomes: (cochez la réponse FAUSSE)

- A. Photocoagulation panrétinienne (PPR)
- B. Iridotomie périphérique
- C. Trabéculoplastie sélective
- D. Cyclophotocoagulation

19. Indications d'une échographie oculaire mode B: (cochez la réponse juste)

- 1. Décollement de rétine
- 2. Masse intraoculaire
- 3. Cataracte obturante
- 4. Hyphéma total sur traumatisme contusif
- 5. Milieux oculaires transparents

A- (1+2+4) B- (2+3+4) C- (1+3+5) D- (1+2+3+4)

20. Indications d'une OCT maculaire dans la DMLA: (cochez la réponse juste)

- 1. Suivi des drusens
- 2. Détection d'œdème sous-rétinien
- 3. Suivi post-injection anti-VEGF
- 4. Détection d'une déchirure rétinienne périphérique
- 5. Détection de néovascularisation choroïdienne

A(1+3+4) B (2+3+5) C (1+2+3+5) D (1+2+3+4+5)

21. Signes de kératite virale herpétique : (cochez la réponse juste)

- 1. Douleur oculaire
- 2. Photophobie
- 3. Ulcère dendritique
- 4. semi-mydriase aréfléxique GAFA
- 5. Cercle périkeratiques/uvéite / GAFA

A-(1+3+4) B- (2+3+5) C (1+2+3+4) D (1+2+3+5)

28. Traitement du glaucome congénital; (cochez la réponse juste)

1. Goniotomie
2. Corticothérapie orale
3. Trabeculoplastie sélective au laser
4. Traitement Hypotonisant à vie
5. trabéculectomie

A-(2-3) B-(3-4) C-(1-5) D-(1-3-5)

29. Complications du trachome (cochez la réponse juste)

1. Entropion-trichiasis
2. Pannus trachomateux
3. Sclérites
4. Rétinite infectieuse
5. Xérosis

A (1+2+3) B (1+2+5) C (1+3+5) D (1+2+4)

30. Paralysie de la 4eme paire crânienne (IV) (cochez la réponse juste)

1. Diplopie monoculaire
2. Gêne lecture/descente escaliers
3. Plus fréquente des paralysies oculomotrices
4. Paralysie de l'abduction
5. Diplopie verticale

A-(2-3) B-(2-5) C-(2+3+5) D-(2+4+5)

PARTIE PRATIQUE:Cas clinique 1:

Patient de 55 ans hypertendu, adressé pour bilan de retentissement de l'HTA... Fond d'œil: excavation papillaire bilatérale suspecte, Tonus oculaire mesuré à 26mmHg OD/OG. Champ visuel 24-2: scotome périphérique nasal bilatéral.

31. Diagnostic le plus probable (cochez la réponse juste)

- A. Glaucome chronique angle ouvert ?
- B. Rétinopathie hypertensive
- C. Neuropathie optique ischémique
- D. Cataracte sénile

32. Facteurs de risque (Cochez la réponse JUSTE)

- 1. Age avancé
 - 2. Tabagisme
 - 3. Pression intraoculaire élevée
 - 4. Sexe masculin
 - 5. Hypertension
- A- (1+2+3) B- (1+3+4) C- (2+4+5) D- (1+3+5)

33. Examens complémentaires nécessaires (cochez la réponse juste)

- 1. OCT RNFL
 - 2. Champ visuel 24-2
 - 3. OCT maculaire
 - 4. OCT GCC
 - 5. Biomicroscopie
- A-(1+2) B-(1+2+4) C-(2+3+4) D-(1+2+4+5)

34. Traitement initial recommandé en première intention:(cochez la réponse juste)

- A Collyres hypotonisants
- B. Chirurgie filtrante
- C. Laser trabéculaire
- D. Surveillance seule

35. Signes spécifiques à surveiller lors du suivi de l'évolution de cette pathologie:(cochez la réponse juste)

- 1. Progression du champ visuel
 - 2. Augmentation de la pression intraoculaire
 - 3. Développement de cataracte
 - 4. Décollement rétinien
 - 5. Œdème maculaire
- A-(1+2) B-(1+2+3) C-(2+3+4) D-(1+3+5)

Cas clinique 2:

Un nourrisson de 8 mois est amené en consultation pour suspicion de malvoyance.

À l'examen, on observe une leucocorie bilatérale, sans douleur, ni rougeur oculaire. Selon les parents, cette anomalie est présente depuis la naissance.

36. Diagnostic probable (cochez la réponse juste)

- A. Glaucome congénital
- B. Cataracte congénitale bilatérale
- C. Rétinopathie du prématuré
- D. Kératite infectieuse

37. Examens complémentaires à demander (cochez la réponse Juste)

- 1. Examen du fond d'œil sous mydriase
- 2. Echographie mode B
- 3. Réfraction cycloplégique
- 4. OCT maculaire
- 5. Biologie (glycémie, rubéole maternelle)

A- (1+2+4) B- (1+3+4) C- (2+4+5) D- (1+2+3+5)

38. Causes possibles (cochez la réponse juste)

- 1. Malformations congénitales
- 2. Infection maternelle (rubéole)
- 3. Traumatisme post-natal
- 4. Médicaments maternels (corticoïdes, chimiothérapie)
- 5. Vieillesse du cristallin

A-(2-3-5) B-(1+2+4) C-(2+3+4) D-(1+2+3+5)

39. Traitement recommandé (cochez la réponse juste)

- 1. Chirurgie précoce des opacités
- 2. Correction optique
- 3. Occlusion de l'œil dominant si amblyopie
- 4. Observation seule
- 5. Chirurgie tardive des opacités

A-(1+2) B-(3+4) C-(1+2+3) D-(2+3+5)

40. Suivi post-opératoire (cochez la réponse juste)

- 1. Contrôle mensuel le premier trimestre
- 2. Surveillance de la pression intraoculaire
- 3. Rééducation visuelle (occlusion si amblyopie)
- 4. Imagerie systématique à chaque visite
- 5. Traitement médical à vie

A- (1+2+3) B- (2+3+4) C-(3+4+5) D-(1+4+5)

Cas clinique 3:

Homme de 30 ans reçu un coup direct à l'œil droit lors d'un match de football, Douleur modérée vision floue, œil rouge,

41. Signes cliniques attendus (cochez la réponse juste)

1. Hyphéma
2. ischémie limbique étendue
3. Cataracte traumatique
4. Œdème de Berlin rétinien
5. Conjonctivite aiguë

A- (1-2-3) B- (2-3-4) C- (2+3+4) D- (1+3+5)

42. Examens à faire (cochez la réponse juste)

1. Examen à la lampe à fente
2. Tonométrie
3. Fond d'œil après mydriase
4. Echographie oculaire mode B si milieux transparents
5. IRM orbitaire systématique

A- (1+2+3) B- (2+3+5) C- (1+3+4+5) D- (1+2+3+4)

43. Complications possibles (cochez la réponse juste)

1. Hémorragie intraoculaire
2. Décollement rétinien
3. Cataracte traumatique
- 4 Glaucome secondaire
5. Endophtalmie

A-(1+2+3) B- (1+3+5) C- (2+3+4) D- (1+2+3+4)

44. Traitement initial (cochez la réponse juste)

1. Repos oculaire
2. Collyres anti-inflammatoires
3. Hypotonisants systématique
4. Exploration immédiate au bloc opératoire
5. Suivi régulier

A-(2+3+5) B- (3+4+5) C- (1+2+5) D- (1+2+3+5)

45. Suivi recommandé: (cochez la réponse juste)

1. Contrôle à 24-48 h
2. Contrôle à 1 semaine
3. Contrôle mensuel jusqu'à stabilisation
4. Suivi par Imagerie systématique
5. Pas de suivi nécessaire si asymptomatique

A- (1+2+3) B- (2+3+4) C- (3+4+5) D-(1+4+5)

Cas clinique 4:

Homme de 65 ans, consulte pour baisse progressive de vision d'un œil depuis 2 mois, sans douleur. Examen révèle une masse pigmentée choroïdienne au fond d'œil.

46. Diagnostic probable : (cochez la réponse juste)

- A. Hémangiome choroïdien
- B. Mélanome choroïdien
- C. Métastases intraoculaires
- D. Dégénérescence maculaire liée à l'âge

47. Examens complémentaires à demander (cochez la réponse juste)

- 1. Echographie oculaire
- 2. OCT maculaire
- 3. Angiographie à la fluorescéine
- 4. IRM orbitaire
- 5. Biopsie transvitréenne

A- (2-3-4) B- (1+2+3) C- (1+2+3+4) D- (2+3+4+5)

48. Facteurs de mauvais pronostic (cochez la réponse juste)

- 1. Taille > 10 mm
- 2. Extension ciliaire
- 3. Antécédents familiaux
- 4. Cellules épithéliales à la cytologie
- 5. Présence de métastases hépatiques

A- (2-3-4) B- (1+3+5) C- (1+2+4+5) D- (1+2+3+4+5)

49. Traitement recommandé (cochez la réponse juste)

- 1. Radiothérapie (plaques ou proton)
- 2. Eviscération
- 3. Exérèse totale de l'œil (énucléation)
- 4. Simple surveillance
- 5. Chimiothérapie systémique seule

A- (1+2) B- (2+3) C- (2+4) D- (3+5)

50. Suivi recommandé après traitement: (cochez la réponse FAUSSE)

- A. Contrôle ophtalmologique tous les 3 mois la première année
- B. Surveillance hépatique tous les 6 mois
- C. Pas de suivi nécessaire si traitement complet
- D. imagerie systématique en cas de symptômes

Examen Ophtalmologie Groupe : 04 / 2026

1. L'acuité visuelle se mesure: (cochez la réponse juste)
 - A. En dioptries
 - B. En dixièmes
 - C. En millimètres
 - D. En millisecondes
2. L'œil emmétrope est: (cochez la réponse juste)
 - A. Myope
 - B. Hypermétrope
 - C. Sans défaut de réfraction
 - D. Astigmat
3. L'échelle de Snellen permet de mesurer: (cochez la réponse Juste)
 - A. La vision des couleurs
 - B. L'acuité visuelle de loin
 - C. Le champ visuel
 - D. La motilité oculaire
4. Une douleur oculaire aigue avec baisse de vision, cornée trouble, pupille semi-mydriatique évoque: (cochez la réponse juste)
 - A. Conjonctivite virale
 - B. Uvéite antérieure
 - C. Crise aigüe de fermeture de l'angle
 - D. Kératite bactérienne
5. La presbytie est due à: (cochez la réponse juste)
 - A. Un excès de convergence
 - B. Une augmentation de la longueur axiale
 - C. Une opacification du cristallin
 - D. Une perte de l'accommodation liée à l'âge
6. Le test de Schirmer évalue: (cochez la réponse Juste)
 - A. La réfraction
 - B. La production lacrymale
 - C. La motilité oculaire
 - D. La transparence cornéenne
7. Une baisse brutale et Indolore de la vision avec fond d'œil montrant une rétine blanchâtre et macula rouge cerise évoque: (cochez la réponse Juste)
 - A. Occlusion de la veine centrale de la rétine
 - B. Occlusion de l'artère centrale de la rétine
 - C. Décollement de rétine
 - D. Névrite optique
8. Un patient Jeune présente une rougeur oculaire unilatérale, douleur et photophobie après l'apparition d'un bouton de fièvre: (cochez la réponse Juste)
 - A. Conjonctivite virale
 - B. Kératite herpétique
 - C. Glaucome aigu
 - D. Dacryocystite

9. Le traitement de la DMLA exsudative repose sur: (cochez la réponse juste)

- A. Laser argon
- B. Injections intravitréennes d'anti-VEGF
- C. Corticoïdes topiques
- D. Chirurgie vitréo-rétinienne d'emblée

10. L'hyphéma correspond à: (cochez la réponse Juste)

- A. Du pus dans la chambre antérieure
- B. Du sang dans la chambre antérieure
- C. Du sang dans le vitré
- D. Une hémorragie sous-conjonctivale

11. Le glaucome chronique à angle ouvert est caractérisé par: (cochez la réponse juste)

- A. Douleur oculaire intense
- B. Perte progressive du champ visuel périphérique
- C. Mydriase aréactive
- D. Hyperhémie conjonctivale marquée

12. Une diplopie monoculaire évoque: (cochez la réponse juste)

- A. Astigmatisme irrégulier important
- B. Atteinte des nerfs crâniens
- C. Myasthénie
- D. Paralyse oculomotrice

13. Le traitement de la cataracte consiste en: (cochez la réponse juste)

- A. Collyres mydriatiques
- B. Laser argon
- C. Extraction du cristallin + Implant intraoculaire
- D. Anti-VEGF

14. L'examen à la lampe à fente permet: (cochez la réponse juste)

- A. Une topographie cornéenne
- B. L'examen du segment antérieur
- C. Le test du champ visuel
- D. La mesure du tonus oculaire

15. Une leucocorie chez l'enfant évoque principalement: (cochez la réponse juste)

- A. Rétinoblastome
- B. Kératite
- C. Uvéite
- D. Myopie forte

16. La photophobie est typique: (cochez la réponse Juste)

- A. D'une atteinte de la cornée
- B. D'une atteinte du nerf optique
- C. D'une diplopie
- D. D'une cataracte

17. L'exophtalmie est caractérisée par: (cochez la réponse Juste)

- A. Un globe enfoncé dans l'orbite
- B. Une protrusion du globe oculaire
- C. Une diplopie binoculaire
- D. Une anisocorie

18. Le traitement de l'amblyopie repose sur: (cochez la réponse juste)

- A. Occlusion de l'œil sain
- B. Occlusion de l'œil atteint
- C. Chirurgie immédiate
- D. Verres progressifs

19. Le signe typique d'une rétinopathie hypertensive sévère est: (cochez la réponse juste)

- A. Des Drusens maculaires
- B. Des exsudats en taches de bougie
- C. Des hémorragies en flammèche et un œdème papillaire
- D. Une hémorragie du vitré

20. Une papille œdématisée bilatérale évoque: (cochez la réponse juste)

- A. Hypertension intracrânienne
- B. Glaucome chronique
- C. Névrite optique unilatérale
- D. Kératite

21. Une iridocyclite correspond à: (cochez la réponse juste)

- A. Une inflammation de la cornée
- B. Une inflammation de l'uvée antérieure
- C. Une atteinte du vitré
- D. Une atteinte du nerf optique

22. L'atteinte du nerf oculomoteur commun (II) entraîne: (cochez la réponse juste)

- A. Diplopie verticale
- B. Myosis
- C. Nystagmus
- D. Ptosis + mydriase

23. Le traitement de la kératite herpétique est: (cochez la réponse juste)

- A. Antibiotiques topiques
- B. Corticoïdes locaux
- C. Antiviraux topiques ± oraux
- D. Mydriatiques seuls

24. Une hémorragie du vitré entraîne: (cochez la réponse juste)

- A. Diplopie
- B. Flou visuel brutal avec perception de corps flottants en pluie de suie
- C. Douleur
- D. Photophobie

25. Le trachome est: (cochez la réponse Juste)

- A. Une infection virale chronique
- B. Une kératite d'origine allergique
- C. Une conjonctivite bactérienne à Chlamydia trachomatis
- D. Une uvéite granulomateuse

26. La rétinopathie diabétique se caractérise par: (cochez la réponse Juste)

- A. Des microanévrismes et des hémorragies rétinienues
- B. Des drusens maculaires
- C. Une excavation papillaire
- D. Un œdème papillaire isolé

27. La cornée est: (cochez la réponse juste)

- A. Vascularisée
- B. Avasculaire
- C. Pigmentée
- D. Innervée par le nerf optique

28. Le réflexe photomoteur implique: (cochez la réponse juste)

- A. La rétine
- B. Le nerf optique
- C. Le mésencéphale
- D. L'ensemble des trois

29. L'occlusion veineuse rétinienne typique montre: (cochez la réponse juste)

- A. Fond d'œil en "orage hémorragique"
- B. Fond d'œil en "taches d'huile"
- C. Macula rouge cerise
- D. Papille pâle

30. La cause la plus fréquente de cécité évitable dans le monde est: (cochez la réponse juste)

- A. DMLA
- B. Glaucome
- C. Cataracte
- D. Rétinopathie diabétique

PARTIE PRATIQUE :Cas clinique 1 :

Un enfant de 6 ans consulte pour rougeur oculaire bilatérale, sécrétions mucopurulentes abondantes au réveil, sans douleur intense.

31. Diagnostic le plus probable: (cochez la réponse juste)

- A. Conjonctivite virale (adénovirose)
- B. Conjonctivite bactérienne aiguë
- C. Glaucome aigu
- D. Kératite bactérienne profonde

32. Traitement de première intention chez l'enfant en ambulatoire: (cochez la réponse juste)

- A. Corticoïdes topiques
- B. Collyre antibiotique topique adapté (ex: tobramycine)
- C. Anti-VEGF
- D. Chirurgie immédiate

33. Mesure d'hygiène recommandée: (cochez la réponse juste)

- A. Fermeture définitive de l'école pour 15 jours
- B. Bonne hygiène des mains, ne pas partager serviettes, nettoyage des sécrétions
- C. Utiliser la même serviette pour toute la famille
- D. Arrêt des vaccins

34. La suspicion d'ophtalmie néonatale à gonocoque chez un nouveau-né, quelle attitude? (cochez la réponse juste)

- A. Collyre lubrifiant uniquement
- B. Aucun traitement nécessaire
- C. Urgence - prélèvement et traitement systémique + topique après avis spécialisé
- D. Anti-VEGF

35. Complication redoutée si non traité: (cochez la réponse juste)

- A. Kératoconjonctivite
- B. Décollement de rétine
- C. Kératocône
- D. DMLA

Cas clinique 2 :

Une femme de 60 ans consulte pour douleur oculaire intense, rougeur, baisse rapide de vision unilatérale et nausées depuis quelques heures.

36. Quel est le diagnostic le plus probable ? (cochez la réponse juste)

- A. Conjonctivite virale
- B. Crise de glaucome aigu par fermeture de l'angle
- C. Kératite bactérienne
- D. Dacryocystite

37. Quel signe clinique est typique ? (cochez la réponse juste)

- A. Sécrétions purulentes
- B. Cornée claire et pupille normale
- C. Cornée trouble et pupille semi-mydriatique
- D. Synéchies irido-cristaliniennes

38. Quel examen est prioritaire ? (cochez la réponse juste)

- A. Mesure de la pression intraoculaire
- B. OCT maculaire
- C. IRM orbitaire
- D. Angiographie rétinienne

39. Quel traitement initial doit être Instauré ? (cochez la réponse juste)

- A. Corticoïdes topiques
- B. Antibiotiques locaux
- C. Hypotonisant systémique + myotique topique
- D. Laser prophylactique immédiat de cet œil

40. Quel geste préventif proposé après stabilisation? (cochez la réponse juste)

- A. Port de lunettes correctrices
- B. Iridotomie au laser
- C. Chirurgie vitréenne
- D. Suivi sans traitement

Cas clinique 03:

Un ouvrier consulte pour douleur oculaire, larmoiement et sensation de corps étranger après avoir meulé sans protection oculaire.

41. L'hypothèse principale est: (cochez la réponse juste)

- A. Ulcère
- B. Corps étranger cornéen
- C. Kératite virale
- D. Uvéite

42. Quel examen est indispensable ? (cochez la réponse juste)

- A. Mesure de la tension oculaire
- B. Examen à la lampe à fente du segment antérieur
- C. OCT
- D. Fond d'œil

43. Quel traitement est indiqué? (cochez la réponse juste)

- A. Collyre mydriatique
- B. Corticoïdes
- C. Extraction du corps étranger + collyre antibiotique
- D. Pansement oculaire sec

44. Une complication possible est: (cochez la réponse juste)

- A. Hypopion
- B. Glaucome
- C. Cataracte
- D. Kératite bactérienne

45. La prévention repose sur: (cochez la réponse Juste)

- A. Collyres antiseptiques
- B. Port de lunettes de protection
- C. Mydriase
- D. Sérum physiologique

Cas clinique 4:

Un homme de 55 ans aux antécédents de diabète déséquilibré depuis 15 ans, consulte pour une baisse progressive de la vision bilatérale, sans douleur ni rougeur.

46. Quel est le diagnostic le plus probable ? (cochez la réponse juste)

- A. DMLA
- B. Œdème maculaire diabétique
- C. Glaucome chronique
- D. Cataracte secondaire

47. Quel est le signe typique au fond d'œil ? (cochez la réponse Juste)

- A. Drusens maculaires
- B. Microanévrismes et exsudats dans la macula
- C. Pâleur papillaire
- D. Œdème papillaire isolé

48. Quel examen est utilisé pour le suivi ? (cochez la réponse juste)

- A. IRM cérébrale
- B. Scanner orbitaire
- C. OCT maculaire
- D. Angiographie cérébrale

49. Quel est le traitement principal ? (cochez la réponse juste)

- A. Injections intra vitréennes d'anti-VEGF
- B. Corticothérapie orale
- C. Laser panrétinien systématique
- D. Antibiotiques topiques

50. Comment prévenir l'aggravation? (cochez la réponse Juste)

- A. Injections intra vitréennes d'antibiotiques
- B. Contrôle strict de la glycémie et de la tension artérielle
- C. Port de lunettes correctrices
- D. Chirurgie préventive

Examen ORL : Groupe 02 / 2026

La Partie théorique

1. Concernant l'otite moyenne aiguë de l'enfant, cochez la/les proposition(s) exacte(s) (plusieurs bonnes réponses):

- A. Elle fait souvent suite à une infection virale des voies aériennes supérieures (rhinopharyngite).
- B. Streptococcus pneumoniae est l'un des principaux agents étiologiques des formes purulentes d'otite moyenne aiguë.
- C. Le traitement probabiliste de première intention est l'amoxicilline (en l'absence d'allergie).
- D. Une complication possible de l'otite moyenne aiguë est la mastoïdite, nécessitant un drainage chirurgical en urgence dans les cas sévères.
- E. Elle est plus fréquente chez l'adulte que chez l'enfant.

2. À propos de l'otite moyenne chronique cholestéatomateuse, quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) (plusieurs bonnes réponses):

- A. Elle se caractérise par la présence d'une poche de rétraction épithéliale remplie de squames kératosiques (cholestéatome) dans l'oreille moyenne.
- B. Elle entraîne habituellement une hypoacousie de transmission (érosion des osselets) pouvant s'aggraver en l'absence de traitement.
- C. C'est une forme bénigne d'otite chronique qui ne provoque pas de complications locorégionales.
- D. En raison du risque de complications graves (paralysie faciale, méningite, abcès cérébral...), le traitement de référence est l'éradication chirurgicale du cholestéatome.
- E. Un dysfonctionnement chronique de la trompe d'Eustache favorise son développement (via les poches de rétraction tympanique).

3. Épreuve de Weber et test de Rinne dans une surdité de transmission droite: quelle(s) observation(s) est (sont) attendue(s) (plusieurs bonnes réponses)?

- A. Rinne négatif à droite (conduction osseuse > conduction aérienne côté droit)
- B. Rinne positif à droite.
- C. Latéralisation du son vers l'oreille droite au test de Weber
- D. Latéralisation du son vers l'oreille gauche au test de Weber.
- E. Rinne négatif à gauche (oreille gauche saine).

4. Concernant le vertige paroxystique positionnel bénin (VPPB), cochez la/les bonne(s) réponse(s) (plusieurs bonnes réponses):

- A. Il se manifeste par des vertiges brefs survenant lors des changements de position de la tête
- B. Il s'accompagne typiquement d'acouphènes et d'une surdité de perception.
- C. La manœuvre diagnostique de Dix-Hallpike permet de déclencher le vertige typique
- D. Le VPPB est dû à la présence d'otolithes libres dans un canal semi-circulaire (canalolithiase).
- E. Le traitement de première intention consiste en des manœuvres de repositionnement canaux (par exemple la manœuvre d'Epley plutôt qu'un traitement médicamenteux)

5. A propos de Petospongiose (otosclérose), cochez la/les réponse(s) juste(s) (plusieurs bonnes réponses)

A. S'agit d'une cause de surdité de transmission progressive due à une ankylose de l'étrier dans l'oreille moyenne.

B. Elle touche préférentiellement les femmes jeunes adultes (2 femmes pour 1 homme, âge typique 20-40 ans).

C. L'examen otoscopique retrouve typiquement des otorrhées purulentes à répétition.

D. L'audiométrie met en évidence un abaissement des seuils aériens avec un Rinne ouvert écart entre la courbe osseuse et la courbe aérienne.

E. Le traitement de choix est purement médical (corticothérapie et antiviraux).

6. Maladie de Ménière-Parmi les affirmations suivantes, laquelle est fausse (une seule bonne réponse)?

A. Elle associe classiquement des crises de vertige rotatoire, des acouphènes et une surdité de perception fluctuante (surdité cochléaire).

B. Elle est causée par une hypertension artérielle mal contrôlée.

C. Les vertiges de Ménière durent typiquement de quelques dizaines de minutes à quelques heures.

D. Un traitement de fond faisant appel à un régime désodé, aux diurétiques et à la bétahistine peut réduire la fréquence des crises.

E. A long terme, elle peut évoluer vers une perte auditive permanente de type perceptif.

7. Concernant la rhinite allergique, cochez la/les proposition(s) exacte(s) (plusieurs bonnes réponses):

A. Il s'agit d'une réaction d'hypersensibilité de type I

B. Elle se manifeste typiquement par des éternuements en salve, une rhinorrhée claire et un prurit nasal et oculaire.

C. Les corticostéroïdes en spray nasal constituent un traitement de première intention dans les formes modérées à sévères.

D. Elle entraîne fréquemment des perforations de la cloison nasale.

E. En cas d'échec des mesures d'éviction et du traitement médical, une désensibilisation allergénique spécifique peut être proposée.

8. Sinusite maxillaire aiguë: cochez la/les proposition(s) exacte(s) (plusieurs bonnes réponses):

A. Elle fait souvent suite à une infection virale nasopharyngée (rhinovirus, etc.).

B. Une douleur projetée au niveau des dents supérieures peut révéler une sinusite maxillaire aiguë.

C. Une cause fréquente de sinusite maxillaire unilatérale est une infection dentaire (sinusite odontogène).

D. La plupart des sinusites maxillaires aiguës sont liées à une polypose naso-sinusienne.

E. Le traitement d'une sinusite maxillaire aiguë bactérienne comprend généralement une antibiothérapie adaptée après 48-72h d'évolution des symptômes persistants ou d'emblée si le tableau est sévère.

9. Otite externe maligne (ou nécrosante)-Quelle(s) proposition(s) est (sont) correcte(s):

- A. Elle survient surtout chez les diabétiques et Immunodéprimés.
- B. Elle est due à Staphylococcus aureus dans la majorité des cas.
- C. Elle peut entraîner une ostéite du rocher et une paralysie faciale.
- D. Le traitement nécessite des antibiotiques systémiques prolongés (anti-Pseudomonas).
- E. Le pronostic est toujours bénin.

10. Parmi les complications suivantes, lesquelles peuvent résulter d'une sinusite aiguë non traitée (plusieurs bonnes réponses)?

- A. Une cellulite orbitaire (par extension d'une sinusite ethmoïdale).
- B. Une thrombophlébite du sinus caverneux.
- C. Un abcès cérébral (notamment à partir d'une sinusite frontale).
- D. Une otite externe nécrosante du conduit auditif dite «maligne »
- E. Une ostéomyélite du frontal (tuméfaction du front appelée tumeur du Pott).

11. Angines aiguës (amygdalites aiguës) Coches la/les réponse(s) Juste(s) (plusieurs bonnes réponses):

- A. La majorité des angines aiguës sont d'origine virale et guérissent spontanément
- B. La présence d'un exsudat blanchâtre sur les amygdales signe obligatoirement une angine bactérienne à streptocoque
- C. Streptococcus B-hémolytique du groupe A est la cause la plus fréquente des angines bactériennes.
- D. En l'absence de contre-indication, l'amoxicilline per os est le traitement de première intention d'une angine streptococcique confirmée.
- E. Une mononucléose infectieuse peut se manifester par une angine pseudo-membraneuse et des polyadénopathies cervicales.

12. Indications de la tonsillectomie (amygdalectomie)-Quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) (plusieurs bonnes réponses)?

- A. Des angines à répétition (25 épisodes par an sur au moins 2 années consécutives) constituent une Indication à l'amygdalectomie.
- B. Un syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil dû à une hypertrophie amygdalienne chez l'enfant est une indication opératoire formelle.
- C. Des abcès péri-amygdaliens récidivants justifient une amygdalectomie d'intervalle.
- D. Une angine de Vincent (angine ulcéro-nécrotique aiguë) isolée constitue une indication classique de l'amygdalectomie.
- E. Une hypertrophie amygdalienne asymptomatique ne justifie pas d'amygdalectomie.

13. L'OSM se manifeste cliniquement par ? (RF)

- a- Des OMA à répétition
- b- Des troubles de comportement de l'enfant
- c. Des difficultés scolaires
- d- Un retard de croissance
- e- Une hypoacousie de perception

14. Cancer du larynx: cochez la/les proposition(s) correcte(s) (plusieurs bonnes réponses):

- A. Les principaux facteurs de risque sont le tabagisme et l'alcool chronique.
- B. Une dysphonie persistante est souvent le signe révélateur des cancers glottiques (touchant les cordes vocales).
- C. Les cancers supraglottiques (situés au-dessus des cordes vocales) sont généralement détectés précocement grâce à une dysphonie d'installation rapide
- D. laryngoscopie direct et biopsie représentent un examen essentiel.
- E. Rhinorrhée claire fait partie des signes cliniques

15. Un patient de 30 ans consulte pour une odynophagie unilatérale fébrile évoluent depuis 5 jours malgré antibiothérapie, avec trismus, voix étouffés et présence à l'examen d'un bombement érythémateux périamygdalien avec déviation de la luette vers le côté sain. Quel est le diagnostic le plus probable (une seule bonne réponse)?

- A. Un phlegmon péri-amygdalien (abcès péri tonsillaire).
- B. Une angine diphtérique.
- C. Une épiglottite aiguë.
- D. Un cancer du cavum.
- E. Une laryngite algue.

16. Concernant l'épistaxis (saignement nasal), cochez la/les proposition(s) exacte(s) (plusieurs bonnes réponses):

- A. La forme la plus fréquente est l'épistaxis antérieure bénigne, due à la rupture du plexus de Kiesselbach (tache vasculaire de la cloison).
- B. Une épistaxis postérieure est favorisée par l'hypertension artérielle et survient plutôt chez le sujet âgé.
- C. La première mesure à prendre devant une épistaxis active est de comprimer les ailes du nez pendant 10 minutes, tête penchée en avant.
- D. Des épistaxis à répétition unilatérales chez un adolescent doivent faire évoquer un angiofibrome naso-pharyngé jusqu'à preuve du contraire.
- E. La ligature de l'artère sphéno-palatine en chirurgie endoscopique est indiquée en cas d'échec du traitement médical et des tamponnements nasaux.

17. A propos des corps étrangers en ORL, cocher la/les bonne(s) réponse(s) (plusieurs bonnes réponses):

- A. Un corps étranger laryngé se manifeste par une détresse respiratoire aigue avec stridor inspiratoire (dyspnée laryngée).
- B. Un corps étranger tracheobronchique chez l'enfant impose une extraction en urgence per bronchoscopie rigide sous anesthésie générale.
- C. Un corps étranger œsophagien pointu (arête de poisson) exposé à un risque de perforation œsophagienne et de médiastinite si non pris en charge rapidement.
- D. Un corps étranger nasal chronique chez l'enfant peut se révéler par une rhinorrhée purulente unilatérale fétide.
- E. L'utilisation d'un coton-tige est recommandée pour déloger un petit insecte présent dans le conduit auditif externe.

18. Traumatisme nasal-Parmi les affirmations suivantes concernant la fracture des os propres du nez, cochez la/les réponse(s) exacte(s) (plusieurs bonnes réponses):

- A. Elle se manifeste cliniquement par une déformation de la pyramide nasale, des ecchymoses périorbitaires (yeux au beurre noir) et un œdème nasal.
- B. La présence d'un hématome de la cloison (septum) nasal impose un drainage chirurgical en urgence pour prévenir les complications (nécrose du cartilage septal).
- C. La réduction chirurgicale des fragments osseux déplacés est idéalement effectuée dans les 7 à 10 jours suivant le traumatisme (après résorption de l'œdème initial).
- D. Le diagnostic de fracture des os du nez est avant tout clinique; une radiographie standard du massif facial n'est pas indispensable en l'absence de suspicion d'autre fracture.
- E. Un hématome septal non drainé peut évoluer vers un abcès septal puis une destruction du cartilage responsable d'une déformation << en selle du nez.

19. Carcinome du nasopharynx (cancer du cavum) Quelle(x) proposition(s) est (sont) exacte(s) (plusieurs bonnes réponses) ?

- A. Ce cancer est fortement associé à l'infection per le virus d'Epstein-Barr (EBV).
- B. Il se révèle souvent par des métastases ganglionnaires cervicales (adénopathies du cou chez un patient sans autre symptôme ORL
- C. Son Incidence est plus élevée en Asie du Sud-Est en Afrique du Nord (bassin méditerranéen) qu'en Europe.
- D. Le traitement de première intention est chirurgical (nasopharyngectomie par vole endoscopique).
- E. Il peut toucher l'enfant de moins de 10 ans, chez qui le pronostic est redoutable.

20. Facteurs de risque des cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS)-Cochez la/les réponse(s) juste(s) (plusieurs bonnes réponses):

- A. Intoxication tabagique chronique.
- B. Consommation régulière et prolongée d'alcool fort.
- C. Infection orale par un papillomavirus humain (HPV à haut risque, notamment dans les cancers oropharyngés).
- D. Consommation élevée de fruits et légumes frais,
- E. Mauvaise hygiène bucco-dentaire et état dentaire délabré (facteur favorisant pour les cancers de la cavité buccale).

21. Lesquelles de ces structures entraine une surdité de transmission ? (RJ)

- a- Le conduit auditif externe
- b- Le nerf auditif
- c- L'enclume
- d- La cochlée
- e- La platine de l'étrier

22. Le corps étranger nasal peut se manifester par? (RJ)

- a- Une obstruction nasale bilatérale
- b- Une rhinorrhée fétide
- c- Des épistaxis
- d- Une rhinolithé à la radiographie
- e- Une cacosmie

23. Un enfant de 3 ans présente brutalement une fièvre élevée, une dysphagie, une voix étouffée une hypersalivation, en position assise penchée en avant (position du tripode). Devant ce tableau. quelle est la conduite à tenir en urgence (plusieurs bonnes réponses)?
- A. Evoquer une épiglottite aigue et éviter toute action invasive pouvant aggraver l'obstruction (ne pas allonger l'enfant ni chercher à examiner la gorge avec un abaisse-langue).
 - B. Appeler en urgence une équipe spécialisée (anesthésiste-ORL) pour sécuriser les voies aériennes par Intubation trachéale sous fibroscope au bloc opératoire.
 - C. Administrer dès que possible une antibiothérapie parentérale adaptée (ex. céphalosporine de 3eme génération) une fois les voies aériennes contrôlées.
 - D. Réaliser immédiatement une radiographie du cou en position couchée pour confirmer le diagnostic.
 - E. Tenter de visualiser l'épiglotte au miroir laryngé en consultation pour gagner du temps.
24. Un enfant de 18 mois présente en pleine nuit une toux rauque aboïante, une voix enrouée et un stridor inspiratoire survenant par accès, dans un contexte de rhinopharyngite. Il n'a pas de fièvre élevée. Quel est le diagnostic le plus probable (une seule bonne réponse)?
- A. Laryngite aiguë sous-glottique (croup).
 - B. Épiglottite aiguë.
 - C. Crise d'asthme aiguë.
 - D. Corps étranger laryngé.
 - E. Angine diphtérique.
25. Mastoïdite aiguë de l'enfant-Quelle(s) proposition(s) est (sont) vraie(s) (plusieurs bonnes réponses)?
- A. C'est une complication de l'otite moyenne aigue, correspondant à l'infection des cellules mastoïdiennes de l'os temporal.
 - B. Elle se manifeste par une fièvre, une douleur et une tuméfaction rétro-auriculaire, avec un décollement du pavillon de l'oreille en bas et en dehors du côté atteint.
 - C. Un scanner des rochers permet de confirmer le diagnostic et de rechercher une extension de L'infection (abcès sous-périosté, abcès intracrânien...).
 - D. Le traitement repose sur une antibiothérapie IV prolongée, associée le plus souvent à un drainage chirurgical (myringotomie, mastoidectomie) en cas de collection ou d'échec du traitement médical seul
 - E. Evoluant presque toujours favorablement sous Antibiotiques, elle ne présente pas de risque de complications neurologiques.
26. Trachéotomie-Cochez la/les réponse(s) exacte(s) concernant cette procédure chirurgicale (plusieurs bonnes réponses):
- A. Elle consiste à réaliser une ouverture au niveau de la trachée cervicale, où l'on insère une canule trachéale.
 - B. Elle peut être indiquée pour assurer une ventilation en cas d'obstruction haute des voies aériennes supérieure chronique (par ex. tumeur laryngée).
 - C. Elle peut être temporaire (canule retirée une fois la cause résolue) ou définitive.
 - D. La cricothyrotomie est une variante de trachéotomie réalisée en urgence au niveau de la membrane crico-thyroïdienne (accès plus rapide mais transitoire).
 - E. Elle se réalise sans anesthésie et sans risque hémorragique significatif.

27. Après une amygdalectomie, quelle est la complication la plus fréquente et redoutée (une seule bonne réponse)?

- A. Une hémorragie secondaire post-opératoire (hémorragie de la loge amygdalienne).
- B. Une lésion du nerf vague (X) avec paralysie vélo-pharyngée.
- C. Une infection sévère de la loge amygdalienne (abcès parapharyngé).
- D. Des troubles du goût par lésion du nerf glossopharyngien (IX).
- E. Une insuffisance vélaire avec rhinolalie (paralysie du voile du palais).

28. Le cancer du cavum peut se manifester cliniquement par ?RF

- a- Une adénopathie cervicale haute et postérieure
- b- Une obstruction nasale
- c- Des épistaxis
- d- Une diplopie
- e- Un reflux gastro-œsophagien

29. À propos du vertige périphérique, quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s):

- A. Il s'accompagne souvent de nausées et vomissements.
- B. Le nystagmus est horizontal ou rotatoire, Inhibé par la fixation visuelle.
- C. Il s'accompagne d'une diplopie et d'un déficit moteur.
- D. L'atteinte auditive (acouphènes, surdité) oriente vers une origine périphérique.
- E. Il traduit toujours une lésion du tronc cérébral.

30. Concernant la névrite vestibulaire:

- A. Elle est due à une inflammation du nerf vestibulaire.
- B. Elle provoque un vertige rotatoire intense sans troubles auditifs.
- C. Elle s'accompagne d'une surdité neurosensorielle bilatérale.
- D. L'épreuve de Romberg est déviée du côté lésé.
- E. Le traitement repose sur les anti-vertigineux exclusivement

La partie pratique:

Cas 1:

Une femme de 20 ans consulte pour une otalgie droite fébrile évoluant depuis 3 jours. L'examen otoscopique montre un tympan rouge, bombe avec disparition du triangle lumineux

31. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Otite externe diffuse
- B. Otite moyenne aiguë suppurée
- C. Otite séreuse
- D. Mastoïdite
- E. Otospongiose

32. Quel est le germe le plus souvent responsable?

- A. Streptococcus pneumoniae
- B. Hæmophilus influenzae
- C. Moraxella catarrhalis
- D. Pseudomonas aeruginosa
- E. Staphylococcus aureus

33. Quel examen complémentaire est indiqué en première intention?

- A. Scanner des rochers
- B. Audiogramme tonal et vocal
- C. IRM cérébrale
- D. Tympanométrie
- E. Aucun, le diagnostic est clinique

34. Quel traitement est approprié ?

- A. Amoxicilline per os
- B. Gouttes auriculaires seules
- C. Corticothérapie seule
- D. Chirurgie d'emblée
- E. Antiviraux

Cas 2:

Un homme de 35 ans présente une douleur infra-orbitaire gauche, une obstruction nasale et une rhinorrhée purulente depuis 10 jours.

35. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Sinusite maxillaire aiguë gauche
- B. Rhinite allergique
- C. Sinusite frontale
- D. Polypose nasale
- E. Angiofibrome naso-pharynge

36. Quels sont les signes de gravité ?

- A. Fièvre persistente élevée
- B. Œdème palpébral
- C. Céphalées intenses
- D. Rhinorrhée claire intermittente
- E. Troubles visuels

37. Quel examen est utile pour confirmer le diagnostic?

- A. Scanner des sinus de la face
- B. IRM cérébrale
- C. Radiographie du crâne
- D. Endoscopie bronchique
- E. Audiométrie

38. Quel traitement de première intention recommandez-vous?

- A. Antibiothérapie (amoxicilline-acide clavulanique)
- B. Corticoïdes systémiques seuls
- C. Lavages nasaux + antalgiques antibiotique
- D. Chirurgie endonasale immédiate
- E. Aucune prise en charge nécessaire

Cas 3:

Un enfant de 5 ans a avalé une pièce de monnaie il y a 2 heures. Il présente une hypersalivation et refuse de s'alimenter.

39. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Corps étranger pharyngé
- B. Corps étranger œsophagien
- C. Corps étranger trachéal
- D. Corps étranger nasal
- E. Ingestion bénigne sans risque

40. Quel examen complémentaire est indiqué ?

- A. Radiographie thorax + cou face et profil
- B. Scanner abdominal
- C. IRM du cou
- D. Echographie cervicale
- E. Fibroscopie digestive sans précaution

41. Quel geste est contre-indiqué?

- A. Tentative d'extraction digitale
- B. Endoscopie rigide sous AG
- C. Surveillance hospitalière
- D. Radiographie de contrôle
- E. Consultation ORL urgente

42. Quelle complication peut survenir en cas de retard diagnostique?

- A. Perforation œsophagienne
- B. Médiastinite
- C. Paralysie faciale
- D. Hémorragie digestive
- E. Infection pulmonaire par fausse déglutition

Cas 4:

Un homme de 70 ans, hypertendu, consulte pour un saignement nasal abondant, non contrôlé par compression digitale.

43. Quelle est l'étiologie la plus probable ?

- A. Traumatisme nasal
- B. Rupture artérielle postérieure (sphéno palatine)
- C. Rhinite allergique
- D. Polype nasal
- E. Trouble de la coagulation

44. Quel est le premier geste à réaliser?

- A. Comprimer les ailes du nez, tête penchée en avant
- B. Tamponner avec de la gaze imbibée d'alcool
- C. Pencher la tête en arrière
- D. Mettre un tampon postérieur Immédiatement
- E. Appeler une équipe chirurgicale d'emblée

45. En cas d'échec du traitement médical, quelle est la prise en charge suivante?
- A. Cautérisation endoscopique de l'artère sphéno-palatine
 - B. Ligature carotidienne
 - C. Pose d'un ballonnet hémostatique postérieur
 - D. Transfusion sanguine d'urgence seule
 - E. Corticothérapie systémique

Examen ORL : Groupe 04 / 2026

La Partie théorique

1- Le vertige paroxystique positionnelle bénin: cochez les réponses justes (RJ)

- a. Est la cause la plus fréquente des vertiges.
- b. Se traduit par des vertiges brefs durant quelques secondes
- c. Peut-être déclenchés par les mouvements brusques de la tête
- d. Le diagnostic est confirmé par la mise en évidence d'un nystagmus a la manœuvre clinique de Dix et Hallpike
- e. Le traitement est toujours anti vertigineux

2. les contre-indications relatives a l'amygdalectomie sont: cochez les réponses justes

- a- les troubles de l'hémostase
- b- le retard staturo-pondéral
- c- un retard de langage
- d- otites seromuqueuses
- e- une infection fébrile

3- Concernant la sinusite frontale aiguë: cochez les réponses justes

- a. Elle est souvent associée à une sinusite maxillaire ou pansinusite
- b. Elle est potentiellement dangereuse avec des complications plus fréquentes.
- c. Elle ne complique jamais
- d. Peut donner des douleurs provoquées ou spontanées en sus orbitaire
- e. Elle est l'apanage du nouveau-né

4. La surdité neurosensorielle affecte: (RJ)

- A. Tympan
- B. Cochlée ou nerf cochléaire
- C. Osselets
- D. Conduit auditif
- E. Oreille externe

5. Les facteurs de risque du carcinome du cavum comprennent: cochez les réponses Justes

- A. Infection par le virus Epstein-Barr
- B. Consommation d'aliments salés et fumés
- C. Tabagisme exclusif
- D. Prédisposition génétique
- E. Exposition professionnelle aux poussières de bois

6. Maladie de Ménière - Parmi les affirmations suivantes, laquelle est fausse (ane seule bonne réponse) ?

- A. Elle associe classiquement des crises de vertige rotatoire, des acouphènes et une surdité de perception fluctuante (surdité cochléaire).
- B. Elle est causée par une hypertension artérielle mal contrôlée.
- C. Les vertiges de Ménière durent typiquement de quelques dizaines de minutes à quelques heures.
- D. Un traitement de fond faisant appel à un régime désodé, aux diurétiques et à la bétahistine peut réduire la fréquence des crises.
- E. A long terme, elle peut évoluer vers une perte auditive permanente de type transmissionnel.

7. Les manifestations otologiques du cancer du cavum comprennent: cochez les réponses justes
- A. Otite séreuse unilatérale
 - B. Hypoacousie de transmission
 - C. Otalgie réflexe
 - D. Acouphènes
 - E. Otorrhée purulente chronique
8. Devant une surdité de transmission avec tympan normal: cochez les réponses justes
- A. Une otosclérose otospongiose » doit être évoquée
 - B. Une discontinuité ossiculaire est possible
 - C. Une otite séreuse est probable
 - D. Un cholestéatome peut être en causes
 - E. Le réflexe stapédien peut aider au diagnostic
9. Otite externe maligne (ou nécrosante). Quelle(s) proposition(s) est (sont) correcte(s):
- A. Elle survient surtout chez les diabétiques et immunodéprimés.
 - B. Elle est due à pseudomonas dans la majorité des cas.
 - C. Elle peut entraîner une ostéite du rocher et une paralysie faciale.
 - D. Le traitement nécessite des antibiotiques systémiques prolongés (anti-Pseudomonas).
 - E. Le pronostic est toujours bénin.
10. Concernant la névrite vestibulaire: cochez les réponses justes
- A. Elle donne un vertige brutal prolongé
 - B. Elle s'accompagne d'hypoacousie
 - C. Le nystagmus est unidirectionnel
 - D. L'épreuve calorique est pathologique
 - E. Elle est souvent d'origine virale
11. Les signes en faveur d'un vertige central comprennent: cochez les réponses justes
- A. Nystagmus vertical
 - B. Déficit neurologique associé
 - C. Nystagmus inhibé par fixation
 - D. Céphalées inhabituelles
 - E. Instabilité majeure sans vertige rotatoire
12. Concernant la sinusite maxillaire aiguë bactérienne: cochez les réponses justes
- A. Douleur majorée à l'antéflexion
 - B. Peut donner cellulite orbitaire
 - C. Scanner systématique
 - D. Antibiothérapie est utile
 - E. Évolution toujours bénigne
13. Les complications intracrâniennes des sinusites incluent: cochez les réponses justes
- A. Abscès extradural
 - B. Thrombophlébite du sinus caverneux
 - C. Méningite
 - D. Abscès cérébral
 - E. Hydrocéphalie primitive

14. Concernant le cancer du larynx glottique: cochez les réponses justes

- A. Il donne une dysphonie précoce
- B. Il métastase précocement
- C. Le drainage lymphatique est pauvre.
- D. Le tabac est un facteur majeur
- E. Il est toujours diagnostiqué tardivement

15. Concernant le cholestéatome: cochez les réponses justes

- A. Il entraîne une lyse osseuse
- B. Il peut compliquer une otite chronique
- C. Il est radiosensible
- D. Il peut donner abcès cérébral
- E. Il nécessite traitement chirurgical

16. Concernant la surdité brusque: cochez les réponses justes

- A. Elle est toujours d'origine virale
- B. Elle est définie par une perte ≤ 30 dB sur 3 fréquences
- C. Elle nécessite corticothérapie rapide
- D. L'IRM est inutile si récupération
- E. Un neurinome doit être éliminé

17. Une otite moyenne aiguë compliquée peut donner: cochez les réponses justes

- A. Paralysie faciale périphérique
- B. Méningite
- C. Abcès cérébral
- D. Surdité de transmission
- E. Surdité neurosensorielle toujours

18. Devant une otite séreuse unilatérale chez l'adulte: cochez les réponses justes

- A. Il faut traiter par antibiotiques prolongés
- B. Une tumeur du cavum doit être éliminée
- C. Une fibroscopie est indiquée
- D. Elle est toujours bénigne
- E. Elle peut être secondaire à un dysfonctionnement tubaire

19. Les complications de la sinusite frontale comprennent: cochez les réponses justes

- A. Abcès sous-périosté
- B. Méningite
- C. Abcès cérébral
- D. Thrombose du sinus sagittal
- E. Pneumothorax

20. la dyspnée laryngée peut résulter: cochez les réponses justes

- a- d'une imperforation choanale
- b- d'une laryngite striduleuse
- c- d'un cancer de l'oropharynx
- d- d'un cancer sous-glottique
- e- d'un corps étranger bronchique

21- parmi les pathologies suivantes quelles sont celles responsable d'épistaxis: cochez les réponses justes

- a- allergie nasosinusienne
- b- carcinome du sinus maxillaire
- c- végétation adénoïde
- d- polypose nasosinusienne
- e- fibrome nasopharyngien

22. Concernant la rhinite allergique: cochez les réponses justes

- A. Elle est médiée par IgE
- B. Elle peut s'associer à l'asthme
- C. Elle entraîne une anosmie définitive
- D. Les cornets inférieurs sont souvent hypertrophiés
- E. Le traitement repose uniquement sur antibiotiques

23. quels sont les facteurs de risque des carcinomes du larynx: cochez les réponses justes

- a- tabagisme passif
- b- traumatisme cervical
- c- intubation prolongée
- d- laryngite chronique
- e- alcoolisme

24. Un enfant âgé de 5 ans, il se présente en consultation pédiatrique pour tuméfaction rouge de l'angle interne de l'œil gauche évoluant depuis 8 heures avec fièvre et rhinorrhées
quels sont les diagnostics que vous pouvez évoquer chez le petit: cochez les réponses justes

- a- érysipèle de la région oculaire
- b- piqure d'insecte
- c- sinusite ethmoïdale aiguë
- d- sinusite ethmoïdale chronique
- e- sinusite maxillaire

25. Le Fibrome nasopharyngien: cochez les réponses justes

- a. Donne une obstruction nasale intermittente
- b. Donne une obstruction nasale permanente
- c. Est une tumeur vasculaire
- d. Touche le sexe féminin.
- e. La biopsie est contre-indiquée.

26. Les pathologies suivantes sont responsables d'obstruction nasale permanente sauf une, laquelle ?

- a. La polypose nasale
- b. Le cancer des fosses nasales ou des sinus
- c. L'imperforation choanale
- d. Cancer du cavum
- e. Hypertrophie amygdalienne

27. Le kyste du tractus thyreoglosse: cochez les réponses justes

- a. Est une masse latérale
 - b. Est une masse médiane
 - c. Est une masse réductible
 - d. Est mobile à la protraction de la langue
 - e. C'est la tuméfaction chronique la plus fréquente chez l'adulte
28. Moyen pour arrêter une épistaxis (cochez la ou les réponses justes)

- a. Cautérisation de la tâche vasculaire
- b. Ligature de la carotide externe
- c. Ligature de la carotide interne
- d. Embolisation de l'artère le maxillaire interne
- e. Méchage postérieur

29. La dyspnée laryngée peut résulter:

- a. D'une intubation prolongée
- b. D'une infection diphtérique
- c. D'un hématome de plancher buccal.
- d. D'une papillomatose laryngée
- e. D'une imperforation choanale

30. Toutes les affections suivantes entraîne une surdité de transmission, sauf une laquelle?

- a. Otospongiose
- b. Cholestéatome de l'oreille moyenne
- c. Tympanosclérose
- d. Otite muqueuse chronique à tympan fermé
- e. Surdité toxique

La partie pratique :

Un homme de 62 ans, diabétique mal équilibré, consulte pour une otalgie droite intense évoluant depuis 3 semaines, insomniante, associée à une otorrhée purulente. L'examen retrouve un conduit auditif inflammatoire avec tissu de granulation au plancher. La CRP est élevée. Il présente une faiblesse de l'hémiface droite.

31. Concernant cette situation:

- A. Le diagnostic le plus probable est une otite externe maligne
- B. Le germe le plus fréquemment en cause est *Pseudomonas aeruginosa*
- C. Une TDM des rochers est indiquée
- D. Le traitement repose uniquement sur des gouttes auriculaires
- E. Une atteinte des nerfs crâniens est possible

Une femme de 45 ans présente des épisodes récurrents de vertige rotatoire durant 2 à 3 heures, associés à des acouphènes graves unilatéraux et une sensation de plénitude auriculaire. L'audiogramme montre une surdité neurosensorielle prédominant sur les basses fréquences.

32- Concernant ce tableau:

- A. Il s'agit probablement d'une maladie de Ménière
- B. Le mécanisme est un hydrops endolymphatique
- C. La surdité est initialement fluctuante
- D. Le traitement de première intention est chirurgical
- E. L'évolution peut se faire vers une surdité de transmission permanente

Un homme de 58 ans, tabagique chronique, consulte pour une dysphonie persistante depuis 3 mois. Il n'a pas de fièvre. L'examen retrouve une lésion ulcero-bourgeonnante de la corde vocale droite.

33- Concernant ce cas:

- A. Un carcinome épidermoïde doit être suspecté
- B. Une biopsie n'est pas indispensable
- C. Une TDM cervicale fait partie du bilan
- D. L'HPV est le principal facteur de risque
- E. Le tabac est un facteur de risque majeur

Cas:

il s'agit d'un homme âgé 49 ans qui consulte en ORL pour baisse de l'audition à droite évoluant depuis trois mois en associé à des épistaxis homolatérales minimales à répétition

34- Pour ce patient il est nécessaire de faire (cochez la ou les réponses fausses):

- a. Une otoscopie
- b. Une acoumétrie au diapason
- c. une rhinoscopie antérieure et postérieure complétée d'une naso fibroscopie
- d. Un examen ORL complet
- e. Toutes les réponses sont fausses

35- Quel est le ou les diagnostics à évoquer (cochez la ou les réponses fausses):

- a. Cancer de l'oreille
- b. Cancer du cavum avec otite sero muqueuse à droite
- c. Ectasie de la tache vasculaire
- d. otospongiose.
- e. Une otite moyenne chronique cholesteatomateuse droite

L'examen clinique de ce patient contient retrouve un tympan épaissi, sans relief et mat à droite; le rinne est négatif à droite et le weber est latéralisé à droite ainsi qu'un processus bourgeonnant comblant tout le cavum. Le reste de l'examen est normal.

36- pour confirmer ce ou ces diagnostic(s), il est nécessaire de faire:

- a. Une biopsie centrée sur l'oreille
- b. Une biopsie du cavum avec étude anatomopathologie
- c. Un tympanogramme
- d. Un audiogramme
- e. Des potentiels évoqués auditifs

Une femme âgée de 40 ans consulte en ORL pour otorrhée fétide droite évoluant en poussée depuis son enfance associée à une douleur retro auriculaire récente
L'examen clinique retrouve une perforation tympanique atticale laissant voir une masse blanchâtre d'aspect épidermique et un comblement du sillon retro auriculaire à droite.

37- Quel est le ou les diagnostic(s) à évoquer:

- a. Otite moyenne chronique cholestéatomateuse droite
- b. Mastoïdite
- c. Otite externe maligne
- d. Réponses a et c sont justes
- e. Réponses a et b sont justes

38- Cette patiente nécessite un traitement:

- a. Uniquement médical
- b. Abstention
- c. Un traitement médico chirurgicale
- d. Uniquement symptomatique
- e. toutes les réponses sont justes

Cas:

Un enfant de 10 ans consulte pour une masse cervicale médiane évoluant depuis plusieurs année. Les parents rapportent une augmentation de volume lors des épisodes d'angine, avec régression partielle ensuite.

39. Quel est le diagnostic le plus probable

- A. Kyste du tractus thyroïdienne
- B. Nodule thyroïdien
- C. Kyste branchial
- D. glomus carotidien
- E. sous maxillite chronique

À l'examen clinique:

Masse médiane sous-hyoïdienne, douloureuse de 3 cm, Mobile à la déglutition et à la protrusion de la langue, Peau en regard est érythémateuse, Pas de fièvre Adénopathies cervicales au niveau du territoire 2A

40. Quels signes cliniques sont en faveur de ce diagnostic?

- A. Kyste du tractus thyroïdienne
- B. Nodule thyroïdien
- C. Kyste branchial
- D. glomus carotidien
- E. sous maxillite chronique

41. Quel examen complémentaire demandez-vous en première intention?

- A. Kyste du tractus thyroïdienne
- B. Nodule thyroïdien
- C. Kyste branchial
- D. glomus carotidien
- E. sous maxillite chronique

42. Quelles complications peuvent survenir lors de cette pathologie?

- A. Infection du kyste
- B. Fistulisation cutanée
- C. Compression trachéale aiguë fréquente
- D. Récidive après chirurgie incomplète
- E. Transformation maligne

43. Concernant le traitement, quelles propositions sont justes ?

- A. L'abstention thérapeutique est recommandée
- B. La ponction évacuatrice est curative
- C. Le traitement de référence est chirurgical
- D. la résection du corps de l'os hyoïde est le gold standard
- E. La chirurgie peut être réalisée chez l'enfant

Un enfant de 3 ans présente brutalement une dyspnée inspiratoire avec stridor, hypersialorrhée et fièvre à 39,5°C. Il est assis penché en avant, anxieux.

44. Concernant la prise en charge:

- A. Une épiglottite aiguë est probable
- B. Il faut éviter toute manipulation oropharyngée brutale
- C. Une sécurisation des voies aériennes est prioritaire
- D. Une antibiothérapie IV est indiquée
- E. Il faut réaliser immédiatement un scanner

Un homme de 42 ans, sans antécédents particuliers, consulte pour une baisse brutale de l'audition de l'oreille droite apparue au réveil il y a 24 heures.

Il ne rapporte ni douleur otologique, ni vertige rotatoire, ni otorrhée. Il décrit des acouphènes unilatéraux associés.

L'otoscopie est normale. L'audiogramme tonal montre une perte auditive neurosensorielle unilatérale de 50 dB intéressant plusieurs fréquences.

45- Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Otite moyenne aiguë
- B. Surdit  brusque idiopathique
- C. Maladie de M ni re
- D. Neurinome de l'acoustique
- E. Otospongiose

Examen Maladies de Systèmes Groupe : 02 / 2026

1. Le syndrome pneumo-rénal au cours des vascularites systémiques se caractérise par (choisissez les réponses justes):
 - A- La présence d'une atteinte pulmonaire type asthme bronchique.
 - B- La présence d'une atteinte rénale type syndrome néphrotique pur, uniquement
 - C- La présence obligatoire des anticorps anti cytoplasme des neutrophiles (ANCA)
 - D- Une fréquence faible mais un pronostic sombre, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique
 - E- La présence de croissants glomérulaires à l'histologie rénale.
2. Quels sont les vaisseaux atteints au cours de la maladie de Behçet ? (Choisissez les réponses justes):
 - A- Les vaisseaux de gros calibre.
 - B- Les vaisseaux de moyen calibre
 - C- Les vaisseaux de petit calibre
 - D- Les veines.
 - E- Toutes les réponses sont fausses.
3. Concernant l'artérite à cellules géantes, (choisissez les réponses fausses):
 - A- Elle peut provoquer une cécité brutale si elle n'est pas traitée rapidement.
 - B- Elle touche plus fréquemment les femmes surtout âgées de plus de 50 ans.
 - C- L'imagerie par PET-scan n'a aucune utilité au diagnostic en cas d'atteinte des gros vaisseaux.
 - D- La biopsie de l'artère temporale est l'examen de référence pour le diagnostic
 - E- Elle peut s'associer à une pseudopolyarthrite rhizomélique.
4. Toutes les propositions suivantes sont une cause du syndrome pneumo-rénal sauf une; laquelle:
 - A- Le lupus érythémateux systémique.
 - B- L'endocardite infectieuse subaigüe.
 - C- La polyarthrite rhumatoïde.
 - D- Le syndrome de Goodpasture.
 - E- La cryoglobulinémie.
5. Parmi les signes cliniques de la maladie de Takayasu, on peut retrouver (choisissez la réponse fausse):
 - A- Une claudication des membres supérieurs à l'effort.
 - B- Un accident vasculaire cérébral ischémique.
 - C- Une hypertension artérielle rénovasculaire.
 - D- Une VS (vitesse de sédimentation) calme.
 - E- Une abolition asymétrique des pouls périphériques.
6. À propos de la périartérite noueuse (PAN), choisissez les réponses justes:
 - A- Une atteinte neurologique périphérique avec mononévrite multiple est fréquente
 - B- Une ischémie digestive ou infarctus mésentérique peut survenir
 - C- Une glomérulonéphrite rapidement progressive est typique de la PAN
 - D- Elle touche préférentiellement les petits vaisseaux.
 - E- Une biopsie musculaire ou nerveuse peut permettre le diagnostic histologique

7. À propos de la granulomatose avec polyangéite (GPA), (choisissez la réponse fausse)

- A- Les ANCA de type anti-PR3 (-ANCA) sont fréquemment positif
- B- L'hémoptysie peut être liée à des nodules pulmonaires excavés
- C- Les atteintes rénales sévères sont un facteur de bon pronostic
- D- Les lésions cutanées de type purpura vasculaire peuvent se voir
- E- La présence à l'histologie d'un granulome est possible

8. Parmi les manifestations cliniques du LES, on retrouve fréquemment (choisissez les réponses justes)

- A- Une atteinte cutanée photosensible.
- B- Une fièvre inexpliquée.
- C- Des arthrites érosives invalidantes appelées arthropathie de Jaccoud
- D- La pleurésie est la manifestation respiratoire la plus fréquente du LES
- E- Les ulcérations buccales font partie des critères diagnostiques

9. Concernant les facteurs déclenchant une poussée lupique, (choisissez les réponses justes)

- A- L'exposition aux rayons ultraviolets.
- B- Certaines infections virales.
- C- Le stress psychologique.
- D- La grossesse
- E- Le post partum

10. Un homme de 35 ans atteint de lupus sous corticoïdes et Rituximab développe des convulsions. Parmi les étiologies possibles, on peut évoquer (choisissez les réponses justes):

- A- Une poussée neuro-lupique.
- B- Une crise comitiale hypoglycémique.
- C- Une leuco-encéphalopathie iatrogène
- D- Une thrombose cérébrale liée au SAPL
- E- Un hématome cérébral

11. Toutes les anomalies biologiques suivantes sont typiques d'une granulomatose systémique sauf une laquelle ?

- A- Une VS (vitesse de sédimentation) accélérée
- B- Une hypocalcémie
- C- Une hypercalciurie
- D- Une cholestase intra-hépatique
- E- Une hypergammaglobulinémie

12. Lequel des éléments suivants est un facteur de risque majeur de développement des granulomatoses systémiques ? (Choisissez les réponses justes):

- A- Le mycobacterium tuberculosis.
- B- La syphilis
- C- Le béryllium
- D- Le déficit immunitaire commun variable
- E- L'histiocytose langerhansienne

13. Au cours de la maladie de Behçet, le test pathergique permet de (choisissez la réponse juste):

- A- Rechercher une réaction allergique
- B- Détecter une forme viscérale grave.
- C- Evaluer l'hyperréactivité cutanée
- D- Détecter une pustule bactérienne.
- E- Toutes les réponses sont justes

14. Au cours de la maladie de Behçet, l'atteinte vasculaire (choisissez la proposition fausse):

- A- Peut se manifester par des anévrismes
- B- Peut se manifester par des sténoses artérielles
- C- Peut toucher les vaisseaux cérébraux.
- D- Peut toucher les vaisseaux digestifs.
- E- Touche exclusivement les vaisseaux de gros calibre

15. Quels sont les facteurs prédictifs de la survenue de la crise rénale sclérodermique? (Choisissez les réponses fausses):

- A- La forme cutanée diffuse,
- B- Prise de corticothérapie sup à 15 mg/j
- C- Après 5 ans d'évolution.
- D- Présence d'AC anti ARN polymérase III.
- E- Présence d'AC anti topoisomérase

16. La vasculopathie au cours de la sclérodermie systémique est responsable de (Choisissez les réponses justes):

- A- La pneumopathie interstitielle diffuse.
- B- La crise rénale sclérodermique.
- C- L'HTAP
- D. Les ulcères digitaux
- E- Les troubles du rythme cardiaque.

17. Quels éléments permettent de suspecter un VEDOSS (Very Early Diagnosis Of Systemic Sclerosis)? (Choisissez les réponses justes):

- A- Phénomène de Raynaud.
- B- Sclérose cutanée franche.
- C- Doigts boudiné
- D. Anticorps antinucléaires.
- E- Syndrome restrictif à la spirométrie.

18. L'atteinte digestive de la sclérodermie systémique peut se manifester par tous les signes suivants sauf un, lequel?

- A- Une incontinence fécale.
- B- Un micro anévrisme des artères digestives.
- C- Une gastrite antrale télangiectasique .
- D- Un syndrome de pseudo-obstruction intestinale.
- E- Une constipation.

19. Quelle est la principale protéine impliquée dans l'amylose AL ? (Choisissez la réponse juste):

- A- Transthyrétine.
- B- Sérum amyloïde A.
- C- Chaines légères d'Immunoglobulines.
- D- Fibrinogène.
- E- Beta-2 microglobuline.

20. Quel signe est évocateur d'une atteinte cardiaque dans l'amylose AL ? (Choisissez la réponse Juste)

- A- Le tachycardie sinusale
- B- L'hypotrophie du VG
- C- L'angor avec obstruction athéromateuse des coronaires.
- D- L'épanchement péricardique abondant
- E- L'épaississement pariétal granuleux et brillant à l'échocardiographie

21. L'atteinte digestive de l'amylose peut se manifester par (Choisissez les réponses justes):

- A- Un syndrome de malabsorption intestinal
- B- Une hémorragie digestive
- C- Un endobrachyœsophage
- D- Une maladie hémorroïdaire.
- E- Une macroglossie

22. Au cours du syndrome de Sjörger, le test de Schirmer est considéré positif si (choisissez la réponse juste)

- A- > 10 mm à 5 minutes
- B- Entre 5 et 10 mm à 5 minutes
- C- > 15 mm à 5 minutes
- D- < 5mm à 5 minutes.
- E- Toutes les réponses sont fausses

23. Au cours du syndrome de de Sjörger, les manifestations extra glandulaires peuvent être (choisissez les réponse justes)

- A- Des arthrites destructrices
- B- Une pneumopathie interstitielle diffuse
- C- Une neuropathie périphérique
- D- Un purpura vasculaire.
- E- Une péricardite

24. Parmi les manifestations cardiaques du SAPL, on peut retrouver (choisissez la réponse fausse):

- A- Des végétations valvulaires,
- B- Une thrombose intracardiaque
- C- Une dysfonction diastolique
- D- Une Hypertension pulmonaire
- E- Une endocardite bactérienne.

25. Le Traitement des déficits immunitaires humoraux fait appel à (choisissez les réponses justes)

- A- Une substitution par immunoglobulines polyvalentes par voie intraveineuse
- B. Une antibiothérapie précoce, prolongée et adaptée en cas d'infections.
- C- Une vaccination par les vaccins vivants atténués.
- D- Un arrêt impératif du tabac.
- E- Toutes les réponses sont justes.

26. Les myosites inflammatoires associées aux anticorps anti-MDA5 sont caractérisées par (choisissez les réponses justes):

- A- Une atteinte musculaire obligatoire.
- B- Une atteinte respiratoire rapidement progressive
- C- Une atteinte cutanée à type de calcifications
- D- Une atteinte articulaire.
- E- Toutes les réponses sont justes.

27. Concernant les atteintes neurologiques de la maladie de Fabry, choisissez la réponse fausse:

- A- Les AVC ischémiques sont fréquents.
- B- L'atteinte périphérique se manifeste par des acroparesthésies
- C- La surdité est fréquente et liée à une atteinte cochléo-vestibulaire.
- D- La substance blanche n'est jamais touchée.
- E- La dolichoectasie du tronc basilaire est une anomalie possible.

28. À propos de la maladie de Kawasaki, choisissez les réponses justes:

- A- Elle touche préférentiellement les enfants de plus de 10 ans.
- B- La conjonctivite de la maladie de Kawasaki est bilatérale et purulente.
- C- L'atteinte cardiaque détermine la gravité de la maladie
- D- L'éruption cutanée de type exanthème non vésiculeux est spécifique de la maladie.
- E- Les immunoglobulines sont le traitement de première intention.

29. À propos de la physiopathologie des maladies auto-immunes chez l'enfant, choisissez les réponses justes:

- A- Implique une rupture de la tolérance au soi.
- B- S'explique uniquement par des facteurs génétiques.
- C- Fait intervenir l'immunité adaptative.
- D- Implique parfois un dérèglement des lymphocytes T et B
- E- Le stress psychologique est un facteur déclenchant possible.

30- Madame Nadia âgée de 47 ans est hospitalisée pour asthénie, fièvre, hématurie macroscopique et dyspnée. Elle présente un syndrome inflammatoire, une insuffisance rénale aiguë avec protéinurie, et une hémoptysie modérée.

La recherche d'ANCA anti-MPO est fortement positive. Une biopsie rénale montre une glomérulonéphrite nécrosante pauci-immune, le diagnostic de polyangéite microscopique est posé. La patiente débute un traitement par bolus de méthylprednisolone puis prednisone Per Os avec une proposition du cyclophosphamide IV.

Quels sont les effets indésirables classiques du cyclophosphamide à surveiller ? (Choisissez les réponses justes):

A- Cystite hémorragique.

B- Aplasie médullaire.

C- Cécité rapide.

D- Risque tératogène.

E- Risque infectieux.

31- Nadia a refusé un traitement par le cyclophosphamide, vous optez pour un traitement biologique par Rituximab, avant de commencer le Rituximab, quels examens sont indispensables ?

(Choisissez les réponses justes):

A- Hémogramme.

B- Sérologie virale B, C et HIV.

C- Dosage pondéral des Immunoglobulines.

D- Bilan lipidique.

E- Intradermoréaction à la tuberculine (IDR) et/ou un test sanguin IGRA (Quantiféron").

32- Concernant l'atteinte oculaire dans la maladie de Behçet, (choisissez la réponse fausse):

A- L'uvéite antérieure est toujours isolée.

B- L'uvéite postérieure est la plus grave.

C- L'uvéite est généralement bilatérale.

D- L'effet Tyndall traduit une inflammation du segment antérieur.

E- Les vascularites rétinienne sont souvent occlusives.

33- Concernant le traitement des atteintes vasculaires de la maladie de Behçet, (choisissez la réponse juste)

A- Les corticoïdes seuls sont suffisants pour les anévrismes pulmonaires

B- Les anti-TNFa sont indiqués dans les anévrismes pulmonaires.

C- L'anticoagulation n'est jamais indiquée dans les thromboses veineuses

D- La chirurgie d'un anévrysme pulmonaire doit obligatoirement précéder le traitement

E- Le cyclophosphamide est le traitement de choix des thromboses veineuses

34- Les facteurs prédictifs de lymphome au cours du syndrome de Gougerot Sjogren sont (choisissez les réponses justes)

A- La présence d'un purpura vasculaire.

B- L'atrophie des glandes salivaires principales

C- La présence de cryoglobulinémie

D- L'absence d'un composant monoclonal.

E- L'absence de lymphopénie.

35- La biopsie des glandes salivaires accessoires (choisissez les réponses justes)

A- Est une technique facile à réaliser.

B- Consiste à prélever au moins 4 glandes salivaires mineures au niveau de la face interne de la lèvre.

C- Consiste à la recherche des agrégats de cellules inflammatoires mononucléaires 50 cellules, qu'on appelle foyer ou focus.

D- Son score repose sur la classification de Chisholm et Masson

E- Un score de III ou IV selon Chisholm et Mason (1 focus/4mm) est retenu comme un critère du syndrome de Gougerot Sjögren

36- Au cours du syndrome des anti-phospholipides; le bilan immunologique peut montrer un (choisissez les réponses justes):

A. Un taux élevé d'anticoagulant circulant lupique (ou lupus anticoagulant LA)

B. Un taux élevé d'anticorps anticardiolipine (CL)

C. Un taux élevé d'anticorps anti- β 2 glycoprotéines I (β 2GPI)

D. Un taux de C1q bas

E. Un taux élevé d'anticorps anti membrane basale glomérulaire.

37- Parmi les manifestations suivantes, laquelle est "typique du lupus systémique (Choisissez la réponse juste)?

A. Arthrite érosive et déformante

B. Exanthème maculo-papuleux prurigineux

C. Rash malaire épargnant les sillons nasogéniens

D. Hypertension maligne

E. Splénomégalie massive

38- Quel auto-anticorps est le "plus spécifique du LES(Choisissez la réponse juste)

A. Anti-CCP

B. Anti-Ro

C. Anti-centromère

D. Anti-dsDNA

E. Anti-mitochondries M2

39- Quel élément biologique évoque "fortement une poussée lupique"

(Choisissez la réponse juste)?

A. Augmentation du C3 et C4

B. Hyperleucocytose franche

C. Hypocomplémentémie élévation des anti-dsDNA

D. Hyperkaliémie

E. Éosinophilie à plus de 1500/mm³

40- Quel traitement est "fondamental" et recommandé pour **tous** de première intention les patients Lupiques sauf contre-indication (Choisissez la réponse juste)?

A. Corticoïdes à forte dose en continu

B. Hydroxychloroquine

C. Méthotrexate systématique

D. Belimumab d'emblée

E. Cyclophosphamide en entretien long terme

41- La maladie de Gaucher de type 1 est caractérisée par (choisissez les Réponses justes)

- a) Asthénie
- b) syndrome cérébelleux
- c) Pigmentation brun-jaune sur le visage et les tibias
- d) Neuropathie périphérique
- e) encéphalopathie progressive

42- Dans le panel de l'arsenal thérapeutique de la maladie de Fabry on retrouve: (choisissez les Réponses justes)

- a) Enzymothérapie substitutive
- b) La biothérapie immuno-modulatrice
- c) Chaperon pharmacologique
- d) Traitement immunosuppresseur
- e) Thérapie génique

43- Quelles sont les signes cutanés des principales maladies auto-inflammatoires (choisissez les réponses justes)?

- A. Le pseudo-érysipèle de la cheville est classique dans la FMF
- B. L'urticaire au froid environnemental se voit dans les cryopyrinopathies
- C. Une urticaire est pathognomonique du déficit en MVK
- D. L'œdème périorbitaire se voit dans le syndrome TRAPS
- E. Les aphtes sont fréquents dans le déficit en MVK et le syndrome PFAPA

44- Quel traitement, est obligatoirement associé avec le méthotrexate ? (choisissez la réponse juste):

- A- Les anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- B- Les antalgiques.
- C- L'acide folique
- D- Les corticoïdes
- E- Les antihistaminiques

45- A propos de la granulomatose avec polyangéite (GPA), (choisissez la réponse fausse)

- A- Elle se manifeste par une glomérulonéphrite pauci-immune, nécrosante et segmentaire.
- B- Elle se manifeste par un écoulement nasal purulent ou sanglant.
- C- Elle atteint surtout les vaisseaux de gros calibre.
- D- Elle se manifeste par un syndrome pneumo-rénal
- E- La gravité est évalué par le FPS score

46- Quel type d'amylose est le plus fréquemment associé à une inflammation chronique? (la réponse juste)

- A. Amylose AA
- B. Amylose AL
- C. Amylose ATTR sauvage
- D. Amylose ATTR héréditaire
- E. Amylose A β 2M

47- Le signe clinique le plus évocateur d'une atteinte rénale dans l'amylose Al est la réponse juste)

- A. Hématurie macroscopique
- B. Une protéinurie massive
- C. Anurie
- D. Colique néphrétique
- E. Pyélonéphrite

48- Concernant le lupus pédiatrique, (une seule proposition est fausse):

- A. Le lupus peut se manifester à tout âge chez l'enfant
- B. Le dépistage d'anticorps antinucléaire se fait par la technique d'IFR
- C. Dans certains cas de lupus l'hypocomplémentémie peut être due à un déficit inné
- D. Le traitement par l'hydroxychloroquine doit être instauré en cas de poussée
- E. Le SAPL doit être recherché systématiquement chez tout patient avec lupus

49- Les vascularites chez l'enfant sont caractérisées par: (une réponse fausse)

- A- Sont classées selon le calibre des artères touchées
- B- la biopsie est utile en cas de doute diagnostic
- C- L'œdème hémorragique du nourrisson est une forme grave du purpura rhumatoïde
- D- La corticothérapie doit être instaurée pour les formes graves ou compliquée du purpura rhumatoïde
- E- Certaines vascularite peuvent se présenter à un très jeune âge

Examen Maladies de Systèmes : Groupe 03 / 2026

1. Parmi les propositions suivantes concernant le purpura vasculaire aigu au cours des vascularites systémiques, laquelle est fausse:
 - A- Se caractérise par des lésions d'âge différents.
 - B- Son siège de prédilection est les membres inférieurs.
 - C- Peut se manifester par des lésions plus monomorphes nécrotiques.
 - D- Peut s'associer à un livedo s'il est dû à une inflammation pariétale..
 - E- Se caractérise cliniquement par un purpura infiltré.
2. Le syndrome pneumo-rénal au cours des vascularites systémiques se caractérise par (choisissez les réponses justes):
 - A- La présence d'une atteinte pulmonaire type asthme bronchique.
 - B- La présence d'une atteinte rénale type syndrome néphrotique pur.
 - C- La présence obligatoire des anticorps anticytoplasme des neutrophiles (ANCA).
 - D- c'est une urgence diagnostique et thérapeutique
 - E- La présence de croissants glomérulaires à l'histologie rénale.
3. Au cours des vascularites systémiques, l'exploration radiologique par scanner associé à des séquences angioscannographiques peut montrer (choisissez les réponses fausses):
 - A- Une aortite spécifique des vascularites à ANCA
 - B- Des micro-anévrysmes des artères viscérales au cours des vascularites des vaisseaux de moyen calibre.
 - C- Des sténoses vasculaires au cours de la maladie de TAKAYASU.
 - D- Des lésions de vascularites pulmonaires spécifiques de l'artérite à cellules géantes.
 - E- Des lésions de vascularite coronaire spécifique de la polyangéite microscopique.
4. Quels sont les vaisseaux atteints au cours de la maladie de Behçet? (Choisissez les réponses justes):
 - A- Les vaisseaux de gros calibre.
 - B- Les vaisseaux de moyen calibre.
 - C- Les vaisseaux de petit calibre,
 - D- Les veines.
 - E- Toutes les réponses sont fausses.
5. Le syndrome de Cogan est caractérisé par (choisissez les réponses justes):
 - A- Une aortite possible.
 - B- Une fréquence rare
 - C- Un vertige.
 - D- Une évolution lente favorable.
 - E- Toutes les réponses sont justes.
6. Concernant l'artérite à cellules géantes, choisissez la ou les réponses fausses:
 - A- Elle peut provoquer une cécité brutale si elle n'est pas traitée rapidement.
 - B- Elle touche les femmes âgées de moins de 40 ans.
 - C- L'imagerie par PET-scan n'a aucune utilité au diagnostic en cas d'atteinte des gros vaisseaux.
 - D- La biopsie de l'artère temporale est l'examen de référence pour le diagnostic.
 - E- Elle peut s'associer à une pseudopolyarthrite rhizomélique.

7. Toutes les propositions suivantes sont une cause du syndrome pneumo-rénal sauf une; laquelle

A- Le lupus érythémateux systémique.

B- L'endocardite infectieuse subaigüe.

C- La polyarthrite rhumatoïde

D- Le syndrome de Goodpasture.

E- La cryoglobulinémie.

8. Parmi les signes cliniques de la maladie de Takayasu, on peut retrouver (choisissez la réponse fausse):

A- Une claudication des membres supérieurs à l'effort.

B- Un accident vasculaire cérébral ischémique.

C- Une hypertension artérielle rénovasculaire

D- Une VS (vitesse de sédimentation) calme.

E- Une abolition asymétrique des pouls périphériques.

9. À propos de la périartérite noueuse (PAN), choisissez les réponses justes:

A- Une atteinte neurologique périphérique avec mononévrite multiple est fréquente.

B- Une ischémie digestive ou infarctus mésentérique peut survenir.

C- Une glomérulonéphrite rapidement progressive est typique de la PAN.

D- Elle touche préférentiellement les petits vaisseaux.

E- Une biopsie musculaire ou nerveuse peut permettre le diagnostic histologique.

10. Parmi les manifestations cliniques du LES, on retrouve fréquemment (choisissez les réponses justes):

A- Une atteinte cutanée photosensible.

B- Une fièvre inexpliquée.

C- Des arthrites érosives invalidantes appelées arthropathie de Jaccoud.

D- La pleurésie est la manifestation respiratoire la plus fréquente du LES.

E- Les ulcérations buccales font partie des critères diagnostiques,

11. Un homme de 35 ans atteint de lupus sous corticoïdes et Rituximab développe des convulsions. Parmi les étiologies possibles, on peut évoquer (choisissez les réponses justes):

A- Une poussée neuro-lupique.

B- Une crise comitiale hypoglycémique.

C- Une leuco-encéphalopathie iatrogène

D- Une thrombose cérébrale liée au SAPL.

E- Toutes les réponses sont justes.

12. Concernant les manifestations hématologiques du LES (choisissez la réponse fausse):

A- Les cytopénies peuvent toucher toutes les lignées.

B- La lymphopénie profonde est associée à une activité élevée de la maladie.

C- Le syndrome d'Evans associe une anémie hémolytique et une thrombopénie.

D- La thrombopénie est parfois satellite d'un syndrome des anti-phospholipides.

E- L'anémie est exclusivement périphérique hémolytique auto-immune.

13. Lesquels des éléments suivants est un facteur de risque majeur de développement des granulomatoses systémiques? (Choisissez les réponses justes):

- A- Le mycobacterium tuberculosis.
- B- La syphilis.
- C- Le béryllium.
- D- Le déficit immunitaire commun variable.
- E- L'histiocytose langerhansienne.

14. Au cours de la maladie de Behçet, l'atteinte vasculaire (choisissez la proposition fausse):

- A- Peut se manifester par des anévrismes.
- B- Peut se manifester par des sténoses artérielles.
- C- Peut toucher les vaisseaux cérébraux.
- D- Peut toucher les vaisseaux digestifs.
- E- Touche exclusivement les vaisseaux de gros calibre.

15. Quels sont les acteurs principaux intervenant dans la physiopathologie de la sclérodermie systémique ? (Choisissez les propositions justes)

- A- La cellule musculaire striée.
- B- La cellule endothéliale.
- C- Le lymphocyte B
- D- Le fibroblaste.
- E- Le kératinocyte.

16. Quels sont les facteurs prédictifs de la survenue de la crise rénale sclérodermique? (Choisissez les réponses fausses):

- A- La forme cutanée diffuse.
- B- Prise de corticothérapie à 30 mg/J.
- C- Après 5 ans d'évolution.
- D- Présence d'AC anti ARN polymérase III
- E- Présence d'AC anti topoisomérase I.

17. La vasculopathie au cours de la sclérodermie systémique est responsable de (Choisissez les réponses justes):

- A- La pneumopathie interstitielle diffuse.
- B- La crise rénale sclérodermique.
- C- L'HTAP
- D- Les ulcères digitaux
- E- Les troubles du rythme cardiaque..

18. Quels éléments permettent de suspecter un VEDOSS (Very Early Diagnosis Of Systemic Sclerosis) ? (Choisissez les réponses justes):

- A- Phénomène de Raynaud.
- B- PID avec une extension supérieure a 20% au scanner thoracique
- C- Doigts boudiné.
- D- Anticorps antinucléaires.
- E- Syndrome restrictif à la spirométrie.

19. L'atteinte digestive de la sclérodermie systémique peut se manifester par tous les signes suivants sauf un, lequel?
- A- Une incontinence fécale.
 - B- Un micro anévrisme des artères digestives.
 - C- Une gastrite antrale télangiectasique.
 - D- Un syndrome de pseudo-obstruction intestinale.
 - E- Une constipation.
20. Quelle est la principale protéine Impliquée dans l'amylose AL ? (Choisissez la réponse Juste):
- A- Transthyrétine.
 - B- Sérum amyloïde A.
 - C- Chaînes légères d'immunoglobulines.
 - D- Fibrinogène.
 - E- Beta-2 microglobuline.
21. Quel signe est évocateur d'une atteinte cardiaque dans l'amylose AL? (Choisissez la réponse juste):
- A- La tachycardie sinusale.
 - B- L'hypotrophie du VG.
 - C- L'angor avec obstruction athéromateuse des coronaires.
 - D- L'épanchement péricardique abondant.
 - E- L'épaississement pariétal granuleux à l'échocardiographie.
22. L'atteinte digestive de l'amylose peut se manifester par (Choisissez les réponses justes):
- A- Un syndrome de malabsorption intestinal
 - B- Une hémorragie digestive.
 - C- Un endobrachyœsophage...
 - D- Une maladie hémorroïdaire.
 - E- Une macroglossie.
23. Au cours du syndrome de Sjörger, le test de Schirmer est considéré positif si (choisissez la réponse juste):
- A- 10 mm à 5 minutes.
 - B- Entre 5 et 10 mm à 5 minutes.
 - C- 15 mm à 5 minutes.
 - D- 5 mm à 5 minutes.
 - E- Toutes les réponses sont fausses.
24. Au cours du syndrome de Sjörger, les manifestations extra-glandulaires peuvent être (choisissez les réponses justes):
- A- Des arthrites destructrices.
 - B- Une pneumopathie interstitielle diffuse.
 - C- Une neuropathie périphérique.
 - D- Un purpura vasculaire.
 - E- Toutes les réponses sont justes.

25. Parmi les manifestations cardiaques du SAPL, on peut retrouver (choisissez la réponse fausse):
- A- Des végétations valvulaires.
 - B- Une thrombose intracardiaque.
 - C- Une dysfonction diastolique.
 - D- Une Hypertension pulmonaire.
 - E- Une endocardite bactérienne.
26. A propos du déficit immunitaire en IgA, choisissez les propositions justes:
- A- Il se manifeste exclusivement par des infections.
 - B- Il peut être une forme du déficit immunitaire secondaire.
 - C- Il peut être associé à une maladie cœliaque.
 - D- Il peut parfois être en cause dans des accidents transfusionnels.
 - E- Il peut se compléter par un déficit en IgG2 et IgG4.
27. Le Traitement des déficits immunitaires humoraux fait appel à (choisissez les réponses justes):
- A- Une substitution par immunoglobulines polyvalentes par voie intraveineuse.
 - B- Une antibiothérapie précoce, prolongée et adaptée en cas d'infections.
 - C- Une vaccination par des vaccins vivants atténués.
 - D- Un arrêt Impératif du tabac.
 - E- Toutes les réponses sont justes.
28. A propos du déficit en complément C1 Inhibiteur, choisissez les propositions justes:
- A- Il est exclusivement d'origine acquise.
 - B- Il peut être à l'origine d'un angioedème bradykinique.
 - C- Il peut se voir au cours des hémopathies lymphoïdes.
 - D- Son diagnostic repose uniquement sur le dosage antigénique du C1 inhibiteur.
 - E- Toutes les réponses sont justes.
29. Les myosites inflammatoires associées aux anticorps anti-MDA 5 sont caractérisées par (choisissez les réponses justes):
- A- Une atteinte musculaire obligatoire.
 - B- Une atteinte respiratoire rapidement progressive
 - C- Une atteinte cutanée à type de calcifications.
 - D- Une atteinte articulaire.
 - E- Toutes les réponses sont justes.
30. Concernant la maladie de Fabry, choisissez les réponses justes:
- A- C'est une maladie autosomique dominante.
 - B- Le gène impliqué est GLA.
 - C- L'activité enzymatique de l' α -galactosidase A est toujours effondrée chez les femmes.
 - D- L'atteinte cardiaque est la cause de décès la plus fréquente.
 - E- L'atteinte rénale est plus fréquente chez la femme que chez l'homme.

31. Concernant les atteintes neurologiques de la maladie de Fabry, choisissez la réponse fausse :

- A- Les AVC ischémiques sont fréquents.
- B- L'atteinte périphérique se manifeste par des acroparesthésies.
- C- La surdit   est fr  quente et li  e    une atteinte cochl  o-vestibulaire.
- D- La substance blanche n'est jamais touch  e.
- E- La dolichoectasie du tronc basilaire est une anomalie possible.

32- Quels sont les signes pr  coces    l'ECG de la maladie de Fabry: RJ

- a) Raccourcissement du PQ +++
- b) Sus d  calage du segment ST
- c) Raccourcissement de la dur  e de l'onde P
- d) Arythmies atriales
- e) Bloc auriculo ventriculaire de de troisi  me degr  

33-    propos des formes cliniques de la maladie de Gaucher, choisissez les r  ponses fausses:

- A- Le type 2 est la forme la plus fr  quente.
- B- Le type 3 peut   tre diagnostiqu   chez l'adulte.
- C- Le type 2 associe spl  nom  galie et atteinte neurologique pr  coce."
- D- La forme f  tale se traduit souvent par un d  c  s in utero.
- E- Le type 1 pr  sente toujours une atteinte neurologique.

34- A propos de la maladie de Gaucher, choisissez les propositions justes:

- A- Elle expose    un risque accru de maladie de Parkinson.
- B- Elle pourrait exposer    un risque de d  veloppement des pics monoclonaux et de my  lome multiple.
- C- Les r  ducteurs de substrat sont le traitement de choix chez les m  taboliseurs ultra-rapides
- D- La spl  nectomie est syst  matiquement recommand  e.
- E- La th  rapie g  nique est largement utilis  e.

35- A propos de la maladie de Kawasaki, choisissez les r  ponses justes:

- A- Elle touche pr  f  rentiellement les enfants de plus de 10 ans.
- B- La conjonctivite de la maladie de Kawasaki est bilat  rale et purulente.
- C- L'atteinte cardiaque d  termine la gravit   de la maladie.
- D- L'  ruption cutan  e de type exanth  me non v  siculeux est sp  cifique de la maladie!
- E- Les immunoglobulines sont le traitement de premi  re intention.

36-    propos de l'atteinte r  nale du purpura rhumato  ide chez l'enfant, choisissez les r  ponses fausses:

- A- Elle survient dans un quart des cas.
- B- Elle peut se pr  senter sous forme de syndrome n  phrotique
- C- L'atteinte r  nale est toujours r  versible.
- D- Une biopsie r  nale est indiqu  e en cas de prot  inurie isol  e minime.
- E- Les sympt  mes r  naux apparaissent dans 98% des cas avant le 2eme mois...

37- Madame Nadia âgée de 47 ans est hospitalisée pour asthénie, fièvre, hématurie macroscopique et dyspnée. Elle présente un syndrome inflammatoire, une insuffisance rénale aiguë avec protéinurie, et une hémoptysie modérée.

La recherche d'ANCA anti-MPO est fortement positive. Une biopsie rénale montre une glomérulonéphrite nécrosante pauci-immune, le diagnostic de polyangéite microscopique est posé. La patiente débute un traitement par bolus de méthylprednisolone puis prednisone Per Os avec une proposition du cyclophosphamide. Quels sont les effets indésirables classiques du cyclophosphamide à surveiller? (Choisissez les réponses justes):

A- Cystite hémorragique.

B- Aplasie médullaire.

C- Cécité rapide.

D- Risque tératogène.

E- Risque infectieux.

38- Nadia a refusé un traitement par le cyclophosphamide, vous optez pour un traitement biologique par Rituximab, avant de commencer le rituximab, quels examens sont indispensables? (Choisissez les réponses justes):

A- Hémogramme.

B- Sérologie virale B,C et HIV.

C- Dosage pondéral des Immunoglobulines.

D- Bilan lipidique.

E- Intradermoréaction à la tuberculine (IDR) et/ou un test sanguin IGRA (Quantiféron®).

39- Les facteurs prédictifs de lymphome au cours du syndrome de Gougerot-Sjögren sont (choisissez les réponses justes):

A- La présence d'un purpura vasculaire.

B- L'atrophie des glandes salivaires principales.

C- La présence de cryoglobulinémie.

D- L'absence d'un composant monoclonal

E- L'absence de lymphopénie.

40- Quel élément biologique évoque fortement une poussée lupique (Choisissez la réponse juste)?

A. Augmentation du C3 et C4

B. Hyperleucocytose franche

C. Hypocomplémentémie + élévation des anti-dsDNA

D. Hyperkaliémie

E. Eosinophilie à plus de 1500/mm³

41- Selon L'OMS on parle d'une maladie rare lorsque (choisissez la réponse juste)

a) Une personne sur 100 est atteinte

b) Une personne sur 200 est atteinte

c) Une personne sur 1000 est atteinte

d) Une personne sur 2000 est atteinte

e) Une personne sur 20 est atteinte

42- Expression clinique du DICV (choisissez la réponse fausse)

- 1) Des infections récurrentes.
- 2) Des manifestations auto-immunes
- 3) Un syndrome lymphoprolifératif
- 4) Les granulomes
- 5) Angioedème bradykinique

43- Quelles sont les signes cutanés des principales des maladies auto-inflammatoires (choisissez les réponses justes)?

- A. Le pseudo-erysipèle de la cheville est classique dans la FMF
- B. L'urticaire au froid environnemental se voit dans les cryopyrinopathies
- C. Une urticaire est pathognomonique du déficit en MVK
- D. L'œdème périorbitaire se voit dans le syndrome TRAPS
- E. Les aphtes sont fréquents dans le déficit en MVK et le syndrome PFAPA

44- Quel traitement, est obligatoirement associé avec le méthotrexate?(choisissez la réponse juste):

- A- Les anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- B- Les antalgiques.
- C- L'acide folique.
- D- Les corticoïdes.
- E- Un antihistaminique.

45- Quels sont les déficits primitifs de la lignée B: RF

- 1. Déficit sélectif en Ig A
- 2. Déficit immunitaire commun variable (DICV)
- 3. Agammaglobulinémie de Bruton
- 4. Syndrome hyper- Ig M (SHIGM)
- 5. Syndrome de DI-GEORGE

46- Les Indications du traitement enzymatique substitutif dans la maladie de Gaucher sont (choisissez les réponses justes):

- A- Thrombopénie symptomatique ou taux de plaquettes ≤ 50 G/L.
- B- Anémie symptomatique et/ou taux d'hémoglobine ≤ 10 g/dL.
- C- Hépatomégalie et/ou splénomégalie
- D- Atteinte osseuse cliniquement symptomatique.
- E- Atteinte osseuse radiologique à type d'infarctus, ostéonécrose ou fracture pathologique

47- Concernant la grossesse au cours du lupus érythémateux systémique (LES), choisissez les propositions justes:

- A- La grossesse est formellement contre-indiquée au cours du LES.
- B- Une grossesse peut induire une poussée lupique.
- C- La présence d'Anti-Ro/SSA est associée à un risque accru de lupus néonatal.
- D- L'azathioprine est contre-indiqué au cours de la grossesse pour éviter la toxicité fœtale.
- E- Les œstrogènes sont recommandés en cas de SAPL associé au LES au cours de la grossesse

48- Selon les critères de classification de l'ACR/EULAR 2019 du LES, Le diagnostic de lupus systémique est retenu lorsque le score (Choisissez la réponse juste):

- A- Est supérieur à 6.
- B- Est supérieur à 7.
- C- Est supérieur à 8.
- D- Est supérieur à 10.
- E- Est supérieur à 20.

49- Selon les recommandations KDIGO 2024, la biopsie rénale au cours du LES est indiquée devant (choisissez la réponse juste):

- A- Protéinurie des 24h $\geq 300\text{mg}/24\text{h}$.
- B- Le rapport protéine/créatinine urinaire $\geq 1000\text{ mg/g}$.
- C- Protéinurie des 24h $\geq 300\text{mg}$ et $\leq 500\text{ mg}/24\text{h}$.
- D- Protéinurie des 24h $\geq 500\text{ mg}/24\text{h}$ et Le rapport protéine/créatinine urinaire $\geq 500\text{ mg/g}$
- E- Clairance de la créatinine sanguine $\leq 60\text{ml/mn}$.

50- Dans le cadre de la sclérodermie Cochez la ou les réponses justes

- a) Le phénomène de Raynaud comporte 3 phases et parmi les signes de gravités, on décrit: ulcères digitaux et nécrose digitale.
- b) La capillaroscopie fait partie des examens complémentaires en présence d'un phénomène de Raynaud.
- c) La sclérose cutanée au cours de la sclérodermie est évaluée par le score de Rodnan
- d) Le diagnostic de la pneumopathie interstitielle et de la fibrose se fait par une TDM thoracique HR
- e) L'HTAP est dépistée par l'écho doppler cardiaque

Examen Medecine de Travail : Groupe 03 / 2026

1) A propos des rayonnements ionisants: (RJ)

A. La quantité d'énergie transmise par les RI est mesurée par le becquerel

B. La dose efficace est mesurée par le Sievert

C. Les effets stochastiques sont doses dépendants

D. Le SAR apparait à partir de 5 Gray

E. Les RI agissent principalement par effet direct sur l'ADN

2) L'effet des toxiques dépend de: (1RJ)

1. La dose

2. Site d'action

3. Uniquement de sa toxicité

4. Existence de moyens de protection

5. Toutes les réponses sont justes

A5 B3 C (1+2+4) D (2+3) E(1+4)

3) CAT devant un AES: (RF)

A. Réaliser les premiers soins

B. Faire saigner la plaie

C. Interrompre le geste

D. Réaliser une sérologie du patient source

E. Réaliser un suivi sérologique

4) La prévention de la pollution atmosphérique (RJ):

A. Est réglementée en Algérie

B. Consiste à prévenir la production des polluants

C. Consiste à respecter les limites d'émission

D. Identifier les déchets rejetés

E. Toutes les réponses sont justes

5) Les effets des perturbateurs endocriniens: (1RJ)

1. Sont toujours doses dépendants

2. Les plastifiants représentent des PE

3. Sont transmis à la descendance

4. Secondaires aux seules expositions professionnelles

5. Peuvent être cancérigènes

A (1+4) B (2+4) C (2+3+5) D (1+2+3) E(1+2+5)

6) A propos des dermatoses professionnelles: (RF)

A. Le syndrome de Raynaud représente une DP d'origine traumatique

B. Radiodermite représente une DP d'origine physique

C. Dermatose due au latex est d'origine immunologique

D. Une brûlure au ciment est d'origine immunologique

E. Une acrocyanose est une DP due aux agents physiques

7) Il s'agit d'un homme âgé de 28 ans reçu aux urgences pour un traumatisme de l'épaule suite à un accident.

Quels éléments sont recherchés à l'anamnèse pour déterminer l'origine professionnelle: (RF)

- A. Caractère soudain
- B. Lieu de l'accident
- C. Responsabilité du travailleur dans l'accident
- D. Heure de l'accident
- E. Relation avec le travail

8) S'il s'agit d'un accident de travail, quelle sera la CAT: (RJ)

- A. Etablir un CMI
- B. Etablir un certificat médical descriptif de consolidation
- C. Etablir un certificat en 3 exemplaires
- D. L'employeur déclaré l'accident à la CNAS dans un délai de 24H
- E. La victime déclare l'accident à la CNAS dans un délai de 24H

9) Une visite médicale périodique a pour but de: (RF)

- A. Déterminer l'aptitude au poste
- B. Rechercher une pathologie en rapport avec le travail
- C. Effectuer un aménagement de poste
- D. Revêtir un caractère facultatif
- E. Effectuer des examens complémentaires orientés

10) A propos du risque biologique (RF)?

- A. Intéresse uniquement le personnel de santé
- B. Secondaires aux agents biologiques pathogènes
- C. Sa prévention consiste à agir sur le réservoir et le mode de transmission
- D. Vaccination de l'hôte permet de supprimer le risque
- E. Est à l'origine d'effets cancérogènes

11) La gale au ciment? (RF)

- 1. Il s'agit d'une dermatite irritative,
- 2. Il s'agit d'une dermatite eczématiforme
- 3. Elle est secondaire à une exposition au chrome hexavalent
- 4. Son diagnostic consiste à réaliser un test d'éviction-réintroduction
- 5. Elle est caractérisée par un passage à la chronicité

A (2) B (1) C (2+3) D(1 + 3) E(1 + 5)

12) Une surdité professionnelle se définit par: (RF)

- A. Surdité symétrique bilatérale
- B. Elle débute par un scotome à 2000 Hz
- C. Il existe un phénomène de recrutement
- D. Elle est irréversible
- E. Elle nécessite un temps d'exposition

13) Une fiche de donnée de sécurité: (RF)

1. Comporte 15 rubriques
2. Elle établit par le fournisseur
3. Elle est établit par le médecin du travail
4. Elle informe sur les dangers d'un produit chimique
5. Elle est facultative

A (1 + 2 + 4) B (1 + 3 + 4) C (2+5) D (1 + 3 + 5) E(1 + 5)

14) Quels sont les prérogatives du médecin du travail : (RF)

- A. Réaliser des visites des lieux
- B. Informer l'employeur sur l'état de santé des travailleurs
- C. Informer les travailleurs sur les risques
- D. Réaliser des visites médicales préventives
- E. Réaliser des visites médicales curatives.

15) La prévention des nuisances sonores consiste: (RF)

- A. Agir sur l'émission du bruit
- B. Agir sur la propagation du bruit
- C. Fournir uniquement des protections auditives
- D. Isoler les salariés du bruit
- E. Former et informer les salariés

16) Concernant les manifestations cliniques et la définition du Burn-out selon le modèle de Maslach, quels sont les éléments caractéristiques? (1RJ)

1. Épuisement émotionnel, physique et psychique
2. Sentiment de dépersonnalisation ou de cynisme
3. Augmentation du sentiment d'accomplissement personnel
4. Troubles du sommeil et fatigue chronique
5. Origine systématiquement extra professionnelle

A (1+2+4) B (2+3+5) C (1+3+4) D (1+2+5) E (1+2+4)

17) Parmi les propositions suivantes, quels sont les facteurs de risque liés au travail reconnus favorisant l'apparition d'un Burn- out? (1RJ)

1. Surcharge de travail et pression temporelle
2. Manque de reconnaissance de la part de la hiérarchie
3. Conflits de valeurs (éthiques)
4. Stratégies de coping actives et combatives
5. Estime de soi élevée et réalisme

A(1+4+5) B(2+3+4) C(1+2+3) D(1+3+5) E (2+4)

18) Concernant les facteurs de risque ergonomiques et les mécanismes des TMS liés aux TIC, quelles sont les propositions exactes? (1RJ)

1. La compression du nerf médian provoque le syndrome du canal carpien.
2. Un écran positionné trop haut favorise l'apparition de cervicalgies.
3. Un clavier placé trop loin engendre une hypesollicitation des épaules.
4. Un appui continu du poignet protège contre l'atteinte du canal carpien.
5. Une souris positionnée trop loin réduit la tension au niveau de l'épaule.

A (1+3+5) B (2+4+5) C (1+2+4) D (1+2+3) E (2+3+5)

19) Quels sont les impacts sur la santé et les risques psychosociaux (RPS) inhérents à l'usage professionnel intensif des TIC? (IRJ)

1. Un syndrome de l'œil sec favorisé par la fixité du regard.
2. Un allègement de la charge mentale grâce à l'automatisation des tâches.
3. Une interférence entre la vie privée et la vie professionnelle.
4. Un risque d'isolement social et un affaiblissement des collectifs de travail.
5. Une amélioration de la gestion du stress (réduction du techno-stress).

A (1+3+4) B (1+2+5) C (2+3+4) D (1+3+5) E (3+4+5)

20) Vous recevez à votre consultation de pathologie professionnelle Monsieur B.A, âgé de 48 ans, éleveur de bovins depuis 25 ans. Il ne fume pas, sans notion d'atopie personnelle ou familiale. Il consulte pour des épisodes récidivants associant une sensation de malaise général, des frissons, une toux sèche et une dyspnée d'effort.

L'interrogatoire minutieux révèle que cette symptomatologie apparaît typiquement en fin de journée ou le soir, après avoir travaillé l'après-midi à la distribution de fourrage et de foin stocké dans une étable mal ventilée. L'examen clinique retrouve des râles crépitants aux bases pulmonaires.

Concernant le diagnostic positif de cette affection, quelles sont les propositions exactes 7(1RJ)

1. Il s'agit d'un asthme professionnel.
2. Il s'agit d'une Pneumopathie d'Hypersensibilité (PHS).
3. L'entité clinique est la « Maladie du poumon du fermier ».
4. Il s'agit d'une BPCO professionnelle débutante.
5. C'est une pneumoconiose de surcharge. A (1+3) B (2+3) C (2+4) D (1+5) E (3+4)

21) Concernant les mécanismes physiopathologiques et étiologiques en cause chez ce patient, quels éléments sont corrects (IRJ)

1. Il s'agit d'une réaction d'hypersensibilité de type 1 médiée par les IgE.
2. C'est une pathologie immunologique allergique de type III ou IV.
3. L'agent causal est une substance inorganique fibrosante.
4. Les agents responsables sont des moisissures (actinomycètes) présentes dans le foin.
5. Le mécanisme est purement irritatif et toxique sans base immunologique.

A (1+3) B (2+4) C (1+4) D (2+5) E (3+5)

22) Concernant les agents cancérigènes, leur classification par le CIRC et leurs effets, quelles sont les propositions exactes? (1RJ)

1. Le Groupe 1 rassemble les agents dont la cancérigénicité est certaine pour l'Homme.
2. Le Groupe 2A correspond aux agents "peut-être cancérigènes".
3. Les poussières de bois sont associées spécifiquement à l'adénocarcinome des sinus.
4. L'amiante est classée dans le groupe 2B (cancérigène possible).
5. Le Benzène est un agent du groupe 1 responsable de leucémies.

A (1+3+5) B (1+2+4) C (2+3+5) D (1+3+4) E (3+4+5)

23) Concernant l'organisation temporelle du travail posté et atypique, quelles sont les propositions exactes? (1RJ)

1. Les horaires atypiques incluent le travail de fin de semaine.
2. Le système "2x8" assure une activité continue sur 24 heures.
3. Le mode "semi-continu" comporte un arrêt en fin de semaine.
4. Le mode "continu" nécessite une équipe de suppléance.
5. Les horaires aléatoires sont des horaires fixes et structurés.

A (1+3+4) B (1+2+3) C (2+4+5) D (1+3+5) E (3+4+5)

24) Parmi les signes cliniques suivants, lesquels caractérisent spécifiquement le syndrome muscarinique lors de la phase d'état d'une intoxication aiguë aux organophosphorés? (1RJ)

1. Bradycardie.
2. Fibrillations musculaires.
3. Hypersécrétion bronchique et diarrhées.
4. Myosis.
5. Faiblesse musculaire et ataxie,

A(1 + 3 + 4) * B(1 + 2 + 5) * C(2 + 3 + 4) * D(1 + 4 + 5) * E (3 + 4 + 5)

25. Concernant le mécanisme d'action toxique des pesticides organochlorés sur le système nerveux central, quels sont les processus impliqués? (1RJ)

1. Inhibition acétylcholinestérase de l'enzyme
2. Inhibition des récepteurs GABAergiques
3. Augmentation du taux de glutamate.
4. Diminution de la libération de sérotonine
5. Phosphorylation du site estérasique.

A (1 + 2 + 3) * B(2 + 3 + 4) * C(1 + 4 + 5) * D(2 + 4 + 5) * F (3 + 4 + 5)

26) Concernant le devenir des solvants organiques dans l'organisme, quelles sont les propositions exactes? (1RJ)

1. La voie respiratoire représente la principale voie de pénétration en milieu professionnel.
2. La pénétration cutanée est impossible raison de la barrière lipidique de la peau.
3. Le stockage s'effectue préférentiellement dans les tissus riches en graisses (SNC).
4. Le passage transplacentaire est possible pour la majorité des solvants.
5. L'élimination se fait exclusivement par la voie urinaire sous forme de métabolites.

A(1 + 3 + 4) * B(1 + 2 + 3) * C(2 + 4 + 5) * D(1 + 3 - 5) * E (3 + 4 + 5)

27) Quels sont les éléments cliniques caractéristiques du psychosyndrome organique observé lors de l'intoxication chronique aux solvants? (1RJ)

1. Une asthénie associée à des troubles du sommeil.
2. Des troubles mnésiques.
3. Une paralysie motrice des extenseurs de la main.
4. Des troubles de la personnalité et de l'humeur.
5. Une polynévrite ascendante sensitivo-motrice

A(1 + 2 + 5) * B(1 + 2 + 4) * C(2 + 3 + 4) * D(1 + 3 + 5) * E (3+4+5)

28) Concernant le mécanisme de l'hématotoxicité du plomb sur la synthèse de l'hème, quelles sont les propositions exactes? (1RJ)

1. Le plomb inhibe l'enzyme ALA-Déshydratase.
2. Il provoque une diminution du taux d'acide delta amino-lévulinique (ALA) urinaire.
3. Il entraîne une augmentation des protoporphyrines zinc (PPZ).
4. Il inhibe l'enzyme Hème Synthétase (ferrochélatase).
5. Il stimule la production d'hémoglobine par la moelle osseuse.

A(1 + 3 + 4) * B(1 + 2 + 5) * C(2 + 3 + 4) * D(1 + 4 + 5) * E (3 + 4 + 5)

29) Quels sont les signes cliniques caractéristiques de la phase d'intoxication (phase d'état) au plomb? (1RJ)

1. La colique de plomb (douleurs abdominales, constipation)
2. Le tremblement intentionnel des membres supérieurs.
3. La paralysie pseudo-radiale des extenseurs des doigts.
4. L'encéphalopathie hypertensive.
5. La stomato-gingivite avec hypersalivation.

A (1 + 2 + 4) * B(1 + 3 + 4) * C(2 + 3 + 5) * D(1 + 3 + 5) * E (2 + 4 + 5)

30) Concernant les manifestations cliniques de l'intoxication chronique au Mercure, quels éléments sont corrects? (1RJ)

1. L'atteinte de la cavité buccale se manifeste par une stomato-gingivite.
2. Le tremblement est intentionnel et aggravé par les émotions.
3. L'atteinte rénale se traduit typiquement par une colique néphrétique.
4. Les troubles du caractère (irritabilité, timidité) sont présents.
5. L'atteinte de l'œil (Mercurialentis) correspond à une cécité brutale.

(1 + 2 + 3) * B(2 + 3 + 4) * C(1 + 2 + 4) * D(1 + 3 + 5) * E (3+4+5)

Examen UMC Groupe : 01 / 2026

Q1. Le triage médical; a pour objectif principal ? (RJ)

- a. De remplir les dossiers administratifs.
- b. D'établir le diagnostic définitif du patient.
- c. De décider du traitement à long terme.
- d. D'évaluer la gravité et prioriser la prise en charge.
- e. Toutes ces réponses sont justes.

Q2. Dans un service d'urgence; le triage est effectué par: (RJ)

- a. Le médecin chef de l'hôpital.
- b. Le personnel administratif.
- c. Un infirmier formé ou un médecin urgentiste
- d. Les agents de sécurité.
- e. Le directeur de l'hôpital

Q3. Le triage doit être: (RJ)

- a. Fixe et inchangé une fois établi.
- b. Réévalué régulièrement selon l'évolution du patient.
- c. Effectué par un médecin spécialiste uniquement.
- d. Basé sur des critères sociaux.
- e. Fait par le personnel seul sans protocoles de tri.

Q4. Le rôle de l'infirmier organisateur de tri comprend: (RJ)

- a. L'évaluation rapide des signes vitaux.
- b. L'identification des urgences vitales.
- c. L'orientation du patient vers le bon secteur.
- d. La réévaluation si l'état s'aggrave.
- e. Toutes ces réponses sont justes.

Q5. Un homme âgé de 35 ans est mordu au mollet par une vipère lors d'une randonnée, à son admission on note une douleur intense, un œdème étendu avec ecchymoses, et un trouble de la coagulation au bilan biologique, quelle est la meilleure conduite à tenir: (RJ)

- a. La sérothérapie est administrée dès la constatation d'un choc anaphylactique
- b. Réserver la sérothérapie aux morsures multiples
- c. Préférer un traitement par les corticoïdes seuls
- d. Administrer le sérum anti vipérin spécifique le plus tôt possible
- e. Contre indiquer la sérothérapie en présence d'un œdème local important

Q6. Le mécanisme d'action de la ricine repose sur: (RJ)

- a. L'inhibition de la libération de l'acétylcholine
- b. L'inhibition de la synthèse protéique
- c. La stimulation du système sympathique
- d. L'activation des canaux sodiques
- e. L'inhibition de la glycolyse

Q7. Le traitement spécifique de l'envenimation scorpionique grave repose sur (RJ)

- a. L'adrénaline sous cutanée
- b. Les corticoïdes seuls
- c. Le repos strict
- d. L'administration de sérum spécifique
- e. L'hydratation orale abondante

Q8. Le venin de scorpion agit principalement par: (RJ)

- a. Blocages des synapses cholinergiques
- b. Destruction directe des fibres musculaires
- c. Stimulation massive du système nerveux autonome
- d. Inhibition de la conduction cardiaque
- e. Lyse des hématies

Q9. Le venin de vipère agit principalement par: (Ri)

- a. Action neurotoxique
- b. Action hémato toxique et nécrosante
- c. Action cholinergique
- d. Action cardio-toxique pure
- e. Action Inhibitrice de la conduction nerveuse

Q10. Le SAMU (service d'aide médicale urgent) a pour mission principale:

- a. Le transport de patients entre établissements
- b. La régulation médicale des appels d'urgence
- c. L'intervention immédiate sur tous les lieux d'accidents
- d. L'accueil des urgences hospitalières
- e. Les secours aux victimes d'incendie

Q11. La première étape de la chaîne de secours est:

- a. L'arrivée du SMUR
- b. L'appel du SAMU
- c. Le transport à l'hôpital
- d. Le diagnostic médical
- e. La réanimation en service hospitalier

Q12. L'objectif majeur de la médecine pré hospitalière

- a. Diagnostiquer de manière rentive la pathologie
- b. Délivrer un traitement suite complet
- c. Evite tout transport hospitalier
- d. Effectuer des actes de chirurgie sur place
- e. Stabiliser le patient avant apital

Q13. Le SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation):

- a. DU SAMU
- b. Des sapeurs-pompiers
- c. De la police
- d. Des associations de secours (Croissant-Rouge)
- e. Des cliniques privées

Q14. Tous ces gestes sont proscrits lors de l'ingestion d'un produit caustique sauf un (01), lequel:

- a. La lavage gastrique
- b. le proclive à 45
- c. La mise en place d'une sonde naso-gastrique
- d. Le décubitus dorsal
- e. Induire des vomissements

Q15. Les complications tardives de l'ingestion de produit caustique sont (RF):

- a. La perforation d'organe
- b. La fistulisation
- c. Les hémorragies
- d. La dégénérescence néoplasique
- e. les sténoses

Q16. Le traitement des brûlures cutanées repose sur (RF):

- a. Une bonne analgésie
- b. Le refroidissement des lésions
- c. Une antibiothérapie
- d. Une expansion volumique guidée
- e. Une Oxygénothérapie

Q17. Parmi les localisations à risque de brulures cutanées (RF):

- a. Le thorax
- b. La tête
- c. Le périnée
- d. Les mains
- e. Les brulures circulaires

Q18. Une brulure avec 18% de SCTB (Surface Cutanée Totale Brulée) est dite (RJ):

- a. Brulure légère
- b. Brulure modérée
- c. Brulure sévère
- d. Ne nécessite pas une hospitalisation
- e. Touche seulement la tête et le cou chez l'adulte

Q19. Une brulure cutanée profonde de 2 ème degré (RJ):

- a. Touche uniquement l'épiderme
- b. Touche la couche papillaire du derme
- c. Touche la couche réticulaire du derme
- d. Touche l'hypoderme
- e. Guérie sans séquelles

Q20. Quel est le centre nerveux responsable de la thermorégulation (RJ)

- a. Le cervelet
- b. Le tronc cérébral
- c. L'hypothalamus
- d. Le thalamus
- e. Le cortex

Q21. Quelle est la principale cause d'hypothermie ? (RJ)

- a. Une infection virale
- b. Une exposition prolongée au froid
- c. Une déshydratation
- d. Un effort physique intense
- e. Une hyperthyroïdie

Q22. Quel mécanisme physiopathologique permet de lutter contre l'hypothermie ? (RJ)

- a. La vasodilatation viscérale
- b. Stimulation des glandes sudoripares
- c. La tachycardie
- d. La vasoconstriction cutanée
- e. Inhibition des hormones thyroïdiennes

Q23. Quelle est la première mesure de réchauffement pour un patient conscient souffrant d'hypothermie légère à 35°C ? (RJ)

- a. Réchauffement actif interne par des solutés de perfusion chaudes
- b. Administration de boissons chaudes, et couvertures chaudes
- c. Intubation et ventilation avec un air chaud et humidifié
- d. Utilisation de la circulation extra-corporelle CEC afin de filtrer et de chauffer le sang
- e. Mise en place d'une sonde naso-gastrique afin d'administrer des solutés chauds

Q24. Lors d'un afflux massif de blessés (RJ)

- a. les capacités de prise en charge de la structure médicale et chirurgicale sont conservées.
- b. Lors d'une situation de multiple causalités, La perte de chance individuelle est Importante.
- c. Lors d'une situation d'afflux limité mass causalités, La perte de chance Individuelle est limitée.
- d. Un afflux limité n'est jamais saturant, et la perte de chance est gérée.
- e. L'afflux est dit saturant lorsque le nombre de blessés dépasse les possibilités de PEC

Q25. Principes du triage lors d'un afflux massif de blessés (RF)

- a. C'est une classification des victimes en catégories selon l'urgence.
- b. Il est effectué en préhospitalier, au pavillon des urgences et au bloc opératoire.
- c. il a pour but de poser le diagnostic et d'établir un bilan lésionnel détaillé.
- d. la recherche d'une détresse neurologique, hémodynamique et/ou ventilatoire.
- e. Une catégorisation des blessés selon la gravité des lésions

Q26. Selon la nouvelle classification des blessés du SSA (Service de Santé des Armées) (RF)

- a. Une Plaie oculaire bilatérale est classée T1 et doit être PEC dans un délai de 06 h
- b. Un délabrement important des parties molles est classé T1 et doit être PEC dans un délai de 18 h
- c. la plaie craniocérébrale, la lésion de l'artère fémorale, et les brûlures de plus de 50% sont tous classés T1
- d. La catégorie T4 englobe les patients nécessitant un geste chirurgical sans urgence
- e. Le choc hémorragique non contrôlé fait partie de la catégorie T4 du SSA.

A. (a; b; e) B. (b; c; d) C. (c, d; e) D. (a, b, c) E (a; e)

Q27. A propos du Damage control (RJ)

- a. Correction complète de toutes les lésions viscérales
- b. Éviter toute chirurgie avant 24 heures
- c. Contrôle du saignement et de la contamination
- d. Fermeture définitive de la paroi abdominale
- e. Réalisation du chirurgie complète dès la première intervention

Q28. Dans les pendaisons de justice: (RF)

- a. Le sujet est arrêté dans sa chute par la brièveté du lien.
- b. Il se produit une élongation brutale de la moelle épinière cervicale
- c. On retrouve des lésions bulbaires et des lésions osseuses rachidiennes
- d. Les lésions sont d'autant plus graves que le nœud est latéral.
- e. La mort est souvent immédiate.

Q29. À propos de la pendaison, (RJ)

- a. Le mécanisme principal du décès est la section médullaire haute
- b. La compression des vaisseaux cervicaux entraîne une anoxie cérébrale rapide
- c. La libération de la victime doit se faire rapidement en coupant la corde
- d. La fracture du cartilage thyroïde est rare
- e. La réanimation cardiorespiratoire est inutile en cas de pendaison complète

Q30. Concernant l'électrisation: (RF)

- a. Le courant alternatif domestique (220 V) est plus dangereux que le courant continu
- b. Le passage du courant par le thorax peut entraîner une fibrillation ventriculaire
- c. Les brûlures d'entrée et de sortie traduisent toujours des lésions internes minimales
- d. L'arrêt cardiaque peut survenir même avec des lésions cutanées discrètes
- e. Le patient peut être laissé en observation simple si l'ECG initial est normal et le patient asymptomatique

Q31. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont communes aux trois situations d'urgence (noyade, pendaison, électrisation)? (RF)

- a. Le risque d'arrêt cardiorespiratoire justifie la surveillance continue initiale
- b. La prise en charge préhospitalière suit les principes du ABC de réanimation
- c. L'intubation trachéale est formellement contre-indiquée
- d. Le maintien de la température corporelle fait partie du traitement
- e. Un transfert en unité de soins intensifs est souvent nécessaire

Q32. L'oxygénothérapie (RF)

- a. Est un médicament.
- b. Peut-être prescrire en mode invasive ou non invasive
- c. Est indiquée lors d'un déficit en oxygène
- d. Est indiquée en cas de manifestations ou de suspicion d'hypoxie tissulaire
- e. N'est pas nécessaire en cas de trouble de la conscience ou d'instabilité hémodynamique.

Q33. Lors d'une catastrophe a dégâts limités, (le/les RF)

- a. Il est nécessaire de s'organiser et de tracer un algorithme de prise en charge.
- b. La direction des secours coordonne ses missions selon le plan NOVI nouvelle appellation du plan blanc.
- c. L'élément de sécurité civile hospitalier projetable est la pierre angulaire de la stratégie de prise en charge.
- d. Le plan rouge est spécifique en cas d'accident majeur nécessitant une coordination interservices.
- e. Toutes les réponses sont justes.

Q34. En cas d'un séisme de forte magnitude, lors du triage: (la/les RJ)

- a. Le but du triage est de poser un diagnostic clinique en moins de 10 mn
- b. Le tri est effectué par un médecin affecté au poste médical avancé (PMA).
- c. L'urgence absolue de niveau 1 nécessite une prise en charge en moins de 03 heures.
- d. Une victime qui présente une surface cutanée brute 20 % avec prédominance au cou et au visage constitue un niveau 2 et doit être évacuée en moins de 18h.
- e. Le Crush syndrom est le tableau clinique le plus rencontre.

Q35. À propos du Crush syndrome :(la/les RF)

- a. Ensemble des manifestations rénales et hémodynamiques liées à une rhabdomyolyse victimes, il est nécessaire de faire passer du sérum
- b. Avant l'extraction des physiologique 01L/h pour les deux premières heures.
- c. Au poste médical avancé (PMA), maintenir la réhydratation et lutter contre l'hyperkaliémie
- d. La myoglobine est administrée avant d'évacuer la victime afin d'éviter l'agression rénale aigue.
- e. L'hypercalcémie doit être corrigée avant d'évacuer la victime.

Q36. Lors d'un flux massif de blessés, la gestion médicale des patients comporte (la/les RJ)

- a. La priorité est donnée aux urgences absolues (UE et U.1).
- b. Le triage doit s'accompagner de gestes médico-chirurgicaux de sauvetage, écourtés, de type damage control
- c. Le recours aux examens biologiques et d'imagerie est limité aux catégories de tri type Urgences absolues.
- d. L'afflux est dit saturant lorsque le nombre de blessés est supérieur aux possibilités de la structure médicale.
- e. Toutes les réponses sont justes

Cas Clinique: (les questions N 37, 38, 39, 40)

Un homme de 28 ans est amené aux urgences suite à un accident de la circulation impliquant un carambolage. Les équipes de secours rapportent qu'une personne est décédée sur les lieux.

► Bilan Préhospitalier:

Les secouristes ont trouvé un patient conscient, tension artérielle (TA): 92/55 mm Hg. fréquence cardiaque (FC): 112 bpm, fréquence respiratoire (FR): 23 cycles/min, une déformation de la jambe et de la cuisse droite.

Le patient a bénéficié des premiers soins et d'un remplissage vasculaire de 1200 ml.

► Examen Clinique à l'Arrivée aux Urgences:

Patient conscient, se plaignant de douleurs abdominales et au niveau du membre inférieur droit, Tension artérielle (TA): 74/45 mm Hg. Fréquence cardiaque (FC): 125 bpm; Pâleur, Auscultation pulmonaire normale, SpO2 à 98%, Plaies du scalp qui saignent malgré le pansement.

Q37. Quel est le type et le stade d'état de choc que vous constatez chez ce patient ? (RJ)

- a. Choc cardiogénique, stade I
- b. Choc hypovolémique, stade II
- c. Choc hypovolémique, stade III
- d. Choc septique, stade I
- e. Choc neurogénique, stade II

Q38. Citez les critères de Vittel retrouvés chez ce patient? (la/les RJ)

- a. Notion de décès dans l'accident
- b. Pression Artérielle Systolique à 74 mm Hg
- c. Remplissage vasculaire préhospitalier > 1000 ml
- d. Saturation en Oxygène supérieur à 92%
- e. Fracture du membre inférieur

Q39. Suite à l'échographie FAST, la présence de liquide libre est confirmée et le patient reste instable (TA 70/40, FC 130). Quel est l'objectif tensionnel initial à viser dans le cadre d'une stratégie de damage control? (RJ)

- a. Maintenir une TA systolique > 120 mm Hg
- b. Maintenir une TA moyenne entre 80 et 90 mm Hg
- c. Maintenir une TA systolique entre 90 et 110 mm Hg
- d. Maintenir une TA systolique entre 60 et 70 mm Hg
- e. Maintenir une TA diastolique > 65 mm Hg

Q40. Quels sont les éléments clés à optimiser pendant la réanimation en phase initiale de damage control, en dehors du contrôle du saignement ? (La/les RJ)

- a. Correction rapide de l'hypothermie
- b. Maintien d'un rapport CGR/PFC/Plaquettes de 1/1/1
- c. Minimisation des apports de cristaalloïdes
- d. Correction de l'acidose métabolique par sérum salé isotonique
- e. Administration systématique de fibrinogène

Examen UMC : Groupe 02 / 2026

- Q1. Chez un patient victime de noyade, quelle est la priorité absolue en préhospitalier? (RJ)
- A. Réchauffer le patient
 - B. Administrer des antibiotiques
 - C. Assurer l'oxygénation et la ventilation
 - D. Réaliser une radiographie thoracique
 - E. Administrer un diurétique
- Q2. Quelle complication est la plus fréquemment associée à une électrisation grave ? (RJ)
- A. AVC ischémique
 - B. Fibrillation ventriculaire
 - C. Embolie pulmonaire
 - D. Tamponnade cardiaque
 - E. Choc septique
- Q3. Dans la pendaison, le mécanisme physiopathologique principal du décès est: (RJ)
- A. Fracture cervicale systématique
 - B. Obstruction trachéale isolée
 - C. Compression vasculaire cervicale entraînant une anoxie cérébrale
 - D. Inhalation de sécrétions
 - E. Arrêt cardiaque réflexe par stimulation vagale uniquement
- Q4. La morsure de serpent: (RF)
- A. Les morsures sont de gravité variable.
 - B. La localisation de la morsure ne représente pas un facteur de gravité
 - C. La diffusion du venin est lymphatique et hématogène.
 - D. Peut-être responsable de l'installation d'un coma
 - E. Chez un enfant est un facteur de gravité.
- Q5. Quelle différence majeure distingue la strangulation de la pendaison? (RJ)
- A. Le mécanisme est toujours accidentel
 - B. Le poids du corps n'intervient pas dans la strangulation
 - C. Il n'existe jamais de lésions cutanées
 - D. La strangulation entraîne toujours une fracture laryngée
 - E. Le décès est immédiat
- Q6. La médecine de catastrophe se caractérise par: la/les RJ
- A. Une prise charge individualisée optimale
 - B. Une priorisation collective des soins
 - C. L'absence de triage
 - D. Une adaptation aux ressources disponibles
 - E. Une médecine exclusivement hospitalière
07. Concernant le plan ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) la/les RJ
- A. il est uniquement hospitalier
 - B. Il coordonne plusieurs acteurs
 - C. Il est déclenché lors d'un afflux massif de victimes
 - D. remplace le SAMU
 - E. Il est dirigé par une seule structure médicale

Q8. Le tri START repose sur: la/les RJ

- A. La pression artérielle
- B. La respiration
- C. La perfusion
- D. L'état neurologique
- E. Le score de Glasgow détaillé

Q9. Le rôle du médecin sur le terrain comprend: la/les RJ

- A. Le tri des victimes
- B. La coordination avec les secours
- C. Les gestes vitaux simples
- D. Les examens complémentaires complexes
- E. La participation à la chaîne de commandement

Q10. Le poste médical avancé (PMA) permet: la/les RJ

- A. Le tri secondaire
- B. La chirurgie lourde
- C. La stabilisation des victimes
- D. L'orientation vers les hôpitaux
- E. L'hospitalisation prolongée

Q11. Les fonctions de la peau humaine sont les présentes (RF)

- A. Thermorégulation
- B. Protection
- C. Perception
- D. Production d'enzyme
- E Immunologique

Q12. L'hypercatabolisme secondaire aux brûlures est responsable de (RJ):

- 1. Dénutrition sévère
- 2. Retard de cicatrisation
- 3. Chute de la pilosité
- 4. Approfondissement secondaire des lésions
- 5. Hémococoncentration

A:1+2 B:1+3+5 C:1+2+4 D:2+3+4 E:3+4+5

Q13. Facteurs de risque d'approfondissement des brûlures sont (RJ):

- 1. Hypoxie
- 2. Hyperhydratation
- 3. Infection
- 4. Intoxication CO
- 5. La surface brûlée élevée

A / 1 + 3 + 4 B / 3 + 4 + 5 C:1+4+5 D:3+4 E:1+5

Q14. Les objectifs de la réanimation hydroélectrolytique en cas de brûlures sont (RJ):

1. Hémoglobine > 10 g/dl
 2. Hématocrite <50%
 3. Diurèse 1 cc/Kg/h
 4. Fréquence cardiaque < 100 b/min
 5. Tension artérielle diastolique > 70 mmHg
- A / 1 + 2 + 3 B/2 + 3 + 4 C:2 + 3 + 5 D:4+5 E / 2 + 4 + 5

Q15. Concept structurel de prise en charge aux urgences: (RF)

- A. On a 3 niveaux d'exercice selon le type d'urgence
- B. Les urgences mineures sont traitées au niveau des structures de niveau 1
- C. L'hôpital est considéré niveau 2 dans l'échelle des structures
- D. L'hospitalisation au niveau des structures d'urgence doit se faire jusqu'à guérison du patient
- E. La durée d'hospitalisation des patients au niveau des urgences doit être courte de moins de 48 H

Q16. La médecine d'urgence est: (RJ)

1. Une médecine simple et mono disciplinaire
 2. Nécessite un travail d'équipe permanent
 3. Est un exercice sans sélection
 4. Doit accueillir tout type d'urgences 24 H/24 H sauf les week-ends
- A / 1 + 2 B / 1 + 2 + 3 C / 2 + 4 D / 2 + 3 E / 1 + 4

Q17. Dans une structure d'urgence: (RF)

- A. Un code couleurs international et conventionnel est utilisé au tri
- B. On a 5 échelles d'évaluation selon le code couleurs
- C. Le triage est basé sur les symptômes et non pas sur le diagnostic
- D. Le code rouge est destiné pour les urgences vitales
- E. la zone de triage est tenue par un médecin spécialiste

Q18. L'orientation des patients après tri/examen se fait: (PU)

- A. Salle de déchocage si pronostic vital engagé
- B. Unité de courte durée pour poursuivre son traitement
- C. Décider le lieu de transfert du patient selon la disponibilité des services
- D. Permet de libérer les locaux en zone d'exams
- E. Toutes les réponses sont justes

Q19. En situation d'afflux massif de blessés aux urgences, l'objectif principal du triage est (RJ):

- A. D'assurer à chaque patient une prise en charge complète et individualisée
- B. D'appliquer le principe premier arrivé, premier pris en charge
- C. De diminuer les coûts hospitaliers
- D. D'optimiser l'utilisation des ressources pour maximiser le nombre de survivants
- E. De prioriser systématiquement les patients les plus graves, quel que soit le pronostic

Q20. À propos des algorithmes de triage lors d'un afflux massif de victimes, quelle proposition est la plus conforme aux données actuelles?

- A. Un seul algorithme (méthode START) a démontré une supériorité claire et constante
- B. Les systèmes de triage préhospitaliers fournissent en pratique une précision élevée, avec une fiabilité et une cohérence quasi parfaite
- C. Aucun algorithme ne s'est avéré supérieur en tous points, l'élément déterminant reste l'entraînement régulier au triage avec un système validé
- D. Les algorithmes ne sont pas nécessaires si l'équipe est expérimentée
- E. Les algorithmes récents ont quasiment supprimé les phénomènes d'over triage et d'Under triage en situation réelle

Q21. L'hyperthermie se distingue de la fièvre par (RJ):

- A. Une origine infectieuse constante
- B. Une inefficacité des antipyrétiques
- C. Une augmentation du frisson
- D. Une hypothermie associée
- E. Une baisse de la sudation

Q22. Le signe neurologique le plus fréquent d'une hyperthermie grave est (RJ):

- A. Céphalées
- B. Confusion
- C. Frissons
- D. Tremblements
- E. Myosis

Q23. Une température corporelle $<30^{\circ}\text{C}$ définit (RJ):

- A. Hypothermie légère
- B. Hypothermie modérée
- C. Hypothermie sévère
- D. Fièvre
- E. Normothermie

Q24. La dysthermie centrale est due principalement à (RJ):

- A. Infection
- B. Trouble endocrinien
- C. Lésion hypothalamique
- D. Déshydratation
- E intoxication

Q25. Dans l'hypothermie sévère, on observe typiquement (RJ):

- A. Tachycardie
- B. Hyperthermie
- C. Bradycardie
- D. Polypnée
- E. Hyperglycémie

Q26. Concernant les définitions fondamentales en oxygénothérapie, quelles affirmations sont exactes ? Cochez les réponses justes

- A. L'hypoxémie se définit par une PaO_2 , <80 mmHg.
- B. L'hypoxie correspond à une réduction de l'apport d'oxygène au niveau des tissus, elle peut être estimée avec mesure de lactatémie
- C. Hypoxémie engendre obligatoirement une hypoxie
- D. La pression partielle en oxygène alvéolaire (PAO) peut être maintenue stable lors d'une hypoventilation par une augmentation de la FiO_2
- E. Hypoxie engendre dans tous les cas une hypoxémie.

Q27. Quels sont les dispositifs d'oxygénothérapie qui permettent d'administrer une FIO_2 précise la/les RJ

- A Lunettes nasales
- B. Masque facial simple
- C. Masque à effet Venturi.
- D. Masque à réservoir
- E Système d'oxygène à haut débit (High Flow).

Q28. Quelles affirmations concernant les caractéristiques techniques des interfaces d'oxygénothérapie sont correctes ?

- A. Les lunettes nasales permettent d'administrer une FiO_2 , allant jusqu' à 44% avec un débit maximal de 6 L/min
- B. Le masque à effet Venturi permet de délivrer une FIO , précise et prédéterminée variant de 24% à 60%
- C. Le masque à réservoir nécessite un débit d'au moins 10 L/min pour fonctionner correctement,
- D. Le masque facial simple permet d'administrer une FID , comprise entre 40% et 60%
- E. Le masque à réservoir permet d'administrer une FiO_2 à 100%.

Q29. Concernant le masque à réservoir utilisé en oxygénothérapie, quelles affirmations sont correctes? la/les RJ

- A. Il fait partie des dispositifs de l'oxygénothérapie hyperbare.
- B. il permet d'administrer une fraction inspirée en oxygène (FiO_2) comprise entre 70% et 100%
- C. Le réservoir se vide complètement à chaque inspiration pour maximiser l'apport d'oxygène
- D. Sa structure comprend des valves unidirectionnelles empêchant le retour d'air expiré dans le réservoir
- E. Il est appelé masque à haute concentration.

Q30. Quelles sont les complications possibles de l'oxygénothérapie ? la/les RJ

- A. Une toxicité pulmonaire avec œdème interstitiel et alvéolaire.
- B. Des atelectasies par dénitrogénéation alvéolaire.
- C. Hyperoxie.
- D. Gonflement des cellules endothéliales des capillaires
- E. Rétention de gaz carbonique par correction de l'hypoxie

Q31. La morsure de serpent: (RF)

- A. Les morsures sont de gravité variable
- B. La localisation de la morsure ne représente pas un facteur de gravité
- C. La diffusion du venin est lymphatique et hématogène.
- D. Peut être responsable de l'installation d'un coma
- E. Chez un enfant est un facteur de gravité

Q32. Les soins pré hospitaliers: la/les RJ

- A. Débutent sur les lieux de l'accident
- B. Débutent à l'arrivée des équipes de sauvetage et transport
- C. Débutent à l'arrivée à la structure hospitalière
- D. Ne peuvent être initié que par un médecin
- E. Contiennent les gestes de base et des soins spécifiques

Q33. La chaîne de secours: la/les RU

- A. Constitue l'enchaînement de quatre actions vitales
- B. Est déclenché par l'arrivée des secours sur les lieux de l'accident
- C. Constitue l'enchaînement de cinq actions vitales
- D. L'ordre des actions n'est pas important
- E. Elle s'achève par l'arrivée de la victime à l'hôpital

Q34. Parmi les soins de base ou the basic life support BLS: la/les RJ

- A. La pose d'une voie veineuse périphérique
- B. La protection du rachis cervicale
- C. Le massage cardiaque externe
- D. L'intubation orotrachéale
- E. Le contrôle de la douleur

Q35. Le transport des victimes: la/les RJ

- A. Peut-être primaire ou secondaire
- B. Nécessite une ambulance et un ambulancier
- C. Ne nécessite pas une surveillance durant le trajet
- D. Est fait par une équipe mobile constituée d'un médecin, un infirmier et un ambulancier
- E. Le moyen du transport est discuté selon l'état de la victime

Cas clinique (questions numéro 36,37,38,39,40)

Vous recevez au PU un patient âgé de 67 ans antécédents de DNID sous metformine, victime d'un accident de la voie publique, présentant à l'examen clinique: TA: 75/40, FC a 123/mn, FR a 24c/mn, SpO2 87%, pâleur et froideur des extrémités. Une altération de son état de conscience avec ouverture des yeux après stimulation douloureuse, répond aux questions d'une façon inappropriée, présentant une triple flexion stéréotypée des membres supérieurs et extension des membres Inférieurs.

L'examen locomoteur: déformation de sa cuisse droite avec augmentation de son volume

Q36. Quelle est la définition du polytraumatisé? (Cochez la réponse juste)

- a. Une personne présentant de multiples fractures.
- b. Une personne présentant un état de choc hémodynamique par rupture de rate
- c. Une personne présentant un traumatisme crânien grave
- d. Une personne présentant au moins 2 lésions dans une mis en jeu le Pc vital
- e. Une personne qui présente plusieurs traumatismes corporels graves

A: a-b-d B: d-e C: b-d-e D: b-c E: b

Q37. Quelle est votre évaluation du score de Glasgow chez ce patient:(Cochez la réponse juste)

- A. Score à 10
- B. Scope à 08
- C. Score à 07
- D. Score à 12
- E. Score à 06

Q38. Parmi ces propositions, laquelle ne fait pas partie des critères de gravité chez la polytraumatisé, selon le score de Vittel. (Cochez la réponse fausse)

- A. Age du patient > 65 ans
- B. Remplissage vasculaire: colloïdes > 1000ml
- C. La SpO₂ <90%
- D. Chute d'une hauteur de trois (03) mètres
- E. Score de Glasgow <13

Q39. Parmi ces propositions, laquelle ne fait pas partie des mécanismes directs chez le polytraumatisé. (Cochez la réponse fausse)

- A. Lésion par objet contondants
- B. Lésion par objet tranchant
- C. Une chute du 2ème étage avec arrachement des pédicules vasculaires
- D. Explosion d'une bombe
- E. Ecrasement ou compression

Q40. Chez ce patient, quels sont les examens complémentaires à faire dans l'immédiate? (Cochez la réponse fausse)

- A. Body scanne avec injection du produit de contraste
- B. Telethorax de face
- C. Echographie abdomino-pelvienne (FAST écho et e-FAST)
- D. ECG

E. Bilan biologique: Groupage RAI; FNS; glycémie, bilan rénale (créatininémie, urée): ionogramme sanguin; hémostase (TP, TCK)